

总主编 潘桂娟

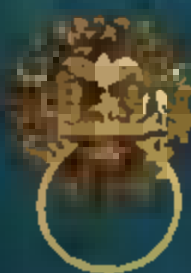
中医药防治流感参考丛书

ZHONGYIAO FANGZHI LIUGAN CANKAO CONGSHU



近现代名老中医 时病医案

主编 金香兰



中国中医药出版社

（北京）



中华医药 源远流长
古今中外 博大精深



中医药防治流感参考丛书

近现代名老中医时病医案

ISBN 978-7-5132-0010-3



9 787513 200103 >

中国医药出版社

定价：20.00元

中医药防治流感参考丛书

近现代名老中医时病医案

主 编 金香兰

编 委 (按姓氏笔画排列)

王左原 刘理想 李志更

张玉辉 金香兰

中国中医药出版社
· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

近现代名老中医时病医案/金香兰主编. —北京: 中国中医药出版社, 2010. 7

(中医药防治流感参考丛书)

ISBN 978 - 7 - 5132 - 0010 - 3

I. ①近… II. ①金… III. ①流行性感冒—中医治疗法—医案—汇编—中国—现代②流行性感冒—中医治疗法—医案—汇编—中国—现代 IV. ①R254. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 095350 号

中国中医药出版社出版

北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层

邮编 100013

传真 010 64405750

北京时代华都印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 880 × 1230 1/32 印张 10.875 字数 309 千字

2010 年 7 月第 1 版 2010 年 7 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978 - 7 - 5132 - 0010 - 3

*

定价 20.00 元

网址 www.cptcm.com

如有印装质量问题, 请与出版社出版部调换

版权专有 侵权必究

社长热线 010 64405720

读者服务部电话 010 64065415 010 84042153

书店网址 csln.net/qksd/

内 容 提 要

本书收录了近现代部分名老中医专家治疗中医时病的医案，通过这些医案可以清晰地体会到老中医的临床思维活动，可以从中学习治疗时病的思路、方法和具体的用药经验；对现代流行性感冒的防治，具有重要的参考和借鉴意义。本书适于中医药及中西医结合临床、教学、科研工作者参考和借鉴。

.....



《中医药防治流感参考丛书》

编委会

总主编 潘桂娟

副主编 (按姓氏笔画排列)

杨 威 陈 曦 金香兰 翟志光

编 委 (按姓氏笔画排列)

于 峥 马晓彤 王克林 刘理想

刘寨华 李志更 杨 威 张立平

张宇鹏 张 晨 陈 曦 金香兰

郑 齐 唐玲玲 翟志光 潘桂娟

前 言

流行性感胃 (influenza, 简称流感) 是流感病毒引起的急性呼吸道感染, 也是一种传染性强、传播速度快的疾病。其主要通过空气中的飞沫、人与人之间的接触或与被污染物品的接触传播。典型的临床症状是: 急起高热、全身疼痛、显著乏力和轻度呼吸道症状。一般秋冬季节是其高发期, 所引起的并发症和死亡现象非常严重。

据相关文献记载, 20 世纪以来, 流感——这一看似常见的疾病频繁爆发, 已经对人类生命和社会稳定造成了极大的威胁。2009 年 4 月, 甲型 H1N1 流感在墨西哥爆发, 并迅速向世界范围扩散。尽管世界各国采取了有力措施积极防范, 但仍造成了数以千计的病人死亡, 同时造成了人们心理的极大恐慌。

中医学在长期与传染病作斗争的过程中, 积累了丰富的临床经验和有效处方, 为中华民族的繁衍昌盛作出了巨大贡献。中华人民共和国成立以来, 中医药在 1955~1956 年流行性乙型脑炎、2003 年 SARS 以及后来的禽流感防治工作中, 取得了举世瞩目的成绩, 得到了国际医学界的认可。

西医学的流行性感胃, 属于中医学的伤寒、温病和 (或) 瘟疫范畴, 运用中医学理论对流行性感胃的病因、病机及传变进行分析, 能够有效指导临床治疗。古今医家对流感样病症的发病、诊疗和预防有着不同的认识, 在长期的临床实践过程中形成了独特的诊疗理论。系统发掘沉积于中医古代文献之中的医论医话、临床医案, 进一步发挥中医药防治流行性感胃的特色与优势, 对于中医学基本理论和诊疗经验的继承与创新, 对于临床急救救治能力的提升, 均具有重要的学术价值和实际意义。

中医学认为, 流行性感胃类似病证具有时令性和 (或) 时行性特点。因此, 我们统称为“时病”。本丛书基于历代中医文献, 跟踪现代流感防治进展, 对古今著名医家的医论、医话、医案以及

代表方剂的基础证和拓展证，进行系统梳理与类编；对现代中医药防治流感的临床研究成果，进行全面汇总与评述。丛书内容重点突出中医药对流感病因病机的认识、中医临床对流感辨证论治的原则、防治方药和中成药的合理使用等中医原创思维。希望通过本丛书的出版，在来来防治流感的过程中，为中医临床诊疗提供有益的借鉴与参考，从而能够积极有效地提高中医药防治重大传染病的能力和水平。

编写说明

流行性感胃，属中医外感病的范畴。外感病，也称时病。“时病指的是春夏秋冬一般常见的急性热性疾病。”（蒲辅周）中医在时病的诊治方面，已有丰富的理论与实践积淀。根据流行性感胃的发病情况，本书主要收集了近现代名老中医诊治时病的医案。其中主要包括风温、春温、温病、暑温、湿温、冬温等发病机制，诊治规律，方药论治，个案总结等内容。

本书中的名老中医医案，主要来自中国中医药出版社出版的《中国百年百名中医临床家丛书》。本书以名老中医姓名为纲，以姓氏笔画为序，共收录了77位医家的医案及部分医家的医论。内容以时病的诊治医案为主，为保持医案书写的原貌，整理时未对内容体例进行统一调整。剂量单位仍按原来写法。对于在医案之前阐述的理论性内容，因其与医案的联系较密切，予以保留。对于一些无医案的论述性内容，因其内容系统并且结合实际阐述，因而酌情予以选录，如蒲辅周、潘澄濂老中医有关流行性感胃的论述。对采用的内容又重新进行了必要的编排。

本书对于中医从业人员及临床相关学科的医务人员，具有很好的指导和示范作用。医案的学习关键，是要掌握名老中医在临证时的思维过程，而不单单是学习一方一药。另外，对于加减的处理也是非常重要的，有时临证思维的“火花”往往就在于此。因此，读医案需细致揣摩其中的奥妙。另外，还应善于比较，对于同样的证候，每个医生的处方用药不尽相同，在比较中找出不同之处，方能对临证的规律有基本的把握。由于大部分医案案后均有按语，按语中往往详细阐述治疗的过程，故仔细阅读按语是掌握医案的关键。因此，建议读者对按语进行精读，体会其中的精髓。

本书是应目前流感在世界范围内大流行的紧急情况而编写的，对现代流行性感胃等时病的诊治，具有一定的借鉴和启发意义。因时间仓促，文中难免出现讹误，还望读者提出宝贵意见，以便再版时修订提高。

金香兰

2010年3月

目 录

丁光迪	(1)
治感冒医案	(1)
感冒虽然常见病,寒温兼夹要论证	(1)
万友生	(4)
治感冒医案	(4)
王合三	(7)
论外感邪入膜原	(7)
论瘟疫邪入膜原	(9)
战汗三部曲	(9)
论治伏气温病	(12)
误汗口伤烂赤治愈医案	(12)
论治风热感冒医案	(13)
伤寒温病“变统”论治	(13)
论治流行性感冒	(16)
王伯岳	(18)
论治小儿感冒	(18)
小儿感冒须辨风寒风热与夹食	(18)
辨治感冒多取辛温辛凉两并用	(19)
夹食感冒尤宜发表和里须双解	(21)
甘均权	(23)
治春温误汗变证案	(23)
治春温邪陷少阴案	(23)
叶鉴清	(25)
春温发痧案	(25)

春温夹痰案	(27)
春温夹痰喘案	(30)
叶熙春	(32)
治湿温医案	(32)
治风湿医案	(40)
治春温医案	(43)
治暑温医案	(45)
附：暑湿	(48)
治冬温医案	(49)
史沛棠	(50)
治春温医案	(50)
邢子亨	(51)
论治感冒	(51)
过允文	(53)
风湿案	(53)
治秋温夹湿案	(53)
温病晚发案	(54)
风湿时毒案	(55)
刘志明	(57)
用辛凉宣肺、清营解毒法治愈风湿一例	(57)
许公岩	(58)
疏邪化湿法治愈急性发热三例	(58)
表里双解案	(58)
化湿降浊清热案	(58)
疏风散寒、化湿导滞案	(59)
温散法治愈寒湿困阳感冒不解一例	(60)
许翔霄	(61)

风湿伏邪案	(61)
严执中	(62)
春温案	(62)
李竹溪	(64)
春温晚发误治坏症案	(64)
李振华	(66)
用人参白虎汤加减治愈风湿一例	(66)
李翰卿	(68)
论治感冒	(68)
治感冒重在认证,用成方妙在加减	(68)
杨熙龄	(70)
论治暑疫	(70)
杨燧熙	(72)
春温案	(72)
肖龙友	(73)
清降法治愈风热喘咳医案	(73)
吴古年	(74)
论治风湿郁火	(74)
论治风湿神昏呃逆	(74)
论治风湿	(75)
治春温医案	(75)
治时感温邪医案	(76)
治痰饮兼时感医案	(76)
吴兴南	(77)
治时行冬温医案	(77)

何任.....	(79)
温病医案	(79)
何书田	(82)
治温热病医案	(82)
何炎燊	(88)
论治温病医案	(88)
余无言	(92)
论治春温痰火发狂证	(92)
汪逢春	(94)
论治温病医案	(94)
宋达三	(97)
治流行性感胃医案	(97)
流感误汗并发抽风	(97)
流感并发肺气闭塞(肺炎)	(98)
劳复流感	(99)
旧病血虚复染流感	(100)
宋爱人	(103)
治咳嗽医案	(103)
外感痰咳,卫外不和——宣肺化痰,降气止咳	(103)
治风湿医案	(104)
风湿疾喘神昏——安宫牛黄合银翘解毒	(104)
治春温医案	(106)
痰热郁闭包络——清气透邪,宣化痰热	(106)
温毒疫疹——凉肝熄风,通腑存阴	(108)
春温热厥——双解阳明经腑	(110)
张震	(113)

宣清湿热法治愈风湿一例	(113)
张子琳	(114)
论治感冒	(114)
虽是小恙谨于微,寒热暑时分型治	(114)
医案	(115)
张伯臾	(117)
用大柴胡汤加减治愈外感发热医案一例	(117)
张际春	(119)
治冬温战汗医案	(119)
冬温战汗案	(119)
张菊人	(121)
论治温病医案	(121)
论治温热病医案	(123)
张锡纯	(133)
风湿案	(133)
风湿喘促案	(134)
风湿兼伏气化热案	(135)
温病案	(136)
温病兼喉疼案	(137)
张镜人	(138)
论治外感发热	(138)
风寒	(138)
湿热	(140)
温疫疠气	(146)
疟邪瘴毒	(147)
用泄热化湿法治愈风湿案	(148)
治春温医案	(150)

陈务斋	(154)
三阳风热症案	(154)
陈存仁	(156)
治感冒医案	(156)
陈作仁	(158)
春温案	(158)
春温误治案	(159)
风湿发痉案	(160)
陈良夫	(162)
论温热病	(162)
治风湿医案	(162)
治春温医案	(166)
陈莲舫	(170)
治风湿医案	(170)
治春温医案	(171)
范文甫	(173)
论治外感热病	(173)
明辨伤寒温病,治法相应变通	(173)
表达里下,法药相宜	(174)
温病救阴湿温重湿	(175)
洞察寒热真假,救脱杜渐防微	(176)
治风湿医案	(178)
治春温医案	(180)
治暑温医案	(186)
林沛湘	(188)
论治感冒	(188)
外感风邪夹湿证	(188)
气虚感冒	(188)

岳美中	(190)
用白虎汤治温热证案	(190)
金子久	(192)
治风湿案	(192)
周小农	(195)
温病案	(195)
周筱斋	(197)
论治风湿	(197)
郑沛江	(199)
风湿夹湿案	(199)
赵文魁	(201)
疏卫清化法治恶寒灼热案	(201)
赵心波	(202)
论治感冒	(202)
赵锡武	(207)
用麻杏石甘汤加味治愈小儿风湿案	(207)
胡希恕	(209)
论治感冒	(209)
感冒在表变匆匆,审证勿疏有合病	(210)
感冒并非皆表证,治疗当忌都发汗	(211)
表证阴证阳证分,论治温补发汗殊	(212)
胡剑华	(214)
治风湿夹食案	(214)

俞慎初	(216)
温热病治验举要	(216)
时发暑疟,治以清泄少阳	(216)
施今墨	(218)
论外感病证治	(218)
风寒外袭案	(220)
表寒里热案	(220)
半表半里案	(221)
类疟案	(223)
热入血室案	(224)
外感表虚案	(224)
温邪内伏案	(225)
暑温案	(227)
暑风案	(228)
治流行性感胃医案	(228)
费伯雄	(230)
论治时病	(230)
费绳甫	(232)
论治伤寒案	(232)
治感冒案	(235)
治春温案	(237)
治冬温案	(239)
贺季衡	(241)
论治风湿案	(241)
袁桂生	(246)
温病案	(246)
春温兼寒案	(249)
钱存济	(251)

春温夹食案	(251)
钱苏斋	(253)
风湿暴泄案	(253)
风湿火逆案	(254)
风湿夹食案	(255)
徐小圃	(257)
治温病案	(257)
徐恕甫	(262)
论治温病案	(262)
温病伤阴,邪气深入血分,不得任用苦燥	(262)
阳明温病,温邪入下焦,施增水行舟法	(262)
温病神昏,病见危象,勉以大剂三才冀挽回于前	(263)
昏谵,芳香护应中以防内闭,一剂病瘥	(263)
郭士魁	(265)
论治发热案	(265)
曹沧州	(268)
治温热病案	(268)
章次公	(273)
用泻肺消痰为主治愈风湿一例	(273)
梁右斋	(274)
风热案	(274)
风热夹痰案	(274)
风热夹积案	(275)
董廷瑶	(277)

论小儿高热证治	(277)
风寒表证	(277)
风热上受	(278)
邪结少阳	(280)
董建华	(284)
论治春温病	(284)
具体治法	(284)
治疗用药特点	(285)
病案举例	(285)
论治风湿	(288)
韩绪臣	(294)
风热咳血案	(294)
蒲辅周	(295)
论治春季、夏季时病	(295)
春季时病	(295)
夏季时病	(296)
论治流行性感胃辨证的一般原则	(300)
流行性感胃的辨证规律	(301)
流行性感胃的治疗原则	(303)
治感冒医案	(307)
风热感冒	(310)
阳虚感冒	(311)
治温邪郁闭(腺病毒肺炎)案	(312)
治温邪入营(腺病毒肺炎)案	(313)
治风湿犯肺(腺病毒肺炎)案	(315)
廖浚泉	(317)
用宣肺清热法治愈风湿一例	(317)
颜德馨	(318)
论四时感冒务明时气疫气	(318)

潘澄濂	(320)
论养阴生津法在温病临床上的应用	(320)
理论依据	(320)
养阴生津法方剂的组成和作用	(321)
论治流行性感胃	(322)
魏树森	(324)
春温夹痰热案	(324)
治疫验方	(325)

丁光迪

治感冒医案

感冒虽然常见病，寒温兼夹要论证

例一，汤某，女，22岁，本校学生。

初诊：1960年11月18日。本有眩晕病，发作时头痛如裹，头眩而重，胸痞泛恶；发病甚时，几欲跌倒，肌肤发凉，汗冷而黏。在上学期即曾晕倒过两次。形体较丰，当为风痰之证。

最近感冒，头痛而眩，清涕多，咳嗽。开始发热，今稍可，但恶寒头痛等症不解。脉较细，苔白腻。分析病情，此为风寒外袭，兼夹痰湿。治以解表化痰为法。方拟葱姜荆防兼二陈。

荆芥5克，防风5克，蔓荆子10克，苏叶5克，炙苏子（研）10克，光杏仁（打）10克，橘皮5克，姜半夏10克，姜川朴5克，生姜2片，葱白头（打）3个，2帖。

二诊：药后得汗，感冒之症已解除，但尚有头痛而眩。效议出入再进。原方去生姜、葱白、苏叶，加白术10克，泽泻10克。3帖。

此后诸症全除，眩晕亦不发作了，偶在疲劳时有头眩，但移时即平。

按：“夫病痼疾，加以卒病，当先治其卒病，后乃治其痼疾也。”这是临床常规，张仲景早已指出（见《金匮要略》）。但新病旧病病情相通的，又可以异病同治，同样能够获得疗效。如此例原有风痰眩晕病，近又新感，风邪夹痰湿，两者病因相同，见症亦近似，治以祛风化痰方法，新病得解，旧病亦好转，一举而两得。这是临床的活法，并不有违于仲景，实师其意而变通之，以从见症出发，如是则治法灵活了。学此专业的，亲身体验一下，很有好处，

可以多一些感性知识，增进学好中医的信心。

例二，岳某，男，40岁，武进市农民。

素多劳碌，脾胃不健，年当壮盛，而形体清瘦，面色晄白，时易感冒。上午形寒为甚，加衣稍迟，即清涕涟涟。无分春秋，几乎感冒不断。并且易汗、自汗、盗汗，但并不典型，已经两三年，人们讥笑为白面书生。纳谷不香，时易便溏，已经不胜农业劳动。脉细略数而虚，舌苔薄白（曾经医院检查，心肺正常，亦无肝病史）。

分析病情，属于内伤脾胃之证。元气不足，营卫交虚。无阳以卫护其外，所以时易感冒；腠理不固，则气虚不能摄津，所以自汗盗汗。治以补中益气方法。方从补中益气汤加味。

升麻5克、柴胡5克，黄芪10克，白术10克，炙甘草5克，党参10克，陈皮5克，当归10克，炮姜4克，防风10克，生姜2片，大枣5个。10贴。

二诊：药后有小效，畏寒、自汗均减，舌质转红。效议出入再进。原方去炮姜、防风，加桂枝10克，炒白芍10克。10帖。

嗣后接近秋收农忙，服汤药不方便，改用补中益气丸，姜枣汤送下。服了个把月，又参加些劳动，自感不及汤药见效，即用第二诊方药，改成煮散，断续煎服将近三个月，大显功效。首先自汗、盗汗逐渐收敛，以后感冒显著减少，最后一个多月，竟然没有感冒。精力明显健旺，食欲大振，新米登场，吃了甚香，面色亦泛润泽。观察几年，不但旧病消失，而且形体壮实，成为乒乓球运动的爱好者。这种经验曾治多个病例，同样获效。说明李东垣“肺之脾胃虚”的论证，是确有道理的。

例三，王某，男，67岁，东南大学教授。

因发热咳嗽，去医院就诊，胸透检查，肺部发现一块阴影，当时疑为老年性肺部感染，尚未吸收，给予抗生素治疗，药后无效。又去某医院求治。摄胸片，阴影似呈圆球形，印象为肺瘤。建议服抗癌药，三个月后复查。家属颇为紧张，要求对病员保密，未服抗癌药。又去另一医院求诊，因检查尚难以确诊，只能对症处理；即便是肺癌，如此老年人亦无特效办法，建议休养一段时间，进一步临床观察。病员亦产生疑窦了，几个医院不能及时处理，问题定多

麻烦，要求去中医院就诊一下。

诊时见其形体尚丰，行动自如，眠食虽差，但思维尚很清楚。主症是时有低热，并时形寒瑟缩，畏寒而无汗。喉痒咳嗽，晨晚咽干作呛。但有痰不多，咽喉不红，面色尚和，有些愁容。按脉稍浮略弦，关尺平静；舌色正，苔薄腻。平时血压略偏高，但无明显症状。分析病情，并无肺与心肝的不祥之征，年岁虽高，本气尚实，不能疑为恶变重病。其所以畏寒微热，喉痒咳嗽，当为肺感微寒，郁于气分，卫失宣畅，肺欠肃降所致。治以疏解微邪，理气肃肺可已，许其无碍。方从止嗽散加减。

前胡 10 克，荆芥 10 克，紫菀 10 克，苦桔梗 7 克，炙甘草 4 克，橘红 5 克，茯苓 10 克，赤芍 10 克，黄芩 10 克，鲜枇杷叶（去毛，包）15 克。3 帖。

二诊：药后形寒、微热均减，呛咳亦少。惟眠、食尚差。效议再进。原方前胡、荆芥减量，加谷、麦芽各 10 克，合欢皮 15 克。3 帖。

三诊：近来得微汗，自感轻适，寒热全平，寐亦自安。惟苔薄微糙，又见咽干作呛，盖是表邪汗出而肺气又见失润。再为顾津，润养肺气。上方去前胡、荆芥、赤芍、黄芩，加北沙参 15 克，川百合 15 克，炙桑叶 10 克。3 帖。

药后诸症平善，原有些疑虑，亦随之消释。适逢有全国性专业会议，前后参加十余天，兴致很高，亦即停药。又去医院复查一次，摄胸片，心肺正常，未见其他异常改变。一场虚惊，从此平安。

按：本例原是小病，易认易治，但一经检查，本想早些明确病情，却从此疑窦丛生，莫衷一是。现在临床，时有遇到这种情况，人们亦司空见惯，不再追问，默然自认了。

同样一个病人，经过几个医院的检查，诊断出现分歧，现在是不足为怪了，其中有许多主客观因素，很难简单下定论。但病人要有主见，医生更要能善于分析；即便检查结果是一致的，诊断确定了，还须留下余地。

（选自《中国百年百名中医临床家丛书·丁光迪》，中国中医药出版社 2001 年版，5~9 页）

万友生

治感冒医案

例1：李某，男，25岁。

1989年3月3日初诊：伤寒一日，恶寒重，发热 39.5°C ，无汗，头项痛，身痛，鼻塞流涕，咳嗽，口渴水入即吐，已呕吐6次，面色苍白，精神不振，苔薄白润，脉浮紧。按太阳表寒实证处理，投以麻黄汤冲剂，每次2包，日3次。药后2.5小时见汗，3.5小时体温降至 37.8°C 。

3月4日二诊：体温 38.1°C ，诸症减轻，守方再进。

3月5日三诊：体温 37°C ，诸症消失。

例2：刘某，5个月。

1993年3月4日初诊：感寒咳喘痰鸣已5天，咳甚时则呕痰吐乳，鼻流清涕，喷嚏，眼泪汪汪，纳减，大便溏软色黄，苔薄白润，指纹青。按太阳表寒闭肺处理，投以麻黄汤加减：炙麻黄10克，杏仁10克，甘草10克，桔梗10克，法半夏10克，陈皮10克，云茯苓10克，前胡10克，白前10克。2剂。

3月7日复诊：服上方3剂后，咳喘痰鸣基本解除，未再吐乳，纳增，大便成条，守上方减半量再进2剂而痊愈。

例3：程某，女，28岁。

产后感冒风寒，头痛，发热恶风寒无汗，暖腐吞酸，干呕，不思食，苔薄白，脉浮数而且虚弱。按太阳表寒虚证处理，投以桂枝汤全方（桂枝10克，白芍10克，甘草10克，生姜5片，红枣5枚），连服2剂即愈。

例4：王某，女，45岁。

1991年7月23日下午初诊：形寒易感，时自汗出，畏风怕冷已10多年，脉虚弱甚。投以大剂玉屏风散合生脉散加味：生黄芪

100克，防风15克，白术30克，党参50克，麦冬15克，五味子15克，生龙骨50克，生牡蛎50克，乌梅肉30克，浮小麦30克，凤凰衣30克。连服20剂，自汗渐减少，但仍畏风怕冷。复诊仍守上方加重生黄芪用量至120克，减去五味子、乌梅肉、浮小麦、凤凰衣、生龙骨、生牡蛎，再进15剂，自汗停止，即使跑步半小时以上亦仅身有微汗而已，不再畏风怕冷，脉力明显增强，已一个多月未再感冒。最后嘱长服玉屏风散以巩固疗效。

例5：廖某，女，59岁。

一诊：1991年8月1日上午。平素容易感冒，感即难以脱体，常常低热不退。上月6日又感冒发热，经治至15日退热后，仍低热昼作夜止，汗出齐胸，微恶风寒，鼻塞，头昏痛（患偏头痛已4年），眼花，神疲乏力，如用力则手足发抖，夜卧如失盖即受冷而痰多鼻塞甚，纳少乏味，纳后脘胀，口干渴喜冷饮，舌红，中心有裂痕，脉浮虚而数，投以补中益气汤合玉屏风散加味：黄芪50克，当归10克，党参30克，白术15克，防风15克，生甘草10克，升麻10克，柴胡15克，陈皮15克，葛根30克，川芎10克，白芷15克，山楂30克，六神曲10克，麦芽30克，鸡内金15克。

二诊：8月10日。连服上方9剂，昨日体温仅下午为 37.2°C ，余时均未超过 37°C 。用力已不手足发抖，口已不干，虽仍纳少乏味，但纳后不觉脘胀，夜卧仍鼻塞，昨日喷嚏多。守上方再进7剂。

三诊：8月17日。早晚体温不超过 36.9°C ，下午 $37^{\circ}\text{C} \sim 37.1^{\circ}\text{C}$ ，手足心热，仍有头昏痛、鼻塞，但喷嚏已止，守上方去山楂、六神曲、麦芽、鸡内金，加生晒参15克，麦冬15克，五味子10克，再进10剂。

四诊：8月28日。午后低热（ 37.3°C ）间作，寐差，头昏痛乏力，手足心热，仍舌红，中心有裂痕，但胃纳增加。守上方加减：黄芪30克，党参30克，白术10克，炙甘草10克，升麻10克，银柴胡15克，青蒿15克，生鳖甲30克，地骨皮15克，葛根30克，西洋参10克，麦冬10克，五味子10克，酸枣仁30克，川芎10克，知母10克，茯苓30克。

五诊：10月19日。再进上方6剂，低热解除，精神、饮食、睡眠、二便正常。仍守上方加减以善其后。

（选自《中国百年百名中医临床家丛书·万友生》，中国中医药出版社2001年版，13~16页）

王合三

论外感邪入膜原

一天两次病重来，如疟情形教你猜，二分桂枝麻黄一，两汤合并细分开。

服桂枝汤后，形如疟，日再发，是病重药轻，遗邪尚在，按时分裂，故以桂枝二麻黄一汤发其汗。此条最宜细认，不然，则杀人如反掌矣。

按语：“疟”字最早记载于殷商时代的甲骨文中，此后《周礼·天官》载曰“秋有疟寒疾”等。至《内经》已立有专论，指出：“疟气者……极则阴阳俱衰，卫气相离，故病得休；卫气集，则复病也。”（见《素问·疟论》）对疟疾的休作有时以及病因证治有详述。疟疾有一日疟、间日疟、三日疟等分别，绝不会一日反复发作二三次者，此是如疟，而非疟疾。虽有恶寒发热，或寒热往来，头项强痛，并非是“疟”为患，乃是太阳表证未解，故先生曰“如疟情形教你猜”，让与疟疾鉴别，两者不可混淆。寒热往来，日二三次，是正气虽弱，但仍可与邪抗争的表现。若用麻黄汤有病轻药重之过，若只用桂枝汤，但散表寒之力不足，故仲景根据病邪轻重，在营在卫之不同，采用桂枝汤量的三分之二和麻黄汤量的三分之一，合称桂枝二麻黄一汤〔桂枝一两十七铢（去皮），芍药一两六铢，麻黄十六铢，生姜一两六铢（切），杏仁十六个（去皮尖），甘草一两二铢（炙），大枣五枚（擘）。上七味，以水五升，先煮麻黄一二沸，去上沫，内诸药，煮取二升，去滓，温服一升，日再服〕，服之则邪去表解病愈矣。如误用麻黄汤过发其汗，后果难测，所以王合三先生特别指出，“此条最宜细认，不然，则杀人如反掌矣”。正如柯韵伯所言：“凡太阳发汗太过，则转属阳明，不及则转属少阳。此虽寒热往来，而头项强痛未罢，是太阳之表尚

在，故仍在太阳。夫疟因暑邪久留而内着于膜原，故发作有时，日不再作。此因风邪泊于营卫，动静无常，故一日再发，或三度发耳。邪气稽留于皮毛肌肉之间，固非桂枝汤之可解，已经汗过，又不宜麻黄汤之峻攻，故取桂枝汤三分之二，麻黄汤三分之一，合而服之，再解其肌，微开其表，审发汗于不发之中。”

治往来寒热，用小柴胡汤加减，取效亦捷。张仲景《伤寒论》第101条曰：“有柴胡证，但见一证便是，不必悉具。”临床运用很有参考价值。曾诊一患者张某，女，38岁，厨师，汉族。自诉恶寒发热已7天，病因不明，在工作时突然周身发冷，手不能摄物，全身无力。自服西药，未见效果。之后全身发冷，心中颤抖，眼睁不开，欲寐。如此间日一作。近三天每于中午开饭前后发作，先寒后热，心烦，夜间常失眠多梦。患者精神尚可，面色如常，脉沉弱无力，舌质红，舌苔白。分析：患者起病突然，病因不明，“从症求因”，其主症为先寒后热，寒热往来，间日发作，日晡益甚，为邪在膜原之征。至于目闭不睁，心烦颤抖，欲寐，为正虚邪盛，影响心肝。应治其本，使邪从膜原一解，诸症可愈。故以小柴胡汤和解少阳，合达原散驱除膜原之邪，两方随证加减，用柴胡9克，黄芩9克，党参9克，槟榔9克，厚朴9克，知母12克，草果9克，常山6克，甘草6克，水煎服。上方连服3剂，恶寒发热减轻，头痛、身困、不寐未除，右脉沉弱，舌质稍红，舌苔白。照上方加细辛6克，川芎9克，水煎服。连服3剂，恶寒发热、头痛均愈。尚有视物不清，头晕，脉弱无力，舌质红，苔白。改用明目地黄丸巩固疗效，月余后随访病愈。

有发病即见恶寒发热、寒热往来、日晡发热益甚、脉浮数者，常遵吴又可达原散加减治愈；也有因风热表证，治不得法，或延误时日，病邪由表入里，见以上脉症者，也可用本法治疗。如寒热往来，而热不甚者（不超过38℃），方中必用柴胡、黄芩；高热不退，口渴，脉洪大者，可重用生石膏、知母，配山药护胃（有粳米更好）；寒热往来，间日一作者，加常山6克（量多易发生呕吐）；若兼见咽喉肿痛者，加大青叶、生地、元参。此遵仲景方法，不泥仲景之药也。吴又可亦如此也，故吴氏当为仲景之功

臣也。

（选自《中国百年百名中医临床家丛书·王合三》，中国中医药出版社2001年版，13~16页）

论瘟疫邪入膜原

战汗三步曲

太阳病，久失治，必先战栗，汗出而解，此言战汗之情形也。脉阴阳俱停，即脉伏也。盖服药之后，久居之病邪，与药发生激烈战斗，久之邪不胜正，驱之于体外，故始而脉停，继而战栗，终而汗出，此战汗时一定之步骤。然所服之药，亦不必尽属汗剂，亦有服下剂而发战汗者，观吴又可《温疫论》可知也。下后而发战汗，盖邪由表入里，凝结固滞，或阳明内实，使汗不能透彻，邪亦不出者，往往里气一通，邪遂透表，此症瘟疫发疹发斑最多，不可不知。

按语：战汗是一个症状，不是一个病，是多种疾病在特定条件下，正邪交争，正胜于邪，病人自觉“战栗”汗出的一种病症。战汗一症，太阳伤寒见之，温病、瘟疫亦见之。病邪在表者见之，病邪在里者亦见之。服药后助正杀邪，“与药发生激烈之战斗”、战汗出病解者见之，不服药而正气恢复，战栗汗出病愈者亦见之。战汗是邪与汗并出的一种反应，多视为疾病康复之佳兆，但亦不能忽视潜在之危症。故必须详细询问病史，了解既往治疗情况，认真观察病情变化和进食情况，有无失治、误治，做到心中有数，正确治疗。所谓战汗三步曲，乃王合三先生所言：“始而脉停”一步矣，“继而战栗”二步矣，“终而汗出”三步矣。此乃先生对疾病长期观察，得出的经验。战汗未出现之前，病人最早在脉象上反映出“始而脉停”；战汗既作之时，正邪交战激烈，“继而战栗”随之第三步“终而汗出”，宣告一次“战役”取得胜利。是否会发生再一次的“战争”，还要看邪气是否彻底被歼灭。这“始而脉停、继而战栗、终而汗出”，简单的12个字，清晰地道出战汗的全过

程。下面再看战汗发生在伤寒、温病中的情况。仲景曰：太阳病未解，脉阴阳俱停，必先振栗汗出乃解。但阳脉微者，先汗出而解；但阴脉微者，下之而解。太阳病之所以未从表解，可因失治、治疗不当或未治等，症见头痛、恶寒或发热，脉当浮而反见“阴阳俱停”。此“停”字，虽然是“停止”之“停”，其意则应是潜伏，“即脉伏也”。伏脉法地，如石投水，是正邪抗争激烈之反应，预示战汗来临。由于气血未乱，阴阳尚平，抗邪能力未衰，故“必先振栗汗出乃解”。如单见邪尚在表，随其表实、表虚，用麻桂，除邪扶正战汗病愈。若因邪气从表入里，“凝结固滞”，或因阳明“胃家实”，邪气不能从表而解，可用三承气法，使“里气一通，邪遂透表”，战汗而解。至于温邪，常有二种情况。其一，可战汗病愈。一待正复，与温热之邪交争，正胜于邪，战汗病解。其二，医生详加辨证，用药驱邪扶正，达到战汗之目的。王合三先生说：“温邪不传心胞，始终在气分流连……则战汗之希望，是在医生之权衡耳。”未战汗之因，乃津液暗耗，不能作汗，治当益胃，如增液汤、五汁饮，“阴液既充，邪亦混合其内，血活动，而邪亦活动……则腠理开，邪汗一并而出矣。然此是人为的，非天然的”。有战汗一次病即痊愈者，有战汗未愈者，可再次战汗，至愈为度。战汗之后，还须细心观察，脉症合参，以判断是属病愈或成脱证。叶天士曰：“盖战汗而解，邪退正虚，阳从汗泄，故渐肤冷，未必即成脱证，此时宜令病者安舒静卧，以养阳气来复，旁人切勿惊惶，频频呼唤，扰其元神，使其烦躁。但诊其脉，若虚软和缓，虽蜷卧不语，汗出肤冷，却非脱证；若脉急疾，躁扰不卧，肤冷汗出，便为气脱之证矣。更有邪盛正虚，不能一战而解，停一二日再战汗而愈者，不可不知。”但亦有只战不汗出者，其因有三：一是正气虽复，邪热不减，虽有欲战之势，未能邪汗并出，可扶正祛邪，战汗出即可；二因邪热流连，津液暗耗，用益胃法治疗后，较之以往，抗邪力增，但仍不能胜邪，虽战无汗，当再益胃，胃气和，津液足，不愁战汗不解矣。三因邪胜正虚，虽正邪交争，但战而邪不却，随即发生变症，宜急当救治，或可不死。吴又可曰：“疫邪先传表，后传里，忽得战汗，经气输泄，当即脉静身冷，烦渴顿除，

三五日阳气渐积，不待饮食劳碌，或有反复者，盖表邪已解，里邪未去，才觉发热，下之即解。疫邪表里分传，里气壅闭，非汗下不可，汗下之未尽，日后复热，当复下复汗。瘟疫下后，烦渴减，腹满去，或思饮食而知味，里气和也。身热未除，脉近浮，此邪气怫郁于经，表未解也，当得汗解。如未得汗，以柴胡清燥汤（柴胡、黄芩、陈皮、甘草、花粉、知母，姜枣引，水煎服）和之，复不得汗者，从渐解也。不可苛求其汗。应下失下，气消血耗，既下欲作战汗，但战而不汗者危，以中气亏微，但能降陷，不能升发也。次日当期复战，厥回汗出者生，厥不回汗不出者死，以正气脱，不胜邪也。战而厥回无汗者，真阳尚在，表气枯涸也，可使渐愈。凡战而不复，忽痉者必死。痉者身如尸，牙关紧，目上视。凡战不可扰动，但可温覆，扰动则战必中止，次日当期复战，战汗后复下后，越二三日反腹痛不止者，欲作滞下也。无论已见积未见积，宜芍药汤（白芍一钱，当归一钱，槟榔二钱，厚朴一钱，甘草七分，生姜一斤，水煎服。里急后重加大黄三钱）。”瘟疫战汗亦变化多端，不仅注重辨证论治，必须认真观察，随证治之。切忌粗心大意，误治、失治，后患无穷。曾诊治患者刘某，女，汉族，34岁，工人。自诉：头痛欲吐，周身痛如跳脓状已四五天。病史：初因脱衣受凉，随即感觉肌肉疼痛，又外出淋雨，周身不适。至昨天下午病情转重，心中迷糊不清，全身肌肉疼痛，头痛欲吐，睡眠不熟，恶寒发热（体温 38°C 以上），寒热往来，日晡发热益甚，全身无力，欲吐不出，呼吸气短，急来诊治。检查：表情痛苦，倦困乏力，呼吸气促，尺肤热，体温 38.5°C ，舌质淡，舌苔薄白。诊断：瘟疫邪入膜原。辨证：初因减衣受凉，已见肌肉疼痛，风寒侵表之兆，又淋雨受寒，故恶寒发热，寒热往来，日晡发热益甚，系邪从太阳转入少阳，故倦困乏力，头身疼痛，不寐、欲吐等，应拟清热和胃。吴又可曰：“瘟疫初起，先憎寒而后发热，嗣后但热而不憎寒也。初得之二三日，其脉不浮不沉而数，昼夜发热，日晡益甚，头疼身痛。其时邪在伏膺之前，肠胃之后，虽有头痛身痛，此邪热浮越于经，不可认为伤寒表证，辄用麻黄桂枝之类，强发其汗，此邪不在经，汗之徒伤卫气，热亦不减；又不可下，此邪不在里，下

之徒伤胃气，其渴愈甚。宜达原散主之。”用药：柴胡9克，黄芩9克，知母9克，槟榔9克，厚朴9克，草果9克，白芷9克，生石膏15克，山药9克，甘草6克，水煎服。上药先服3剂，战汗出热减，诸症渐减。又服3剂，汗出热退身凉而痊愈。

（选自《中国百年百名中医临床家丛书·王合三》，中国中医药出版社2001年版，16~19页）

论治伏气温病

误汗口伤烂赤治愈医案

伤寒一二日至四五日，而始见厥，其为热厥明矣。热厥为里热太过，血管中之水分缺乏，血行不利，使阴阳不相顺接，当其未厥之先，则必发热，是厥之寒热，当于未厥之先，细细留意，所以先热者后必厥，可见厥由于热，若仅以辛温之药发其汗，以热济热，再夺血管中之水分，轻则口伤烂赤，重则亡阴而死。

癸丑年，友人郝又甫患感，盖伏气温病也。余治之，屡以犀角地黄汤大剂投之，斑已见苗矣，然尚未见厥。后延时医，王某诊之曰：“中指发冷，温疹未透也。”一剂荆防，遂口伤烂赤，登高发狂。后用大剂下药与养阴之剂，始庆更生，然已百日之久矣。故厥深热亦深，厥微热亦微，热厥应下。

按语：仲景在《伤寒论》第335条中详细讲述了热厥的临床表现及热与厥的关系，他说：“伤寒一二日至四五日而厥者，必发热，前热者后必厥，厥深者热亦深，厥微者热亦微。”如何治疗“热厥”？仲景只讲“法”不出方。先生治愈此病案不足百字，但对伏气温病之治法，误治之原因，误治后之变证，又如何将病治愈，记录十分清楚，愚略加分析：

①何谓伏气温病？《素问·金匱真言论》曰：“夫精者，身之本也。故藏于精者，春不病温。”王合三先生注曰：“伏气温病是由冬不藏精，冬伤于寒，伏气所发而致。凡是热由内发者，皆以温病括之矣。”感而后发者，称伏气温病。

②伏邪温病，邪在营血的治法：此案先生“屡以犀角地黄汤大剂投入”，即知温病人营矣。“大凡治病，必先虑邪之出路，然后可水到渠成。邪方入营，不能逐之，必使委委曲曲，达出皮毛，方为正治，故用犀角、羚羊、元参……”服药之后，效果显然，故“斑已见苗矣，尚未见厥”。由于内热得到控制，避免了仲景指出的“厥深者热亦深，厥微者热亦微”的病重现象。“斑已见苗”也是病邪得到控制，正气战胜邪气之佳兆。王合三先生在其注疏的《温热论》中曰：“津液足，则邪仍透皮毛而解，往往斑出……此即透热转气之明证也。”

③误治之缘由：经先生治疗后，病势减轻，向愈之时，改请时医王某诊治。王某既知“温疹未透”，又用辛温发表之法，助温热之邪迫汗伤津，只服“一剂荆防，遂口伤烂赤，登高发狂”，犯仲景“一逆尚引日，再逆促命期”之戒。

④先生用何法转危为安？先生遵仲景法，活用仲景方药，“后用大剂下药与养阴之剂”。大剂下药，乃大承气汤（大黄、芒硝、枳实、厚朴）矣。再佐以养阴之剂，如增液汤方（元参、麦冬、生地）、益胃汤（沙参、麦冬、生地、玉竹、冰糖），服后很快取效，使病人从危转安，“始庆更生，然已百日之久矣”。赠王合三先生“妙手回春”不愧矣。

（选自《中国百年百名中医临床家丛书·王合三》，中国中医药出版社2001年版，5~6页）

论治风热感冒医案

伤寒温病“变统”论治

营卫气血，乃病邪侵入一定之道路，伤寒如是，温病亦何尝不如是，其所以不同者，惟在于治法耳。外感温病与外感伤寒，似为一病，特因时期之不同，名目亦异。在冬曰伤寒，在春曰温病。伤寒用辛温，温病用辛凉。叶天士治外感温病，首推葱豉汤。葱豉汤，辛温药也。鞠通银翘散，其中之芥穗、豆豉，皆辛温药。而

四川张氏，犹嫌其过凉，每加生麻绒，效如桴鼓。章氏虚谷，亦疑一味辛凉之不足恃也。时无彻底知识，暗将辛凉改为辛平，反遭孟英之呵。陆九芝谓：温病在中焦，不在上焦，盖知伏气温乃温病，外感温病，决非温病，确有见地。惜我国治病无精密之分析法，特不知首先犯肺之温邪与太阳伤寒之病菌是否一样，将来解决于显微镜之下，则一切疑团，皆迎刃而解矣。

按语：从仲景《伤寒论》之后，温病学术兴起之日，即伤寒与温病争论之始，一直延续至今。对伤寒、温病的认识日趋一致，特别是随着现代科学技术的不断发展，从宏观到微观的认识，在中西医之间逐渐统一，这是非常可喜的现象。伤寒多发于冬季，但也可有温病发生。温病多发于春季，伤寒春季也可见到，西医称为流行性感，这本来是无需争议的事，确由于种种原因争论至今，或许还要争论下去。《素问·评热病论》篇曰“邪之所凑，其气必虚”，就是指的这种情况。即使在同样的环境中，由于年龄、性别、体质的强弱等不同，其结果也可完全不同。《灵枢·五变》篇曰：“一时遇风，同时得病，其病各异……论以比匠人，匠人磨斧斤斫刀，削斫材木，木之阴阳，尚有坚脆，坚者不入，脆者皮弛，至其交节，而缺斤斧焉。夫一木之中，坚脆不同，坚者则刚，脆者易伤，况其材木之不同，皮之厚薄，汁之多少，而各异耶。夫木之早花先生叶者，遇春霜烈风，则花落而叶萎；久曝大旱，则脆木薄皮者，枝条汁少而叶萎；久阴淫雨，则薄皮多汁者，皮溃而漉；卒风暴起，则刚脆之木，枝折机伤；秋霜疾风，则刚脆之木，根摇而叶落。凡此五者，各有所伤，况于人乎！”说明起决定因素的是人体正气是否充足，其次才是病邪的侵入。《灵枢·百病始生》篇曰：“风雨寒热不得虚，邪不能独伤人。卒然逢疾风暴雨而不病者，盖无虚，故邪不能独伤人。”人虽然同处于一个环境之中，但其“虚”各不相同，故有病有不病者，虽病而各不相同，其愈之快慢，安危夭亡也各异。从这简明朴素之理中很易理解有病伤寒、有不病伤寒、有病温病、有不病温病之道理。王合三先生唯恐后人不理解他对伤寒、温病的这种看法，感叹地指出：“惜我国治病，无精密之分析法（认识致病菌的医疗设备），特不知首先犯肺之温

邪与太阳伤寒之病菌，是否一样，将来解决于显微镜之下，则一切疑团，皆迎刃而解矣。”科学发展至今天，总算有了一个比较满意的结果。流行性感胃是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病，病原体为甲、乙、丙三型流行性感胃病毒，通过飞沫传播……流感病毒，尤以甲型极易变异，往往暴发大流行。在这些流感病人中，症状因人而异，如表现太阳伤寒症状，治用麻黄汤，表现太阳中风者，用桂枝汤，此辛温解表法也。若表现不恶寒，但发热而渴，是太阳温病，则禁用辛温法，当用辛凉法，并随其表现不同，选用银翘散、桑菊饮等方。若见大热、大汗出、大烦渴、脉洪大四大症状者，用白虎汤。若见痞、满、燥、实、坚之阳明腑实证，定用大承气汤。在临证中春见温病者多，见伤寒者少，冬见伤寒者多，见温病者少，在流感暴发人群中，病症大多相似，但有轻重等差异，治疗既遵仲景之法，用仲景之方，也用叶天士、吴鞠通、吴又可诸家之经验，灵活加减变通。

现举一风热感冒 2 剂治愈医案。袁某，女，37 岁，工人。自诉：发热、恶寒、头痛已 3 天。病史：开始因外出受风，随即恶寒发热，头身疼痛，全身困乏无力，鼻塞流涕，双侧鼻孔充血发红，咳嗽，吐痰呈泡沫样，咽喉疼痛，声音嘶哑，饮食减少，时有暖气，大便稀溏，每日一次，因咳嗽频作致胸腹肌肉疼痛。检查：精神疲倦，言语少力，声音嘶哑，面色微红，鼻塞流涕，鼻孔和咽喉充血发红，脉象浮数有力，舌质红，舌苔薄白。诊断：风热感冒。辨证：恶寒发热，头身疼痛，舌质红，苔薄白，脉浮数有力，系风热侵犯肌表；鼻塞流涕，咳嗽吐痰，声音嘶哑，咽喉肿痛，为邪热入肺；饮食减少，暖气为胃失和降。拟解表清热，滋阴和胃。药用：金银花 30 克，连翘 12 克，竹叶 9 克，薄荷 9 克，荆芥 9 克，元参 12 克，麦冬 12 克，丹皮 9 克，杏仁 9 克，葶苈子 15 克，陈皮 9 克，黄芩 9 克，大青叶 30 克，甘草 6 克，水煎服。治疗经过：患者服上药 1 剂减轻，2 剂痊愈。按：肺与胃二个脏腑有病，可相互影响。肺有病可影响及胃，胃有病可影响及肺，治疗也应兼顾。陈修园治肺疾强调“肺最重，胃非轻”，实属经验之谈。临诊必须全面观察，抓住主要矛盾，再随兼证而治之；多可迅速获愈，切忌

顾此失彼也。

(选自《中国百年百名中医临床家丛书·王合三》，中国中医药出版社2001年版，113~116页)

论治流行性感冒

此菌在各种病菌中，较为短小，多在病人鼻涕痰涎之中，乃1892年普淮飞所发现，近人谓此病并非细菌，乃一种显微镜不能见之物质，此说赞成者不多，尚难证实。除气管有轻微发炎外，别无特别之显著之病理改变，若有并发症者，不在此限。本病之潜伏，一日至三日。其症状为发热恶寒，流鼻涕，目红肿，或衄血，身痛，头痛，或咽痛，然与本病并发者，有兼消化系者，有兼神经系者。兼消化系者：如中医所谓太阳与阳明合病必下利或呕是也。兼神经系者：如《伤寒论》中表邪不解而谵语是也。中西医对本病之治疗，皆以发汗为主治，而中医之治法，尤有一定之步骤，总以解表为主。桂枝汤：桂枝三钱，白芍二钱，甘草钱半，生姜一钱，大枣五枚。麻黄汤：麻黄二钱，桂枝三钱，杏仁二钱，甘草一钱。麻杏石甘汤，方见前白喉病内。九味羌活汤：羌活钱半，防风钱半，苍术钱半，白芷一钱，川芎一钱，黄芩一钱，生地一钱，甘草一钱，细辛五分。加生姜、葱白煎。银翘散：连翘三钱，银花三钱，桔梗二钱，薄荷二钱，竹叶一钱，甘草一钱半，芥穗一钱，豆豉钱半，牛蒡子二钱，苇根二钱。葱豉汤：葱白、香豉、童便，水煎日三服。预防方法：注意身中体温，常保持三十七度半。流行性感冒与寻常之感冒不同，寻常之感冒，不过鼻塞声重，轻微咳嗽，如《温病条辨》中之桑菊证。若流行性感冒，则必发热恶寒，头痛，身痛，富有传染性。

按语：流行性感冒是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病。其病毒由飞沫传播，有甲、乙、丙三型。尤以甲型流感病毒极易变异，往往造成大流行。仲景在描述当时伤寒病流行时曰：“余宗族素多，向余二百，建安纪年以来，犹未十年，其死亡者，三分有二，伤寒十居其七，感往昔之沦丧，伤横天之莫救。”可见当时伤

寒流行的情景。吴又可可在其《温疫论·序》中对当时温疫流行及其惨景和医生缺乏治疗经验时说：“投剂不效，医者彷徨无措，病者日近危笃，病愈急，投药愈乱，不死于病，乃死于医，不死于医，乃死于圣经之遗亡也。”温疫流行常波及数省，曰：“崇祯辛巳，疫气流行，山东、浙省、南北两直，感之尤多，至五六月益甚，或至阖门传染。始发之际，时师误以伤寒法治之，未尝见其不殆也。或病家误听七日当自愈，不尔十四日必瘳，因而失治，有不及期而死者；或有妄用峻剂、攻补失序而死者；或遇医家见解不到，心凝胆怯，以急病用缓药，虽不即受其害，然迁延而致死，比比皆是。所感之轻者，尚可侥幸，感之重者，更加失治，枉死不可胜计……余虽固陋，静心穷理，格其所感之气，所入之门，所受之处及其传变之体，平日所用历验方法，详述于后，以俟高时者正之。”从汉代仲景《伤寒论》到明代吴又可《温疫论》、清代吴鞠通《温病条辨》及叶天士、王孟英、余师愚等温病学家的著作，都是在不同时期、不同情况下传染病流行时总结的治疗经验，流行性感胃定在其中，又因流感病毒有甲、乙、丙等类型，再加之甲型流感病毒极易变异等特点，单用一方一药，或仅遵一家之言，是不能解决好不同病毒及其变异后致病情况的，因此，应当像王合三先生那样，加强中西医学习，不断总结出新的治疗经验和方法，把仲景、叶天士、吴又可等医家理论及其治疗独到经验和现代医学研究成果紧密结合，随着流感病毒的变化而变化用药，做好预防，及时治疗，减少蔓延和流感的暴发，尽早尽快使现证病人康复。王合三先生综合各家之长，结合中西医理论和自己的经验，选出行之有效的治疗方药。如流感伤人出现太阳中风证，用桂枝汤；出现太阳伤寒证，用麻黄汤；若见风寒湿邪袭表，兼见内热者，选用张元素九味羌活汤；或因湿邪为患侵及肌表，用辛凉解表，选用银翘散、桑菊饮等。随证加减治之。

（选自《中国百年百名中医临床家丛书·王合三》，中国中医药出版社2001年版，300~302页）

王伯岳

论治小儿感冒

小儿感冒，是儿科常见的一种外感性疾病，病在肌表，属于表证。由于小儿腠理嫩弱，抵抗力不足，一遇气候变化，稍有不慎，即会因寒温失宜，而为外邪所侵，因此，小儿感冒一年四季都很容易发生，但以冬春季节最为常见。

小儿感冒须辨风寒风热与夹食

先师强调，小儿脏腑未充，肺尤娇嫩，不耐寒热之邪所侵。无论受寒受热，皆能引起感冒。但因病因的不同，病证也有所不同，故小儿感冒，首先应当辨清寒热。

感冒有风寒、风热之分。风寒感冒，以发热、无汗为主，在发热前或发热的同时，有恶寒现象。小儿感冒后出现“汗毛立”，即是恶寒的表现。风热感冒，表现为发热，头身或手足心有汗，恶风，恶寒轻或不恶寒。

风寒感冒和风热感冒的主要区别在于：

风寒恶寒，风热恶风；

风寒无汗，风热有汗；

风寒面白、唇青，风热面赤、唇红；

风寒汗毛立，风热多烦躁；

风寒口不甚渴，风热口渴喜饮；

风寒小便清长，风热小便短赤；

风寒脉浮紧，风热脉浮数；

风寒多头痛、身痛，风热但头痛，身不痛；

风寒手足指末梢微冷，风热手背发热，手足心有微汗。

先师认为，寒与热可以同时出现，但有所偏胜，有的寒多于

热，有的热多于寒。寒与热也可以互相转化，但因小儿为“纯阳”之体，“阳常有余”，所以患病往往热多于寒，纵使感冒风寒，亦多寒从热化，或见寒热并存。故小儿感冒多呈寒热夹杂之证。

先师还说，凡是感冒，一般都要出现发热、喷嚏、鼻塞等症，而重点是发热。同样是表热，可以因偏寒偏热的不同，临床可有不同的表现，医生可根据其不同的临床表现来分辨是寒是热，这是辨证的重要环节。寒热既清，还应进一步考虑有无其他原因，以及兼证。

如小儿感冒亦常由于因时、因地、因人的不同，病情也有差异。如风寒感冒多见于冬季，风热感冒四时皆有，而多见于夏秋或春初；又南方多风热，北方多风寒；小儿感冒风热多于风寒，体弱小儿更容易经常反复感冒。因此，不同的季节，不同的地区，不同的体质，在临床辨证时都须详细审慎。

又如有的小儿经常伴有消化不良，饮食积滞，此类小儿脾胃素虚，肺卫不固，故亦容易感冒，也即群众所习称之“停食着凉”。这类情况，已不是单纯的表证，而是兼有里证，也就是小儿常见的夹食感冒。这也是临床上应当注意分辨的。

辨治感冒多取辛温辛凉两并用

先师说，感冒属于表证，表证自当运用解表法。解表法主要是指汗法，即是通过发汗，使表邪由汗而解。小儿风寒感冒，见汗而热易解，故宜以辛温解表为治。风热感冒，见汗而热不易解，故宜以辛凉解表为治。

辛温解表与辛凉解表仅是一般习用而且有效的治疗方法，但是治疗小儿感冒，并不局限于一个汗法，而且在汗法的运用上也需要慎重。

小儿“易虚易实”，无论是风寒感冒，还是风热感冒，发汗都不宜太过，剂量也不宜过大。过汗容易使津液受伤，反而引起其他变化。

小儿“易寒易热”，又往往热多于寒，一经感冒，很容易寒从热化，或热为寒闭，形成寒热夹杂之证。

鉴于小儿的这些病理方面的特点，单独用辛凉解表，往往汗出不透，单独用辛温解表，又往往汗出而热不解。因此，针对这种情况，在临床上常常采用辛温辛凉并用，从而使风寒、风热两解。

先师指出，辛温辛凉并用法在具体运用时并不一定要“平分秋色”，而是应根据具体情况，随其寒热之偏胜不同而选方用药。如寒邪偏重，则辛温重于辛凉，如热邪偏重，则辛凉重于辛温。

如治疗风寒感冒，常用辛温为主的荆防葱豉汤。然方中除用荆芥、防风、苏叶、羌活、白芷、葱白等辛温解表药外，还加用薄荷、豆豉、黄芩、竹叶等辛凉解表、苦寒清热和辛淡、甘寒之品。而治疗风热外感常用辛凉为主的加减银翘散，方中除用金银花、连翘、牛蒡子、黄芩、大青叶、薄荷、豆豉等辛凉解表、苦寒清热或辛淡、甘寒之药外，还每加用荆芥、防风等辛温之品；即使对于高热、寒战、头痛较剧、周身酸痛、咽红肿痛的流行性感冒，在习用的银翘解毒汤中除用金银花、连翘、菊花、薄荷、生石膏、知母、山栀、公英、黄芩清热解毒药外，也总要加用荆芥、羌活等辛温解表之品，以避免过用寒凉使邪气冰伏不解。

病例1：艾某，男，7个月。1980年5月19日就诊。患儿发热，微咳，有汗不多，鼻流清涕，曾由家长自予阿鲁片、感冒冲剂、至宝锭等药，症犹未减。今晨起又增目眦红痒，口角流涎，体温仍39℃。查扁桃体Ⅰ度红肿，舌苔白。证属外感风邪，上犯心肺，治宜祛风邪以解表，清心肺以退热。处方：

荆芥穗6克，羌活6克，板蓝根6克，牛蒡子9克，防风6克，黄芩9克，炒知母6克，淡豆豉6克，神曲9克，桔梗9克，杏仁泥6克，淡竹叶6克，生甘草3克。

服上药三剂，诸症悉除。

按：热为风邪犯表，咳为风邪袭肺。“风胜则痒”，目眦红痒亦为风邪上泛，心经有热之象。口角流涎当责之心胃积热。故此，治宜解表退热为主，辛温辛凉并用。解表用羌活、防风、芥穗之类，较之桑菊更易速效。退热则用板蓝根、牛蒡子、黄芩、知母、竹叶诸药双清心肺，加之桔梗、杏仁宣利肺气，神曲兼护胃气，诸症悉顾，又有侧重，故服后效若桴鼓。

夹食感冒尤宜发表和里须双解

先师治疗“停食着凉”的小儿夹食感冒，尤其善用表里双解法。他常说，小儿素有食积者，极易罹患外感。感冒与消化不良相伴，外有风邪袭表，内有乳食内伤，形成表里同病局面，其治必须于解表的同时，助以消导。如若食积化热，还当在配合消法的同时，注意使用清法。对于体质素弱，抵抗力低下的小儿，不宜过于发表，而应运用和解法。这种在使用汗法的基础上，根据不同情况，适当配合消法、清法或和法的治疗方法，就是先师常用的表里双解法。

表里双解法，在临床具体运用时，也要根据不同病情随证施治。如针对风寒感冒或风热感冒而伴有消化不良的夹食感冒，可分别于治疗风寒感冒和风热感冒的处方中加入枳壳、焦三仙等；如属表里俱热，伴有恶心，呕吐，腹痛，或腹泻、发热不退，口渴喜饮等胃肠症状比较明显者，则可选用表里双解的藿香散加减：

藿香6克，紫苏6克，葛根6克，黄芩6克，连翘6克，焦三仙各6克，淡竹叶6克，陈皮6克，甘草3克。

由于小儿病的合并症较多，因此临证时，必须根据不同兼证有所加减。

如恶寒，无汗，加葱白二节，生姜二片；

有汗，口渴，加生石膏24克，知母6克；

头痛较甚，加羌活6克，白芷6克；

咽红肿痛，加板蓝根9克，大青叶9克，锦灯笼6克；

惊掣不安者，可加钩藤6克，蝉蜕6克。

病例1：隋某，男，1岁3个月。1980年7月14日就诊。患儿发热，有汗，流涕，咳嗽以夜间为甚。纳呆食少，腹胀便溏，两手心热。舌苔薄黄而腻。证属外感风邪，内伤乳食，积而化热，肺失清肃。治宜疏风解表，消食和里，兼清积热。处方：

杏仁6克，紫苏6克，荆芥穗6克，桔梗9克，大腹皮6克，黄芩9克，云茯苓9克，前胡6克，知母6克，枇杷叶9克，炒三仙各6克，甘草3克。

服药三剂，热退，咳止，大便成形，乳食见增，继以白术散方三剂，调理而愈。

病例2：张某，女，1岁。门诊号231543。1981年5月11日就诊。患儿发热三天，热虽退而未尽，仍流清涕，食欲不振，时有恶心，夜寐不安。咽红，右侧扁桃体Ⅱ度肿大，舌苔白。证属表未尽解，胃气不和。治以疏解余邪，清肺胃之热，佐以和脾为法。处方：

藿香6克，苏梗6克，连翘9克，牛蒡子6克，菊花9克，桑叶9克，黄芩6克，焦三仙各6克，云茯苓9克，半夏6克，陈皮6克，竹茹6克，淡竹叶6克，甘草3克。

服上药四剂，热除，纳增，泛恶亦止，夜寐已安。

按：此二例均属表里兼病，既有外感在表之风邪，又有乳食所伤，脾胃不和之表现。唯前例有脾运不健而便溏之证，故其治取疏风解表而兼和脾升提；后例则以胃气不和为主，故其治重在疏解余邪而和胃降逆。

（选自《中国百年百名中医临床家丛书·王伯岳》，中国中医药出版社2001年版，7~12页）

甘均权

治春温误汗变证案

欧某，男，8岁，1948年春季就诊。

患春温时病，前医误诊为伤寒，用荆防败毒散加减，一剂得汗，身热稍退，再剂与服，热灼如焚，烦躁，口渴，唇焦，舌燥，便秘，继则神昏抽搐，急来商洽于余。诊之其脉弦数有力，视其舌尖边绛，苔黄燥而无津。诊为春温误汗之变证。原为太阳温病，因误汗劫液，邪热不解，由表入里，热闭心包，引动肝风所致。急用凉膈散加减：大黄、朴硝各4.5克，栀子、黄芩各15克，连翘、干地黄、麦门冬各12克，菊花9克，甘草、薄荷、竹叶各6克，羚羊角3克，加安宫牛黄丸1粒。服上方1剂后，身热退，神识清，抽搐止，惟津液未回，唇舌尚燥，用干地黄、麦冬、菊花、羚羊角、竹叶、沙参、石斛，连服3剂，转危为安。

按：本案病在春天，初起恶寒轻，发热重，原为温病，前医不察，误为伤寒，一汗再汗，身变灼热如焚，烦躁便秘，口渴，乃误用辛温发汗化燥之品；继则神昏抽搐，尤为劫液动风之候。仲景示证而不出方，余参照后贤用清热泻火熄风之法，并以甘寒善后，故能转危为安。

（选自《广西老中医医案选·春温误汗变证》，广西卫生厅中医处，广西中医学会编，1987年，4页）

治春温邪陷少阴案

宋某，男，20岁，已婚。1963年春季就诊。

平素阴亏，因患急性热病，初则头痛，恶寒，咳嗽。服银翘散加减多剂，头痛恶寒、咳嗽已除，但仍发热无汗，且增烦躁、谵

妄、渴饮而就医。初用双解散，后用白虎汤数剂无效，乃远来求余出诊。诊见面赤，唇红焦裂，舌绛无苔，手足微冷，胸腹灼热，肌肤甲错，大便色黑，时溏时结，小便短赤而热，渴饮不多，手足心热，甚于手背，呻吟不休，间有谵妄烦躁，神志模糊，语言不清，日轻夜重，脉虚数无力。按其发病季节及症状表现，断为春温。由新感引动伏邪之证，现新感已解，伏于少阴之邪，清之不去，透之不出，但阴液仍未枯竭，尚冀滋阴战汗而解。拟复脉汤加减为治：炙甘草 12 克，干地黄、山药、白芍各 18 克，阿胶、沙参、黑芝麻各 9 克，麦门冬 15 克，大枣 6 枚。水煎热饮，温覆。并嘱其家人：“今晚如见病人战栗微汗出而身和，是邪去正安的现象，可让病人充分休息，使其元气渐复，不必惊扰。”

翌日复诊：谓昨夜服上药，得战汗后而热退神清，安睡达旦。诊之脉静身和，惟有气虚弱，阴分仍亏。再以三才复脉汤加鸡子黄等品，调理半月而愈。

按：“冬不藏精，春必病温。”这就是说，肾阴虚的人一受外邪易发温病。此案所谓新感引动伏邪，正是肾阴先亏，春感温热，不能鼓邪外达，故汗之不解，清之不去，透之不出，邪郁少阴，阴液虽伤但未至竭，古有“滋阴战汗而解之法”，余拟复脉汤加减热服，温覆，得战汗随解者，实即扶正托邪之义也。

〔选自《广西老中医医案选·春温邪陷少阴》，广西卫生厅中医处，广西中医学会编（1987 年），4~5 页〕

叶鉴清

春温发痧案

病者：杨左，年三十余，宁波人。

病名：春温发痧。

原因：邪陷入胃，化火劫津，致热蒸发痧。

证候：温邪已逾一候，身不恶寒，蒸蒸发热，痧如锦纹，头面胸背四肢均有，色尚红活，大渴饮冷，头额汗多，烦躁气闷，甚则神昏谵语，溺赤如血，便闭三日，舌干绛，根苔黑，唇焦，前板齿燥。

诊断：脉来右洪数，左弦数。脉症合参，显是阳明热盛之候，上蒸包络，则时有谵语，熏蒸肌表，则灼热发痧，邪势方张，津液已伤，诚恐骤变痉厥，勿谓言之不豫也。

疗法：阳明经腑气血皆热，故用膏、知、地、斛双清气血生津救液为君，大青叶、生草化痧解毒为臣，竹叶清泄膈上之热，茅根清宣血分之热，玄参专泻浮游之火，味咸色黑，且能养阴，以清心肾之热，合银翘清解为佐使。服一剂。

处方：生石膏二两，鲜生地二两，生甘草一钱，大青叶三钱，大竹叶三钱，连翘四钱，肥知母四钱，鲜石斛八钱，润玄参四钱，金银花四钱，茅根肉五扎（去心衣）。

二诊：热灼较和，赤痧更多，昨夜谵语较少，寐亦稍安。醒后烦闷渴饮尚甚，舌根黑苔已化，干绛无津，唇焦便闭，溺赤茎痛，种种火盛劫津之象，未见少减。病已九日，右脉洪数，左脉弦数，仍防昏痉变端。再以大剂生津清热法治。

二方：生石膏二两，鲜生地二两，生甘草一钱，大青叶三钱，净连翘四钱，肥知母三钱，鲜石斛三钱，肥玄参四钱，天花粉四钱，金银花四钱，茅根肉五扎（去心衣），鲜竹叶三钱，黑犀角四

分（磨冲）。

另用鲜石斛三钱炖汤代茶。

三诊：热势渐减，赤斑渐淡，有汗津津，谵语已止，舌绛有液，脉来洪数稍静，烦闷渴饮尚甚，大便未行，小溲赤痛，邪恋阳明，慎防昏痉变端。守原法治疗。

三方：生石膏一两五钱，鲜石斛八钱，京玄参四钱，净连翘四钱，焦山栀三钱，鲜生地一两五钱，生草梢一钱，天花粉四钱，金银花四钱，竹叶心三钱，茅根肉五扎（去心），灯心三扎，犀角三分（磨冲）。

另炖鲜石斛代茶。

四诊：斑渐回，热较退，烦躁、气闷、渴饮等亦有减无增，夜寐较安，谵语不作，脉右尚形浮数，左弦数，便畅不痛，色深黄，舌苔红润，胃纳渐展，病情已有转机。治再生津清化，然必须加意谨慎，勿变为上。

四方：生石膏一两，鲜石斛五钱，京玄参三钱，净连翘三钱，大竹叶三钱，鲜生地一两，天花粉四钱，焦山栀三钱，金银花三钱，嫩芦根一两（去节），灯心三扎。

鲜石斛汤代茶。

五诊：身热解而不彻，诸恙悉退，三部脉象，数而不大，舌苔红润，微有薄苔，烦闷已平，渴饮渐和，赤斑循序而回，小溲黄。邪势已退六七，不生他变，可保无虞。

五方：鲜石斛四钱，净连翘三钱，绿豆皮四钱，鲜竹叶三钱，甘蔗皮五钱（塘西产），冬桑叶钱半，金银花三钱，嫩芦根一两（去节），生竹茹钱半，灯心三扎。

六诊：斑虽回净，肌热犹未解清，易汗口干，舌红润，根生薄苔，脉象弦数，右甚于左。今日频转矢气，大便欲解而未行，大邪虽退，余烬尚存。治再清胃养津，参以润肠。

六方：西洋参一钱，生扁豆衣钱半，火麻仁四钱（研），大竹叶三钱，绿豆衣四钱，鲜金斛四钱，净连翘三钱，瓜蒌仁四钱（研），嫩芦根八钱（去节），甘蔗皮五钱（塘西）。

七诊：交两候热退身凉，脉来静软，大便亦行，干燥异常，温

病后津虚肠燥，往往如此。

七方：西洋参一钱，生扁豆衣钱半，净连翘三钱，火麻仁四钱（研），生谷芽三钱，鲜石斛三钱，稽豆衣三钱，嫩芦根八钱（去节），松子仁三钱（研），淡竹叶钱半。

八诊：胃纳颇旺，脉来濡而有神，溺长色淡，皆邪去正复之佳象也。前方既合，毋庸更章。

八方：西洋参一钱，南沙参三钱，稽豆衣三钱，橘白一钱，淡竹叶钱半，川石斛三钱，扁豆衣钱半，生谷芽三钱，生竹茹钱半，灯心三扎。

九诊：大病之后，全恃胃气健旺。今寝食均安，大便又行不时，津液来复，即脾家运化之力亦健，所以神采颇好，脉象有神。治再和养，惟怡情静摄，调匀饮食，较服药尤为紧要。

九方：米炒洋参钱半，川石斛三钱，生谷芽三钱，水炒竹茹钱半，灯心三扎，南沙参钱半，稽豆衣三钱，橘白一钱，抱木茯神三钱，红枣三枚。

效果：服四剂痊愈。

廉按：肝胆为发温之源，阳明为成温之藪，诚以肝主回血，血中含有炭素，每从火化，故厥阴经最多伏火，每挟春温时气而暴发。其发也，阳明首当其冲，故身灼热而发斑，与新感风温病势，轻重悬殊。此案辨证有识，处方有胆，非学验兼优确有把握者不办，惟方中再加羚羊为尤妙。

（选自《全国名医验案类编》，福建科学技术出版社 2003 年版，289—292 页）

春温夹痰案

病者：席锡蕃先生令姪润身兄，年廿余岁，洞庭山人，住爱文义路。

病名：春温夹痰。

原因：新感风温，素蕴痰热。

证候：但热不寒，有汗不解，咳嗽气逆，痰厚若胶，咯吐维

艰，病已逾候。表分之风邪虽从汗达，里分之痰热正在熏蒸，蒸于胃，则脘闷渴饮，发热不已，熏于肺，则咳嗽痰厚，气急不平，便闭溺赤，烦躁少寐。

诊断：脉来右寸关浮滑数，左弦数，舌尖边红，根中黄苔。津液已经受伤，最恐上痹肺气为痰厥，内陷包络为神迷，不可不预防也。

疗法：初方，用鲜斛清胃生津，苏、葶、桑皮、白前泻肺开降为君，芦根、苡仁、冬瓜子（即千金苇茎汤去桃仁）清肃肺胃为臣，余如杏仁利肺，萎、贝化痰，连翘清热，枇杷叶顺气，用为佐使，各尽其清肃上中两焦之功能也。

处方：鲜石斛四钱，炙苏子三钱，象贝钱半，连翘四钱，生苡仁四钱，水炙桑皮四钱，甜葶苈一钱，瓜蒌仁五钱，杏仁三钱，冬瓜子四钱，白前钱半，枇杷叶三片（去毛），嫩芦根二两（煎汤代水）。服一剂。

次诊：大便先清后溏，痰浊下达，气急较平，熏灼势缓，身热稍和，惟咳嗽尚甚，稠痰咳吐尚艰，烦闷渴饮，饮又不多，小溲短赤，赤而且浑，脉右数大于左，舌红苔黄腻。种种胃热上蒸，肺不清肃，痰与热熏灼，津与液受伤。热无形也，痰有质也，宜清无形之热，化有质之痰，清理肺胃，顺气生津。病已经旬，慎防昏喘变端。

次方：霍石斛三钱（另煎），炙苏子钱半，象贝钱半，杏仁二钱（去尖），广郁金钱半（生打），生桑皮四钱，甜葶苈一钱，瓜蒌皮四钱，连翘四钱，枇杷叶三片（去毛），嫩芦根一两（去节），生苡仁四钱，冬瓜子四钱。一剂。

三诊：昨夜寐颇安，气分逐渐平降，惟咳嗽依然，咳痰尚利，身热较轻，烦闷亦减，大便又行，微带溏薄，病势日见退机，全赖痰从上出，热从下达。今日诊脉，右部浮大虽平，滑数尚甚，左尚弦数，舌苔化薄。当再清化肺胃痰热。

三方：水炙桑皮三钱，杏仁二钱（去尖），象贝一钱，冬瓜子四钱，赤苓四钱，芦根一两（去节），白前钱半，连翘四钱，瓜蒌皮三钱，生苡仁四钱，通草一钱，枇杷叶三片（去毛）。一剂。

四诊：身热乍盛乍衰，咳嗽或平或作，所幸咳痰颇爽，气逆已和，肺气不至有升无降，痰热亦不至有人无出，舌质既淡，苔亦化薄，小溲较长，色尚深黄，脘闷口渴均减，右脉仍形滑数。再拟清胃肃降，顺气化痰，不加昏喘变端，可保无虞。

四方：嫩芦根一两（去节），生苡仁四钱，杏仁二钱（去尖），川、象贝各一钱，生竹茹钱半，冬瓜子四钱，桑叶、皮各钱半，连翘三钱，瓜蒌皮三钱，广郁金钱半（生打），枇杷叶三片（去毛），通草一钱，鲜地栗三枚。一剂。

五诊：身热大减，大便又行，脘闷气逆等次第减轻，咳嗽亦不若前日之剧作，咳痰较薄，肺气渐得清降，痰热日见退化，溺色仍黄，脉来右部滑数，左尚和平，舌苔薄黄。病势已松，再以清化。

五方：嫩芦根一两（去节），生苡仁三钱，川、象贝各钱半，鲜竹茹三钱，赤苓四钱，冬瓜子四钱，青连翘三钱，全瓜蒌四钱，生蛤壳四钱（打），通草一钱，淡竹叶三钱，枇杷叶三片（去毛）。一剂。

六诊：身热交两候退净，诸恙均平，胃纳亦展，惟咳嗽未已，咳痰厚薄不一，余热挟痰尚恋肺胃，清肃下降，不能如常，脉来数象已和，右濡滑，左小弦，舌淡红，根苔薄黄。火邪已退，仍从肺胃治之。

六方：嫩芦根六钱（去节），生苡仁三钱，川贝二钱，橘白一钱，生竹茹钱半，冬瓜子四钱，川石斛三钱，蒌皮三钱，生扁豆衣钱半，淡竹叶钱半。二剂。

七诊：昨食粥稍多，脘中微闷，时欲作暖，大病小愈，胃虚消化力薄，所以每每能食运迟，咳嗽有痰，肺邪亦未清肃，舌根薄黄，溺色渐淡，大便三日未行，脉右濡细带滑。治再清化，务宜调匀饮食，安养怡情，当此九仞，幸加意留神为上。

七方：宋公夏钱半，广郁金钱半，橘皮一钱，炒扁豆衣钱半，冬瓜子三钱，川贝母钱半，炒蒌皮三钱，炒竹茹钱半，旋覆花钱半（包煎），通草一钱，枇杷叶三片（去毛），玫瑰花五分（后下）。二剂。

八诊：和胃清肺，顺气化痰，乃病后清理之法。

八方：川石斛三钱，宋公夏钱半，橘白一钱，茯苓三钱，冬瓜子三钱，甜杏仁三钱，川贝母钱半，炒竹茹钱半，炒蒺藜皮三钱，枇杷叶三片，灯心三扎。三剂。

九诊：便通溺长，胃纳亦展，惟稍有咳嗽，晨起尚有稠痰，脉濡有神，胃府湿热已化，肺家痰邪未清。

九方：甜杏仁三钱，宋公夏钱半，川石斛三钱，橘白一钱，冬瓜子三钱，茯苓三钱，川贝钱半，蒺藜皮三钱，炒竹茹钱半，枇杷叶三片（去毛）。四剂。

十诊：诸恙均平，咳嗽已和，舌苔亦化，脉来柔软，邪虽去，正未复。治再清养。

十方：西洋参一钱，宋公夏钱半，甜杏仁三钱，橘白一钱，茯苓三钱，川石斛三钱，川贝母钱半，冬瓜子三钱，炒竹茹钱半，稽豆衣三钱，红枣三枚。四剂。

十一诊：胃热已清，肺痰亦化，平素食后，时欲作噯，胃气不和所致，脉来较振。治再清养，饮食尤宜谨慎。

十一方：西洋参一钱，川贝钱半，杏仁二钱（去尖），旋覆花钱半（包煎），炒竹茹钱半，原金斛三钱（另煎），瓜蒌皮三钱（炒），橘白一钱，绿萼梅一钱，枇杷叶三片（去毛）。

效果：服六剂痊愈。

廉按：新感风温，素蕴痰热，为春季最多之候。叙证详明，处方轻稳，先清化，后清养，治则井然。似此佳案，堪为后学法程。

（选自《全国名医验案类编》，福建科学技术出版社2003年版，294~297页）

春温夹痰喘案

病者：陈女孩，年二岁，苏州人。

病名：春温夹痰喘（俗名肺风痰喘，实则肺闭，西医名肺炎）。

原因：痰热内蕴，又感风温。

证候：壮热有汗，神识昏蒙，微咳喘急，喉有痰声漉漉，便溏

溺少。

诊断：纹淡紫，舌苔厚白，脉来细数。已服过麻杏甘膏汤，无效。风痰热交结上焦，肺气将闭，襁褓肺弱，防涌塞骤变，勉拟轻清开泄，以尽医力。

疗法：肺位最高而司呼吸，喉为肺之外候，射干、牛蒡、甘、桔利肺开喉为君，苏、葶、莱菔子豁痰宣降为臣，更以杏仁、枳壳、前胡、郁金宽胸宣郁为佐使也。病在上焦，药用轻清，仿徐之才“轻可去实”之义。

处方：炒牛蒡三钱，生甘草四分，广郁金钱半，莱菔子三钱，甜葶苈一钱，前胡钱半，泡射干八分，苦桔梗五分，白杏仁二钱，炙苏子钱半，生枳壳钱半。

次诊：喘势较平，小洩稍长，热灼之势亦缓，咳嗽痰多，便溏甚黏，痰邪已由肺入胃肠而下行，脉细较扬，右部濡滑数，关纹隐而不显，痰热尚充斥肺胃。质小病重，防喘塞骤变，治再清宣。

次方：炒牛蒡三钱，生甘草四分，广郁金钱半，炙苏子钱半，泡射干八分，苦桔梗五分，白杏仁二钱（勿研），甜葶苈一钱，生枳壳一钱，嫩前胡钱半，白通草一钱，广橘白一钱。

三诊：喘平，咳声亦松，肺气已得宣利，热退身凉，微微自汗，大便溏薄，溺多而黄，舌苔腻薄，脉象濡滑数。病情已入坦途，治再清肺，顺气化痰。

三方：熟牛蒡二钱，象贝三钱，炙苏子钱半，冬瓜子四钱，囟囟杏仁二钱（去皮尖），炒蒺藜三钱，连翘壳三钱，通草一钱，生枳壳一钱，前胡钱半，莱菔子三钱。

效果：服二剂后诸恙均和，惟尚咳嗽有痰。仍宜清肺化痰，又服二剂痊愈。

廉按：邪闭在肺，势极危险，而对症发药，不旬日已痊者，因小儿脏腑嫩薄，易入亦易出，所以效力神速也。

（选自《全国名医验案类编》，福建科学技术出版社2003年版，297~299页）

叶熙春

治湿温医案

例一，倪某，男，30岁。6月。杭州。

湿温三候，身热不解，有时神昏谵语，渴而喜饮，口气臭秽，大便旬余未解，小溲短赤，脉象沉数，舌苔黄燥。阳明腑实，急以清热荡积。

带心连翘9克，黑山栀9克，制大黄8克，厚朴3克，炒枳实5克，元明粉12克（分冲），天花粉9克，淡竹叶8克，茯苓12克，灯心草30支。

二诊：昨投承气加味，服后大便已下，小溲由赤转黄，身热顿减，苔转薄黄而润，脉象滑数。再拟清热化湿。

清水豆卷9克，藿梗5克，淡子芩6克，赤苓12克，淡竹叶6克，苡仁9克，天花粉9克，金银花9克，益元散9克（荷叶包），佩兰6克，川石斛9克。

三诊：身热已退，湿未尽化，神倦嗜卧，不思饮食，脉转濡缓，舌苔白腻，大便虽能自下，小溲仍然短少，并有数声咳嗽。再拟渗湿兼以宣肺化痰。

淡竹叶5克，泽泻6克，白蔻仁3克（杵，后下），猪苓12克，益元散9克（荷叶包），佩兰6克，白杏仁9克（杵），赤苓12克，炒香枇杷叶12克（包），苡仁9克，炙前胡3克。

例二，蒋某，男，21岁。6月。余杭。

湿蕴化热，热伏阳明，壮热无寒，头剧痛，痛在正面，胸次窒闷，口渴索饮，大便秘结，脉数而实，舌苔黄燥。邪不在表，故虽得汗，热仍不解，阳明实热之证毕见。亟拟大承气汤加味。

生锦纹9克，枳实5克，制川朴3克，元明粉12克（分冲），通草5克，原干扁石斛9克（劈，先煎），苡仁9克，淡竹叶6克，

天花粉 12 克，赤苓 12 克。

二诊：昨投承气汤加味，大便已通，热势减低，口渴亦瘥，无如湿邪窃据未逐，清旷失舒，胸次窒闷如故，脉数，舌苔薄黄。治以泄热生津为继。

原干扁石斛 9 克（劈，先煎），天花粉 9 克，生枳壳 5 克，制大黄 3 克，川朴 3 克，大腹皮 6 克，省头草 9 克，金银花 9 克，淡竹叶 5 克，苡仁 9 克，陈青蒿 60 克，赤苓 12 克。

三诊：湿浊熏蒸未艾，热势仍见起伏，渴喜冷饮，胸闷烦懊，夜来谵语，脉弦而数。势虑入营昏痉，再予芳香开逐，宣畅气机，俾邪从外达，以杜内陷之渐。

紫雪丹 1.8 克（吞），青连翘 9 克，鲜菖蒲根 6 克，鲜石斛 9 克（劈，先煎），川贝 9 克，炒牛蒡子 9 克，金银花 9 克，天花粉 6 克，元参 9 克，白杏仁 9 克（杵），茯神 15 克，通草 6 克。

四诊：热减神清，胸膈宽舒，内蕴邪热，始得外达，再以循序而进。

鲜扁石斛 9 克（劈，先煎），川贝 6 克，辰茯神 12 克，杏仁 9 克（杵），淡竹叶 5 克，竹茹 9 克，广郁金 2.4 克（杵），天花粉 6 克，鲜石菖蒲根 6 克，青蒿梗 9 克，金银花 6 克。

五诊：余热渐退，神安得寐，渴止胸舒，惟邪退正虚，头鸣，纳食无味，舌苔薄黄，脉缓不弦。顾其胃先苏其困，得谷食以助元气。

省头草 9 克，扁石斛 6 克（劈，先煎），炒香豉 3 克，白蔻壳 5 克，生谷芽 8 克，炒谷芽 8 克，生鳖甲 15 克，米炒麦冬 9 克，茯神 15 克，陈青蒿 6 克，六神曲 5 克，小生地 12 克。

六诊：余热未尽，津伤未复，头昏体痛，知饥少食，脉见小数，再以清养继之。

细生地 12 克，扁石斛 9 克（劈，先煎），陈青蒿 6 克，神曲 5 克，省头草 6 克，生鳖甲 15 克，米炒麦冬 12 克，炒香豉 3 克，地骨皮 9 克，砂仁 1.5 克（杵，后下），生谷芽 8 克，炒谷芽 8 克。

七诊：大病初瘥，湿热尽化，胃津渐充，脉缓无力，头昏心悸，耳作蝉鸣，正虚未复，再当调理。

米炒上潞参9克，生鳖甲15克，辰茯神15克，元参9克，生白芍5克，神曲5克，生谷芽8克，熟谷芽8克，砂仁1.8克（杵，后下），橐豆衣9克，细生地12克，扁石斛（劈，先煎），红枣3个。

按：以上两例，皆为湿热挟实之证，治疗均先用攻下之法。倪姓患者，邪热较轻，在积滞排除以后，续用渗湿泄热，宣通气机，病遂向愈。至于蒋姓患者，湿热业已化燥，虽经导下，而热势不减，且有谵语，故谓有人营之虑，三诊处方，用紫雪丹清热透泄，乃杜绝温邪之内陷，为病情转机之关键所在，服后热减神清，邪得外达，湿化热退而愈。盖湿温有忌下之诫，唯恐损伤中气。但以上患者，阳明燥实之证已具，如应下而失下，亦足以贻误病机，故须灵活掌握，不可拘泥。

例三，茹某，男，30岁。7月。杭州。

湿温一候，身热不扬，胸闷泛恶，神倦嗜卧，渴不喜饮，不思纳谷，脉濡而小数，舌苔白腻。湿遏热伏，热为湿郁，中阳受困，气机阻滞。拟四苓芩石汤法。

清水豆卷12克，生茅术6克，泽泻6克，赤苓12克，飞滑石12克（包），苡仁9克，淡竹叶6克，猪苓5克，淡子芩5克，白蒺藜6克，五加皮5克。

二诊：服四苓芩石加味，湿热渐除，胸闷略舒，泛恶亦止，胃气来苏，已思纳谷，而肢体倦怠如故，脉濡缓，苔薄腻。蕴郁之邪未尽，再进芳香淡渗。

大豆卷12克，秦艽5克，焦苡仁9克，佩兰6克，生茅术5克，制木瓜5克，白蒺藜8克，赤苓12克，五加皮8克，淡竹叶6克，六一散9克（包）。

三诊：热虽已退，湿未尽化，纳谷欠馨，口淡乏味，二便如常，脉缓，苔薄白。再清余湿，兼以和中。

米炒上潞参6克，佩兰6克，威灵仙9克，炒麦芽15克，大豆卷9克，杜仲15克，淡竹叶6克，苡仁12克，五加皮8克，白蒺藜8克，赤白苓各8克。

例四，闻某，女，21岁。6月。余杭。

温邪夹湿，困于太阴阳明，微寒身热，胸次塞闷，咳嗽多痰，不思纳谷，时时欲呕，脉滑数，舌苔薄黄而腻。浊邪犯于清旷，肺失肃化；蕴湿留于中焦，胃失降和。拟宣畅气机，清利湿热。

清水豆卷9克，白杏仁9克（杵），制苍术5克，炒枳壳5克，带皮苓12克，炒竹茹9克，浙贝母9克，炙橘红5克，白蒺藜9克，益元散9克（包），生苡仁9克。

二诊：身热略减，咳嗽较稀，胸满呕恶仍有，脉弦滑，苔黄腻。湿热未清，原法加減。

制厚朴5克，白蔻仁3克（杵，后下），浙贝母9克，姜汁炒竹茹8克，白杏仁9克（杵），大腹皮9克，前胡6克，炙橘红6克，云茯苓12克，益元散9克（包）。

三诊：湿化热退，痰咳均减，无如邪去正虚，头昏目眩，脉象转缓，舌淡无垢。脾胃未健，再拟调理。

米炒上潞参9克，茯神9克，新会白5克，杏仁9克（杵），仙露半夏6克，杜仲9克，炒香麦芽9克，制扶筋9克，建泽泻6克，建曲5克（包），红枣3枚。

例五，王某，男，15岁。5月。余杭。

湿困太阴，热伏阳明，旬日不化，日晡身热，微汗无寒，四肢酸重，胸闷纳减，精神疲乏，大便溏薄，小溲短赤，脉来濡数，舌苔黄腻。治用芳香合淡渗法。

淡子苓5克，飞滑石12克（包），佩兰5克，大豆卷12克，白蔻仁2.4克（杵，后下），带皮苓12克，炒枳壳2.1克，大腹皮6克，制苍术5克，陈青蒿6克，白蒺藜9克。

二诊：前进苦辛清热，淡渗利湿，服后湿去热减，胸闷肢酸亦除，惟胃气未复，脉濡缓，苔薄腻。再以和中舒胃。

大豆卷9克，佩兰5克，仙半夏8克，赤苓12克，白蒺藜9克，苡仁12克，炒麦芽12克，陈皮5克，白蔻仁2.4（杵，后下）。

三诊：诸恙悉平，胃纳已有馨味。再用香砂平胃，调理继之。

按：以上三例，俱属湿重于热，热为湿遏，故用芳香苦辛合淡渗化湿清热之剂，一服后，湿化热解而愈。叶老经验，对湿温之偏

重于湿者，每用芳香燥湿之苍术、蔻仁、姜夏、厚朴等，但必须及时观察舌象变化，毋使太过而化燥伤津。

例六，沈某，女，30岁。2月。

形寒壮热，热度稽留在 39°C ~ 40°C 之间，见汗不多，头眩，骨节酸疼，口渴喜饮，胸闷作呕，神烦不寐，大便薄泻，小便短赤，舌糙绛，脉弦数。宜和解宣化法。

柴胡3克，葛根6克，小川连2.1克，乌梅肉9克，陈蒿根6克，天花粉6克，竹叶6克，佩兰6克，刺蒺藜8克，蔓荆子6克，夏枯草8克。

二诊：前方服后，壮热已减，诸症见瘥，神安得寐。但由病前任意饮食，尚有食滞于中，便下黑垢，小溲短赤如前。原方出入再进。

柴胡2.4克，威灵仙9克，蔓荆子6克，蜜炙南山楂9克，炙鸡内金9克，竹叶8克，酒炒黄芩5克，佩兰6克，潼蒺藜9克，川石斛9克，夏枯草9克。

按：叶老诊治此案，认为属温病中之少阳阳明合病，拟用先贤治风劳之柴葛连前煎乃异病同治。患者无咳嗽而见口渴且呕，故去前胡，易乌梅以生津止呕。服2剂病情显减，后诊调理而愈。

例七，麻某，女，32岁。5月。余杭。

湿温三候，壮热不退，胸闷烦躁，神昏谵语，口不渴饮，小溲短少，大便秘结，舌尖边绛，苔中白腻，脉沉而数。此属湿温不从气分而解，扰及心营，有痃厥之虑，用清透宣开之法。

牛黄至宝丹2粒（分2次吞），带心连翘12克，黑山栀9克，鲜石菖蒲根8克，鲜竹叶卷心40支，炒大力子9克，飞滑石2克（包），川贝5克，鲜芦根30克（去节），白蒺藜8克，炒香豉5克，橘红6克。

二诊：痞露，胸宇较宽，热减，神识转清，营分之邪已得外达，而大便不下，腑气未通耳。

瓜蒌皮9克，丹皮6克，鲜石菖蒲根3克，飞滑石12克（包），川贝5克，炒香豉5克，广郁金5克，黑山栀9克，橘红5克，羌蒺藜9克，竹叶卷心40支，鲜芦根2尺（去节）。

三诊：胸闷已宽，惟热势尚有起伏，并增咳嗽，再以两清肺胃。

苡仁9克、白杏仁9克（杵），赤苓9克，橘红6克，宋半夏6克，姜竹茹9克，清水豆卷9克，藿梗6克，炙前胡5克，北路太子参5克（先煎），炒香白薇8克。

四诊：热势尽退、大便亦下，咳嗽痰多，胸胁隐痛，原方出入再进。

宋半夏8克，茯苓12克，姜竹茹9克，橘红6克，焦枳壳2.4克，白杏仁9克（杵）、枇杷叶12克（包），炙前胡6克，清水豆卷9克，青蒿梗6克，广藿根5克。

按：本例系湿热熏蒸，扰及心营，苔见白腻，口不渴饮，为尚未化燥伤津，故在清营之中结合宣肺之法，使邪从气分而解。

例八，吴某，男，16岁。6月。余杭。

湿温九朝，壮热见汗不解（体温 39.6°C ），咳嗽痰稠，胸闷不宽，便下褐秽，小溲短赤。湿热郁蒸多日，势将传变，脉滑数。舌尖绛，苔中腻厚。治拟清解。

青连翘9克，银花9克，川贝5克，炒淡子芩5克，清水豆卷12克，川石斛9克，炒橘红6克，飞滑石9克（包），炒苡仁12克，干芦根18克，炙前胡8克。

二诊：热退不多（体温 39°C ），胸闷咳嗽尚频，利下赤色，脉数，舌尖绛，中黄腻。再拟清气透热。

青连翘9克，淡子芩5克，粉葛根5克，清水豆卷9克，桑叶9克，川贝6克，苡仁12克，淡竹叶8克，飞滑石12克（包），橘红6克，干芦根18克，炙前胡8克。

三诊：热势尚高、汗出溱溱、白痞稀露，赤利见瘥，咳嗽如故，夜来神昏谵语，舌绛，中黄腻，脉象滑数。再以透热开窍，清营达邪。

紫雪丹1.8克（先化吞），带心连翘12克，炒大力子6克，鲜石斛9克（劈，先煎），川贝6克，鲜竹叶卷心20支，淡子芩5克，鲜芦根1尺5寸（去节），飞滑石9克，苡仁12克，赤苓9克，橘红6克。

四诊：白痞续透，胸项为多，热势得减，胸宇未宽。咳嗽爽多，入夜间有谵语，舌绛苔黄，脉来细数。原法出入。

至宝丹1粒（先化吞），带心连翘9克，鲜菖蒲根6克，鲜石斛9克（劈，先煎），川贝6克，鲜竹叶卷心32支，鲜芦根2尺（去节），橘红6克，芫荽子6克，飞滑石9克（包），白茯神9克，灯心草1束。

五诊：热势顿减，白痞已回，神清，胸宇较宽，渴饮瘥减，惟痰伏尚多，肺失清肃，咳嗽未绝，脉小数，舌薄绛，再拟清肺蠲痰。

青连翘9克，冬瓜仁12克，炒香枇杷叶12克（包），苡仁12克，川贝5克，炒橘红6克，川石斛9克，淡子芩5克，炙前胡6克，泡射干4克，干芦根18克（去节），淡竹叶6克。

六诊：脉静身凉，痰少，咳嗽已稀，胸宇亦宽，胃苏，渐思纳谷，舌绛。再拟养胃佐清余邪。

象贝母5克，川石斛9克，炒橘红5克，炒香谷芽9克，白杏仁9克（杵），麦冬6克，苡仁9克，忍冬藤9克，白茯神9克，淡竹叶5克，干芦根15克。

按：高热，下利褐秽，系属热重于湿，里热充斥，用清气透热法，虽痞有露，而高热未退，又见人暮神昏谵语，谅由患者受邪过重，热蒸心营，故复用两清气营之法，使邪从外达，即叶天士所谓“入营犹可透热转气也。”

例九、汪某，男，28岁。7月。杭州。

病起一候，始则凛凛恶寒，继之身热，头昏而重，如蒙如裹，胸次窒闷，沉困嗜卧。初时汗出甚多，以后纯热无汗，渴不多饮，小溲短少，昨日起神识昏迷，上肢痉挛，下肢痿软，小溲不通，脉象沉弦而数，舌尖边绛，苔黄燥。乃湿热化燥，邪毒入营，袭于厥少二经，亟拟清营镇痉。

羚羊角尖1.5克（先煎），带心连翘15克，金银花9克，元参心9克，鲜石菖蒲根9克，鲜生地12克，黑山栀9克，鲜竹叶卷心12克，淡子芩6克，郁金6克，飞滑石12克（荷叶包），牛黄至宝丹2粒（分上下午化送）。

二诊，壮热见退，神识依然昏迷，牙关紧闭，两手尚痉，下肢未能伸缩，小溲未通，舌绛燥，脉沉细数。入营之邪尚盛，阴液难以骤复，再拟清营养阴继之。

乌犀角尖 1.5 克（先煎），带心连翘 12 克，玳瑁 15 克（先煎），鲜石菖蒲根 12 克，元参心 9 克，鲜细生二地各 15 克，丹皮 5 克，赤芍 6 克，川贝 6 克，郁金 5 克，灯心草 1 束，安宫牛黄丸 1 粒（先化吞）。

三诊：热退痉定，神清寐安，牙关已启，下肢稍能活动，惟小溲依然未通，精神倦怠，谷食无味，脉弦细数，舌苔黄腻。温邪已由营转气，拟再清热化湿，以降浊阴。

甘露消毒丹 12 克（包煎），青连翘 12 克，黑山栀 6 克，清水豆卷 9 克，鲜石菖蒲根 9 克，川贝 9 克，广郁金 9 克，淡竹叶 6 克，元参 12 克，川斛 12 克，茯神 15 克，灯心草 1 束。

四诊：神清，入夜酣寐，下肢已能伸缩，小溲已利，午后仍有低热，渴不多饮，不思纳谷，时有干呕，脉象细缓。再清余热，佐以养胃。

陈青蒿 6 克，佩兰 6 克，川石斛 12 克，苡仁 9 克，赤茯苓 12 克，天花粉 9 克，盐水炒橘红 6 克，蔻仁 3 克（杵，包），盐水炒细生地 18 克，盐水炒刀豆子 9 克，生鳖甲 24 克（先煎）。

五诊：胃气渐苏，纳谷见增，胸闷干呕已除，小溲亦得畅通，脉细而缓。前方既效，增减续进。

陈青蒿 6 克，佩兰 6 克，炒麦芽 12 克，蔻仁 3 克（杵，包），茯神 12 克，炒香豉 5 克，炒上潞参 6 克，麦冬 12 克，生鳖甲 15 克（先煎），杜仲 15 克，炒橘红 5 克。

按：本病初起，恶寒发热，沉困嗜卧，胸宇塞闷，为湿温发于太阴、阳明之间。湿热郁蒸过极，窜入诸经，入厥阴心包，则神昏不清，上肢痉挛；入少阴肾经，则小溲不通，下肢痿软。此即《素问·痿论》所谓：“肾气热，则腰脊不举……发为骨痿。”故初诊、二诊用羚、犀、玳瑁、至宝、安宫等清热、熄风、宣窍以制燎原，而防痉甚内闭；元参、鲜细二生地养阴增液，以防肾水涸竭。病虽危在顷刻，处方极其周密，故能立竿见影。至三诊舌苔黄腻满

布，乃温邪已由营转气，蕴湿犹留，膀胱腑气未通，是以在清热中佐芳香淡渗，开湿邪之出路，服后苔腻渐化，小溲自利。但下午仍有低热，此为余邪外达，非死灰复燃，再投和解枢机，清热养胃数剂，诸症消失，病体逐渐恢复正常。本案系浙江医科大学附属第一医院住院病人。诊断为“脊髓前角灰白质炎”，经叶老会诊6次，服药9剂而愈。曾总结刊载于1955年《中华医学杂志》第六期。

（选自《叶熙春专辑》，人民卫生出版社2006年版，46~57页）

治风温医案

例一，张某，男，30岁。2月。余杭。

身热三月，汗出未解，头痛恶风，咳嗽痰稠，口渴喜饮，脉浮而数，舌苔微黄。时当仲春，厥阴风木行令，风温袭肺，治以辛凉透表。

青连翘8克，黑栀9克，冬桑叶9克，炒牛蒡子6克，淡豆豉8克，荆芥穗5克，知母12克，天花粉9克，杏仁9克（杵），蜜炙前胡6克，炙橘红5克。

二诊：前方服后，身热已退，头痛恶风亦杳，尚有数声咳嗽，脉微数，苔转白薄，再拟清宣肺气。

杏仁9克（杵），炒牛蒡子9克，桔梗5克，炒枇杷叶12克（包），浙贝9克，炙前胡6克，知母12克，生甘草3克，淡子芩6克，天花粉9克，炙橘红5克。

按：风温上袭于肺，肺合皮毛而主卫表，故症见恶风发热，咳嗽口渴。盖风为阳邪，因而初起即有汗出。治用辛凉透表，此乃正治之法也。

例二，方某，男，40岁。2月。余杭。

恶寒壮热，汗出未解，咳嗽气急，喉间痰声辘辘，胸部隐痛，脉滑数，苔白腻，根微黄。风温夹痰，热不速解，有化燥之虑。

青连翘9克，杏仁9克（杵），淡豆豉5克，鲜石斛9克（劈，先煎），桑叶6克，桔梗2.4克，天花粉5克，浙贝9克，枳壳2.4克，炒枇杷叶12克（包），陈皮5克。

二诊：服前方后，痰热未清，咳嗽胸痛，口渴索饮，更衣秘结，脉滑数，苔根黄腻。痰热相并，交阻肺胃，再拟前方佐以润下。

青连翘9克，鲜扁石斛9克（劈，先煎），杏仁9克（杵），全瓜蒌24克，桃仁3克（杵），郁李仁24克（杵），元参12克，橘络红各5克，丹皮5克，生蛤壳15克（杵），浙贝9克。

三诊：壮热悉退，大便亦下，虽不化燥，津液未还，脉滑，苔白。太阴郁热已解，阳明秽浊得行，尚有小咳胸痛，乃余热未清耳。

杏仁9克（杵），川贝6克，桃仁2.4克（杵），冬瓜仁12克，知母6克，生蛤壳5克（杵），天花粉6克，生粉草1.5克，麻仁9克（杵），蜜炙橘红5克，茯神15克。

按：此为风温痰热交阻肺胃之证，有形之痰浊与无形之热邪互结于中，气机被阻，因而咳逆胸痛，燥渴便秘，汗出热亦随之而解。

例三，单某，女，28岁。2月。杭州。

产后十日，恶露已净，感受风温，突发壮热，见汗不解，咳嗽痰稠，气急烦渴，红疹隐隐。昨晚起神志昏迷，两手抽搐，舌绛而燥，脉弦数。为产后新虚，无力御外，温邪由表转里，由气入营，且动内风，亟宜清营泄热息风为治。

牛黄至宝丹1粒（先化吞），带心连翘12克，黑山栀9克，元参9克，川贝9克，天花粉9克，鲜芦根60克（去节），鲜竹叶卷心30支，双钩12克，炙前胡6克，杏仁9克（杵）。

二诊：壮热得减，神识已清，抽搐亦定，疹点隐回，夜来寐安，而咳嗽痰多，渴欲喜饮，脉细数，舌绛，苔薄黄，温邪已有外达之渐矣。

青连翘12克，金银花9克，淡子芩5克，知母9克，天花粉12克，鲜芦根24克（去节），淡竹叶8克，炒大力子6克，炒枇杷叶12克（包），杏仁9克（杵），炙前胡6克。

三诊：温邪留恋气营，昨日红疹又现，咳嗽尚频，痰稠胸痛，脉细数，苔薄黄，原法增损续进。

青连翘12克，金银花9克，嫩紫草9克，丹皮5克，鲜芦根24克（去节），生甘草24克，淡竹叶24克，炙桔梗5克，橘红5克，炒枇杷叶12克（包），炙前胡6克。

四诊：疹已默消，咳嗽亦稀，余热尽退，脉转缓滑，而痰多胸痛如故，再清余邪。

川贝粉3克（研吞），杏仁9克（杵），炒大力子9克，金银花9克，桔梗5克，生甘草2.1克，炙前胡6克，生蛤壳18克（杵），炒枇杷叶12克（包），陈芦根21克，化橘红5克。

按：患者感受温邪，未从外解，而迅即由表转里，由气入营，见有神昏、抽搐、舌绛而燥，谅由正不胜邪，病邪速进而内陷，故用清营泄热之剂推邪外出，不使正伤，此为急则治标之法，至红疹回而复现，乃温邪介于气营之间，血分郁热未清，三诊中加紫草、丹皮等，即是斯意。叶老对本病明辨本虚标实，治标急于治本，庶乎应手奏效也。

例四，蒋某，男，24岁。3月。临安。

时值春令，农事方兴，日前跋涉崎岖，冒雨淋湿，至夜恶寒身热，头昏而痛，咳嗽频频，口渴不喜多饮，胸次塞闷，大便溏薄，小溲短赤。自服午时茶，汗出热仍不解，按之脉象濡数，舌苔白腻满布，乃风温夹湿，治拟辛凉合渗湿。

淡豆豉9克，黑山栀9克，淡子芩6克，粉葛根6克，浙贝9克，炙前胡6克，赤苓12克，生苡仁12克，制苍术6克，陈皮3克，炒神曲6克（包）。

二诊：前药服二剂后，身热减退，胸次已宽，小溲清长，大便亦不溏薄，而独咳嗽未已，脉象微数，舌苔白薄，为湿去热减，肺气未宣，再拟宣肺降气，并清余热。

炒枇杷叶1克（包），前胡6克，浙贝母12，桔梗3克，炙橘红5克，云苓12克，生甘草2.4克，天花粉9克，淡竹茹6克，淡子芩5克，苡仁12克。

按：风温夹湿，法用辛凉解表合淡渗化湿者，以冀微微汗出，俾使风湿俱去，效麻黄加术汤意也。

（选自《叶熙春专辑》，人民卫生出版社2006年版，36~39页）

治春温医案

例一，蒋某，男，18岁。3月。余杭。

春温壮热一候未解，烦躁不安，渴喜多饮，面赤口臭，舌唇焦燥，时有谵语，不思纳谷，大便八日未落，曾服辛凉之剂未效。脉象滑数，舌苔黄糙而燥，阳明腑实之证毕现，拟凉膈散化裁，以符清上泄下之意。

青连翘9克，黑山栀9克，淡子芩6克，知母12克，生锦纹6克，元明粉5克（冲），全瓜蒌9克，炒枳壳5克，天花粉6克，生甘草2.4克，原干扁石斛9克（劈，先煎）。

二诊：前方服后，今晨便下燥矢甚多，壮热略减，已能安寐，唇舌之燥不若前甚。脉数苔黄，阳明腑实虽清，而经热未解，久热阴液被劫，再拟养阴清热继之。

生石膏30克（杵先煎），知母9克，西洋参6克（先煎），原干扁石斛9克（劈，先煎），天花粉9克，鲜生地24克，青连翘9克，淡子芩5克，生甘草2.4克，川贝9克，瓜蒌12克。

三诊：服人参白虎加减，身热顿减，渐思纳谷，舌苔薄黄，脉见小数，伏邪已得外达，再拟清养胃阴，以撤余邪。

太子参6克（先煎），原干扁石斛9克（劈，先煎），知母12克，生石膏24克（杵，先煎），鲜生地24克，淡子芩5克，青连翘9克，生甘草1.5克，冬瓜仁12克，川贝5克，云苓9克。

前方进2剂，身热尽退，后以原方去淡子芩、石膏，加麦芽，续服二三剂，渐次而愈。

按：春温邪热郁于胸膈，中焦燥实已具，方用凉膈散，翘栀清其无形之热，硝黄荡其有质之垢，乃清上泄下之法。服后阳明腑实得清，而经热未解，阴液又伤，故续用白虎加西洋参、石斛、鲜生地等养阴清热，以肃余邪。

例二，毕某，男，45岁。2月。昌化。

察体素虚，且有淋患，肝肾之阴先伤，又得春温。初时微寒，以后壮热无汗，烦躁不安，耳聋目糊，口渴喜饮。昨夜起神识昏

迷，手足痲疯，颧红面赤，脉来细数，似丝无神，舌紫绛，苔燥黑如龟壳，齿龈衄血。病乃伏邪不得从阳分而解，内陷厥少二经，阴液涸竭，虚阳浮越。温病到此，既笃且极矣。亟拟养阴潜阳，宣窍达邪。

吉林人参5克（先煎），麦冬12克，元参心12克，大生地24克，紫丹参24克，阿胶24克，生白芍6克，生龟甲、鳖甲各24克（先煎），生牡蛎18克（杵，先煎），川贝9克，人中黄6克，陈胆星2.4克，鲜竹茹12克，鲜菖蒲汁1匙（和药冲），至宝丹2粒（先化吞）。

二诊：温邪深扰厥少二经，灼耗津液，大有吸尽西江之势。昨投扶正祛邪，营热犹炽，神昏如故；风阳未清，痲疯难定；金受火烁，气促鼻煽。症势虽笃，所幸脉象稍见有神，生机尚未绝望。

吉林人参5克（先煎），天麦二冬各12克，犀角尖3克（先煎），大生地24克，粉丹皮5克，白芍5克，元参12克，丹参9克，蛤粉炒阿胶12克，人中黄5克，天花粉6克，生龟甲、鳖甲各24克（先煎），生牡蛎24克（杵，先煎），至宝丹2粒（先化吞）。

三诊：今日衄血已止，鼻煽亦定，舌苔黑壳渐落，舌本干燥起有芒刺，神识时昧时清，痲疯未已。再以原法出入。

吉林人参5克（先煎），天麦冬各12克，元参12克，细生地24克，阿胶9克，川贝9克，天花粉8克，粉丹皮6克，青蛤散12克（包煎），杏仁9克（杵），生龟甲、生鳖甲各24克（先煎），灯心草50支。

四诊：营热未清，变幻多端，神明仍为所蔽。阴液大伤，内风鸱张。两手颤动，舌绛且糙，脉见沉细。证属正虚邪实，当拟大定风珠加减。

别直参5克（先煎），西洋参5克（先煎），霍石斛6克（先煎），犀角尖1.5克（先煎），阿胶9克，大生地24克，生白芍6克，川贝6克，生牡蛎24克（杵，先煎），天竺黄5克，甘菊花6克，鸡子黄1枚（打匀，冲）。

五诊：昨进大定风珠，诸恙已十去七八，风定则不扬焰，热退

则不劫阴，神识已清，瘕疝亦定。胃气初见来复，稍思饮食；元神散而复敛，自能酣寐。惟唇舌尚燥，脉细无力，大势虽已由逆转顺，调护仍须留意。再拟养阴扶正，以清余邪。

别直参5克（先煎），西洋参5克（先煎），麦冬12克，元参心12克，蛤粉炒阿胶9克，炙甘草2.4克，生白芍12克，生牡蛎24克（杵，先煎），川贝9克，茯神12克。

按：春温之邪，变化多端。王氏所说“正如抽蕉剥茧，层出不穷”即斯意也。患者素体阴虚，又感春温，始有微寒，继而壮热，邪不从汗解，而见神昏瘕疝，此乃病邪深陷，由气入营，液涸风动。叶老治用三甲复脉法加至宝丹，育阴潜阳，清营解毒，是为拨乱反正之义。复诊虽然证势未减，而脉稍见有神，可见初方已中肯綮，再加犀角一味，意在清营解毒，沃焦救焚。三诊衄血止，鼻煽定，舌苔黑壳始脱，而舌本干燥起有芒刺，为营热犹炽，阴液难复，故四诊用大定风珠养阴柔肝，熄风，济涸澈之水，而滋化源，服后热退神清，风定痉止，胃气见苏，病情出险入夷，邪去正伤，续予气阴两顾之法，是属善后之计也。

（选自《叶熙春专辑》，人民卫生出版社2006年版，39~42页）

治暑温医案

例一，金某，男，24岁。7月。昌化。

暑温一候，汗出壮热不退，渴喜冷饮，神倦嗜卧，唇红面赤。昨夜起神识时昏时清，且有谵语，脉象弦滑而数，舌绛，苔黄燥。暑邪内干心营，扰乱神明，邪势鸱张，亟拟清营达邪。

带心连翘9克，金银花9克，元参心9克，黑山栀9克，鲜石菖蒲根6克，川贝6克，鲜生地2.4克，益元散9克（荷叶包），黄郁金6克，茯神12克，牛黄清心丸1粒（先化吞）。

二诊：神识转清，身热未退，汗多口渴，面红目赤，脉象滑数，舌苔黄燥。暑邪虽已由营外达，而热势未平，再仿人参白虎汤加味。

北路太子参6克（先煎），生石膏30克（打，先煎），知母12

克，鲜扁石斛9克（劈，先煎），带心连翘9克，元参9克，鲜生地15克，黑山栀9克，益元散12克（荷叶包），天花粉12克，川贝6克。

三诊：高热得减，面红已除，舌苔黄燥转润，津液已有来复之渐，脉象弦数。再拟养阴泄热。

北路太子参6克，元参9克，鲜生地15克，知母12克，金银花9克，连翘12克，天花粉12克，活芦根30克（去节），六一散9克（荷叶包），生苡仁12克，赤苓9克。

四诊：前方服2剂，身热尽退，脉象转缓，苔薄黄，小溲短赤，前方去太子参、连翘、芦根、元参，加扁石斛9克，麦芽9克，淡竹叶6克，以清余邪。

例二，徐某，男，1岁。7月。三墩。

乳婴体质娇弱，感受暑邪，暑遏热郁，气机闭塞，痰浊内阻，心包被蒙，神识昏迷；热激风动，四肢抽搐，角弓反张；肢末厥冷，指纹紫伏，直透命关。舌苔焦燥。痉厥重症，内闭堪虞。亟宜清暑熄风，豁痰开窍。

羚羊角尖1.5克（先煎），连翘5克，金银花9克，鲜扁石斛5克（劈，先煎），双钩9克，天竺黄3克，川贝5克，丝瓜络9克，竹茹6克，橘红络各5克，鲜枇杷叶2张（拭，包），牛黄至宝丹1粒（先化吞）。

二诊：昨进清暑熄风、豁痰开窍之剂，痉势虽见缓和，而神识依然未清，喉间痰声辘辘，乳汁不进，指纹如前，四指厥冷。邪犯厥阴少阴，症势鸱张，如小舟之重载，未逾险境，再拟原法踵步。

羚羊角尖2.1克（先煎），带心连翘6克，金银花5克，天竺黄3克，制天虫5克，制胆星1.8克，川贝5克，益元散9克（荷叶包），扁石斛6克（劈，先煎），双钩9克，竹沥30克（分冲），牛黄至宝丹1粒（先化吞）。

三诊：前方服2剂，身热得减，痉定，神识亦清，四肢转温，喉间痰声消失，而指纹紫伏如故，病见转机。再拟养阴清暑化痰继之。

鲜生地12克，川贝5克，鲜竹茹9克，金银花9克，橘红络

各5克，茯神6克，天竹黄3克，双钩9克，青连翘6克，制胆星1.5克，益元散9克（荷叶包）。

四诊：热退，吮乳如常，指纹转红，已回气关，而唇舌仍然干燥，便下痰浊。热去津液未还，已履坦途，再清余邪以善其后。

益元散6克（荷叶包），川贝5克，鲜竹茹6克，茯神9克，生苡仁9克，天花粉9克，扁豆衣9克，通草2.4克，陈茅根9克，炒橘红5克，鲜荷梗1尺（切断）。

按：以上两例，皆系暑温入营之证，但邪势深浅不一，故治亦有异。金某一案，症见壮热面赤，渴饮多汗，然内无痰浊夹滞，故虽有谵语，而神识有时尚清，为气分之热偏重，用清营透泄即见转机，继以泄热生津而获向安。第二例徐姓幼婴，年才周岁，禀体本弱，抗邪无力，暑热深陷厥少二阴，酿痰动风，以致昏痉厥闭，险象环生。故在清热之中，着重豁痰镇痉，始得化险为夷。前后两案，一则在于救气津之伤，一则在于开痰热之闭。读者可以互相参看。

例三，秦某，男，21岁。7月。昌化。

暑温汗出壮热不退，头昏而胀，渴欲冷饮，面垢烦闷，小溲短赤，脉来濡数，舌绛苔黄。暑热蕴蒸阳明，仿白虎汤法。

生石膏24克（杵，先煎），知母9克，青连翘9克，金银花9克，鲜生地15克，天花粉9克，益元散9克（荷叶包），淡竹叶6克，赤苓9克，淡子芩5克，广郁金5克。

二诊：热退不多，口渴索饮，神烦不安，脉濡数，舌尖边绛，苔黄燥。阳明蕴热未清，而气津已伤，再以白虎加人参法继之。

西洋参6克（先煎），生石膏30克（杵，先煎），知母9克，金银花9克，连翘9克，天花粉9克，生地15克，原干扁石斛9克（劈，先煎），淡竹叶6克，淡子芩6克，六一散9克（荷叶包）。

按：暑热留恋气分，初诊汗出不解，壮热烦渴，为白虎汤之主证。因邪势鸱张，气液两伤，故难速解，二诊原方加参，益气生津。服后正胜邪去，病即霍然。

附：暑湿

例四，蒋某，女，27岁。7月。余杭。

日间冒暑受热，夜来露宿感凉，初起形寒，继而壮热无汗，头胀而痛，胸闷欲呕，周身关节酸痛，脉象浮弦而数，舌苔白薄。暑为表寒所遏，阳气不得伸越，先拟疏表。

杜苏叶5克，防风3克，广藿香9克，佩兰9克，蔓荆子6克，青蒿6克，白蒺藜9克，金银花5克，六月霜9克，夏枯草9克，丝瓜络15克。

二诊：服药后汗出，身热大减，胸闷未宽，脉象转缓，舌苔薄腻。暑热尚未尽除，再以宣化继之。

广藿梗6克，佩兰6克，制厚朴5克，炒枳壳5克，陈皮6克，云苓12克，陈青蒿6克，丝瓜络9克，淡竹叶9克，六一散9克（鲜荷叶包），夏枯草9克。

按：先暑后凉，卫阳被遏，症见形寒无汗，肌肤灼热，故治用苏、防发汗解表；暑必夹湿，又佐芳香辟浊。服后得汗，形寒即解，身热顿减。续进正气散2剂，暑湿尽除而愈。方中白蒺藜一味，叶老常用于表证肢节酸痛，取其散风通络，效果颇显。

例五，于某，男，18岁。6月。于潜。

身热五日，汗出不解，头昏而胀，胸院痞闷，不时泛恶，口渴不喜多饮，小溲短赤，脉濡数，苔白腻。暑邪夹湿，气机郁阻，治拟清暑化湿。

青连翘9克，金银花9克，飞滑石9克（荷叶包），清水豆卷9克，鲜佩兰9克，广藿梗5克，淡竹叶9克，苡仁12克，赤苓9克，通草3克，白芷尖3克。

二诊：前方服后，身热略减，胸宇塞闷已宽，口渴欲饮，苔转薄黄，脉数。湿化热留，再拟清暑泄热治之。

大豆卷9克，青连翘9克，青蒿子5克，银花9克，淡竹叶9克，赤苓9克，鲜芦根1尺（去节），佩兰6克，黑山栀9克，川石斛9克，六一散9克（荷叶包）。

按：王孟英谓：“暑令湿盛，多必兼感。”患者为暑热夹湿，症

见头昏而胀，胸宇塞闷，渴不喜饮，虽汗出热仍不解。初诊用清暑化湿，而以化湿为重，服后头胀顿减，胸闷亦宽，口渴欲饮，苔转薄黄，乃湿去热留，故二诊重在清暑泄热，续服2剂而愈。

（选自《叶熙春专辑》，人民卫生出版社2006年版，42~46页）

治冬温医案

林某，男，36岁。12月。余杭。

禀体素虚，又感冬温乘时而发，始时恶寒身热，渐即热盛无寒，由午至暮，热势加增，咳嗽气逆，胸膈烦闷，有痰不易外吐，脉象弦滑而数，舌绛，苔黄中灰而燥。病属冬温夹痰，痰热胶结，热依痰为关隘，痰据热为护符，合则势甚，分则势孤。治拟清热涤痰。

青连翘9克，元参9克，鲜石斛9克（劈，先煎），川贝9克，莱菔子9克（杵），金银花9克，炒牛蒡子9克，白杏仁9克（杵），枇杷叶12克（拭，包），青黛0.3克，拌蛤壳18克，葛根5克，竹沥60克（入姜汁8滴，分冲）。

二诊：见微汗而热显减，热不恋痰，痰松能吐，咳嗽亦稀，无如燔灼之下，津液不无受劫。口苦咽燥，更衣虽通，小溲短少，脉转缓滑，舌苔灰垢亦蠲。仍宗前意，略增甘寒继之。

冬瓜仁12克，元参9克，辰砂拌麦冬12克，生甘草5克，炒大力子9克，桔梗3克，天花粉9克，川贝9克，鲜石斛9克（劈，先煎），丝通草5克，浮海石9克。

按：冬日应寒反温，感非时之暖，发为冬温，属新感温病。初起在卫，畏寒较重，嗣后热盛无寒，舌质绛，苔灰黄而燥，温邪业已入气。脉象弦滑而数，滑则为痰，数则为热，痰热互蕴，胶黏不易外吐。故在透达之中，佐人清化痰浊，服后热势显减，痰浊得化。但热灼阴伤，症见口苦而燥，小溲短少，又去苦寒易甘寒，以养肺胃。

（选自《叶熙春专辑》，人民卫生出版社2006年版，64~65页）

史沛棠

治春温医案

沈某，男，42岁。武康人。

患春温证，红疹布后，大热已退，口也不大渴，惟午后仍有潮热，傍晚至黄昏，神识不甚清爽，胡言乱语，经常自笑，鼻中有如黑煤，频有黏痰咳出，舌苔黄燥中腻，脉象沉数而滑，询其大便，已十余日不下，小溲短赤。前医均投清热宣窍、养阴化痰之品，服之均未收效。此乃余邪遗热不清，阳明腑气不降，燥矢阻塞，浊火上冒，治当清热之中，参入调胃承气汤。方拟：鲜生地八钱，鲜石斛四钱，连翘三钱，黑山栀二钱，川贝母二钱，杏仁三钱，广橘络一钱五分，瓜蒌皮三钱，赤苓四钱，甘草一钱，玄明粉一钱五分（分冲），生大黄一钱五分。服一剂后，大便即下燥黑粪块甚多，神识骤清，热也退净。继用养阴清肺和胃法，即前方去生大黄、玄明粉、甘草、连翘、鲜生地、鲜石斛，加用南北沙参各三钱，麦冬三钱，天花粉三钱，扁石斛三钱。连服4剂而愈。

按：春温发痧，无论是药力宣透，抑或病自外达，红疹遍布，是为邪热外透，故大热能退。然日晡仍有潮热，且神识似清非清，大便十余日不下，温热之邪已伤阴液，又因阳明腑气不通，燥矢浊火积滞，故前医单用清热养阴不能奏效。遂于清热之中参入调胃承气汤，以通腑泄热，急下存阴，则余邪浊火得以通泄，药后神识骤清，热也即退。

（选自《中国百年百名中医临床家丛书·史沛棠》，中国中医药出版社2004年版，99~100页）

邢子亨

论治感冒

感冒通常是指伤风、风湿、春温一类的疾病而言。所谓伤风，即是感冒风寒之轻证；风湿，即是内有温热复感风邪而发病；春温，即是春时感冒风寒而病热，有时亦小有流行。感冒治疗不当亦可缠绵不愈，甚则引起其他疾病，故当注意治疗。此类疾病是多发疾病，人人皆难幸免，治不及时往往诱发旧病，或与宿疾绵缠一起，致成误诊。余每见肺结核患者因感冒加重而误诊为肺结核恶化，阴虚发热病人有时因感冒风邪不解久成劳热，亦有感冒轻症因误治而成重症，诸如此类不胜枚举。根据临床体验，善治感冒则杂病之治法亦可扼其大纲。感冒属气化病变，人体气化与机能是不可分割的整体，且淫邪外感先伤气化，气化失调之后乃及气血经络脏腑。人身除情志劳损致病之外，大率是属于外感影响气化失常之病，故治感冒当属治病之重要环节，万勿忽视。如能把感冒早期治愈，则疾病可以减少大半，古人谓风为百病之长确有深意。

治疗大法，当执简以驭繁，审清致病之因，辨明六经气化之义，初感邪在表者当从太阳论治，勿使邪气内传，邪入阳明急清燥热勿使人腑，邪涉少阳急扼表气勿使内入阴经，则邪易外解不伤脏腑。因于寒者用辛温以发散，因于热者清热以透表，驱邪安正，防止传变，则正气不伤，抗邪有力，庶可以药到病除，收到早期治愈之效，免于缠绵复杂之变。

兹将常用效方附后，可以随症加减，使主次不乱，则可收显著之效。

解表清热方：主治感冒风热和春温发热，身困，微恶风寒等。

葛根 12 克，连翘 15 克，银花 15 克，桑叶 9 克，桔梗 9 克，浙贝母 10 克，荆芥 9 克，淡豆豉 15 克，牛蒡子 9 克，桑枝 12 克，

甘草 9 克，薄荷 5 克，芦根 12 克。

咽痛加射干 9 克，板蓝根 12 克，蝉蜕 9 克。

咳嗽加前胡 9 克，天冬 12 克，杏仁 12 克，瓜蒌 15 克。

身痛加鸡血藤 20 克。

头痛加菊花 12 克，僵蚕 12 克，生石决明 20 克，兼有风寒加苏叶 9 克。

夏月感暑邪，自汗发热不退，去荆芥，加香薷 9 克，滑石 15 克，猪苓 12 克。

寒热如疟加常山 9 克。

兼有湿邪阻滞中焦加苍术 9 克，川朴 9 克，炒槟榔 12 克。

高烧不退加丹皮 15 克，犀角 9 克（用代用品）。

（选自《中国百年百名中医临床家丛书·邢子亨》，中国中医药出版社 2004 年版，5~6 页）

过允文

风温案

病者：朱熙臣令郎，年十五岁，住宜兴竹巷。

病名：风温。

原因：感受温风，首先犯肺，早服滋养，邪热留恋。

证候：咽喉肿痛发热，咳嗽音哑不扬，痰黏胸痞。

诊断：脉右浮数，舌边尖红，苔白薄滑，证属风热伤肺。治宜辛平宣透，而乃误投滋腻，致邪胶固，久延恐成肺癆。

疗法：达邪宣肺，清肃气机，故以牛蒡、蒺藜为君，佐以沙参、杷叶、杏、桔等品，以冀热退咳爽。

处方：牛蒡子二钱，苦桔梗一钱，瓜蒌皮三钱，北沙参三钱，光杏仁三钱，冬桑叶钱半，鲜竹茹三钱，枇杷叶五片（去毛）。

先用生萝卜四两、鲜青果两枚煎汤代水。服三剂，热虽退，咳不止。

又方：京川贝三钱，款冬花钱半，浙茯苓三钱，前胡二钱，冬瓜子三钱，瓜蒌皮二钱，光杏仁三钱，枇杷叶三片（去毛），北沙参二钱。

效果：五剂咳止而痊。

廉按：药用轻清，方效叶案，此风温轻证之治法。

（选自《全国名医验案类编，福建科学技术出版社2003年版，17~18页》）

治秋温夹湿案

病者：蒋一清之子，年三十二岁，住蛟爪圩。

病名：秋温夹湿。

原因：素有痰湿，又感秋凉，郁伏化热。

证候：发热谵语，胸痞便溏，苔厚黄腻，渴不多饮。

诊断：脉不宣扬。乃湿遏热郁之候。本当辛开苦泄，奈一误于香燥，再误于凉遏，香燥则热炽，凉遏则枢窒。故热绵三月，呓语神昏，其胶固不解之情，皆药误有以致之也。

疗法：辛以宣之，芳以开之，苦以泄之。

处方：石菖蒲一钱，前胡二钱，苏薄荷钱半（后人），陈胆星钱半，广郁金钱半，象贝母三钱，玉枢丹五分（研，冲），枳壳一钱，鲜枇杷叶五片（刷净），白蔻仁五分（后人），瓜蒌皮二钱。

效果：二剂湿开热透，神清。继用轻清淡渗法收功。

廉按：湿遏热郁，自以苦辛开泄为首要。方中既有玉枢丹，特长于芳透，则蔻仁可以去之。

（选自《全国名医验案类编》，福建科学技术出版社2003年版，303~304页）

温病晚发案

病者：潘伯石令郎，年十四岁，住宜兴南大街。

病名：温病晚发。

原因：素质阴亏，冬伤于寒，潜伏至春未发，夏初乃发。

证候：壮热无汗，神昏谵语，便泄溺赤，舌干懊恼。

诊断：脉浮数沉滑。沉滑为伏温将发，浮数乃邪已外溃，惟时已初交夏令，故断为伏温晚发。

疗法：生津托邪，使邪透汗出为首要。

处方：黑膏一两，前胡二钱，连翘三钱，天冬三钱，薄荷钱半（后人），知母三钱，玄参五钱，赤芍一钱，金银花五钱，东垣凉膈散三钱，开水先下，白茅根四两（去心，煎汤代水）。

服三剂，接服后方。

二方：淡豆豉拌捣鲜生地二两，知母三钱，前胡二钱，生石膏一两（研细），玄参五钱，鲜竹叶三十片，薄荷头二钱（与石膏同打），天冬五钱，金银花五钱，鲜茅根四两（去心，煎汤代水）。

五剂便泄止而汗不出。接服后方。

三方：冬桑叶二钱，川贝母三钱，川石斛三钱，前胡二钱，鲜枇杷叶五片（刷净），北沙参三钱，苏薄荷钱半，蔻仁五分（同打，后人），豆豉五钱，旋覆花钱半（包煎），白茅根四两（去心，煎汤代水）。

效果：服三剂，得战汗而解。

廉按：前后三方，均属生津托邪法，于伏气温病大致亦合。拟去凉膈散，再加活水芦笋之清透，则见效当更速矣。

（选自《全国名医验案类编·初集·四时六淫病案》，福建科学技术出版社2003年版，274~275页）

风湿时毒案

病者：周恒和妇，年五十二岁，住徐舍市。

病名：风湿时毒。

原因：吸受风湿，误服辛热。

证候：头面赤肿，壮热便闭，谵语昏狂，口大渴，舌鲜红，溲赤而短。

诊断：两脉洪数有力，已成阳明热盛之候。

疗法：先用釜底抽薪法，后用清凉品以消热毒。

处方：生川军五钱，元明粉三钱，生甘草一钱，金银花五钱，小枳实三钱，天花粉五钱，青连翘三钱，玄参五钱。

次诊：服一剂，下大便二次，色黑而坚，后少溏薄，尚有昏谵。

次方：生川军一钱，白池菊二钱，大青叶三钱，金银花五钱，冬桑叶二钱，天花粉五钱，生粉草一钱，活水芦根一两，生绿豆一两（煎汤代水），羌活八分，紫雪丹五分（开水先下）。

三诊：服一剂热减，再剂肿全消。惟津亏热不退，不能眠，甘寒复苦寒法。

三方：天麦冬各三钱，鲜生地五钱，小川连五分，鲜石斛三钱，金银花五钱，鲜竹叶三十片，大玄参三钱，汉木通八分，生绿

豆一两，丝瓜络三钱，辰砂染灯心三十支。

效果：一剂热清得眠，三剂痊愈。

廉按：识既老当，方亦清健，是得力于河间一派者。

（选自《全国名医验案类编》，福建科学技术出版社 2003 年版，21～22 页）

刘志明

用辛凉宣肺、清营解毒法治愈风温一例

张某，女，3岁。

初诊：1979年3月10日。

主诉：咳喘伴高热三日。某医院确诊为小儿病毒性肺炎。

诊查：发热较甚，测体温达40℃。咳嗽气喘憋闷，咯痰黄稠，烦躁不安，面赤头汗出，口渴引饮，鼻翼有轻微煽动。脉滑数，舌苔薄黄。

辨证：证属风温犯肺，有逆传心包之势。

治法：辛凉宣肺、清营解毒，以麻杏石甘汤加味。

处方：麻黄6克，杏仁9克，生石膏18克，银花9克，连翘9克，丹皮9克，生地9克，甘草6克。另以紫雪丹3克，分两次冲服。

服上方药两剂，体温渐降，咳喘减轻，情绪安定。继以上方加减，再进药两剂，体温即降至正常，精神转佳。唯有轻微咳嗽，更以千金苇茎汤合生脉散加减，调治数日而诸恙皆平。

按语：小儿病毒性肺炎，属于中医温病范畴。叶桂云：“温邪上受，首先犯肺，逆传心包。”一方面指出温病顺传的规律，另一方面也提示逆传的可能，即风温之邪侵袭肺卫，可以不循卫气营血次第顺传于胃（气分），而逆传心包（营血），此论于小儿风温尤具意义。因小儿血气未充，脏腑娇嫩，易寒易热，易实易虚，外感风热最易邪陷神脏。故余主张在小儿病毒性肺炎之早期，已现发热、气喘、烦躁等症，虽未见神昏抽搐，但应乘其邪势未盛之时，采取有力措施，投以辛凉宣肺、清热解毒之剂，甚至早投紫雪丹清心开窍，积极防范其逆传心营，方能迅速分泄其邪，奏效乃捷。

〔选自《中国现代名中医医案精华（三）》，北京出版社2002年，1858页〕

许公岩

疏邪化湿法治愈急性发热三例

表里双解案

郭某，男，74岁。

初诊：1984年8月5日。

主诉：体温 38.4°C ，高烧，十余日，服多种中西药及注射退热剂，烧仍不退，咳痰黄黏，胸痛，咽痛，口渴饮多，思凉饮，脘满闷，食纳少，溲短赤，大便秘，七日未行。

诊查：面红目赤，舌暗红，舌苔满黄厚腻。脉弦滑数有力。

辨证：肺胃素蕴实热，外感风邪。

治法：表里双解。

处方：蒲公英30克，苍术12克，麻黄3克，生大黄12克。

二诊：上方药服二剂，汗出便泻，体温降至 37°C ，咳嗽明显见轻，胸脘满闷、面红目赤均除。舌苔满腻，脉弦滑，仍宜推化。

处方：瓜蒌30克，白芷10克，豆豉30克，熟大黄10克。

三诊：上方药服三剂后，咳嗽、胸脘满闷均除。舌苔薄白，脉静。

化湿降浊清热案

韩某，女，4岁半。

初诊：1984年8月9日。

主诉（患儿家属代述）：十余天前突然高烧，起初体温 38°C 左右，服西药及注射退热剂后，体温降至 37.8°C ，半日后，体温续升至 40°C ，呕吐不能进食，服中西药烧仍不减，便秘，溲黄，倦怠。

诊查：精神萎靡，烦躁不宁。舌湿腻，脉滑数。

辨证：湿浊中阻，外感风邪。

治法：化湿降浊清热。

处方：苍术 10 克，麻黄 3 克，蒲公英 10 克，元明粉 12 克（先冲服）。

二诊：服上方药一剂，得汗，体温降至 36.5℃。舌苔薄白，脉转细滑。久病体弱，邪去正未恢复之象。改用和中法。

处方：焦三仙 18 克，藿香 10 克，白芷 3 克，生甘草 10 克。

三诊：上方药服四剂后，体温恢复正常。

疏风散寒、化湿导滞案

王某，男，8 个月。

初诊：1984 年 8 月 3 日。

主诉：据家属述，发烧已三天，体温 39℃ 左右，服西药、注射退热剂烧未能退，不欲进乳，溲黄，大便正常。

诊查：腹胀如鼓，舌净，脉滑数。

辨证：积湿不化，外感寒邪。

治法：疏风散寒，化湿导滞。

处方：苍术 12 克，麻黄 2 克，六一散 10 克，元明粉 12 克（冲服）。

二诊：上方药服二剂，便泻如水样，热退，腹胀消，一切复常。

按语：以上三例均属夏末秋初之内蕴湿邪、外感风寒，属于表里合邪，病机大致相似，故均以苍术、麻黄疏邪化湿为主。但因其内蕴之邪有水湿、食滞、湿热之不同，故具体配方当有区别。凡舌苔厚腻兼大便干者，用胡黄连或生大黄泻浊；舌苔湿腻兼大便不爽者，用元明粉泻水祛湿。本病标象均为高烧，因此总的意图是立求退热，许老采用“通”和“宣”双管齐下的治法，给我们指出治秋凉暑湿合邪、急性发热的特殊方法。

（选自《中国现代名中医医案精华·六》，北京出版社 2002 年版，62～63 页。）

温散法治愈寒湿困阳感冒不解一例

李某，男，54岁。

主诉：头晕、浑身发冷两周，伴心慌，心悸，不欲饮食，大便如常，溺欠畅，曾数服西药，症状不缓解。

诊查：颜面苍白无华，舌质暗淡，舌苔灰腻不厚，脉沉细滑不起。血压24.0/14.7kPa（180/110mmHg）。

辨证：寒湿久蕴，复感风寒，内外交困。

治法：温阳化湿。

处方：乌附片15克（先煎），干姜15克，桂枝24克，炒莱菔子30克，甘草30克。

药服三剂。第一煎药服后汗出，身冷即解，心慌心悸少减，颜面已转红润。药服完三剂，头晕并除，舌苔变为白腻，脉滑略弦。血压亦平，惟纳仍不香。中脘犹被湿阻，再以推化法，予药三剂遂愈。

按语：缘患者嗜饮浓茶，寒湿虽已久蕴，设无外寒复加，机体尚能相安。今以寒湿内外合邪，阳气受困，无能用事。见面苍身冷、苔灰、脉沉滑不起，即说明此时病机已完全在里。观头晕心悸，乃机体犹欲拼力以为救。血压骤高亦欲降压作助力，奈阳虚难以为用，仅见此冲动情况。方用辛温力雄之乌附片、干姜、桂枝，固属大力温阳以苏困。应知阳被湿困，湿停于虚，为平素脾难健运之结果。故必以大量补中益气之甘草作培中之主力，虽云扶正，实乃使甘与辛味合化以成复阳之动力，亦属治本之道。加莱菔子推化湿浊，宽胃下气以调中，是以服后即能得汗，脉亦不复沉而不起。本例形似外感，只因病理不同，故两周来予解表而未能得解，依舌脉知病机在于阳被湿困而不能为用，大力温阳，阳即可展，疗效遂亦得显。

（选自《中国现代名中医医案精华·六》，北京出版社2002年版，46~47页）

许翔霄

风温伏邪案

病者：徐锡甫，年甫弱冠，纱厂机工，住锡城。

病名：风温伏邪。

原因：冬稍受寒，伏而不发，至春感风，触动伏气而发病。

证候：身热懊恼，咳嗽咽痛，微寒便泄，鼻衄耳聋，吐痰黄稠。

诊断：脉形数大，重按带弦，舌红苔黄，断为肺胃痰热。盖气热则痰为火灼，色变黄稠，气燥则清窍不利，两耳失聪。咽通于胃，喉通于肺，今肺胃为风热渊藪，自然咽喉作痛。大肠与胃相连续，与肺相表里，热盛则下移于肠而便泄。兼症虽繁，仍不越乎风温之本因。

疗法：清痰热以保肺，存津液以养胃。

处方：泡射干六分，苦桔梗一钱，淡片芩钱半，黑山栀三钱，前胡一钱，青连翘三钱，细木通五分，六一散三钱（包煎）。鲜石斛五钱，竹叶三十五片，白茅根一两（去心），此三味煎汤代水。

效果：服二剂后，咳爽痰活，热减泄止，后以清肺汤收功。

廉按：风温之为病，其因有二：一为新感，一为伏气。此证属太阴伏热感风而发，故用肃肺养胃以奏效，继用清肺汤以收功，尚属伏气风温之轻证治法。

（选自《全国名医验案类编》，福建科学技术出版社 2003 年版，23~24 页）

严执中

春温案

病者：张东楼之妹，年十九岁，住常州陈巷。

病名：春温。

原因：去岁暮略受寒邪，寒郁化热，至今春复新感风寒而发。前医令服解表药数帖，汗出而热不退。

证候：初病头疼身痛，胸闷食少，口渴引饮，晚间热重，时或呢喃。一星期后，经行忽停，因而少腹痛，连夜谵语，咳嗽黏痰，用力而不得出，齿焦舌刺，索茶而不多饮，屈指已廿七日。

诊断：六脉弦数，尺部细，候则促。证属春温而邪入阴分，蓄血胞宫也明矣。幸喜二九之年，真阴尚未消烁，如急救得法，犹可转危为安。

疗法：治病必求于本，故重用黑原参、原麦冬、鲜生地、肥知母、粉丹皮滋阴清热为主，川贝母、牛蒡子、广陈皮理气豁痰为辅。又思蓄血下焦，大便燥结，扬汤止沸莫若釜底抽薪，因用桃仁泥、广箱黄前后通行合治，而丹皮佐桃仁，甘草佐大黄，意在一则防缓，一则恐急。余若芦根、茅根、银翘与川贝、牛蒡等，不过邪由外人者，仍使之由外而出，所以吴鞠通、叶天士、陈平伯、王孟英诸先生谓为温邪发表之要药也。

处方：肥知母三钱，川贝母三钱，桃仁泥三钱，生甘草五分，净连翘三钱，黑玄参五钱，粉丹皮三钱，广箱黄三钱，金银花三钱，广陈皮一钱，鲜生地五钱，原麦冬三钱，牛蒡子二钱。

鲜芦根三钱，鲜茅根一两（去衣），二味先煎代水。

效果：予方一出，当时诸医议论纷纷，谓死期将临，尚用大黄三钱，怙患病家莫服。予见胶柱派反对，乃大声曰：倘病者服余方而死，余愿出大银百元，为之棺槨丧葬。于是病家使病者连服两

煎，果月信复来，腥臭难闻，夜不谵语，日不糊涂，身热亦退，颇思饮食。延余复诊，苔腻黄已化，脉弦数已缓，惟咳嗽稠痰，比前尤多。予乃于前方去大黄、桃仁，加杏仁泥、全瓜蒌，连服四剂而愈。

廉按：病属冲任伏热，桃仁承气加减正合病机，然非素有胆识者，不敢担任。

（选自《全国名医验案类编》，福建科学技术出版社 2003 年版，285～286 页）

李竹溪

春温晚发误治坏症案

病者：张维翰，年三十七岁，浙江人，芜湖常关吏。

病名：春温晚发，误治坏症。

原因：冬伤于寒，潜伏营分，偶触新感而发。据述初起寒热无汗头痛，医以麻黄、杏仁等暨开泄之品，服后逾时即汗，头晕舌干，服梨一枚，稍定。更医，桂枝温胆诸汤，毫无效果。

证候：汗不能收，热不肯退，起坐憎寒，卧又汗泄，神疲气索，颧赤懒言，舌干绛，苔薄焦，齿板目合，寐则呓语郑声，循衣摸床，略触即醒，醒后仍能了了，咳嗽痰红，日倾三盏，左胁疼痛，一派阴液就亡正气将残之象。

诊断：左脉细数，右细滑无力。查问此病之初，正当谷雨，乃少阴君火司令，阳气大升之时，虽当时有寒热无汗头痛之新邪，法宜清解，微透其汗为先。前医麻黄分量尚轻，而开泄之品过多，脱营之体，力不能胜，以致变症蜂起，坏象丛生。及扶起坐憎寒，卧又汗泄，亦当仿白芍、甘草汤法。更医又误以桂枝、温胆等汤，肌不解而痰反多，且营络更沸，痰红胁痛频增。脉症如斯，危机显露，请先留命，慢言治病。

疗法：先贤有云：存得一分阴，退得一分热。此时门户洞开，藩篱尽撤，首当育阴救本，仿集灵膏法，作滋苗灌根之策。本方加入二至，斡旋阴阳，牡蛎存阴止汗，阿胶补坎填离，鲜石斛得水石之精清滋胃肾而益脾阴，梨汁、蔗浆纯含天然真液，生津降火，功冠草木，入乳汁血液所成，借充营络而有殊功，日夜频进勿辍。

处方：别直参一钱，生、熟地各四钱，天冬连心一钱，麦冬三钱，女贞子二钱，旱莲草三钱，鲜石斛三钱，左牡蛎四钱，东阿胶三钱，甘蔗浆一杯，雪梨汁一杯，鲜人乳一杯，河水煎成，另冲浆

汁乳三味。

二诊：夜分稍静，呓语郑声均减，而汗仍未收，津仍未复，苔黑略退，舌绛依然，红痰减半，胁痛犹存，是方不为无效，不过救阴较补阳本难，水到渠成，稳持勿变。仍于原方之中，加生鳖甲三钱，生龟板三钱，五味子五分，以灵介潜滋肝肾，较草木事半功倍，更借五味之力，滋肝肾而敛肺止汗，又精不足者补之以味，此品独有之矣。

三诊：力挽颓波，诸恙均减，险象悉平，谅无枝节横生之患。惟是质虚，骤难复元，余烬仍嫌未熄。乃于原方去二至、鳖甲，专以养正涤邪，渐次转危为安。

效果：三候热已退净，汗亦全收，而精神委顿，起坐殊难，动则心悬欲脱。则参加至三钱，牡蛎、龟板用至一两。幸能饮食，嘱早晚以冰糖炖熟藕熟梨作点心食之。匝月始离床褥，诂料久卧之人，足力顿减，立则需人，嘱以靠椅铺褥坐之，以足践地，如移步状。依法行之，日渐有力，而复原状矣。

廉按：伏气春温，偶感新寒而晚发，折衷张长沙《伤寒论》者，每以麻杏甘膏汤为正治药。然就余实验，苟非其时、非其经、非其人之质，足以当之，鲜不为害，未可拘执古方而轻试也。历见温热病误服麻黄，或汗出不止而死，或咯血不止而死，或目赤唇焦、裸体不顾而死，或两颐暴肿溃烂而死，骤变坏证不治者多多矣。此案用集灵膏加味解救，幸而得生，然亦侥幸成功，不可尽信其一概得效也。

（选自《全国名医验案类编》，福建科学技术出版社 2003 年版，300-302 页）

李振华

用人参白虎汤加减治愈风温一例

韩某，女，34岁。

初诊：1982年2月20日。

主诉：患者发热已25天，经中西药治疗效果不明显，体温39℃左右，微恶寒，口干渴喜饮，汗出时多时少，头痛身痛，胸痛干咳，不思饮食，厌油腻厚味，心烦，睡眠不实，大便初头硬，二三日一行。

诊查：面色萎黄，形体消瘦，舌红，苔剥，脉浮数无力。尿常规：蛋白极微量，脓球7~10，红细胞0~1，血沉60毫米/第1小时。血常规正常。血培养及肥达氏反应阴性。

辨证：表部初解，内传阳明，里热炽盛，津气两伤。

治法：清热解毒，养阴生津。治以人参白虎汤加减。

处方：人参10克（另煎），生石膏30克（先煎），知母15克，葛根12克，元参30克，忍冬花20克，连翘15克，黄芩10克，生地15克，板蓝根15克。

二诊：上方药连进四剂，体温已降至37℃左右，睡眠已安，精神转爽，恶寒、头痛、身痛、胸痛等症皆除，汗出已少，但仍口干喜饮，食欲差但可少进油腻，四肢无力，足关节仍疼，尚有少许干咳，大便两日一行，不干，舌红，苔白，脉细略数无力。症已大见转机，但余热未清，气液损伤，改投竹叶石膏汤加减。

处方：淡竹叶10克，生石膏20克（先煎），麦冬15克，元参30克，细生地15克，白人参6克（另煎），陈皮10克，炒谷稻芽各10克。

上方药连服三剂，体温恢复正常，诸症悉除，食欲增进，肢体自感有力，精神转佳，大便正常，舌淡红，苔薄白，脉沉细。复查

血沉 23 毫米/第一小时，尿常规正常。

按语：温病日久，高热不退，口干渴喜饮。汗出，显系邪侵气分，阳明热炽。然有微恶寒、头痛、身痛等症，为表邪仍未尽除。古人云：有一分恶寒便有一分表证。热灼胃中故口渴，不思饮食，厌油腻厚味。热蕴大肠则大便秘结。其主证当属里热炽盛，非重剂白虎不足以清其热。然热邪久羁，必致津气两伤，故配人参以扶其正。人参白虎汤专为表邪已解、里热炽盛、津气两伤而设。此例虽表邪未尽，但用古方不应过于拘泥，只要主证相合，便可应用，虽有兼证，佐适当之药，便可两收其功。故投药四剂，即折其大半，唯余热未清，津气耗伤，故予竹叶石膏汤以滋阴清热，加陈皮、炒谷稻芽以理气醒脾，鼓荡胃气。继服三剂，竟获全功。

〔选自《中国现代名中医医案精华（一）·李振华医案》，北京出版社 1990 年版，36～38 页〕

李翰卿

论治感冒

治感冒重在认证，用成方妙在加减

李老认为，经常感冒的情况很多，有的一遇风吹即感冒，有的一吃辣椒即感冒，有的一到月经期间即感冒，综其大要有以下几种类型：

1. 营卫不调证：经常有胃脘不适的症状，出汗以后即感冒，鼻塞喷嚏，全身拘急不适，恶风，舌苔白，脉弦缓。治宜调和营卫，桂枝汤加减：

桂枝 9 克，生白芍 9 克，生姜 3 片，大枣 7 个，炙甘草 4.5 克。

若经常大便干燥者，再加生白芍 9 克，大黄 2 克。

2. 肠胃俱虚证：经常有胃脘冷痛或素有胃脘冷痛史，食欲较差，或遇冷或吃冷性饮食则胃脘冷痛或不适，冬天感冒尤多，遇冷、遇风尤易发病，发病后全身酸痛，微恶风寒，有或无明显鼻塞，指趾厥冷，脉沉细弦或沉细迟缓。治宜益气温阳解表，再造散加减：

黄芪 10 克，党参 10 克，肉桂 4.5 克，附子 4.5 克，细辛 3 克，当归 4.5 克，陈皮 6 克。

3. 气阴两虚证：面色和皮肤均比较白嫩，疲乏无力或无明显疲乏无力，不能劳累，有时头晕失眠，易哭，夏天感冒尤多，舌苔白，脉虚大滑或虚而缓。治宜补气养阴，补阴益气煎加减：

升麻 6 克，柴胡 6 克，黄芪 9~12 克，党参 4.5~9 克，白术 6 克，陈皮 6 克，五味子 6 克，生地 9 克，山药 9 克。

4. 卫气不固证：经常容易出汗，汗出后怕风，遇风即全身酸

痛，鼻塞流涕，疲乏无力，舌苔白，脉濡缓。治宜补气固卫，方用玉屏风散加味：

黄芪15克，白术9克，防风9克，荆芥9克。

或薯蓣丸，1日2次，1次1丸。

5. 三焦郁热，肺气不固证：经常有口苦口干，头晕头痛，大便干燥，小便黄，心烦，恶热，遇风则感冒，或头痛鼻塞，全身酸痛，或感冒后高热头晕，恶心呕吐，舌苔黄厚腻或黄，脉沉弦滑。治宜疏解三焦郁热，凉膈散加减：

黄芩6克，栀子6克，连翘6克，枳壳6克，薄荷4克，大黄1.5克，杏仁6克，甘草3克。

若心烦易怒者，宜大柴胡汤。

若小儿经常感冒，五心烦热，大便干，感冒后即发高热者，升降散加减：

僵蚕6~9克，蝉蜕6~9克，片姜黄6~9克，大黄1~3克，苏叶3~6克。

鼻流清涕者加防风3克。

6. 肝郁血虚，肺气不固证：经常头晕头痛，心烦易怒，胸胁窜痛或胁下痞满，口苦口干，五心烦热，每至月经期间即感冒，感冒后症见头痛，全身酸痛，微有恶寒，脉弦细。治宜解郁疏肝，养血清热，逍遥散加减：

柴胡9克，当归9克，白芍9克，白术9克，茯苓4.5克，薄荷6克，生姜3片，炙甘草6克。

（选自《中国百年百名中医临床家丛书·李翰卿》，中国中医药出版社2004年版，7~9页）

杨熙龄

论治暑疫

表弟周克庵学正士燮熟精医理，道光丙午夏暑风甚剧，时疫大作俱兼喉痛，亡者接踵，医皆束手。克庵家病者甚众，亲自疗治获痊，悯世医之寡识，为作论曰：暑风由口鼻而入，时冷秽气亦由口鼻而入，先伤上焦于太阴肺经，其始见症也。或喉痛而腐或不腐，洒洒恶寒，蒸蒸发热，有汗不解，遍体现红晕，舌白腻，首用辛凉平剂，连翘、薄荷、荆芥穗（性升散不妥），金银花、淡豆豉、牛蒡子、苦桔梗（不妥），杏仁（不妥），玄参性（滋腻不妥），紫马勃（不妥）；瓜蒌皮、白茅根、竹叶可随证选用，以表泄表风，兼宣秽浊。其继也，但热不寒喉痛仍在，痰涎稠腻，目红多眵，舌绛无苔，红痢杂以白疹，烦渴，瞽闷，躁扰不安，寐则自语，醒则神清，状类犀角地黄及白虎汤证。不知肺卫与心营甚近，此系肺热侵通包络，未尝竟入营分，以神不昏昧辨之，此时遽予犀角是开门揖盗也。（俗治温热病动手即用羚羊角、犀角，邪本在肺胃乃转引之入肝心，转病致重职是故尔。）或识蒙窍阻犀角并牛黄清心丸、至宝丹亦不在禁例。至白虎证，脉洪大，自汗不止，口渴无度，遵古法服之诚无误。倘用不合法，恐肺经之邪热无出路致下迫大肠而为病也，宜用川郁金（不妥），黑山栀（宜生用，若炒黑则为无用之物矣）。瓜蒌皮、芦根、竹叶、桑叶、杭菊之类，以廓清热邪，泄秽气。如毒重者甘草、人中黄、大青叶、板蓝根亦可随意加入。再兼证或有身痛肢软（此欲转痛风，又名历节风）。即暑风流走肢体，参用防己、秦艽（不妥），桑枝一二味。（不济事宜，参用黄蘗、木通，便燥，加川军外搽樟脑精），可也。总之此证留恋于太阴肺经居多，故用药宜轻清宣解，不必用苦寒沉降之品，诛伐中下二焦无过之地。

热病愈后往往归之于足，发热肿痛不治则痛甚而死，或致残废，如截足风之类。

咸丰戊午春，余母周太孺人偶发寒热，忽患此证，时余在杭，内人周婉霞在家侍奉，检医书一方，用广胶一两，入糟醋姜葱汁四味，烱化成膏，摊纸或布上，贴患处痛立止。（糟人醋中，将糟啮碎调匀，滤出汁去糟渣勿用，姜汁不必多只用少许，葱汁较姜汁多一半，糟醋汁须三四倍于葱汁）。

庚申冬初姬人李氏患伏暑，愈后两足肿而不红，其痛尤剧，服去湿清热药不效，用此方治之痛亦止，真神方也。因忆道光年间邻人陈氏妇曾患此证，诸医莫能疗治，后以足浸冷水中，号呼痛绝而殒，惜当时未得此方拯之，特详志于此，愿有志者广传焉。

王孟英（上略）更有愈后手指足缝出水，速投米仁三两、茯苓三两、白术一两、车前子五钱、桂心一钱，名驱湿保脱汤，连服十剂可免脚趾脱落，此即谚所谓脱脚伤寒也，亦不可不知。

《重庆堂随笔》注，温病虽能成疫，而治温、治疫有殊。吴又可混同论治未免粗疏，且不知暑热亦能成疫，乾隆甲子（都中暑疫）热死者无算，徐后山《柳崖外编》尝言之，嗣有余师愚专论热疫，惜其书未甚流行耳。

（选自《现代著名老中医名著重刊丛书·著园医话》，人民卫生出版社2008年版，43~44页）

杨燧熙

春温案

病者：陈济川，年五十五，镇江商人，住镇江西门城外。

病名：春温。

原因：幼年完婚太早，后伤酒色而患淋浊，服止涩药过早，毒逼于内，致腿缝生鱼口之症数月。显系内因阴虚，外因温邪而发。

证候：头痛恶寒发热，浑身骨疼，大便数日不行，小溲赤，口不渴，腹部拒按，唇齿干燥，咳嗽不爽，脘闷不舒。

诊断：脉浮滑数，两关较大，舌苔淡黄，朱点甚多。脉症合参，断为温病，此《内经》所谓“冬不藏精，春必病温”也。

疗法：先进桑菊饮加减以清热，继投调胃承气汤加味以下积。

处方：霜桑叶三钱，苦桔梗二钱，净连翘二钱，炒黄芩钱半，杭白菊三钱，薄荷叶八分，瓜蒌皮三钱，京赤芍钱半，光杏仁二钱，生甘草五分，大贝母三钱，枇杷叶二钱（去毛筋净）。

接方：金银花三钱，瓜蒌皮三钱，生甘草一钱，净连翘三钱，生箱黄二钱，黑山栀三钱，川石斛三钱，元明粉钱半（冲服），毛知母钱半，葶苈三枚。

效果：初剂热解，二剂便行，三剂即能起立，可吃稀糜饮少许。后以滋养法，调理二三剂而康健。

廉按：初用辛凉轻剂以宣上，继用苦寒重剂以攻里，此注重肺胃之治法，是得力于《温病条辨》者。

（选自《全国名医验案类编》，福建科学技术出版社2003年版，287页）

肖龙友

清降法治愈风热喘咳医案

齐某，男，60岁。

初诊：1952年8月30日。

主诉：近日因感风热化痰，成为喘咳，或不能起行，亦不安卧，耳内时鸣，喉际汨汨有声。

治法：当从事清降。

处方：南沙参10克，薄荷梗6克，西防风6克，天花粉10克，苦杏仁10克，苦桔梗10克，知贝母各10克，半夏曲6克，灵磁石12克（先煎），云苓块12克，真郁金10克，甘草10克，鲜荷梗一尺，生姜6克。

二诊：9月10日。服前方药多帖，病去十之八九。但痰犹未尽，耳鸣未减。肝胃有热，肺气尚虚，法当从本治。

处方：南沙参12克，苦杏仁10克，苦桔梗10克，天花粉12克，嫩白前6克，京贝母10克，肥知母6克，云茯苓12克，灵磁石12克（先煎），甘枸杞10克，干生地10克，生甘草3克，生藕节5枚，甘菊花6克。

按语：清肃肺胃痰热，则喘咳自宁。药用清润，知其为燥热之痰。以防风、薄荷疏散风热，重在化痰，郁金能开肺金之郁，磁石善治耳鸣，故初诊后病即去十之八九。

〔选自《中国现代名中医医案精华（三）》，北京出版社2002年版，1512~1513页〕

吴古年

论治风温郁火

春温时邪自太阴而干及阳明，初起微憎寒，继即恶热，化火化痰，逆走包络，神思语言渐次昏昧，迄今月余。消烁肺胃之津液，又伤及厥阴，激动肝风，口噤肢搐，亦相因而见。脉数，左三部更往来无韵。内闭已著，诚为险候，勉拟清营育液，豁痰宣络，佐以芳香通神之品，去其痼热。就正高明。

人参须一钱五分，辰砂茯神三钱，西黄一分，珍珠末二分，陈阿胶二钱，紫雪丹四分，胆星八分，川贝四钱，辰砂拌麦冬三钱，粉丹皮三钱，纯钩钩五钱，石菖蒲汁四茶匙，竹沥一两。

（选自《近代中医珍本集·医案分册·吴古年医案》，浙江科学技术出版社2003年版，123～124页）

论治风温神昏呃逆

年逾七旬，正气自虚，因感温邪，初起憎寒，继则发热，兼大便秘结，此邪自太阴而扰及阳明也。热蒸为痰，上干心营，故有神昏之候。迄今旬余，已得更衣四次，以阳明为顺也。身热既退，谷食少加，里邪渐去可知。其呃逆未能尽除，属元气中馁，阴阳清浊之升降未得自如。暮夜小有谵语，水溺频数而少，又属肝肾不足，而心阳亦欠收摄。脉得四至，按之濡细，似得六阴之本体。舌尖光红，中有腻白厚苔。扶正和中、滋养肝肾固为最要，而清营育液、运化痰浊之品亦参酌其间。

高丽参，生于术，连心麦冬，抱木茯神，海石拌生地，淡竹茹，粉丹皮，怀山药，霍山石斛，宋制半夏，青盐制陈皮，糯稻根须，枇杷叶，刀豆子。

(选自《近代中医珍本集·医案分册·吴古年医案》，浙江科学技术出版社2003年版，126页)

论治风温

身热口干，咳嗽脘闷，邪留肺胃可知。脉数偏右。深恐邪入心，有神昏痉厥之变。

羚羊角一钱，连翘一钱五分，牛蒡子一钱五分，黑山栀一钱五分，白杏仁三钱，象贝二钱，鲜石斛四钱，小川连三分，粉丹皮一钱五分，飞滑石三钱，通草一钱，竹茹一钱五分，芦根尺许。

(选自《近代中医珍本集·医案分册·吴古年医案》，浙江科学技术出版社2003年版，151页)

治春温医案

病起春温，迄今十有余日，犹然热蒸作潮，汗出不彻，咳逆痰稠，喉有嘶音，邪有余蕴、肺胃失降可知。神疲嗜卧，时而呻吟，经水又先期而至，营阴亦未免受伤。脉濡小，久按之则左关带弦，右寸关微兼滑数。虚实错杂，岂容轻视。

高丽参，抱木茯神，地骨皮，生蛤壳，绿豆衣，粉丹皮，竹茹，冬瓜仁，金钗石斛，川贝，杏仁，枇杷叶。

(选自《近代中医珍本集·医案分册·吴古年医案》，浙江科学技术出版社2003年版，127页)

此春温证也。虽已七日，犹然神识如蒙，便结不通，是邪化为热，热化为痰，自肺胃气分扰及心营也。顾肿右起赤斑，胸次亦隐约红疹，右手指微有掣搐，少阳亦受病矣。脉弦数滑相兼，左为甚。恐液耗风动，将有闭脱之忧。谨拟清营生津，佐以芳香通神之品，去其痼热，谅合病情。

犀角尖，羚羊角，玄参心，鲜生地，连翘心，陈胆星，紫雪丹五分，天竺黄，纯钩钩，粉丹皮，赤茯神，川贝，辰砂拌灯心，竹

沥一两，鲜石菖蒲汁三茶匙，银花露送下。

（选自《近代中医珍本集·医案分册·吴古年医案》，浙江科学技术出版社2003年版，128页）

治时感温邪医案

感风辄觉头痛，血虚可知。寒热似疟，作止无定，营卫虚而欠和也。日来咳嗽时作，又微有时序温邪自肺袭人。兼顾为宜。脉初持濡小，久按则左关带弦，右寸关微带滑数。拟方候正。

西洋参一钱五分，连翘一钱五分，牛蒡子一钱五分，黑荆芥一钱五分，粉丹皮一钱五分，北杏仁三钱，水炒竹茹一钱五分，纯钩钩三钱，川贝母二钱，生米仁六钱，胡麻仁三钱，杭菊花一钱五分，经霜桑叶一钱五分，冬瓜仁三钱，枇杷叶三张。

（选自《近代中医珍本集·医案分册·吴古年医案》，浙江科学技术出版社2003年版，152页）

治痰饮兼时感医案

寒热往来，时复呕恶，总属痰饮泛动，以致肺胃欠和，脉濡小且柔，岂是轻易调治之候。

柴胡三分，生鳖甲二钱，淡干姜五分，赤苓五钱，青盐制陈皮一钱五分，宋制半夏一钱五分，旋覆花一钱，代赭石二钱，金铃子一钱五分，炒黄秫米三钱，水炒竹茹一钱，红枣四枚。

（选自《近代中医珍本集·医案分册·吴古年医案》，浙江科学技术出版社2003年版，153页）

吴兴南

治时行冬温医案

病者：刘姓女，年二十岁，辽阳县人，住玉嘉沟。

病名：时行冬瘟。

原因：民国六年八月望后至二十三等日，天气似烟非烟，似雾非雾，昏迷岚瘴，日为之赤，昼为之暝，别有一种气氛。是女为人拾棉，早出暮归，感染斯疫，伏至冬初病作。

证候：四肢酸软，头目昏眩，目眦如血，胸满气喘，神昏谵语，甚则抽搐，两目天吊，牙关紧闭。

诊断：脉来洪大有力，人迎气口尤盛，呼吸之间，脉约八至，满舌浊苔。直断为时行冬瘟，不可误认作伤寒。

疗法：先用双甲重按其少商两穴，抽搐顿止，以通关散通其肺窍，少时得嚏。次用芒针，量病人中指中节横纹为度，刺其左右两鼻孔，令血盈盂；又刺颊车、曲池，泻合谷，病者能言矣；次泻廉泉、玉英、手之三里，并中冲、劳宫，心包络经得开；刺左期门，泻肝经邪热；刺右章门，劫肺窍温毒。又次用刮法，顺刮其两胁与两尺泽，如刮痧状，均令黑紫，两腿犹言紧急。又取承山、鱼腹、委中等穴刺之，病觉稍安。此急则治标之法。用药以解毒活血，新加羚羊角汤，方用羚羊角为君，性善解毒，直清肺肝，安神定魄，镇风定抽，双花重用解毒，红花、桃仁专行破血，菊花为清静之品，得秋肃之气，花开于顶，其香清馨，不杂浊味，能清头风，人共知之，能辟瘟毒，人鲜知焉，重用三钱以清温解毒，根朴、榔片、枳壳，吴又可达原饮曾用之，其槟榔一名劫瘴丹，生于热带烟岚之地，治瘟疫生用，大得效力。土瓜根即天花粉，能荡平胸中实热，性擅解毒，尤专止渴。

处方：羚羊角二钱（磨服），金银花五钱，南红花三钱，甘菊

花三钱，土瓜根三钱，生桃仁二钱（去皮），钩藤钩三钱，坚榔片三钱，川根朴二钱，炒枳壳二钱，生甘草一钱，净连翘二钱。

效果：服二帖，诸症大减，惟尚有谵语。又予自配牛黄安宫丸二丸，服之神清。嗣用清养法调理月余而痊，然已发落甲脱，自己尝言重生也。

廉按：症既明辨，法宗清任，况解毒活血汤，本治热疫之良方，能对症而加减善用之，自然应手奏功。

（选自《全国名医验案类编》，福建科学技术出版社 2003 年版，358～359 页）

何任

温病医案

例一，胡某，男，40岁。

初诊：1972年2月4日。身热面赤，齿干唇焦，目瞑嗜卧，神昏谵语，大便未下，手足扰动，脉数。以清热开窍为主。

连翘12克，黄芩9克，焦山栀9克，郁金9克，金银花12克，生甘草4.5克，鲜生地30克，滑石9克，安宫牛黄丸二颗（分两次研送），二剂。

复诊：2月6日。药后身热除，神志已清，大便下一次，扰动亦安，惟小便赤，脉数，唇舌干。以清热解余烬而滋育。

连翘9克，黄芩9克，鲜生地15克，银花9克，玄参9克，淡竹叶9克，百合12克，金石斛9克，益元散12克（包煎）。四剂。

按：冬春之交，感受温邪，内传营分，耗伤津液，而见身热面赤，齿干唇焦；邪入心包，故神昏谵语，目瞑嗜卧；津伤风阳鸱张，而见手足扰动。处方以银翘栀芩清热，鲜地生津，滑石利尿而引热下行；再以安宫牛黄配郁金宣窍清心。二剂而神清热退，改用生津为主，清热为辅，佐以利尿之剂以清余邪，充分体现了叶天士的“炉烟虽熄，灰中有火”的治疗原则。用药灵活，丝丝入扣，所以疗效显著。

例二，贾某，男，10岁。

初诊：1970年6月5日。头痛身热已三数日，纳滞不展，恶心呕不出，渴欲饮。今晨起头痛转剧。嗜睡唤之不醒，苔白黄，脉浮数，腋下体温39.5℃。先予清解。

连翘12克，金银花9克，淡竹叶9克，生石膏15克，生甘草4.5克，知母6克，桑叶9克，黄芩9克，生山栀9克，鲜芦根1

尺。二剂。

复诊：6月7日。高热未已（腋下体温 39.5°C ），神志昏沉，手足抽搐，闭目扰动，大便三日未下，唇红而燥，脉数盛。治宜清热熄风解毒。

炒天虫9克，全蝎1.5克，大青叶9克，连翘12克，生石膏30克，知母6克，生甘草6克，生山栀9克，生大黄4.5克，黄芩9克，石菖蒲4.5克。安宫牛黄丸1颗（研灌）。二剂。

三诊：6月10日。6月7日方服后（以购药耽误迟服一天半），神昏一度清醒，唤之张目，呕恶已解，大便下一次，稀烂臭秽，尿少而棕赤色，搐动已止。唇干舌绛，腋温 38.5°C ，脉细数。续当清热解毒救阴。

生石膏15克，知母9克，生甘草4.5克，粳米1小盅，连翘12克，鲜生地30克，玄参9克，赤芍9克，石菖蒲4.5克，丹皮6克，淡竹叶心6克，大青叶9克。三剂。

四诊：6月15日。神志转清，身热亦平，偶尚见手足颤动，倦怠溲少，舌绛苔薄，脉虚。

鲜生地30克，麦冬12克，白芍12克，焦枣仁9克，火麻仁6克，牡蛎12克，炙鳖甲12克，阿胶9克，朱茯神12克，炙甘草9克，玄参9克，连翘9克。三剂。

五诊：6月18日。

脉静身凉，神清，溲亦长，色转黄，渐思饮食，已入坦途矣。

北沙参12克，麦冬9克，生甘草6克，天花粉6克，连翘6克，白术6克，茯苓9克，牡蛎9克，净滑石9克，白扁豆12克。四剂。

按：本例初起以高热、头痛、恶心、渴饮、嗜睡为主要症状，乃热邪逗留气分，有渐入心营的趋势，正如叶天士所说：“不从外解，必致里结。”拟方以清气分邪热立法。

由于热毒壅盛，内传之机已露，故很快地出现化风症状，同时气分之邪未罢，复诊时呈现气营两燔现象，何医师采取两清气营，熄风宣窍方法，两剂即热降神清，这是一个极为重要的关键时刻，是挽狂澜于将倒的有力措施。三诊以清热解毒养阴立法，既清余

邪，又培本元。只缘阴液过耗，邪热虽解，而终见虚风内动之象。四诊以二甲复脉立法，阴复风靖。最后转以调理而安。

（选自《何任医案选》，浙江科学技术出版社 1981 年版，4~6 页）

何书田

治温热病医案

例一，右，三十四岁。证自十一日始，寒热如疟，每晚必至，渐致神思昏乱，连次发厥。现在心志稍清，而耳不聪听，懒言目瞪；舌苔黄而带黑，脉象弦大不摄。此温邪由少阳而传入厥、少二阴矣，势颇棘手。且在怀妊之体，尤可惧也。旦晚防其痉厥，此方勉拟。（十一月廿七日诊）

犀角五分（磨冲），鲜生地七分，黄芩钱半，石决明七分，川连四分，黑山栀钱半，丹皮二钱，石菖蒲钱半，生甘草四分，赤茯苓三钱，橘红八分，茅根，竹心。

复诊：

前用清心泻热之法，夜间疟势稍轻，神志略觉清楚，舌根黑色未退，脘闷烦躁；脉右大于左，而不甚数。可见时邪尚盛，阳明宿垢未得通达，转而为呃逆、昏愦，不可不防。姑照前方略添承气法，未知效否。廿九日诊。

犀角四分，鲜生地六钱，柴胡梢五分，石决明六钱，川连四分，黑山栀钱半，肥知母钱半，生甘草四分，赤苓三钱，牡丹皮二钱，青麟丸钱半（研冲）。

又复：

昨用清通之法，宿垢已下，神思渐清，似属转机。但温邪尚盛，舌黑色退而未净，安危尚未定也。再与清热滋润，以图渐添佳境为幸。

犀角尖四分，鲜生地六钱，肥知母钱半，生苡仁三钱，羚羊角一钱，牡丹皮二钱，天花粉二钱，赤茯苓三钱，白归身二钱，芦根五钱。

三复：

日来热势渐退，夜间疟疾已止，舌黑十去其七八，此佳兆也。但时邪去而真阴内亏，神志躁烦，夜卧不安，脉形弦大。此属三阴证之见象，不可以小效遂视为稳境也。

原生地，炙龟板，白归身，麦冬，知母，茯苓，羚羊片，牡丹皮，京玄参，鲜斛，花粉，枣仁，竹心。

例二，某，初患阳明挟邪停滞，迭投承气之剂而渐解；现在舌苔仍黄，口中秽热之气颇盛，咳痰带红，膈次满闷不舒。此属肺胃郁火内燔，娇脏被伤所致，所以右脉沉弦而滞，二便不利。延久必成肺痿之候，难期速效也。

炒川连，淡黄芩，瓜蒌霜，生苡仁，赤苓，广橘红，黑山栀，白杏仁，生石膏，芦根。

复诊：

昨用三黄加减法，大小便已通，而不甚爽利，舌苔仍带黄色，脉象弦而不数。所嫌湿热下注，昨晚遗泄一次。胃气终不贪纳，阳明之郁热未清，气机无由舒快。久恐延为阳疽之候，殊难速效。再拟化热利便养胃法，以冀得谷为妙。

炒黄芩，丹皮，炒黄柏，瓜蒌霜，苡仁，香粳米，黑山栀，知母，鲜石斛，甜杏仁，赤苓，芦根。

又复：

舌黄渐退，秽热之气稍减。惟膈次不快，右寸关弦数有力，此属上中焦郁火未泄。再拟清通一法，得下窍润利为妙。

炒川连，黑山栀，杏仁，生苡仁，橘红，淡黄芩，瓜蒌仁，通草，赤茯苓，青麟丸（研冲）

三复：

迭投清通苦泄之剂，积垢积湿俱已清彻。惟脉形细软，胃气未旺。从此静养，可冀痊愈安也。

细生地，肥知母，鲜石斛，赤茯苓，橘红，石决明，甜杏仁，天花粉，水梨肉。

例三，某，初起寒热，继则寒微热盛，胸膈胀闷，舌微黄而脉不甚数。此由阳明邪伏食滞所致，防其壮热神昏。

炒中朴，草果仁，肥知母，炒山栀，赤茯苓，炒枳实，全瓜蒌，淡黄芩，法半夏。

复诊：

照前方去山栀加大黄。

例四，某，少阳阳明邪郁气滞也。防其壮热神昏，暂用疏泄之法，然不可忽视。

炒柴胡，炒小朴，法半夏，焦建曲，赤茯苓，炒黄芩，炒枳壳，草郁金，生甘草，新会皮。

例五，某，气郁食郁，兼感时湿。身微热而脘次窒闷，时吐痰沫，脉象弦细而数。势颇淹缠，若得阳明之气通达，可冀全愈。

炒中朴，全瓜蒌，川郁金，赤茯苓，陈皮，炒枳实，法半夏，炒竹茹，黑山栀，生草。

复诊：

照前方去郁金、竹茹，加煨木香、莱菔子。

例六，某，始起恶寒，现在寒微热盛；舌苔白而中间微带黄色，耳不聪而鼻煽，神气倦怠。此少阳阳明感受湿邪所致，非小恙也。防发昏谵语。

软柴胡，炒厚朴，草果仁，淡黄芩，赤茯苓，煨葛根，尖槟榔，炒枳壳，瓜蒌皮，生甘草。

例七，某，初患霍乱呕吐，现在身微热而不寒，舌苔黄滞；六脉沉微。则知外邪将彻，里结未通。暂用小承气法加减。然须节饮食为要。

炒中朴，枳实，炒黄芩，焦建曲，赤苓，滑石，制大黄，广藿香，黑山栀，生甘草，陈皮，荷梗。

复诊：

里邪既达后，舌苔又现黄滞，身微热，而大便不通，脉沉弦不数。知阳明宿邪未尽，少阳余热未清，颇有淹缠之势。兹用小柴胡参小承气法，再视进止（是证后服西瓜，便通热退而愈）。

柴胡梢，炒枳实，全瓜蒌，广藿香，赤茯苓，淡黄芩，炒中朴，肥知母，广陈皮，青麟丸。

例八，某，阳明挟食，少阳感邪，恐有热炽神昏之变。

炒柴胡，炒黄芩，炒中朴，瓜蒌仁，赤茯苓，煨葛根，炒山梔，炒枳实，法半夏，广橘红，生甘草，鲜荷叶。

例九，某，时邪热结于阳明，身热脉数，脘闷便闭。用白虎合承气法。

生石膏，炒枳实，生锦纹，风化硝，鲜生地，炒小朴，全瓜蒌，炒知母，生甘草，天花粉。

例十，某，少阳挟邪、阳明停滞，身热不凉，舌苔黄色。防谵语神昏，得下为妙。

软柴胡，炒小朴，生军，黑山梔，生甘草，淡黄芩，炒枳实，蒌全，赤茯苓，新会皮。

例十一，某，阳明少阳蕴热挟食，六脉沉微。防谵语发狂。

柴胡梢，炒黄芩，炒枳实，法半夏，生甘草，煨葛根，炒小朴，全瓜蒌，赤茯苓，炒山梔。

复诊：

温邪渐解，治以清理二阳之火为主。

炒黄芩，炒山梔，甜杏霜，生苡仁，赤苓，净连翘，湖丹皮，天花粉，生甘草，橘红。

例十二，某，阳明少阳，时热内蕴为患也。防热甚发谵语，不可忽视。

柴胡梢，炒黄芩，炒小朴，炒青皮，赤茯苓，煨葛根，黑山梔，炒枳壳，广陈皮，生甘草。

例十三，某，肺家温热内蕴，兼之木火烁金，但热不寒，多痰舌绛，脉来沉细而数。已入少阳之经，防谵语神昏，不可忽视。

羚羊片，牡丹皮，光杏仁，川贝母，花粉，黑山梔，石决明，肥知母，鲜石斛，橘红

复诊：

温热已解，神志亦清，可用清凉甘润之剂。

羚羊角，牡丹皮，黄芩，知母，鲜石斛，天花粉，鲜生地，黑山梔，石膏，麦冬，人中黄，竹叶心。

例十四，某，时邪内蕴，传与厥、少二阴之经。不时谵语神昏，舌滑思饮，吐痰不已，六脉虚微濡数。极险之候也（七月二

十一日诊)。

川黄连，原生地，牡丹皮，远志，天竺黄，橘红，羚羊片，炙龟板，黑山栀，菖蒲，炒竹茹。

复方（二十四日）：

川黄连，鲜生地，丹皮，天竺黄，茯神，橘红，羚羊角，炙龟板，知母，石菖蒲，紫雪丹一钱（冲）。

又复（二十八日）：

羚羊尖（磨冲），原生地，知母，朱茯神，天竺黄，橘红，炙龟板，牡丹皮，麦冬，生枣仁，煅龙齿。

三复（八月初四日）

西洋参，麦冬，远志肉，生枣仁，柏子霜，炙龟板，茯神，建莲肉，原生地，广橘红。

阴虚骨蒸，兼以少阳邪蕴，齿痛身热。暂用清凉法。

青防风，煨葛根，生石膏，炒山栀，广橘红，薄荷叶，淡黄芩，桑白皮，生甘草，芦根肉。

例十五，某，初患阳明热结，得下始安；继则小便短缩，赤淋血痢，脏腑之受病颇深。现在两便均调，精神疲倦，纳食不贪，舌绛而滑；六脉沉微无力，夜卧不适。此由时邪内伤，阴液久而不复，以致淹缠而见大虚之象也。急须峻补真水，兼扶元气。然六秩高年，难许全吉。

台人参，炙龟板，五味，炒归身，茯神，桂圆肉，炒熟地，陈阿胶，麦冬，料豆皮，枣仁。

复诊：

证由时疾后气阴两亏，致虚象迭现。前服滋补之剂，而胃气不增，大便溏薄，殊难措手。再拟摄纳肾阴，兼理脾阳法，未知有效否。

台人参，炙龟板，山药，炒枣仁，金石斛，莲子，熟地（砂仁末炒），炙五味，茯神，炙甘草，桂圆肉。

例十六，某，十日前夜卧不宁，感冒寒热，饮食不进。近三日来壮热不寒，连得大汗，而热仍不退；口渴喜饮，舌尖红而根蒂白，神倦懒言，手足忽冷忽热，汗出不干；脉形滑大，右关空弦。

此由阴虚挟邪，阳明蕴热未得透泄，而元气已散，大危之候也。姑拟生脉合白虎法，以图转机。

台人参，炙五味，肥知母，鲜生地，白茯苓，麦冬肉，生石膏，生甘草，霍石斛，白粳米。

（选自《蕺山草堂医案·温热》，上海中医学院出版社1989年版，82~89页）

何炎燊

论治温病医案

1. 温邪传里，肺胃同病

黄某，男，45岁，干部。1990年春节前天气温煦，风阳鼓荡，流行性感在莞城流行。患者早饭后感受风邪又加劳累，即发热，头痛，口渴不欲饮，咳嗽轻而胸脘满闷，用西药退热药及抗生素未效，继而腹痛下利溏黄多次，脘胀欲呕，小便短而不畅，医者建议入院，患者先驱车就何氏诊。持其脉浮滑数，舌苔薄黄干腻，此冬令风温，肺胃俱受，热邪下注大肠也。用陈氏升泄法加味治之，处方：煨葛根20克，黄芩、竹茹、豆卷各15克，厚朴、桔梗各10克，橘皮、甘草各5克，滑石20克，嘱其即服1剂，黄昏时再服1剂，看病情如何，再商量是否入院。晚上9时，患者电话告何氏，现已热退，利止，痛除，溺畅，惟觉疲倦饥饿耳，问能否进食，以明日尚须外出公务也。是夜食粥两碗，安睡一宵，天明即工作如常。

按：“陈氏升泄法”见《温热经纬·陈平伯外感温病篇》第五条。原文云：“风温证，身热咳嗽，口渴下利，苔黄谵语，胸痞脉数，此温邪由肺胃下注大肠，当用黄芩、桔梗、煨葛、豆卷、甘草、橘皮之属，以升泄温邪。”后贤张聿青善用此法，《张聿青医案·风温门》第二案初诊所用之“薛氏升泄法”，即此方加味。而陈氏却变为薛氏者，因此卷《外感温病篇》最初名《温热病指南集》，题陈平伯撰。后吴子音刻叶、薛、缪三家医案时，附录此卷，易名为《温热赘言》，却题寄瓢子述，后人认为是薛生白所作。姑勿论作者为谁，现以《温热经纬》为准，名之曰“陈氏升泄法”。王孟英评注此条，颇多偏见。如云：“（下利）正是病之去路，升提胡可妄投？……况有咳嗽胸痞之兼证，岂葛根、豆卷、桔

梗之所宜乎？当易以黄连、桑叶、银花。”果如王氏所增删者，则此方只泄不升，与作者立方原意不符矣。试看陈平伯自注云：“温邪下利是风热内迫，虽有谗语一证，仍是无形邪热蕴蓄于中，……故用葛根之升提，不任硝黄之下逐也。”此论实从《伤寒论》之太阳邪陷阳明用葛根黄芩黄连汤一法中悟出，且经实践检验而化裁者。葛根既是主药不可去，桔梗亦不可删。叶氏《幼科要略》论春温、风温初起，皆列清心凉膈散为首选之备用方。此方即凉膈散去硝黄之下夺，加桔梗为舟楫之官，上行而清胸膈无形风热，陈氏此处用桔梗，即取其意。至于大豆黄卷，《纲目》谓能除胃中积热，王孟英自订之蚕矢汤，亦用之与芩、连、蚕矢、木瓜配伍，治热性霍乱吐泻转筋，豆卷岂升提药乎？故陈氏升泄法之妙，在此三昧，王孟英肆意吹求，致使后人畏忌而弃置此法不用，良可慨也。

风热内迫肺胃，表里皆受，此证常见，尤以儿童为然，可以陈氏原方为基础，并根据其原文所列之证候加味，常收良效。陈氏升泄法原方（药量乃何氏所订）：煨葛根、黄芩、豆卷各 15 克，桔梗 10 克、橘皮、甘草各 5 克。

身热，表证较重，无汗，里热较甚，口渴喜饮，心烦，潮辣者，加银花 15 克，竹叶 12 克，芦根 30 克。咳嗽痰稀，喉痒者加前胡 10 克，北杏仁 12 克。痰稠难排者加桑白皮、瓜蒌仁各 15 克。下利黄秽，肛热后重者加黄连 10 克，白头翁 15 克。下利溏滞，腹满痛者加厚朴 10 克，山楂 18 克。胸痞气逆者加瓜蒌皮 10 克，郁金 10 克。胸痞脘闷欲呕者加竹茹 15 克，半夏 10 克。谗语一证较少见，而多是心烦懊恼不安，睡中梦呓，加山栀子 12 克，豆豉 10 克。

总之，前贤经验，可法可师，临证加减，活法在人耳。

2. 伤暑高热，腠理内闭

叶某，男，7 岁，1994 年 7 月 10 日初诊。初因发热不退，曾入某医院治疗，经全面检查无异常，诊断为流行性感冒，西药用抗病毒及静注等法，又结合中药治疗，用白虎、芩连等药，治之 7 天未效，乃来就何氏诊。

病孩面赤，神烦，壮热（40.2℃），无汗，胸痞，肌肉酸痛，

潮黄，口苦不渴，舌黄，脉数，寸浮关滑。此暑热仍在肌表，予清络饮合鸡苏散：

丝瓜络、荷叶、金银花、淡竹叶、篇蓄花各 15 克，西瓜皮、滑石各 25 克，甘草 5 克，薄荷 7 克。

小孩服药后，黄昏时微汗濺然，体温稍降，又将药渣再煎服一次，入夜汗出溱溱，热随汗退，翌晨已退至 37.5℃，脉转大数，口渴思饮，再予竹叶石膏汤两剂病愈。

按：此病本不重，前医用重剂治之不效，何氏用轻药治之而愈者，关键在于辨证。忆 40 年前，有一自诩为“科学化中医师”者，谓治外感热病，用体温计可测其轻重而用药，凡 37℃ ~ 38℃ 者，用银翘散，38℃ ~ 39℃ 者用白虎汤，40℃ 以上者用羚羊紫雪云云。识者皆嗤之。时至今日，仍有以西套中者，见病孩壮热至 40.2℃，则用白虎芩连等大寒之剂，忽略无汗，不渴，脉不洪而浮，非白虎汤所宜。古云“体若燔炭，汗出而散”，常有表证壮热用辛温解表而愈者，故中医之寒热，并不等于体温计之高低也。

清络饮一方，见《温病条辨·上焦篇·暑温》，由鲜荷叶边、鲜金银花、鲜篇蓄花、竹叶卷心、丝瓜皮、西瓜翠衣等六味药组成（无鲜品用干者亦可）。原治暑温余邪未解，但头微眩，目不了了者。又云：“凡暑伤肺经气分之轻证皆可用之。”何氏不但用之治暑证初起之轻者，若加减用之得宜，亦可治重证，此“轻可去实”之妙也。今治此例，兼见脉浮无汗，故加入鸡苏散（六一散加薄荷）。

薛生白《湿热条辨》第 21 条云：“胸痞发热，肌肉微疼，始终无汗者，腠理暑邪内闭，宜六一散一两，薄荷叶三四分，泡汤调下，即汗解。”刘河间创六一散，可治各种暑证。加入薄荷解表，可得微汗而解，与清络饮合用，投剂即效。

附记 45 年前一案：1952 年夏，何氏在联合诊所工作，一日，时近黄昏，诊务已完，何氏下班回家，刚出门，友人带一中年商人请何氏一诊。自述发热已 1 周，服药多剂未效，现仍身热无汗，肢体微疼，胸脘不舒，溺短不渴，脉浮濡略数，正薛氏所云暑邪内闭腠理之证，书方：

滑石 30 克，甘草 5 克，薄荷 5 克，急火煎数沸，乘热服之。

商人见方，面有愠色，归谓友人曰：“汝说何某人诊病细心，现匆匆开方，药仅三味，无非敷衍塞责耳。”友曰：“时已入夜，姑服之，明日易医可也。”

翌晨，商人来所复诊，频呼：“真妙药，昨夜服后 2 小时，遍体汗出，全身轻快，入睡颇安，今晨诸恙悉退矣。”此事与本例有类似之处，故记之以为佐证，可知前贤经验，极为宝贵也。

（选自《中国百年百名中医临床家丛书·何炎桑》，中国中医药出版社 2004 年版，15～19 页）

余无言

论治春温痰火发狂证

春温不解，邪热入于营血，身有斑疹，色紫黑，肌肤炙手，内热如焚，唇焦齿垢，舌苔燥黄。初则谵语神糊，继则发狂乱走，如见鬼神，甚或攀窗登屋。以大承气汤去厚朴易瓜蒌，加石膏、葛根、黄连、连翘、胆南星、石菖蒲主之。名曰豁痰承气汤。

患者胡永年，年四十五岁，于三月间患温病。经医治之无效，于第五日即发斑疹。上述症状，次第而见。此乃大实大热之证。延至旬日，渐见发狂，四出奔走，如见鬼神，作叩拜顶礼之状，甚或殴人骂詈。其妻请强有力者两人，挟之登车，来余诊所求治。余知为狂者，温言以熨之。病者神情稍安，忽跪于地，对余作礼拜状，余更笑容和声以拽之坐。诊其脉沉数而有力，肌肤炙手，胸部尤其，周身斑疹烂然，色带紫黑，唇焦齿垢，舌苔干燥而焦黄。询其大便，已六日未解，小溲短赤。余即告慰病者，令两人先送之回家，其妻留取方笺，盖恐其有发狂之意外也。

因为之处方。以承气汤去厚朴，易全瓜蒌，加生石膏、葛根、黄连、连翘、胆南星、石菖蒲。以芦根为引。其所以去厚朴者，嫌温燥也。易瓜蒌者，能陷胸膈之痰也。加石膏为斑疹所必需，葛根为脑脊及阳明热邪所必用，黄连、连翘之清心凉膈，南星、菖蒲之豁痰开窍。盖证情如此，不得不用此重剂也。服药之后，大便连下两次，如胶如漆，肤有微汗，神情较静，狂态大减。

次日延余出诊。其妻恐其外出也，乘其睡时，将房门上锁，来余诊所。待余至时，开锁推门，则室内无人，病者不知所往。于床下觅之，亦不见。正惊讶之间，忽闻屋上瓦作声，其妻取高凳，立于其上，推天窗视之，则病者固坐于屋上也。其妻唤之，余亦温言以唤之，始含笑入窗而下。余再为之诊察一过，见身上斑疹，紫黑

色已减，而较红润，舌苔亦退去大半，肌热亦大减，表如此，里可知矣。因为之各药减量少许，再加鲜生地、鲜石斛以凉血增液。再剂之后，大便续解三次，其狂状若失，而神识清明矣。后再处以清理余邪兼扶正之品，而病遂痊。

豁痰承气汤方

锦纹军五钱，元明粉五钱，炒枳实四钱，生石膏三两，全瓜蒌六钱，粉葛根四钱，川黄连一钱五分，净连翘四钱，胆南星四钱，石菖蒲三钱，鲜芦根一支。

按：此方次日减量少许，加鲜生地一两，鲜石斛四钱。

（选自《中国百年百名中医临床家丛书·余无言》，中国中医药出版社2004年版，41~42页）

汪逢春

论治温病医案

周右，十二岁，一月四日。

头晕身热，烦倦无力，微有咳嗽，胸膈作痛，舌苔白腻而厚，两脉弦滑而数。风温上犯，内伤饮食，亟以轻香分化，药后不可以风。

薄荷叶五分（后下），朱连翘三钱，鲜枇杷叶三钱（布包），炒麦芽四钱，嫩前胡一钱，忍冬藤五钱，保和丸四钱（布包），小枳壳钱五，苦梗七分，象贝母四钱（去心苦），杏仁三钱（去皮尖），莱菔子三钱（布包），冬瓜子一两，方通草钱五，丝瓜络三钱。

二诊：一月六日。身热渐退，咳嗽，胸膈作痛，舌苔厚腻，大便未通，夜寐不安，时有谵语，两脉弦滑而数。风温挟滞，有逆传之象。拟再以辛凉通腑，宜乎避风慎口。

薄荷叶五分（后下），全瓜蒌一两（枳壳钱五，同打），真郁金二钱，紫贝齿一两（先煎），嫩前胡七分，苦杏仁三钱（去皮尖），鲜枇杷叶三钱（布包），忍冬藤五钱，朱连翘三钱，象贝母四钱（去心），嫩钩钩四钱（后下），家苏子钱五（莱菔子三钱，同打），酒军五分（后下），琥珀抱龙丸一丸（匀两次冲服）。

唐左，九岁，一月五日。

身热咳嗽，咽关红肿，哽痛，两项有核，舌苔垢厚而腻，两脉细弦滑数，禀质薄弱。痰浊蕴蓄肺胃，风温上犯。拟以辛凉宣解，生冷荤腥之味宜忌。

薄荷叶五分（后下），连翘三钱，赤芍药二钱，冬瓜子一两，嫩前胡一钱，忍冬藤五钱，山慈菇三钱，夏枯草钱五，象贝母四钱（去心），家苏子钱五（莱菔子三钱，同打），瓜蒌皮四钱（枳壳钱

五，同打），盐青果二枚，苦杏仁三钱（去皮尖），生熟麦芽各三钱。

二诊：一月七日。身热退而未净，昼轻夜重，咽痛咳嗽均愈，而结核未消，舌苔厚，大便未通，两脉细弦滑，温邪与痰互阻肺胃，再以前法加减。

薄荷叶五分（后下），家苏子钱五，连翘三钱，全瓜蒌五钱（小枳实钱五，同打），嫩前胡七分，白芥子五分（焙），忍冬藤五钱，山慈菇三钱，象贝母四钱（去心），莱菔子五钱，赤芍钱五，蒲公英三钱，夏枯草钱五，枯子芩钱五，生熟麦芽各三钱，保和丸四钱（布包）。

赵小孩，二岁，一月十九日。

身热咳嗽，气窒且促，痰不易咯，舌绛，啼哭无泪，神气烦倦，大便滞下，两脉细数，病十余日。肺脏窒塞，气管炎肿，其势甚重，亟以宣化通络，防其惊搐致厥。

嫩前胡钱五，莱菔子钱五（同打），嫩钩钩二钱（后下），生海石五钱（先煎），象贝母四钱（去心），鲜橘皮三钱（去白），山慈姑三钱，瓜蒌皮三钱（枳实钱五，同打），方通草钱五，琥珀抱龙丸一丸（匀两次药送下）。

二诊：一月二十日。身热乍轻乍重，气窒虽松，喘逆不平，啼哭渐渐有泪，神昏嗜卧，大便滞下色青，舌苔白，质绛。两脉急数，病虽小效，尚在变化之中，拟再以宣化通络，肃降化痰。

嫩前胡一钱，家苏子钱五，莱菔子二钱（布包），嫩钩钩三钱（后下），黛蛤散钱五（布包），牛蒡子七分，山慈菇三钱，陈胆星二钱，全瓜蒌五钱（枳壳钱五，同打），象贝母四钱，鲜橘皮三钱（去心），朱连翘三钱，冬瓜子一两，鲜竹沥五钱（加生姜汁一二滴，匀两次冲服），琥珀抱龙丸一丸（匀两次药送下）。

三诊：一月二十二日。身热已退，气窒喘逆渐平，神气亦复，两脉细数，大便通畅，温邪虽解，肺管炎肿不消，且有停饮，病见小效，尚不足恃，拟再肃降化痰。

嫩前胡七分，家苏子钱五（莱菔子钱五，布包），陈胆星三钱，焦麦芽四钱，生紫菀钱五，黛蛤散四钱，天竺黄钱五，鲜橘皮

三钱（去白），鲜枇杷叶二钱（布包），保和丸四钱（布包），朱连翘三钱，小枳壳一钱，鲜鲜竹沥五钱（加生姜汁少许，匀两次冲服）。

郑右，三十六岁，一月十三日。

身热三日，咽关偏左红肿作痛，左肋与背郁制痛，引及腰部皆痛，舌苔白，质绛，大便干结，两脉细弦滑数。风温上犯，气水互阻，拟以清泻分利，佐以调气之味。

薄荷叶五分（后下），真郁金钱五，净连翘三钱，丝瓜络三钱，白蒺藜三钱（去刺），赤芍药钱五，青皮一钱（同炒），忍冬藤四钱，盐青果二枚，旋覆花钱五（布包），鲜石斛五钱，家苏子钱五（同打），全瓜蒌五钱（苦谏子钱五，同打），青黛拌灯心一钱，方通草钱五，真新绛屑钱五。

二诊：一月十五日。身热退而咽痛亦止，后背与胃院偏右作痛，减而不已，夜不成寐，舌苔白，质绛，两脉细弦滑，温邪渐解，气水不化，再以轻泄分化。

薄荷叶五分（后下），旋覆花二钱（布包），姜竹茹三钱，方通草钱五，净连翘三钱，瓜蒌皮五钱，枳壳钱五（同打），鲜佛手三钱，丝瓜络三钱，忍冬藤三钱，赤芍药钱五，青皮一钱，真新绛屑钱五，嫩桑枝五钱，薤白头四分（研末，装胶管，匀两次药送下）。

（选自《近代中医珍本集·医案分册·洎庐医案》，浙江科学技术出版社2003年版，1121~1125页）

宋达三

治流行性感冒医案

1958年2月和3月上旬流行性感冒在本区流行，情况和去年春季不同。去年是由机关、团体、学校，慢慢流行到农村，今年是在农村弥漫性地发病。发病人数虽不如去年多，但合并症比较严重；去年经笔者治疗的250例中，只有一名合并中耳炎，今年共治疗流感104例，严重合并抽风的一名，呼吸困难剧烈咳嗽的七名（即合并肺炎的），重感（劳复）的一名，素有旧病感染的四名。本着“八纲”及“辨证论治”的法则，通过及时治疗，多数得到痊愈。现在列举四个典型病例，对流感合并症的点滴经验，作一简介，赤诚地就正于大家，敬希不吝指教。

流感误汗并发抽风

柳杨氏，女性，48岁，业农，本乡小董庄居民。

二月十七日清早出诊。据患者兄谈：患者前天感觉身体不舒，头及身痛，发冷。当时认为头痛脑热不算病，抗几天就好了！晚上她自己烧热了炕，喝一些开水，盖被发出大汗。不料第二天突发高热，阵阵抽风，不省人事。急请医生打针治疗，并未见轻。

初诊（2月17日）：体温40.7℃，脉洪数有力，牙关紧闭，角弓反张，正发抽搐，无法舌诊，只见口干唇青，病势危急。此系发汗过多，损伤津液所致。《金匱·痉湿喝病脉证》云：“太阳病，发汗太多，因致痉。”结合伤寒论第八条云：“风温为病，脉阴阳俱浮，自汗出，身重，多睡眠，息必鼾，语言难出，若发汗者，小便不利；若被下者，直视，失溲；若被火者，微发黄色，剧则如惊痛，时瘈瘲；……”这是描述热性病劫损津液，血虚不能荣筋，演变为坏症抽搐瘈瘲，即以增液、退热、解毒、镇肝熄风法治疗。

处方：生石膏（研末，早煎）二两，金银花一两，麦门冬一两，大生地一两，元参八钱，钩藤八钱，胆南星四钱，川芎三钱，杭菊六钱，秦艽三钱，防风三钱，犀角三钱，全蝎二钱，生甘草二钱。

水煎，冲服牛黄一分，辰砂末三分。

嘱其家属趁她不抽搐时，用羹匙徐徐灌下。

复诊（2月18日）：抽搐症状消失，精神清醒，体温降至 38.2°C 。自觉头重胸满，浑身发紧，咳嗽咯痰，呕逆，不思食，脉弦沉，舌绛，舌苔黄腻。此系高烧后，损耗津液，肝胜脾胃不和，心阴不足，法当再进大量增液、平肝健脾、润肺化痰佐以强心之品。

处方：前方去生石膏、全蝎、犀角、防风、牛黄，再加杏仁泥四钱，丹皮三钱，川、浙贝各二钱，杭白芍、鸡内金、青竹茹各三钱，外加伏龙肝一两、鲜苇根二两，水煎送服辰砂末三分，两次分服。

三诊（2月19日）：病者自觉病势大减，头目清快，胸部不甚满闷，早饭喝稀粥一碗，也没呕吐，咳嗽轻微，昨晚约在半夜时，大便一次（干粪），睡觉也很安稳，体温 37.5°C ，脉亦和缓，舌苔虽黄，略有津液，但食欲仍缺。法当清余热、增津和胃为主。

处方：元参、大生地、麦门冬各六钱，广陈皮、清半夏、杏仁泥、鸡内金、六陈曲、大白片、谷麦芽各三钱，全当归五钱，生甘草二钱，外加伏龙肝一两，水煎服。

四诊（2月20日）：症状全部消失，体温正常，脉和缓，惟觉食欲不振，四肢酸软。给天王补心丹10粒，每饭前吃一粒，人参健脾丸10剂，早晚饭后各服一剂，善后调养。2月27日访视，已完全康复。

流感并发肺气闭塞（肺炎）

张某，男性，11岁，学生，张井村人。

初诊（2月28日），其母亲代诉：五日前曾患感冒，病不严重，服平热散发微汗后，觉着好了，前天忽然又病了，咳嗽得很厉

害，喘不上气来，发烧，面红，呕吐，不能吃饭。检查：体温 40.2°C ，咳嗽剧烈，胸部刺痛，头及四肢作痛，鼻翅煽动，呼吸困难，唾吐白黏痰，间有铁锈色，口气臭。

印象：流感并发肺炎。《温病条辨》说：“凡病温者，始于上焦，在手太阴。”由此推究其致病原因，系热邪郁遏于肺，热伤肺络，故突发上述病症。治宜清热、解毒、宣肺、化痰为主：

处方：生石膏一两（研末，早煎），麻黄二钱，金银花四钱，杏仁泥，瓜蒌皮各三钱，川浙贝母、桔梗、枇杷叶（去毛，纱布包）、牛蒡子、前胡、白前、竹茹、山栀子、酒黄芩、葶苈子、生甘草各二钱，橘络一钱，外加藕节五个，水煎，二次分服。

复诊（3月1日）：体温降至 38.2°C ，呼吸略觉痛快，咳嗽亦感轻微，咯痰与昨天相似，面色仍然发红，夜间睡眠不安，苔白腻，脉紧数。仍以前方去竹茹、牛蒡子、酒黄芩、葶苈子，加知母、云苓、麦冬各三钱，藕节五个，水煎冲服辰砂末二分，两次分服。

三诊（3月2日）：体温 37.8°C ，呼吸、咳嗽咯痰均轻，睡眠安适，面色微红，苔脉无变化，食欲不振，仍以前方加减，佐以健胃之品。前方：生石膏改为六钱，去金银花、山栀子、橘络、前胡、白前，加清半夏、广陈皮、紫菀各二钱，神曲、麦芽各三钱，北五味一钱，藕节五个，水煎，分二次服。

四诊（3月3日）：体温 37.6°C ，诸症见轻，照前方再服一剂。

五诊（3月4日）：体温正常，大部症状消失，每餐能喝米粥二碗，惟咳嗽咯痰仍未完全停止。因小孩服药困难，改予通宣理肺丸，每饭后服一粒，一周后痊愈。

劳复流感

刘某母，女性，71岁，业农，住彭寺村。其子代诉：“于三月二日忽患感冒，头痛，怕冷作烧，周身酸软，不愿吃饭，她平素怕吃药，吃了两粒羚翘解毒丸，喝了一些开水，身出微汗，全身轻快，病去大半，住了两天感觉好了，昨天她抱小孩上街去玩，当时

感觉受凉，来家不多时，就浑身发起冷来，头痛厉害，晚上又复发烧。”

初诊（三月十日）：体温 40.4°C ，颜面潮红，头及关节疼，不恶寒，但发热，脉浮数有力，舌苔黄腻，三日未解大便，口渴，食物不愿入口。病后气血俱虚，余热未尽，本宜安卧静养，今早起劳动，气血沸腾，抵抗力小，因劳而复发作，治宜辅正、退热、增液、通便。

处方：全当归一两，金银花、杭甘菊、麦门冬、酒川军各五钱，秦艽、瓜蒌、丹皮、桃杏仁、枳实各三钱，白芷二钱，大力参，生甘草各一钱，生姜三片，伏龙肝一两，水煎，分二次服。

复诊（三月十一日）：体温 38.3°C ，头及关节疼减轻，大便二次（稀粪杂有硬块），有微汗，舌苔黄润。年高经此高热，津液缺乏，食欲不振，理所必然。好在大便通下，急下以存津液，病势好转。所谓“温病下不厌早”、“急下以养阴”是有道理的。拟予退热养阴佐以健胃之品。

处方：金银花、麦冬、元参、大生地各五钱，瓜蒌、丹皮、鸡内金、六陈曲、酒黄芩、谷麦芽、广陈皮各三钱，甘草二钱，水煎，二次分服。

三诊（三月十二日）：体温正常，脉洪大而虚，精神好转，每顿能喝一碗藕粉，小便赤，大便又溏泄一次。法宜健胃辅正。

处方：前方减去金银花、麦冬、元参、酒黄芩，加建莲子、焦白术、茯苓、杭白芍、清半夏各三钱，生姜三片，大枣二枚，水煎，分二次服。

四诊（三月十三日）：症状大部消失，惟感体软无力，消化力弱，夜晚有失眠现象，拟以前方加台党参、山楂片各三钱，水煎送服辰砂末二分，三月十四日其儿子讲“服药见轻”。再照前方取药一付。

旧病血虚复染流感

王某爱人，女性，39岁，业农，家住小董庄。

三月八日初诊。

主诉：平日心跳已逾半年，于昨天感觉受凉，发冷作烧，头痛，浑身疼，彻夜不能睡，一有小响动，就心跳不止，喝口水随即吐出，阵阵出虚汗，不愿睁眼，一点精神也没有。

诊查：体温 38℃，脉浮数微细，舌苔白薄，颜面额部红艳，有轻微咳嗽及流感症状。且其素有蛔虫病史，胃疼可能是蛔虫作祟。《温病条辨》第六条云：“太阴风温，但咳，身不甚热，微渴者，辛凉轻剂桑菊饮主之。”再结合“急则治其标，缓则治其本”的治疗原则，先予加味桑菊饮治疗流感。

处方：霜桑叶、杭甘菊、金银花各四钱，杏仁泥、净连翘、青竹茹各三钱，苏薄荷、苦桔梗、生甘草各二钱，伏龙肝一两，水煎送服辰砂琥珀末三分。

复诊（三月九日）：体温 37.5℃，脉搏舌苔如前，头痛、浑身疼、白汗均见轻，服药后没呕吐，上半夜能入睡，听见动静就醒，胃中仍然作痛，心悸烦躁，感觉四肢无处搁放，此系久病血虚所致。令其先吃“驱蛔片”四片，再予滋阴养血之品。

处方：全当归一两，大力参一钱，干地黄、元参、麦门冬各五钱，杭甘菊、青竹茹各三钱，龟板、鸡内金、阿胶、甘草（蜜炙）各二钱，伏龙肝一两，水煎送服辰砂琥珀末三分。

三诊（三月十日）：据云，服驱蛔片后，泻下蛔虫八条，胃疼顿止，惟不思饮食，盖以胃气不和所致。再予大量养血药剂，佐以健胃之品。

处方：全当归一两，干地黄五钱，云茯神、龙眼肉各四钱，焦白术、生熟枣仁、谷麦芽、清半夏、六陈曲、广陈皮、龟板、建莲子各三钱，炙甘草二钱，生姜三片，伏龙肝一两，水煎分二次服。

四诊（三月十一日）：体温正常，新病不必考虑。

可专治血虚心悸及消化不良，大量给予补血健胃之品。

处方：前方减去焦白术、龟板，再加鸡内金、台党参各三钱，水煎送服辰砂末三分，两次分服，连服两剂。

五诊（三月十三日）：心悸轻微，通夜能眠，每顿能吃面条两碗。惟身体羸瘦，一时难以恢复，再予柏子养心丸 20 粒，每饭前吃一粒，开水送下，并嘱她多吃菠菜和鸡蛋，好好注意营养，先做

轻活，待身体健壮后，再从事劳动。

（选自《现代著名老中医名著重刊丛书·现代医案选》，人民卫生出版社2008年版，84~90页）

宋爱人

治咳嗽医案

外感痰咳，卫外不和——宣肺化痰，降气止咳

孙某，男。

一诊：二月十四日。初因外感风寒，发热咳嗽，经治而愈。惟二月来咳嗽反复不已，近日咳嗽复甚，痰多色白而黏，咽痒，胸闷，咳剧胸胁引痛，胃纳亦减，舌苔薄白微腻，脉小紧而滑。乍暖还寒，卫外不和，肺失肃降。治以宣肺化痰，降气止咳。

炙麻黄二钱，白杏仁四钱，生甘草二钱，象贝母四钱八分，款冬花四钱八分，家苏子三钱，炙紫菀四钱八分，前胡二钱四分，广陈皮二钱，法半夏三钱。

三剂。

二诊：二月十七日。药后咳嗽咯痰已爽，阵咳亦减，晨起尚多白痰，咯出即觉气平胸舒。舌苔薄白，脉濡滑，余症均安。再宗前法加减。

家苏子三钱，甜白杏仁各四钱八分，象贝母四钱八分，白前三钱六分，款冬花三钱六分，炙紫菀四钱，桔梗二钱，化橘红二钱，生甘草二钱。

三剂。

三诊：二月二十日。咳痰已十去八九，前方去款冬花，加枇杷叶三钱。续进三剂。

按：本例外感咳嗽经治而愈，但因痰浊黏滞，未得尽除，肺气欠畅，稍有寒温不适，就会引发，所以咳嗽反复不已，随着痰浊的增多，气机壅阻加剧，所以治疗重在化痰降气止咳。根据病程，先用麻黄、前胡宣肺，继用白前降气，合用枇杷叶止咳。本例病情虽

较简单，但立法选药层层递进，次序井然。

（选自《中国百年百名中医临床家丛书·宋爱人》，中国中医药出版社2002年版，73页）

治风温医案

风温是感受风热病邪所致的外感热病，多发于春冬两季。外感风热，多从口鼻而入，侵犯肺经，所以初起多以肺经的病变为主。宋爱老在《春温新绎》中将春温作为春三月温热病的总称，而于春温证中分出“新感”和“伏邪”二类。他说：“新感者称风温，温邪内发者曰伏温。”所以风温的定义，应该是冬春季新感风热外邪的疾病。如重型感冒、痰火证（马脾风）、风疹、烂喉丹痧（猩红热）、发颐等，多属风温的范畴。现代医学中流行性感、急性支气管炎、大叶性肺炎等发生于冬春季节的也属风温，都可参考风温辨证治疗。

风温疾喘神昏——安宫牛黄合银翘解毒

李某，男。

一诊：二月二十三日。风温五日，咳嗽痰咯不爽，气逆作喘，引动胸胁疼痛，头痛巅厥，昨日吐咯紫血，神情呆异，竟至两目直视，舌音不清，遗尿不禁，扬手掷足，循衣摸床，呓语昏谵，舌苔霉灰如墨，脉搏弦劲而数，热势特壮，心胸痞硬，小便赤如血。腑行泻而不畅，阳明邪热内陷营血，逆传心包，冲激神明，亦即《伤寒论》所谓蓄血发狂。现已厥而未醒，病情万分险恶，勉拟清营解毒，开窍醒脑。

安宫牛黄丸一粒（研，陈金汁一两，温热送服），鲜生地二两，鲜沙参二两，金银花四钱，净连翘三钱，原赤芍四钱，粉丹皮四钱，桃仁泥三钱，象贝母四钱，天竺黄三钱，远志二钱，广郁金二钱。

二诊：二月二十四日。风温逆传心包，昨拟清营解毒，开窍醒脑，幸厥势即回，惟脉象依然弦劲数促，舌苔霉灰如墨，胁痛痰

咳，牵有血丝，热势鸱张，厥变岌岌可危。若云肺炎，化源益难支持矣。

神犀丹一粒，上犀黄三分（二味研匀，开水拌送），鲜生地二两，鲜沙参二两，鲜石斛一两，小川连八分，川象贝各四钱，淡黄芩三钱，天竺黄四钱，甜杏仁四钱，天花粉四钱，橘白络各二钱，赤白芍各四钱，龙贝齿各一两二钱（先煎），甘露消毒丹六钱（包煎）。

三诊：二月二十五日。二进清温解毒、开窍醒脑以来，幸获见效，现两目已转灵活，胁肋疼痛已瘥，气逆喘息亦平，热势较淡，脉弦劲亦缓，惟舌苔依然霉灰如墨，腑气二日未行，足见阳明瘀热在里。现证势虽较平善，然腑邪未祛，仍未可忽。

犀角粉四分（鲜竹沥四两调送），鲜沙参一两二钱，小川连五分，炒淡芩三钱，川象贝母各三钱，杏仁泥三钱，赤白芍各四钱，桃仁泥二钱，七液丹八钱（包煎），龙贝齿各一两二钱（先煎）。

四诊：二月二十六日。今晨腑气已通，所下溏垢如酱，幸腑通之后，即进藕粉半盏，神态知觉已能宁静，此大幸也。脉搏弦迟，未得中和。舌苔黄底罩灰，胸膈胁肋痛势虽缓，而咳痰仍感不爽，肺经痰热未清，包络之邪未撤，所以寐时仍难落睫。再拟清肺化痰，安神宁志。

鲜石斛六钱，鲜沙参一两，淡黄芩三钱，小川连六分，香青蒿二钱，象贝母四钱，甜杏仁四钱，冬瓜子五钱，金银花四钱，桔梗二钱，橘白络各一钱八分，调胃承气丸五钱（包煎），朱灯心四扎，茯苓神各六钱，灵磁石一两二钱（先煎）。

五诊：二月二十八日。日来咳痰较爽，胸院气机亦舒，身热已退，微微有汗，腑气又通一次，舌苔薄黄而腻，脉转弦缓，胃气渐复，余邪未净。治宗前法，参以养阴清气。

鲜石斛五钱，南沙参三钱，冬瓜子四钱，象贝母四钱，甜杏仁三钱，橘白络各二钱，绿萼梅一钱八分，生米仁五钱，嫩白薇二钱，朱灯心四扎，朱滑石六钱。

按：本例为风温重候，当时西医诊断为肺炎。初起一候，即热入血分，邪陷心包，经用清热解毒、清营凉血、开窍醒脑之品，病

情即获转机。方中所用陈金汁能清痰火，解热毒，尤清心胃二经之热。此药为粪清，今多不用。本案第三诊心脑症状已有改善，而舌苔灰霉如墨，大便二日未行，宋爱老认为阳明痰热在里，因此先用七液丹（方中主含大黄），继用调胃承气丸通下阳明实邪，这也是本病治疗中的一个重要环节，加速了本证的痊愈过程。

（选自《中国百年百名中医临床家丛书·宋爱人》，中国中医药出版社2002年版，18~20页）

治春温医案

春温是发生于春季或冬春之交的外感热病，临床多急性发病，即见发热、烦渴，有时尚有恶寒，在病变发展过程中，严重的可以出现神昏痉厥或斑疹等里热证候。涉及现代医学中的病毒性感染、重型流感、流行性脑脊髓膜炎等多种急性传染病。宋爱老认为，本病是伏邪内发，所以在其所著《春温新绎》中称本病为“伏温”。他对本病的辨证曾提出几个要点，即：有无表邪；是否兼夹痰湿；有无时疫温毒；有无阳明腑实；阴气津液的消长情况等。他认为这些都是至关重要而又容易被忽视的。在治疗上曾提出春温以透邪外达为第一要义，热者清之而不可过遏，邪未透达者忌用阴柔滋腻之品。

痰热郁闭包络——清气透邪，宣化痰热

濮某，男，住皮市巷。

一诊：二月十四日。春温二候，邪伏肺胃，痰热郁闭，扰害心主包络，温邪化热，而表邪尚在，所以热势高张，身又凛凛恶寒也。痰咳不爽，气促鼻煽，面赤颧红，唇焦齿枯，夜来反复不安，不得合目，偶一迷蒙，即呓语谵妄，筋惕肉瞤，小溲红赤如血，脉情弦郁，舌苔淡黄。素体气阴薄弱，温邪最易劫阴，而昏愤厥冒之变，意中事耳。急拟清气透邪，参以甘凉存阴，冀其表里两和，毋使神明一蹶不振为幸。

神犀丹一粒（另研冲服），淡豆豉三钱，生山栀四钱八分，鲜

竹沥二两（冲），青连翘四钱八分，淡黄芩三钱，象贝母四钱六分，甜白杏仁各五钱，冬瓜子六钱，南花粉八钱，天竺黄片二钱四分，蔷薇露四两（代茶）。

二诊：二月十五日。昨夜溱溱汗出，恶寒已解，神志已能安静，远不若日前之反复颠倒，呓语谵妄。然而春温化热传里，拨乱神明，二脉弦细，心神不振，势恐骤然热盛昏愤。盖邪在气营之交，全赖正气之强弱、邪气之盛衰为进退。刻诊鼻煽气促略平，颧赤亦退，今午便通一度，溏垢恶臭。咳呛为邪之出路，能得肺气无损，尚非逆候。再以清泄肺气，镇摄神明。

鲜生地一两二钱，京元参六钱，肥玉竹六钱，淡黄芩三钱，青连翘三钱六分，甜白杏仁各五钱，象贝母五钱，天花粉八钱，冬瓜子六钱，天竺黄一钱二分。

三诊：二月十六日。热势渐退，脉之弦细较畅，能得心气振作，神明安宁，则正气回复，邪气不克逗留内伏，三日之内，脉证不变，则坦途可望。刻诊咳势大缓，鼻煽气促已平，颧赤全退。今晨左目红疼多泪。再以甘淡芳通，以撤余邪。惟是体阴素虚，津气亦不足，所以透邪为难也。

天麦冬各三钱六分，青连翘四钱六分，黑玄参六钱，焦山栀三钱，淡黄芩三钱，天花粉八钱，甜白杏仁各四钱六分，冬瓜子六钱，茯苓神各六钱。

四诊：二月十七日。据云，夜寐已安，胃渐思纳，胃气亦有渐复之机，且腑气昨通而温邪无停留矣。惟热犹未净，须防食复。

天麦冬各二钱四分，天花粉八钱，甜白杏仁各四钱六分，冬桑叶四钱六分，冬瓜子五钱，青连翘三钱六分，茯苓神各四钱六分，生米仁一两二钱，蔷薇瓣二钱四分。

按：本证温邪传入气营之交，痰热郁闭，扰及心主包络，而卫分表邪尚未外撤。因此在治疗上除了清解气分之热外，必须兼以辛凉解表。不然里热被遏，易生变端。神犀丹用以清营开窍，治疗痰热蒙蔽心包。二诊以后，邪热回出气分，主要用清肺养阴之品，病情好转比较顺利。

温毒疫疹——凉肝熄风，通腑存阴

稽某，男，八岁。

一诊：二月十四日。温毒窜入督脑，发热五日，神识昏糊，烦躁痉厥，手足搐搦，头痛目赤，所谓疫疹者是也。症起之日，呕吐频作，带有血液，至今仍吐血块，口气臭恶，舌苔灰腻垢厚。大便今日一次，泻下臭水，粪质不多。胸部红疹隐而不透，两脉弦劲不驯，更非善征。温毒炽盛，肝风鸱张，年幼证危，深恐正不胜邪，致有厥闭之危。

羚羊角六分，乌犀角六分，玳瑁片三分（上三味研末，分四次送服），鲜生地一两，鲜金斛一两，川连一钱，鲜菖蒲一两五钱，龙胆草二钱，川部金二钱四分，金银花三钱六分，赤白芍各三钱六分，小枳实二钱，瓜蒌仁三钱六分，陈金汁一两（冲）。

二诊：二月十五日。厥阴肝风痉厥之势，幸得平静，良以时行毒疔深窜营络，故受毒深而来势暴，进清温透毒之剂，得奏小效。惟是病起之前，阳明胃腑夹有积滞，曾经旁流数次，外来温毒与胃中宿垢，朋比为奸。刻诊两脉弦劲稍驯，舌质红绛，苔转灰垢，口气臭恶，足见肠胃实邪燥结之甚。为今之计，当以通腑存阴为急。若解有正粪，舌苔化薄，庶可许入坦途。

鲜金斛四钱，鲜生地一两五钱，生石膏一两（先煎），生知母二钱，川锦纹二钱（后下），小枳实三钱，玄明粉三钱（冲），川连六分，连翘三钱，金银花三钱，陈金汁一两（冲）。

三诊：二月十六日。今日大便二度，色黑如酱，所下颇多。童体质弱，不能与壮盛者并论，宜缓下而不能急下。今虽神清知饥，似得佳兆，然脉仍弦劲，少有神韵，舌质干绛，苔起灰黑，扣之觉有厚壳，唇焦口渴，不独胃阴受劫，而少阴泉源亦竭。当今之时，邪正互为进退，正是吃紧关头，虚风内动，为意中事。当于清瘟解毒之中，参以存津养阴。

枫斛三钱，鲜生地二两，西洋参二钱，生石膏一两（先煎），知母二钱，连翘三钱，京玄参二钱，甘中黄六分，清阿胶二钱（烊化冲）。

四诊：二月十七日。里热劫阴，阴液告竭，昨日肝木鸱张，内风潜动，搐搦复起，烦躁不寐，鼓额作痉，痉甚如厥，舌脱壳而光剥有刺，犹幸胸前红疹续布，温毒犹寻出路，急进存阴潜降，以观动静。

鲜霍斛四钱，西洋参二钱，鲜生地一两，京玄参三钱，青连翘三钱，麦冬三钱，紫贝齿八钱（先煎），生白芍三钱，生牡蛎一两（先煎），炙龟板五钱（先煎）。

另：羚羊角粉六分，分三次送服。

五诊：二月十八日。温毒内炽，津气大伤，肝风内动，神识不宁，手指搐搦，舌绛有烂陷处，脉弦不驯，邪势一再猖獗，治之殊为棘手。

鲜霍斛四钱，西洋参二钱，鲜生地一两，京玄参三钱，青连翘三钱，甘中黄六分，嫩钩藤四钱（后下），生石决一两（先煎），玄明粉三钱（冲），全瓜蒌二钱，生甘草六分。

另：羚羊角粉六分，犀角粉六分，蔷薇露四两，送服。锡类散吹喉。

六诊：二月十九日。起病以来，波澜迭起，几无宁刻。昨起痉搐已止，神志稍安。惟利下大便多为溏垢稀液，未得正粪，左脉弦数，右脉弦细，舌绛渐淡，边有烂陷，身热退而未净，红疹透而未回，邪热未清，津气两虚。宗《内经》“必养必和，待其来复”之旨，参甘平以济之。

鲜霍斛三钱，西洋参二钱，麦冬二钱，连翘三钱，白薇二钱，北沙参三钱，陈粳米五钱，茯神三钱，炙甘草六分。

服两剂，身热已退净，胃气渐醒，大便转黄且干。前方加减，续服数剂而愈。

按：这是一例流行性脑脊髓膜炎，当时中医称之为疫痉。依据辨证，既见到热结旁流、舌苔垢厚、实邪内阻的阳明腑证，又出现了神昏痉厥、肝风鼓动的厥阴证，所以病位在厥阴阳明。这时温毒炽盛，肝风鸱张，而且红疹隐而不透，内陷厥闭的危证随时可以出现。衡量全局，主要矛盾当在在厥阴，因此，治疗以清温解毒、平肝熄风为主，佐以通下的方法。二诊肝风痉厥已平，转从阳明腑证

治疗。宋爱老认为，温热病一旦归并阳明，往往与燥热实邪相结合，阳明实邪不去，厥阴病即使稍能平息，也难久安无事。仲景对少阴病立有三承气法，泻阳明之实，正所以保护少阴的津液。于此可见，治疗阳明对三阴病有着十分重要的意义。第三诊时，出现舌苔灰黑起壳，接着壳脱舌光（俗称铲饭滞），这是阴津耗竭的表现，预示着病情将有亟变。虽然用了大剂甘寒养阴，仍不免出现了第四诊的虚风内动，烦躁痉厥。四诊、五诊宗三甲复脉汤意，育阴潜阳，平熄肝风，才渡过了这一险关。所以，在病变的发展过程中，如何掌握各个阶段的病机，对于采取正确的治疗措施是十分重要的。

春温热厥——双解阳明经腑

周某，男，四十八岁。

一诊：四月二十三日。春温两候，初起发热咳嗽。两日来四肢厥冷如冰，心中寒栗，夜来烦躁不安，神昏谵语，脉滑数带促，舌苔黄垢而干，胸腹灼热如烙。此证热极生寒，热为真热，寒为假寒，正如《内经》所谓：“诸禁鼓栗，如丧神守，皆属于火。”厥闭之危，迫在眉睫。急以白虎汤加味，清解里热为要。

玉泉散二两（包煎），生知母六钱，京玄参五钱，鲜石斛一两，上川连六分，黄芩三钱，连翘五钱，黑山栀五钱，蔷薇露六两（代茶）。

二诊：四月二十四日。热极则生寒，热深厥亦深，凡三阳之邪，在表者不为之辛凉解散，在里者不为之清热通下，汗下两失其宜，乃至郁阳不伸，里热愈炽，肢厥愈甚，神志昏乱。服昨方，四肢厥冷已解，神志较清，惟脉情数促不调，舌白罩黄垢厚，腑气三日不行，腹部痞满，邪伏经腑，仍需两解。

玉泉散二两（包煎），生知母六钱，青连翘五钱，淡黄芩三钱，川连六分，黑山栀五钱，鲜石斛一两二钱，生米仁一两，七液丹八钱（包煎），蔷薇瓣二钱。

三诊：四月二十五日。舌底白罩黄，垢厚异常，脉弦涩而郁，有此脉舌，必有大邪内伏。昨日腑通一度，烦热较减，四肢亦温。

惟昨夜突作寒战，当其寒也，始于足之三阴，寒已而热，热势高张，烦渴求饮，尽三四壶之多，经一时许而厥回热透，神志转清。刻诊胸膈白痞略见数粒，微微有汗，时有咳嗽，内伏之邪有外达之机。仍需甘寒凉淡，参以芳透。

生石膏一两五钱（先煎），知母六钱，鲜金斛一两，香青蒿四钱，佩兰叶三钱，甜杏仁五钱，前胡二钱，生米仁一两，川连六分，黄芩二钱五分，七液丹八钱（包煎）。

四诊：四月二十七。舌白罩黄，中如酱色，脉弦滑数。昨日寒战未作，大便二次，溏垢如酱，身热较退，胸颈白痞续布，微微有汗，仍需凉解苦泄，作葛根芩连合白虎与之。

粉葛根二钱五分，上川连六分，淡黄芩二钱，生石膏一两五钱（先煎），生知母五钱，佩兰叶三钱，甜杏仁四钱，前胡二钱。

五诊：四月二十九日。进甘寒以益阴气，苦寒以制阳亢，热势渐衰，烦渴已减，舌苔垢腻渐退，脉之滑数亦缓，咳嗽痰黏不爽，虽欲思食，而胃纳尚差。再进甘淡芳通，清肃气分余邪。

粉葛根二钱五分，淡黄芩三钱，生米仁一两，扁豆花三钱，佩兰叶三钱，蔷薇瓣三钱，甜杏仁三钱，象贝母三钱。

六诊：五月一日。舌苔薄白，上罩淡黄，脉情弦滑，余邪未净，岂能杜蔓不净。若曰开胃之药，于邪未撤清之前则清理阳明，即是开胃，余则别无他术也。

佩兰叶三钱，蔷薇瓣三钱，生米仁一两，竹二青三钱，广陈皮二钱，象贝母三钱，保和丸四钱（包煎），益元散六钱（包煎）。

按：本证初起为温邪上受的呼吸道感染，由于治疗不当，邪热内郁而致四肢厥逆。时病厥证有寒厥、热厥之别，如何从寒热混杂、病情疑似之间分别真假，是辨证的首要问题。分析本案主要根据以下两点：①起病之初是上焦温病，以后变成厥逆，正是《伤寒论》所说的“前热者，后必厥”证候，多属热厥。喻嘉言也说：“若阳证忽变阴厥者，万中无一。”所以基本上排除了寒厥的可能性。②舌苔干黄，脉象滑数，胸腹灼热，都显示了内热炽盛的征象。有此二者，可以断定是一个热极生寒的真热假寒证，是阳明经腑同病，热盛燥实的证候。所以宗白虎承气意，选用辛凉清解，苦

寒通下，参以甘寒淡渗，两撤经腑之邪，而使厥回热透，病情转危为安。第三诊突然寒热战栗，这是正气胜邪，驱邪外出的另一通道，凡病邪之久郁深伏者，尤多见之。叶天士在讨论“邪留三焦”时说：“因其仍在气分，犹可望其战汗之门户，转疟之机括。”本证虽非转疟，也不是典型的战汗，可是通过正邪交争，将深伏之邪驱逐外出，其机理并无二致。所以当寒战之后，竟得热透神清，微微有汗，白痞敷布，未尝不是佳兆。因而在前方基础上，加入青蒿、佩兰、杏仁、前胡，辛香透化，宣通肺气，因势利导，使邪从气分透泄，病情迅速好转。

（选自《中国百年百名中医临床家丛书·宋爱人》，中国中医药出版社2002年版，9~18页）

张震

宣清湿热法治愈风湿一例

胡某，女，30岁。

主诉：发热恶寒，咳嗽，体倦头痛，胃纳呆滞已有周余，经肌注青链霉素及服中药止嗽散、羌活胜湿汤等未见好转而来院就诊。

诊查：体温38.5℃。脉濡数，舌红苔腻，根垢。

辨证：系湿热郁表，肺火宣降失常。

治法：治拟宣湿清热、芳化疏表之法。

处方：淡豆豉10克，佩兰叶10克，茯苓15克，淡竹叶3克，藿香10克，杏仁10克，连翘10克，通草5克，银花5克，苡仁20克。

服药一剂后微汗出，寒热全解，咳减一半。继服药二剂，诸症完全消失。

按语：此虽为湿热郁表之证，但已有人里碍中之苗头，故予宣清湿热疏达之法，通过轻开上焦，宣发肺气，以消除在卫或在肺之湿热邪气。因肺合皮毛，肺气得宣，则遏郁于表卫之邪自易驱散。且肺为水之上源，宣畅肺气，又可使在体之湿邪随水道之通畅而排除，从而达到“分消”之目的。此即“气化则湿亦化，气行则湿亦行”，“湿邪既去，则热无所附，势孤易除”之理。宣清湿热法若用之得当，则可顿挫病势，阻止其向纵深发展。宣湿之品，通常可选杏仁、桔梗、白蔻仁、郁金等；清热之药可予桑叶、连翘、银花、竹叶、薄荷等。

〔选自《中国现代名中医医案精华（三）》，北京出版社2002年版，2168页〕

张子琳

论治感冒

虽是小恙谨于微，寒热暑时分型治

感冒，系内科常见病，临床上有风寒、风热和暑湿之分。临床见证不同，治疗方法亦异。感冒虽小，临证之时亦须谨慎对待，所谓圣人不忽于细，必谨于微。张老曾多次强调：“医疗工作过程中一定要认真负责，彻底了解症状，弄清初发病的根源，然后再针对病情加之深思，选择有效的方剂对症治疗……其中追究病源是极其重要的一环。正如仲师《伤寒论·序》中所说：‘虽未能尽愈诸病，庶可以见病知源。’知其初得病的根源，然后才进行施治，只有这样才能治之有效。”医者于此等处尤当审证求因，明辨其类，知常达变，辨证施治，方得无误。兹分类叙述如下。

风寒温散不谢方

风寒感冒最为常见，常常表现为恶寒发热，恶寒重而发热轻，无汗，头痛，体痛，鼻流清涕，有时咽痒，咳嗽，咯稀白痰，苔白或无苔，脉浮紧。法当辛温解表，张老习用陆懋修《不谢方》之风寒温散（防风9克，芥穗9克，苏叶9克，姜半夏9克，陈皮6克，枳壳6克，桔梗6克，炙甘草5克，生姜3片），往往随手取效。

此外其自拟的葱豉汤加味亦平正清灵，稳妥可靠，对于较轻的伤风感冒宜之。药用：淡豆豉9克，葱白3茎，防风9克，前胡9克，杏仁9克，桔梗6克。若四时感冒风寒兼夹气郁者可用加味香苏饮（苏叶9克，香附6克，陈皮9克，川芎6克，蔓荆子6克，防风6克，秦艽6克，荆芥6克，甘草5克，生姜3片，葱白3茎）取微汗愈；对于久病或老年病人及体质极虚的风寒感冒病人

当用参苏饮，咳嗽甚者，加杏仁以降气，桑叶以泻肺。

风热凉散不谢方

风热感冒发热重，恶寒轻，头痛头晕，身热，口干渴，咽肿痛，或咳嗽，咯吐黄黏痰，苔薄黄，脉浮数或浮弦。法当辛凉解表，祛风清热，方用《不谢方》风热凉散。药用：防风6克，荆芥6克，薄荷4.5克，桑叶9克，竹叶6克，连翘9克，栀子6克，橘红6克，桔梗6克，枳壳6克，炙甘草4.5克，带须葱白3茎。前胡、川芎、白芷、升麻、葛根等可随症加入。

藿香正气疗暑温

暑湿感冒多为夏秋感受暑湿而发，症见发热恶寒，头闷痛，胸闷，身倦，四肢困重，或者呕吐、腹泻，苔白腻或微黄，脉濡或濡数。治当清暑利湿，芳香化浊，方用藿香正气散加减。药用：藿香9克，紫苏6克，白芷6克，厚朴6克，半夏6克，陈皮6克，桔梗6克。

银翘加减治时行

时行感冒相当于现代医学所说的流行性感，它发病急，病情重，并具有传染性。所谓非其时而有其气，是以一岁之中，病无长少，病状相近似者，此则时行之气也。症见发热恶寒，剧烈头痛，全身痛楚，舌红，苔微黄，脉浮数有力。治法清热解毒，疏散外邪，方用银翘散加减。药用：金银花15克，连翘10克，薄荷5克，板蓝根20克，大青叶20克。若头痛者加菊花；咽痛者加桔梗、甘草；咳嗽者加杏仁、前胡；痰黄者加瓜蒌皮、浙贝。

医案

徐某，男，43岁，干部。门诊号：75411。

初诊：1978年6月17日。

素体虚弱，一周前不慎感冒，头晕，左耳鸣，发高热，体温38.5℃，至今不退。现四肢困痛，咳嗽气紧，口干唇焦，鼻塞干燥，恶心暖气，食欲减退，大便干，小便黄。曾用西药消炎、退热，其病不解，又改服中药，补虚解表，热仍不退。视其舌苔白燥

少津，脉浮而数，此乃外感风热灼伤津液之证。急则治其标，拟辛凉解表，清热止咳，辅以生津润燥。处方：

金银花 15 克，连翘 12 克，荆芥 10 克，竹茹 6 克，瓜蒌 15 克，桑叶 10 克，菊花 10 克，杏仁 10 克，桔梗 6 克，芦根 15 克，甘草 5 克，陈皮 6 克，前胡 10 克，生石膏 15 克，水煎口服。

二诊：6 月 20 日。

上方服一剂后，得微汗，身热已退，体温已正常。服二剂后，精神也较振作。现头晕不清，耳鸣，口干苦不适，食纳不佳，轻微恶心，大便稍干，暖气，舌苔白燥，脉不浮略数。此为表解热退，胃津受伤之证，治以养阴开胃，清解余毒。处方：

桑叶 10 克，菊花 10 克，芦根 15 克，麦冬 10 克，石斛 12 克，竹茹 6 克，陈皮 6 克，鸡内金 6 克，炒谷芽 10 克，地骨皮 12 克，甘草 5 克，神曲 6 克，瓜蒌 15 克，水煎口服。

二剂后诸症遂平。

按：感冒是常见病、多发病，比较容易治疗。但若治疗不及时、不适当，则亦缠绵不愈而变生它病。这就要求医者谨慎从事，辨证清楚，不因病小而轻忽之。本案，头晕身热，鼻塞干燥，肢体疼痛，咳嗽气紧，舌燥少津，便干溲黄，脉象浮数，乃一派外感风热伤津之证。虽然素体虚弱，但仍应遵守先解表后治里和急则治其标的原则。前医用补虚解表之法，其参、芪量大，致使邪气内闭，而身热不退也。张老急用桔梗宣发肺气，给邪热以出路。继用金银花、连翘、菊花、桑叶、荆芥等，使邪热得辛而散、得凉而清。陈皮、前胡、瓜蒌、杏仁化痰理气以止咳，石膏、芦根清热生津。药证相合，一剂而热退身凉，二剂而精神振作。复诊时，食欲不佳，恶心暖气，口干便秘，乃热病伤津之征，头晕不清、耳鸣为余热未尽，以养阴开胃，清利上焦余邪而收功。处方用药清淡和平，先后有序。不用峻烈而收效迅速之药，亦是本案之特点之一。

（选自《中国百年百名中医临床家丛书·张子琳》，中国中医药出版社 2001 年版，5~9 页）

张伯臾

用大柴胡汤加减治愈外感发热医案一例

朱某，男，53岁。

初诊：1983年6月2日。

主诉：患者于两个月前，因洗澡受凉而发热，迄今未得控制，体温在 38°C ~ 39°C 之间。初起热无定时，不恶寒，近一月来，发热有定时，中午起，入暮退，伴有耳聋、目眩、口苦、咽中干热，脘腹及左下腹作胀，胃纳欠馨，无恶心呕吐，二便正常。曾有肝硬化、脾切除史。

诊查：舌红苔薄黄，脉弦数。

辨证：证属少阳阳明合病。

治法：治拟大柴胡汤出入。

处方：银柴胡12克，炒黄芩10克，炒知母10克，炙甘草4克，制川军6克，北沙参15克，麦冬10克，茯苓12克，碧玉散18克（包），鲜芦根30克，四剂。

二诊：6月6日。服药后发热已平两天，耳聋转轻，余恙如前，并见左胁下胀痛。苔薄舌偏红，脉弦数。药已对证，仍拟前法出入。

前法加天花粉15克，赤白芍各12克。四剂。

三诊：6月9日。热仍未发，诸症均减。舌红苔少，脉弦带数。前方改白芍为24克，改柴胡为9克，加生晒参9克（另炖兑入）。四剂。

【按语】病见有口苦，耳聋，目眩，定时发热，不欲食，皆为少阳证；然又热不恶寒，呈潮热状，并见胃脘及左下腹作胀，又属阳明承气证；证兼两经，故辨为少阳阳明合病。取大柴胡汤合蒿芩清胆汤化裁之，再诊、三诊邪渐撤，舌苔渐化，为防炉灰复燃，故

参入养阴活血益气之品，扶正气以善后。

[选自《中国现代名中医医案精华（二）·张伯臾医案》，北京出版社1990年版，774页]

张际春

治冬温战汗医案

冬温战汗案

病者：徐天华，年二十六岁，住泰兴燕头。

病名：冬温战汗。

原因：冬早气温，劳苦受之即发。

证候：两候身热不解，头眩夜烦，便实溺黄，咳嗽少痰，大汗淋漓，形色若有脱象。

诊断：早诊苔黄中绛，脉象滑数。系冬温自口鼻入肺，不得外解，则里急而顺传于胃也。肺为娇脏，胃为阳土，宜清宜降，谁知药服便行，忽然发战，大汗如雨，似有急不可缓之险象。病家疑余误汗致脱，即邀复诊，其脉似和，右部不静，此邪久羁气分，得清解之力，大便之后，邪与正争，以作战汗，非阴阳离决之脱汗，一战不清，恐至再战。今正气未至大虚，邪气未得清除，吴氏鞠通所谓但当听其自然，勿事骚扰可耳。

疗法：取桑叶、杏仁、连翘、山梔皮、薄荷以清肺，枳壳、瓜蒌皮以降胃，贝母、茯苓、薏苡、甘草以清肺胃热化之痰，又加枇杷叶清降之品为佐使。次日又诊，汗后热不清，咳有黏痰，即以参叶养阴为主，茯苓、甘草、薏苡以和胃气，贝母、瓜蒌皮以去未清之痰，少佐连翘、梔皮、丹皮、荷叶络以清气分之余热，仍守先贤战汗后身复温，亦不可骤用补药，恐余邪未净复炽之训。

处方：冬桑叶一钱，青连翘二钱，光杏仁二钱，山梔皮钱半，生枳壳钱半，苏薄荷一钱，象贝母三钱，瓜蒌皮三钱，云茯苓三钱，薏苡仁三钱，生甘草八分，枇杷叶二张（去毛）。

又方：参叶二钱，云茯苓三钱，粉甘草五分，生薏苡三钱，瓜

芩皮钱半，川贝母一钱，连翘一钱，山梔皮一钱，粉丹皮一钱，荷叶络二钱。

效果：翌日汗止热减咳缓，食粥碗许。复一二诊，热净咳已而痊。

廉按：邪与正争，战而汗出病必解，战而不汗病即加，其常也。今因便后而发战大汗，乃内热外溃之佳兆，既非脱汗，自不宜补。故仍用清肃余邪为治，方皆清稳。

（选自《全国名医验案类编》，福建科学技术出版社 2003 年版，304～305 页）

张菊人

论治温病医案

例一，孙某，5岁，1956年4月就诊。

感冒化温，身热口干，手面微肿，大解不畅，小便色黄。宜于清解中佐以消肿。

薄荷梗一钱，黄芩二钱，滑石三钱，丹皮二钱，金银花三钱，知母三钱，蒲公英三钱，净连翘三钱，青竹叶三钱，炒枳壳一钱半，瓜蒌六钱，荷叶三钱。

服上方午后热盛口渴，左关脉盛，右关亦不平和，舌色渐绛而苔垢，小溲色黄，气血两燔，烦躁不宁，手肿尚未大消。非两清气血不能为功。

金银花四钱，玄参六钱，黄芩三钱，枳实一钱半，连翘三钱，寸冬三钱，竹叶三钱，瓜蒌七钱，生石膏五钱，粉丹皮三钱，蒲公英三钱，滑石三钱，知母四钱，栀子三钱。

服上方后热退口不渴，舌色不绛，苔已退，右手肿见消，左手面肿势又起，小溲微黄，邪热未清。再以前法出入。

金银花四钱，丹皮三钱，青黛一钱半，连翘三钱，栀子二钱，鲜竹茹三钱，蒲公英三钱，紫花地丁三钱，元参五钱，生甘草一钱，黄芩三钱，瓜蒌根五钱。

服上方后热退肿消小便清，病已痊愈。

例二，李某，1954年春就诊。

温邪初起，头昏发热，舌苔厚腻，肢体酸痛，小溲深黄，大解未通，右脉浮洪，口作干。宜清化宣通。

薄荷一钱半，金银花二钱，连翘三钱，黄芩三钱，竹叶三钱，滑石三钱，大青叶三钱，黑栀子三钱，枳实二钱，黄郁金一钱半，瓜蒌一两。

服药后汗出甚透，身热即退，大便通调，口不渴，小溲浅黄，脉已平静，唯头尚不清，胃纳不佳，肢体无力。再以上方去大青叶，并将枳实减去四分之一，瓜蒌减去五分之一，服后即愈。

例三，刘某，1957年2月就诊。

午后头昏发热，业已数日，口渴思凉饮，小便深赤，大便秘结，时有谵语，苔黄厚腻，右脉洪数。症已化温，所喜尚在气分，未侵入营分，宜辛凉重剂加以宣通。

金银花四钱，连翘三钱，生石膏八钱，知母四钱，青竹叶三钱，黄芩三钱，益元散四钱，郁金二钱，大青叶三钱，枳实二钱，全瓜蒌一两，生梨汁、荸荠汁各半杯（匀兑）。

上方服后，得汗热退，口不甚渴，神志清爽，舌苔见宣，已转矢气，尚未更衣。仍宜前法增入苦降（大黄一钱半）。服后大便通，脉静身凉，舌苔微垢，小溲微黄，饮食未香。再以清化宣滞为法。

金银花三钱，连翘三钱，黄芩二钱，竹叶二钱，益元散三钱，枳壳一钱半，瓜蒌皮六钱。

例四，沈某，1957年3月就诊。

病已数日，午后壮热，饮不解渴，右脉沉数，舌之尖边色绛，中心老黄，小便深赤，大便秘结，神烦妄言。证明气营两燔，如再迁延，将完全入营，势更严重。宜养阴凉降为法。

玄参一两，连心麦冬五钱，金银花五钱，连心连翘三钱，生石膏一两，知母四钱，鲜竹卷心四钱，丹皮三钱，黑栀子三钱，枳实三钱，黄郁金三钱，全瓜蒌一两，大黄三钱（滚水泡透，分三次酌兑，大便通即止兑）。

上方仅兑大黄一次，未及数分钟，大便即下二次，色如败酱。至夜汗出如雨，旋即热退神清，脉静口和；唯小溲微黄，舌苔微垢，饮食未思，余邪余滞尚未清楚。再以清养胃阴兼化邪滞。

鲜石斛五钱，寸麦冬四钱，石膏五钱，知母三钱，金银花三钱，竹叶三钱，炒枳壳一钱半，瓜蒌皮五钱。

服二剂后，注意饮食调养，薄味为佳。

例五，盛某，1953年2月就诊。

患温邪数日，治未如法，左关脉盛，舌底绛，上见薄垢，口不渴，身热神烦，邪入营分，极虑内闭；幸舌有薄苔，尚未完全光亮。亟须清营热佐以利窍之法。

连心玄参六钱，麦冬四钱，鲜竹叶卷心三钱，连翘心三钱，鲜生地一两，莲子心一钱半，金银花五钱，瓜蒌霜六钱，丹参一钱，紫雪丹五分（匀二次冲服）。

两进上方，舌津已回，绛色已淡，苔复现出垢腻，左脉已缓，右关反数，转矢气不更衣，是营分热邪初转气分之际，稍不注意，极易内闭。拟增液汤加气分药，仍用紫雪丹豁痰利窍，杜其内闭。

鲜生地一两，玄参六钱，麦冬五钱，金银花五钱，鲜竹叶三钱，瓜蒌霜八钱，紫雪丹五分（匀二次服）。

上方服后，大便畅解，舌苔全退，六脉和缓，诸恙消失。再以小剂增液汤合银花、绿豆皮各三钱，气营两清，消除余热。

注：治温病首要明辨邪在卫气营血的不同。当清者清之，当下者下之。掌握这个窍门，温病就不难治。如果分不清邪之所在，不论卫气营血，执方而治，必然治不得当，变症也将百出。

（选自《菊人医话》，人民卫生出版社2006年版，70~74页）

论治温热病医案

例一，四十年前一女性患者张某，体质素弱，因患带下症住某医院，在疗养中突患外感时邪，身已亢热，该院断为肺病。其爱人刘某非常着急，一日间借亲友探病为名（时西医院不许延中医服药），延中医为之诊治达十七人之多。其前十五人亦均诊为肺病，第十六人乃萧龙友先生，独断为实证。以病家犹疑未决，因未处方。余以第十七人最后至，察脉息右关洪大而数，身热已数日不退，亦断为实证。时患者方面壁卧，及闻余江苏同乡口音，遽转面向外，见其两颧红晕，舌苔中呈黄腻而舌尖微绛，问其所苦，则说：口渴，大便秘，小便黄。我告诉她：“这是秋感时邪，气营兼病。”患者闻言点头，颇以为然。立方为：

玄参五钱，麦冬四钱，金银花四钱，竹叶三钱，六一散三钱，

石膏五钱，知母四钱，瓜蒌八钱。用整枳实、郁金、槟榔各一钱半，磨三分之一兑服。

一服便通，二服去磨药，服后热退苔消，溺色微黄。仍以原方出入，一周痊愈。

按：此症原极寻常，方亦平平无奇，不足置论。所可怪者，当末次复诊时，嘱其准备办理出院手续，回家休养。其保姆忽锁眉叹气，低声告我：“张先生医道真好！不过今后她恐怕不能和您再见了！”余闻之甚为惊奇，问其所以，才知道其爱人已在医院签字，将于次日施行手术治疗。余以患者久病新愈，正气尚未恢复，无论是否需要手术治疗，此时绝不能施行。即告知原介绍人，次晨其爱人乃接其出院。

注：此例值得注意的，不是医院施用手术的当否，而是十七位中医竟有十五人对时行感证断为虚劳，只有两人断为实证。一虚一实，有天渊之别。以为虚证，必须用补；若误实证为虚证遽补之，正犯了古人“实者实之”之戒。生死关头，全系于此！是患者之可危，不全系于手术问题；实实之误，即足以致其生命了！

例二，同乡谭某病，一日清晨七时许延余为治，见其由顶至腹，截然猩红，口渴壮热，脉息洪大而数，舌苔黄垢，小便深赤，三焦俱急。当以银翘、白虎、承气、安宫等加入凉血剂中下之。服后大便未通。中午复诊，腹上已脱肤，脐以下至踵猩红如午前上截，知是药后独红游走，颇以为异，唯以上焦既已获效，仍用原方再服一剂。至晚再诊，下焦也和上焦同样脱肤，热退便通，次早即愈。其方为：

金银花五钱，连翘五钱，石膏二两，知母五钱，鲜生地二两，麦冬五钱，丹皮三钱，赤芍三钱，青黛三钱，板蓝根五钱，黄芩三钱，竹叶三钱，栀子三钱，枳实三钱，瓜蒌一两，郁金三钱，元明粉二钱，大黄四钱，安宫牛黄丸一粒。

后谭君一年，有德国医学博士某人之爱人亦染此症，友人张君询余见过此症否？余以治疗谭君经过告之，并谓此症来势汹汹，如上午红色过午不退，下午再蔓延周身，即易成坏症。如发现后随时挽救，或有生望。午后二时许张君复告余：“患者病情有发展，正

如所说，现已蔓延全身，不知还有救否？”余以业难施救，辞之。果于夜间周身色青而死。

注：此症险恶迫切，就是猩红热也没有这样剧烈。阳毒也有五天的施救时间，必七日方不可救。说是丹毒，也只片段游走不定而已，更没有这样剧烈。在险恶症中，只有真心疼、真头疼才朝发夕死。虽险恶迫切相似，但病情又太不相类。究属何症，因生平只医一人，传闻一人，经验太少，始终不知其为何症。特地提出，以供研讨。

例三，皖籍杨姓男孩，约十余岁，当春末夏初，患烂喉痧疹，壮热颇剧。此在温病中不是什么特殊险症，不料正在调治中，忽又吐血，衄血（耳鼻皆衄），大便下血，小便出血，舌苔黄厚，小便色红，口渴思冷饮，饮不解渴，大便秘结。当时以病情剧变，即用大剂清透凉血、苦降存阴之剂；但大便始终不下。又觉如此重剂，如连服太多，必损伐过度，预后不良，乃不得不改用猪胆汁导之。未及三分钟，大便居然畅下很多，但舌苔仍厚，知其邪滞胶固未解。奈正值畅通之后，断没有连下之理，同时衄血、便血尚未根止，痧喉也没消尽，足证邪势仍在猖獗未敛，于是一面顾其正气，一面继续祛邪，仍用前法减轻为治。从此始将三焦邪滞逐渐减轻，七窍不复出血；但邪热未净，又复上攻而发颐，病势辗转缠绵，病家颇为忧惧。余当以大病已去，余邪滞络未清，已如强弩之末，不足为惧慰之。仍继续缓为之治，用清热透解、活血消肿法，数日脓出而愈。

初用方：金银花，连翘，玄参，寸冬，丹皮，栀子，鲜芦根，赤芍，生枳实，楂肉，瓜蒌，竹叶，黄芩，滑石，酒军，郁金。

第二方：金银花，连翘，玄参，寸冬，丹皮，赤芍，茅根，生地，枳实，瓜蒌，大黄，羚羊角，犀角，竹叶，滑石，藕汁，板蓝根，青黛。

连服两剂，大便未下，加玄明粉仍不下，乃用胆汁导法，大方便畅通。

第三方：金银花，连翘，玄参，寸冬，丹皮，栀子，竹叶，滑石，生地，鲜芦根，枳实，瓜蒌，羚羊角，犀角，藕汁，大黄

(隔一二日加少许)。此时七窍出血已止，邪滞渐减，痧喉已退，余邪又上攻发颐。

第四方：金银花，连翘，玄参，丹皮，栀子，板蓝根，蒲公英，贝母，瓜蒌根，人中黄，五谷虫。因大便结燥，加瓜蒌、枳实出入为剂。

外敷方：金黄散三钱，青黛三钱，紫金锭三钱。用凉茶调敷，日数换。

例四，北大学生徐某，患温邪阳明证，壮热口渴，脉洪大滑数，大渴引饮，饮不解渴，小便黄赤，大便秘结，谵言妄语，舌尖色绛，满舌黄垢，呕吐不已，啰物色青，口苦，三数日间呕吐不休，忽轻忽重，大便始终不下，壮热谵语也始终未停，气势颇为汹汹。等到吐势稍安，肝热冲胃之势稍平，减去黄连苦降守而不走之品，加咸寒软坚之味（玄明粉），大便始通，呕吐随之平定，壮热也因得汗而解。方用：

二花，连翘，知母，石膏，鲜芦根，鲜竹茹（姜汁炒），枳实，郁金，黄连，黄芩，麦冬，大黄，玄明粉。

例五，一女性产后郁冒（感冒），寒热无汗，头痛，口干，溺黄；唯以素有寒腿宿疾，疼痛甚剧，颇难处置。予以辛凉宣达，则对寒腿不利；予以辛温发汗，则碍于时令新染。为了两顾，为制羌防麻桂以顾其外，酒蒸后擦腿，内服辛凉清解以疗时疾，果霍然愈。

例六，某饭馆经理，每夜十二时回家前，必食油炸鸡蛋三枚，习以为常。某岁患春温，壮热口渴，神昏谵语，大便秘结，其势甚亟。经杨浩如先生为治，由险化夷，大便初解球粪数枚，其色黑，其坚如石，捶之不开。三日为之一通，五日为之一下，先后下至约百枚时，病势日渐好转。嗣以杨君应诊赴山东，属余为之续治。余仍用杨君法，徐通徐下。又下至百枚时，粪球始略软，色亦转黑为老黄。余以情势和缓，改用滋润，粪球益软而色则转老黄为淡黄。又下二三十枚后，始转球粪为条粪，病亦告愈。

注：此症前后医治约一月有余，脉始终沉实，间有神昏谵语，据证明是结粪未下。不敢猛攻的原因，是由于结粪太坚，粘连胃肠

日久，不能不存投鼠忌器的顾虑。若遽然猛攻，必有穿孔之虞，故始终以缓下为治，实为万全之策。否则必招鲁莽灭裂之讥。

例七，新中国成立前《北京晚报》总编辑赣人某，因别有兼职，酬应极忙，且素贪吃，以健啖自豪。偶患秋温，壮热不汗，舌苔垢腻，脉数而兼有浮象。余以芳香化秽，清热解肌，宣通中脘为治。一剂热解汗透，再服大便通调，解下球粪。当以秋温与春温不同，秋温伏气乃由暑湿化燥，势较春温为缓，柔腻之药不宜多用，连以疏化之品宣通肠胃。热退之后，数日间连下球粪八十余枚，粪色始转淡黄，舌苔亦随之消失。余以积滞虽未清尽，谅亦不致复燃，嘱其连服两剂再诊。詎患者以事务迫促，急于速愈，更投别医，误以参术填补。从此食欲减退，甚至绝谷，大便又复不通，日趋危殆，未久竟死。此正犯实实之戒，安得不死！

例八，患者刘某，即例一之张某之子，平素喜食鸡蛋，偶犯秋温，致暑湿与鸡蛋胶著，缠绵不解，壮热不退，大便不通，舌苔腻满。初以芳香治其外，辛凉苦降治其内，经一二日，热势渐减，大便球解。又数日身热因得汗而退，唯舌苔忽薄忽厚，大便球解如故，于是或宣或通。舌苔厚时用药较重；舌苔薄时用药较轻。重者用枳实、槟榔、瓜蒌，甚至加用酒军；轻者用枳壳、瓜蒌皮、鸡内金为之宣通。球解八十余枚方尽。继用稻芽之属以和胃气，遂愈。

例九，例一之张某，新中国成立前生活困难，居湫隘之西厢房，夏日炎热，因畏暑静居少动而终致受暑。由于体质柔脆，素来大肠液少，兼之营养不足，食量极微；唯嗜饮白酒，意欲借酒开胃，兼助消化；不知脾胃反因此转不灵活，乃至壮热口渴舌垢，小便色赤。予以芳香解热清其外，小承气以玉金易厚朴，以熟军易生军，借通其内，大便始为之通，同时壮热亦因汗而解，内外差算通彻，似应向愈；乃舌苔始终未能退净，或厚或薄，所下结粪亦为小球状，虽不太硬而色则老黄，连下九十余枚之多。所用药味与上一案大致相同，以体质较弱，故用量较少。

注：以上四例均属大便球解。除某编辑因中途更医致生病变外，一属春温内热与阳明积滞结合，胶固难化，非辛凉重剂不能清其热，非咸寒苦降不能通其结。余虽用前法使热退便通，但在仅存

余热停滞时，固不能再用寒凉重剂，然而停滞若不消除净尽，遇有小劳，势必复热，或遇微邪，亦必反复。假如新进饮食再与积滞纠结，又必成食复。尤其此种坚硬球粪，与寻常积滞迥然不同，缓攻则不能下，猛攻又可暂而不可长，最为棘手。在这种情况下，必须扶其正气，清其邪滞，才能转危为安。此症由于邪滞胶着难解，球粪须一月有余方告肃清，而培养正气则非三个月不能复元。更由于治此症每须硝黄并用，所以病愈后邪气虽尽，而正气未免大伤。依个人历年体会，大黄虽峻，其伤正气较少，芒硝似乎平淡，而所伤实多，恢复较慢。故余从不肯轻用硝黄，就因为这个缘故。其余两例则属秋温，病势大致相同，因为患者年龄体质各异，治法不能不有所差别。如患者刘某年壮体健，以素嗜鸡卵，适与秋温结合，体强邪重，所治应稍重；患者张某年事较高，体又柔脆，且嗜饮酒，平素大肠液亏，情形迥然不同，所以治法也较和缓。小承气仅用一次，在缓调缓通的治法下，经一月之久，始竟其功。古人说：“神而明之，存乎其人。”绝不能执一方统治一切病。病可同而人不能同。这和特效药一样，对某种病有特效，并不是对每一个人都有同样的特效。如果只论病而不论人，那么古人早该废医存药了！所以原则上全靠活用，食而不化是不足以济事的。

例十，1922年曾医一男性温病患者，因初起即被升散杂投，致病陷中焦；继又服清热存阴之剂，虽然热退便通，但余邪业已散漫，左关弦紧，胁痛不能转侧，呼号之声达于五层院落之外。余认为阳明之邪虽解，真阴尚未恢复，少阳余邪留连于胁肋之间，如用仲景柴胡法疗之，则与温邪入络治法相悖，乃用清热护阴、通络定痛之药，制成汤剂。一服之后，呼痛声仅三层院落可闻；再服而呼痛声仅达于室之内；连服四剂之后，身可转侧，痛亦旋止。嗣后又用原方出入，未及旬日，恢复健康。北京药肆之有桑叶络，即始于此。方为：

鲜石斛四钱，钗石斛四钱，丹皮三钱，鲜橘络二钱，上血珀五分（胶囊装），细生地六钱，栀子炭三钱，黄郁金二钱，桑叶络五钱，麦冬四钱，竹茹三钱，新绛屑二钱，鲜横桑枝一两，二花三钱，川贝三钱。

例十一，1921年医一未满十岁的男孩，壮热一二日，舌即绛色，满舌大红点如黍粒状，约百余粒。自觉经治邪热入营的患者甚多，从未见舌绛而有红点者，意必营热之中兼有秽浊之热毒在内，或即叶天士所谓“热毒乘心”。于是仿其方义，亟以清营汤加玳瑁、黄连、金汁等出入为治，取其作用如下：

玳瑁——镇心神，行气血，功同犀角；

黄连——以苦降直泄心经毒火；

金汁——以甘寒泻五脏实火兼解热毒。

连服三剂，舌上绛色渐退，红点始消；再服小剂清营，病即痊愈。方为：

二花三钱，细生地六钱，紫丹参一钱半，小川连三钱（连心）连翘三钱，麦冬三钱，乌犀角五分，玳瑁三钱，竹叶卷心三钱，连心，玄参五钱，金汁一两（雪水煎最妙）。

例十二，同乡罗某，体质素弱，春日因感外邪，转成阳明温病。经某医官膏黄并用，大便得通，身热亦退。由于连服上方不减，大便频下，体弱不支，致脉沉而近迟。余急以加减复脉汤去火麻仁，重用炙甘草治之，即愈。

例十三，胡某（女），患温邪，经医院疗治未愈，改就中医。由于病势模糊，阴阳审辨未清，致汗出不已；复用参附回阳，不意连服十帖之多，阳未得回而汗出愈多。余诊其脉来细数，知过去审症有误，汗出虽多而大便三日未解，乃以复脉汤加龙骨治之。汗虽收敛，但动即汗出，进食亦有汗。当大便得解后，更佐以牡蛎之类，而汗始止。

注：以上两例，前例以素弱之质，过用苦寒，一下再下，遂不能支。后例为温邪缠绵，误投辛热，几乎阴分涸竭。二者都是治疗不当。究其原因，不外驱邪过急而忽于固正，及审证疏忽，致病势缠绵，几濒危殆。愿医者审证务要细心分析，用药必须结合患者体质，自不会在业务上有所疏忽。

例十四，黄某（女），患伏暑似疟，虽寒热不甚，但日久不解。医用和化之品，略加人参以固正，反而加剧。余诊其脉滑数，舌苔白腻，口不渴，大便通，小便黄，知其暑湿方盛。投以芳香化

浊之品，略佐升提利湿之味，始得出其汗；惟肤冷达一昼夜不温，病家惊惧。余诊其六脉和平，神志清爽，了无他异，安慰病家勿虑，稍候阳气来复，自然无恙。方用：

鲜藿香三钱，鲜佩兰三钱，鲜荷叶一大张（后下），益元散四钱，白蔻壳一钱半，杏仁泥三钱，鲜竹叶三钱，苡仁六钱，鲜扁豆花两枝（后下），法半夏一钱半，白通草一钱半，西瓜翠衣一两（后下），青蒿一钱半。

注：瘦弱患者，久病佐人参以固正，本无不可，但此例正当暑邪弥漫之际，邪势猖狂，用参既属不急之务，反而助邪益炽。此时化邪，实刻不容缓。至于大汗之后，阳气虚微而见肤冷，本应有之现象，特此例肤冷时间太长，诚为少见，无怪病家以虚脱为虑。不过六脉和缓，足证邪气已退，正气待复，不足为虑。假若汗后脉躁，热不退，那就成“阴阳交”，势濒危亡了。

例十五，某岁治一三岁小儿，心胸间出现颜色晦黯之黑斑数点，神情萎顿，别无所苦。初见其舌黑口臭，即断其胃已烂，无能为力。病家则以症方初见，怎能说是胃烂？余谓此儿绝非新病，询以前有何症象。病家始谓前数月曾患发颐，屡愈屡发。余以疾不可为，病家再三要求，勉立一方，终亦无济，当夜果死。

注：痲疹二症，虽同属阳明病，一出于经，一出于腑，深浅不同。且二症又分种种，亦皆有轻重之别。

以痲而论，仲景所谓“斑斑如锦纹”，即言此症。叶天士有化痲之法，实发前人所未发，足启后学之领悟。然尚少行血散瘀之品，诚恐血毒不能排除净尽，遗留后患。余每遇此症，无论其寒战壮热，神昏谵语，如果口渴潮黄，苔黄便秘，即断定其确为实痲，概以清血化痲及芳香透窍为主，务使气分、血分邪无留滞，一扫而空，能保神明清爽，痲自可化。这是说实的治法。至于虚痲，因所见甚少，千百症中不曾一见。依香岩所论，但须温之，故邹新甫解释：“想前人立有此例，无非使后人勿执见痲为实之意。”叶、邵两氏语意精辟，何敢妄拟方法。但随机应变，也是我们临床要事。执方无权，含而不化，怎能尽到医生的职责？

余对温疹，每以清化宣透和凉血化毒为治，数药即可痊愈。假

如是温热疹，三四日后皮肤始隐隐可见，或者随病随出，壮热不退，势将续出，须注意舌之边尖及舌的本质是否色绛，有无伤阴症状。为了预防疹毒内陷起见，凭舌色以度营热之深浅、血热之轻重，必于清透凉透之中，佐以清营凉血之品，使热毒由阳明之经透发于皮肤之外，在七八日间，热退神清，疹色日淡，邪势渐退，才能保其不别生变故。倘稍不注意，毒不得外发，必向内攻，发生种种病变，常见者如下：

发颐、大头瘟——毒攻颈项脉络间；

神昏抽掣——两厥阴（心包络、肝）皆病；

便秘、发狂——热结肠胃；

旁流——热结；

呛咳、气喘——上攻肺金（肺主一身之气，宜清宜降，一旦为热毒壅塞，气不运行，化源欲绝，疹反不见）。

凡此皆属险候。余临此症，均依各家治温之法，参以当时情况，斟酌加减，颇能应付自如。唯遇化源欲绝之症，补之不可，泻之不及，每苦棘手。因为温由伏热而成，疹则由伏热入于阳明之经，潜居血络而发为疹，所以红色为轻，深红近紫者为重。如能在温疹发现时，按重轻投以清透、凉透之剂，疹势透发自然得安。若误投羌防柴葛一派升散之品，则不但疹不易出，出亦必一见即收，热毒无由而出，必致逆传心包络，迫灼不已，气液两败，化源必为之绝。

至于风疹本无大害，余治以清热化风，颇收成效。至若白疹，乃湿热之伤，苟不白如枯骨，得甘味调之，可以望生。唯北方高亢，若伤气液，多不能愈，不能同南方一律视之。

总的来说，同一斑症，有颜色的不同，有能治与不能治的区别；同一温疹，有热毒之轻重，变化之多端，非素有经验者不能得心应手。细心察辨，实为首要。

例十六，一中年某病暑温（乙型脑炎），热邪侵入手足厥阴经，抽掣，神昏不语，左关虚弦，虚风内起，予以鞠通小定风珠加姜水炒竺黄，一服即定，再服，虚痰降而能言。方为：

生龟甲一两，阿胶三钱，子淡菜四十枚（泡淡，洗去泥沙），

竺黄三钱，意便大半茶杯，鸡子黄二枚。

先煮龟甲、淡菜、竺黄三味，煎取二杯去滓，入阿胶熔化后，更入鸡子黄，冲以童便顿服，移时再服二煎。

例十七，一壮年女性病暑温，左关弦疾，痰涌抽搐，神志不清，不能言语，大便燥结，小便深黄。当予开窍息风之剂。方为：

桑叶三钱，黑栀子三钱，明天麻二钱，羚羊角（镑）五分（先煎），枳实二钱，菊花三钱，九节菖蒲三钱，钩藤三钱，天竺黄四钱，瓜蒌八钱，丹皮三钱，郁金三钱（矾水炒），玄参六钱，益元散四钱（布包）。

愈后，休养相当时日方能言语。

以上两例皆暑温经过腰椎穿刺的变症，也就是热邪潜入两厥阴的病。然脉症表现不同，前一例属虚，后一例属实。虚实治法不同，用药自当有异。临床着眼，首辨虚实，次为用药，不容疏略。

例十八，某妇患湿热挟表，白痢后重，身热。经用唐容川银菊散治之，热退痢止，神志日清，饮食日增，只余窍络阻闭，不能言语。询之方知治法有误。乃复用加减神仙解语丹，借以利窍豁痰。服后正气渐复，惟言语艰涩，为时甚久。因知治法不慎，累及患者留有余憾，真可谓之“医药后遗症”。此案初方为：

九节菖蒲三钱，远志三钱，天麻二钱，全蝎二钱，僵蚕三钱，防风一钱半，陈胆星一钱半，钩藤三钱，麝香五厘。

综合以上三例，后遗症都是言语为难。不知五脏之俞，皆系于背，此处不胜任何刺激，否则必有此类现象。

（选自《菊人医话》，人民卫生出版社2006年版，10~23页）

张锡纯

风温案

病者：赵印龙，年近三旬，业农，住盐山城北许孝子庄。

病名：风温。

原因：孟秋下旬，农成忙甚，因劳力出汗甚多，复在树阴乘凉过度，遂得风温病。

证候：胃热气逆，服药多呕吐。因此屡次延医，服药旬余无效。及愚诊视，见其周身壮热，心中亦甚觉热，舌苔黄厚，五六日间饮食分毫不进，大便数日未行。问何不少进饮食？自言有时亦思饮食，然一切食物闻之，皆臭恶异常，强食之即呕吐，所以不能食也。

诊断：其脉弦长有力，右部微有洪象，知其阳明腑热已实，又挟冲气上冲，所以不能进食，服药亦多呕吐也。

疗法：欲治此证，当以清胃之药为主，而以降冲之药辅之，则冲气不上冲，胃气亦必随之下降而呕吐能止，即可以受药进食矣。

处方：生石膏三两（细末）、代赭石一两（细末），知母八钱，潞党参四钱，粳米三钱，甘草二钱。

煎汤一大碗，分三次温服下。此方乃白虎加人参汤，又加赭石也。为其胃腑热实，故用白虎汤，为其呕吐已久，故加人参，为其冲胃上逆，故又加赭石。

效果：服药尽一剂，呕吐即止。次日减去赭石，又服一剂，大便通下，热退强半。至第三日减去石膏一两，加玄参六钱，服一剂，脉静身凉，而仍分毫不能饮食，憎其臭味如前。愚晓其家人曰：此病已愈，无须用药，所以仍不饮食者，其胃气不开也。夫开胃之物莫如莱菔，可用鲜莱菔切丝，香油炒半熟，加以葱酱煮汤勿过熟，少调以绿豆粉俾服之。至作熟时，病人仍不肯服，迫令尝少

许，始知香美，须臾服尽两碗，从此饮食复常。

廉按：热盛冲逆，用白虎汤加赭石清热镇冲，方极稳健。惟潞党参宜易西洋参。孟英谓西参与古时人参味苦微寒者相同，故案中人参白虎汤每用洋参，良有以也。

风湿喘促案

病者：郝姓幼子，年五岁，住天津小南关柴市旁。

病名：风湿喘促。

原因：季春下旬，感冒风湿，医治失宜，七八日间，喘逆大作。

证候：面红身热，喘息极促，痰声辘辘，目似不瞬，危至极点。

诊断：脉象浮滑，重按有力，启口视其舌苔，色白而润。问其二便，言大便两日未行，小便微黄，然甚通利，且视其身体胖壮，阴分犹足，知犹可治。

疗法：欲治此症，当用《伤寒论》小青龙汤，然须重加凉药以辅之。

处方：麻黄一钱，桂枝尖一钱，五味子一钱，清半夏二钱，川贝母二钱（去心），光杏仁二钱，生白芍三钱，干姜六分，细辛六分，生石膏一两（研细），煎汤一大茶钟，分两次温服下。

说明：此方即小青龙汤加贝母、生石膏。《金匱》治肺胀作喘，原有小青龙加石膏汤，然所加石膏之分量甚少。今所以重用生石膏至一两者，为其面红身热，脉象有力，若不重用石膏，则麻桂姜辛之热，即不能用矣。又《伤寒论》小青龙汤加减之例，喘者去麻黄加杏仁，今加杏仁而不去麻黄者，因重用生石膏、麻黄即可不去也。

效果：将药服尽一剂，喘愈强半，痰犹壅盛，肌肤犹灼热，大便犹未通下，遂用生石膏、杏仁各二两，代赭石一两，煎汤两茶钟，徐徐温服之，痰少便通而愈。

廉按：风湿犯肺，肺胀喘促，小儿尤多，病最危险，儿科专家往往称马脾风者此也。此案断定为外寒束内热，仿《金匱》小青

龙加石膏汤，再加川贝开豁清泄，接方用大剂二石萎仁等清镇滑降而痊。先开后降，步骤井然。惟五岁小儿，能受如此重量，可见北方风气刚强，体质茁实，不比南人之体质柔弱也。正惟能受重剂，故能奏速功。

风湿兼伏气化热案

病者：陈百生将军，年四十六岁，寓天津广东路。

病名：风湿兼伏气化热。

原因：因有事乘京奉车北上，时当仲夏，归途受风，致成温热病。

证候：其得病之翌日，即延为诊视。起居如常，惟觉咽喉之间有热上冲，咳嗽吐痰，音微哑，周身似拘束酸软。

诊断：脉象浮而微滑，右关重按甚实，舌苔白色。知此症虽感风成温，而其热气之上冲咽喉，实有伏气化热内动也。

疗法：病在初起，热虽不剧，而伏气之发动，必继有大热在后。宜少用表药解肌，重用凉药清里，石膏在所必需也。然富贵之人其身体倍自郑重，当此病之初起而遽投以石膏重剂，彼将疑而不肯服矣，斯不得不先为开清解之剂也。

处方：薄荷叶三钱，连翘三钱，蝉退二钱，知母六钱，玄参六钱，天花粉六钱，生甘草二钱，煎汤服。

效果：翌日复诊，言服药后，周身得微汗，而表里反大热，咳嗽音哑益甚。言之似甚恐惧。诊其脉洪大而实，左右皆然。愚曰：君欲速愈乎？能听我用药，甚非难事，但重用生石膏四两，加粳米三钱，煎汤四茶钟，分四次徐徐温饮下，尽剂必愈，此事我能保险也。陈君闻之，欣然听从。遂命人向药房购整块生石膏（药房预轧细者恐溷有煅石膏）一斤，自轧细，秤准四两，加粳米三钱，煮至米熟，取清汤四钟，先温服一钟，后两点钟服一次，果尽剂而愈。

廉按：温风为新感，叶天士所谓“温邪上受，首先犯肺”是也。伏气化热为伏热，张路玉所谓“伏气之发于夏至后者为热病”是也。方用表里双解。周身得微汗，而诸症反益甚者，胃家燥热上

蒸故也。故用重量生石膏清燥解热。妙在将石膏同粳米煎汤乘热饮之，俾石膏寒凉之性，随热汤发散之力，化为汗液，尽达于外，所以人欲发汗者，饮热茶不如饮热稀粥也。然必尽一斤而始愈，可见石膏为凉药中极纯良之品矣。

（选自《全国名医验案类编》，福建科学技术出版社 2003 年版，16~25 页）

温病案

病者：王义源之女，年十四五，住盐山城东牛留里。

病名：温病。

原因：仲春中旬，感受春温。医者诊治失宜，迁延十余日，病益增剧，医者诿为不治。

证候：心下胀满甚剧，喘不能卧，自言心中干甚，似难支持，其舌苔白而微黄，小便赤少，大便从前滑泻，此时虽不滑泻，仍每日下行。

诊断：脉搏一呼吸五至，左脉似弦而有力，右脉似大而有力，然皆不堪重按。知其温病之热本不甚剧，因病久真阴亏损，致小便不利，所饮之水停于肠胃则胀满，迫于心下则作喘，其心中干甚，亦真阴亏损之征也。

疗法：当滋其真阴，利其小便，阴足则心不觉干，便利则胀消，而喘亦可定，至于一些温病之余热，亦不治自愈也。

处方：鲜白茅根（去净皮与节间细根，剉碎）六两，用水三大碗煎一沸，俟半句钟，视其茅根，若不沉水底，再煎一沸，至茅根皆沉水底，其汤即成。去渣当茶，数次温饮之。

效果：饮茅根汤两日，其病霍然痊愈。盖白茅根凉润滋阴，又善治肾阴有热，小便不利，且具有发表之性，能透温病之热外出，一药而三善备，故单用之而能立建奇功也。然必剖取鲜者用之，且复如此煎法（过煎则性变），方能有效。

廉按：发明茅根功用，较徐洄溪尤为详明。方虽简单，药用周到，可谓温病善后之一种简效法。惟症既喘不得卧，拟仿《外台》

法，再加鲜枇杷叶二两，轻降肺气何如？

（选自《全国名医验案类编·初集·四时六淫病案》，福建科学技术出版社，273~274页）

温病兼喉疼案

病者：前察哈尔道尹胡珍簠，年五十四岁，原籍云南，寓天津英租界。

病名：温病兼喉疼。

原因：建筑楼房十余所，自初春开工，一切事务，皆自经管，费心劳神，暗生内热。又日饮牛乳两次作点心，亦能助热。内热上潮，遂觉咽喉不利，至仲秋又感受温病，其咽喉陡然作疼。

证候：表里俱觉发热，咽喉疼痛，妨碍饮食，心中之热，时觉上冲，则咽喉之疼痛益甚，周身酸懒无力，大便干燥。

诊断：脉象浮滑而长，右关尤重按有力，舌上白苔满布。此温病之热已入阳明，与内伤之热相并而为病也。

疗法：此症原初得两日，表证未罢，因内有蕴热，所以阳明之腑热已实，而脉象犹浮，舌苔犹白也。宜用重剂清其胃府之热，而少佐以解表之品，表解里清，喉疼亦当自愈。

处方：生石膏细末四两，煎汤一大钟，乘热将西药阿司匹林三分弱融化其中服之。因阿司匹林之原质存于杨柳皮液之中，实为辛凉解肌之妙品也。服后若得微汗，诸病自退。

效果：服药后约半点钟，肌肤似欲汗而未能透出，迟一点钟，觉心中之热不复上冲，咽喉疼痛轻减，时在下午一点钟。至晚间临睡时，仍照原方再服一剂，周身皆得透汗，安睡一夜，翌晨诸病若失矣。

廉按：温病兼喉疼，多属胃家燥热上蒸咽喉，故重用善清咽喉之石膏清凉解热，配以阿司匹林者，以其性最善发汗，又善透痧疹，使伏热从表外达也。方法虽新，仍是清凉解热之旧例。

（选自《全国名医验案类编·初集》，福建科学技术出版社2003年版，283~284页）

张镜人

论治外感发热

外感指六淫及戾气等外邪感染。六淫外邪偏于风寒者，则属伤寒，偏于温热者，则属温病。伤寒学派强调风寒，辨证分六经，详于寒而略于热。温病学派强调温热，辨证分卫气营血，重于热而忽于寒。我们应该在继承前人理论经验的基础上，取长补短，融会贯通，应用于临床实践。

人体的卫气，通过肺气的宣发，敷布于经脉之外及肌表部位，是一种防御机能。当外邪侵袭人体肌表或从口鼻吸入时，必然会影响卫气的运行，激起抗病反应，邪正相搏，因而导致了发热。如寒邪化热或温邪传里，热灼营血及内脏，又可出现种种热型。发热虽是共同的症状表现，但由于病因的不同，其证候的形成和治疗方法亦有区别，所以必须细致地进行辨证施治。

风寒

风寒之邪郁于肌腠，外邪侵袭，不能宣泄，搏于卫则为寒，郁于营则为热。因而症见发热恶寒。《杂病源流犀烛·恶寒发热原由症治》云：“经曰，人伤于寒，而传为热，何也？曰，夫寒盛则生热也，寒气外凝，阳气内郁，腠理坚致，六腑闭封，致则气不宣通，封则湿气内结，中外相薄，寒盛热生，故人伤于寒转而为热也。”

1. 风寒束表

感染风寒，外束肌表，风伤卫，寒伤营，风寒闭塞肌腠，卫阳被遏，营气不和，故临床表现为恶寒发热，寒重热轻，肢节酸楚。足太阳经循行于项背，主一身之表，邪客太阳，络脉不和，故头项

强痛、肢节酸楚。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》云：“太阳之为病，脉浮，头项强痛而恶寒。”肺合皮毛，表卫受邪，肺气失宣，故鼻塞流涕，咳嗽。《证治汇补·伤风》云：外风所伤，鼻流清涕，咳嗽清痰，舌无苔膜。

治法：疏风散寒，辛温解表。

处方：葱豉汤合败毒散加减。

淡豆豉9克，川芎5克，羌活5克，葱白头2个，桔梗3克，前胡6克，茯苓9克。每日一剂，水煎二次分服。

风寒袭表，邪在卫分者，治疗只宜表散，葱豉汤每能取效。苏颂说：“古今方书用豉治病最多，江南人善作豉，凡得时气即先用葱豉汤服之取汗，往往便瘥。”如表邪较重，症见头疼骨楚，或肺气失宣，症见鼻塞咳嗽，则应配合败毒散加减，以散太阳之邪而宣肺气。

2. 三阳合病

风寒郁遏三阳，表不解而里有热，故临床表现为发热壮盛，肌肤燔灼，邪遏不达，故无汗恶寒。《景岳全书·杂证谟》云：“如感风寒而传化为热。”《类证治裁·伤寒》引程氏说：“夫邪之在三阳也，有太阳之经、有阳明之经，有少阳之经。凡三阳在经之邪，未入腑者，可汗而已。”足太阳膀胱经，起眼内角、上额，循行头顶及耳上部；足少阳胆经，起于眼外角，分布耳前后；足阳明胃经，起于鼻部，经眼内角，眼眶下，入上齿，绕过口角。病邪客扰三阳之络，故头痛，眼眶痛，鼻干。舌苔薄白少润，示外感风寒，热邪于里。脉微洪，示热甚。

治法：疏表散寒，清热和里。

处方：柴葛解肌汤加减。

柴胡9克，葛根9克，羌活5克，白芷3克，桔梗3克，生石膏30克（先煎），白芍9克，黄芩9克，炙甘草5克。每日一剂，水煎二次分服。

柴葛解肌汤出自《伤寒六书》，实为统治三阳合病，表不解，里有热的主方。此时，只重发表，不清其里，则温散反助里热，表邪亦易热化，徒事清里，不解其表，必致遏邪内传。故用羌活、葛

根、柴胡合解三阳表邪，再加黄芩、石膏以清热于里，发表清里同治，对身热壮盛，恶寒无汗，头疼鼻干的证候，往往获得一汗而表解热退。

3. 邪传少阳

伤寒中风，邪传少阳，少阳居半表半里之位，风寒侵入半表半里，外与阳争而为寒，内与阴争而为热，表里不拘，内外无定，故临床表现为寒热往来。足少阳属胆，其脉络耳而循胸胁，客邪留阻，故耳聋，胸胁苦满。胆热气溢，胃失和降，故咽干口苦，嘿嘿不欲饮食，心烦喜呕。《伤寒论·辨太阳病脉证并治》云：“伤寒五六日中风，往来寒热，胸胁苦满，嘿嘿不欲饮食，心烦喜呕。”舌苔薄白而干，示风寒内传化热。脉弦，示病在少阳。

治法：和解表里，达邪清热。

处方：小柴胡汤加减：

柴胡9克，黄芩9克，半夏9克，陈皮5克，党参9克，甘草5克，大枣5个，生姜2片。每日一剂，水煎二次分服。

少阳之寒热，寒已而热，热已而寒，即所谓“往来”。这与太阳之寒时亦热，热时亦寒，阳明之但热不寒，足资鉴别。

其证又颇似疟，多是朝轻暮重，先寒栗而后发热。需分辨的是，一前者寒热往来常一日数次，发无定时，疟疾则日发或间日一发，稍有不同，且疟脉自弦，仍不离少阳，故应用小柴胡汤。由于少阳属半表半里，汗吐下皆在禁例，法当和解，因此，小柴胡汤以和解少阳的柴胡为主药，佐半夏、黄芩苦辛合化、开结泄热，服后“上焦得通，津液得下，胃气因和，身濈然汗出而愈”。说明少阳证候虽忌发汗，然必得汗始解。如正虚邪恋，原方的参甘姜枣，尤不可少。

温热

温热包括风热表证即表热证及春温、暑温、湿温、暑湿、秋燥、冬温等疾患。多由风热或温热兼夹其他病邪侵袭肌体所致。许多疾患，虽有一定的季节或症状等特征，但其病情的反映，可归纳

为卫气营血四类证候。卫气营血的四类证候，区分着温热病邪由浅入深的四个阶段，对外感热病临床提供了很好的辨证依据。

卫气营血的传变过程，是从卫分开始，渐次传入气分、营分和血分，亦有病邪不经卫分，直入气分或营分，或由卫传营。

1. 卫分证候

即表热证，常见于外感风热，亦是温热病早期证候的共同表现。“温邪上受”从口鼻吸入，首先犯肺，肺合皮毛而主表卫，病邪袭肺侵卫，卫气与之抗争，温为阳邪，故临床表现为发热、微恶风寒。《外感温热篇》章虚谷注：“凡温病初感，发热而微恶寒者，邪在卫分。”热性燔灼、开泄，故有汗。热灼津伤，肺失清宣，故咽喉燥痛、口渴、咳嗽。舌苔薄黄、边尖红，示温热。脉浮数，示热邪在卫在表。

治法：泄卫清热，辛凉解表。

处方：桑菊饮合银翘散加减。

清水豆卷 12 克，薄荷叶 5 克（后下），炒牛蒡 5 克，桑叶 9 克，杭菊 9 克，银花 9 克，连翘 9 克，干芦根 30 克，杏仁 9 克，桔梗 3 克，生甘草 3 克。每日一剂，水煎二次分服。

加减：汗多去薄荷叶；咳嗽痰多加炙款冬 9 克、浙贝母 9 克、瓜蒌皮 9 克；秋燥烦热、口干、咳嗽不爽加沙参 9 克、天花粉 12 克、炙桑皮 15 克。

温邪热变最速，邪侵卫分之初，仍当解表，表解热退则可杜其传变，所谓“在卫汗之可也”。但温属阳邪，故解表应取辛凉而避辛温，发热不甚，咳而微渴宜辛凉轻剂桑菊饮以宣肺；发热不恶寒而渴，宜辛凉平剂银翘散以泄卫。然二方都主清热，因此，常可结合使用。

还需指出，温热每多兼感，有夹风者，有夹湿者，临床上必须在辛凉解表的同时，力祛兼感之邪，或透风于热外，或渗湿于热下，热邪孤立，病自易愈。

2. 气分证候

邪在卫分，不得汗解，因而化热内传气分。这时，一方面由于热邪燔灼，另一方面则由于正邪交争，故临床特征为发热不恶寒，

但恶热，汗出不畅或汗出较多而热仍不解。《外感温病篇》章虚谷注：“不恶寒而恶热，小便色黄，已入气分矣。”病邪在气分的过程一般较长，因此，气分证候的范围也较广泛，可包括以下几类。

(1) 热蕴肺胃

热邪蕴阻于肺胃，热迫津液外泄，故临床表现为高热汗多，热扰胸膈，肺失清肃，故咳嗽、气急、烦渴。《伤寒论·辨阳明病脉证并治》云：“问曰，阳明病外证云何？答曰，身热，汗自出，不恶寒，反恶热也。”《温病条辨·中焦篇》云：“面目俱赤，语声重浊，呼吸俱粗，大便闭，小便涩，舌苔老黄，甚则黑，有芒刺，但恶热，不恶寒，日晡益甚者，传至中焦，阳明温病也。”舌苔黄燥，示阳明热盛伤津。脉洪大，示邪热内炽。

治法：清气泄热，除烦止渴。

处方：白虎汤加减：

生石膏 30 克（先煎），知母 9 克，连翘 9 克，银花 12 克，鲜竹叶 9 克，生甘草 5 克。每日一剂，水煎二次分服。

邪入阳明气分，其外证为壮热汗多，其内候为烦躁渴饮。见此症象，方堪投白虎汤，所谓“到气才可清气”。即使四肢厥冷，但脉滑而烦渴谵语者，仍属热深厥深，亦宜清解，误用温药，病必危殆。

(2) 热结胃肠

热邪与胃肠的食积、燥屎结聚，腑气不通，形成实热壅结，故临床表现为日晡潮热，热盛扰心，心气内乱，故神昏谵语，循衣摸床。肠内有燥屎，故脘腹胀满疼痛拒按，便秘或稀水旁流。《伤寒论·辨阳明病脉证并治》云：“阳明之为病，胃家实是也。”“阳明病，谵语，有潮热，反不能食者，胃中必有燥屎五六枚也，若能食者，但硬耳，宜大承气汤下之。”《湿热病篇》云：“湿热证，发痉撮空，神昏笑妄，舌苔干黄起刺，或转黑色，大便不通者，热邪闭结胃腑，宜用承气汤下之。”舌苔黄厚干燥，示阳明腑实。脉沉数，示里热积滞。

治法：通腑破结，泻热存阴。

处方：大承气汤加减。

生大黄9克（后下），元明粉9克（冲），川朴9克，枳实5克，黄芩9克。每日一剂，水煎二次分服。

阳明腑实热结，热邪燔灼，需急下存阴，所谓“阳明之邪，仍假阳明为出路”。承气用硝黄以逐阳明的燥火实热，然必须具备痞满燥实坚潮六证，痞乃胸脘痞闷，满乃腹满，舌苔黄燥，大便干结不通为燥，腹痛拒按为实，胸腹按之坚硬为坚，日晡潮热为潮。六者齐全，即属大承气证无疑。胃脉通心，邪盛热炽，逼乱神明，则见谵语撮空，《伤寒论》中谵语而采取三承气下法的十之八九，可知谵语乃实证应下主要外候。

如内有燥屎坚结，引起旁流注泻，其泻下物多臭秽异常，肛门灼热作痛，亦宜承气泄壅清热。

（3）湿热交阻

湿与温热或夹暑热逗留三焦，气机不调，热邪被湿阻遏不能透达，故临床表现为身热不扬，午后转盛。湿热交阻，清窍被蒙，故头重。中焦气化失宣，津不上承，故胸闷，泛恶，渴不欲饮。脾主四肢，脾为湿困，故肢体疲惫。《湿热病篇》云：“湿热证，始恶寒，后但热不寒，汗出，胸痞，舌白，口渴不引饮。”湿热郁蒸肌肤，故颈项及胸腹布见白痞。《外感温热篇》云：“再有一种白痞，小粒如水晶色者，此湿热伤肺，邪虽出而气液枯也，必得甘药补之，或未至久延，伤及气液，乃湿郁卫分，汗出不彻之故，当理气分之邪，或白如枯骨者多凶，为气液竭也。”下迫肠道，故小便短赤，大便稀薄。舌苔黄厚腻，示湿遏热伏。脉濡数，示湿热。

治法：宣气化湿，清热达邪。

处方：三仁汤合薏苡竹叶散加减。

清水豆卷12克，白蔻仁3克，白杏仁9克，陈皮5克，炒蒿梗9克，生苡仁12克，茯苓9克，连翘9克，益元散9克（包），淡竹叶9克。每日一剂，水煎二次分服。

加减：暑湿交阻，低热，四肢疲惫，去清水豆卷、益元散，加鲜藿香9克、甘露消毒丹12克（包）。

湿热盘踞中焦，氤氲气分，其发热多呈午后升高，常伴发一种晶莹的小粒皮疹，一般先起于颈项，继及胸腹、两腰，痞布前，病

人身热转盛，并感胸院痞闷，见痞后，热势每获缓解，胸院亦舒，三四天左右逐渐回收，甚至连发四五次，身热和症状也随着白痞的出没相应地进退，痞透邪清，则热除病愈。因此，白痞是湿热病邪外达的征象，治疗切忌表散，宜宣气化湿，泄热透邪，三仁汤和薏苡竹叶散最为适合。枯燥如虱壳或带浆的称“枯痞”和“浆痞”，均属正气耗伤，应酌加珠儿参、沙参、石斛等以益气阴。

3. 营分证候

外感温热，在热盛期较气分证有更进一步的证候。如病邪从卫分不经气分而直入于营，则称“逆传心包”。《外感温热篇》云：“温邪上受，首先犯肺，逆传心包。”章虚谷注：“所以言温邪上受，首先犯肺者，由卫分而入肺经也。以卫气通肺，营气通心，而邪自卫入营，故逆传心包也。”其病情较危重。热入营分，侵扰心神，故临床表现为高热烦躁，神昏谵语。热灼血络，故肢体出现斑疹。《外感温热篇》云：“营分受热，则血液受劫，心神不安，夜甚无寐，或斑点隐隐。”舌质红绛无苔或少苔，示热入营分。脉数，示邪热内炽。

治法：凉营解毒，泄热清心。

处方：清营汤加减。

广犀角9克（先煎），鲜生地30克，元参9克，生石膏30克（先煎），知母9克，丹皮9克，赤芍9克，连翘9克，银花12克，鲜竹叶9克。每日一剂，水煎二次分服。

温邪入营，为热病临床的严重证候。叶天士提出，“入营犹可透热转气”，确属经验之谈。邪入营分的指征，是发热烦躁，神昏谵语，皮肤出现斑疹。舌质红绛，苔色深黄少液。转气的治法关键，全在透热，透热自需避免滋阴遏伏，但亦绝不宜用表散。重点应清泄营分热邪，清营可杜温邪入里，泄热可透斑疹外达，临床上均宗吴鞠通的清营汤。然斑出于肌肉，应取石膏、黄芩、知母以清肺胃，疹出于血络，需加丹皮、赤芍以凉营血。

4. 血分证候

邪热内陷，深入血分，可有两种情况。

（1）实热：邪热燔灼，煽动肝风，耗血动血，为实热。故临

床表现为高热、神昏、手足抽搐。《湿热病篇》云：“湿热证，壮热口渴，舌黄或焦红，发痉，神昏，谵语或笑，邪灼心包，营血已耗。”营分热盛，迫血妄行，故鼻血、咯血、便血或皮肤出现紫色斑疹。《湿热病篇》云：“湿热证，上下失血，或汗血，毒邪深入营分，走窜欲泄。”舌质深绛，示邪热消灼营血。脉数，示热盛。

治法：凉血解毒，清热开窍。

处方：犀角地黄汤合紫雪丹加减。

广犀角9克（先煎），鲜生地30克，赤芍9克，丹皮9克，大青叶15克，连翘9克，银花9克，白茅根30克，每日一剂，水煎二次分服。紫雪丹5分，温开水调送。

心主营，肝藏血，热入营血，必然内传包络，煽动肝风，症见神识昏迷，四肢抽搐，且由于温邪燔灼，迫血妄行，常伴有鼻血，咯血或便血，治宜凉血解毒。但凉血解毒，尚不能驱包络之邪，故配合紫雪丹开窍清热。

（2）虚热：邪热劫灼肝肾真阴，虚风内动为虚热，故临床表现为身热朝衰暮盛。《温病条辨·上焦篇》云：“燥久伤及肝肾之阴，上盛下虚，昼凉夜热，或干咳，或不咳，甚则痉厥者，三甲复脉汤主之，定风珠亦主之。”精气虚竭，故神倦、耳聋。《温病条辨·下焦篇》云：“温病耳聋，病系少阴。”阴液耗伤，故咽干口燥，牙齿干枯。《外感温热篇》云：“若如枯骨色者，肾液枯也。”血虚筋脉失养，故手足蠕动。《温病条辨·下焦篇》云：“热邪久羁，吸烁真阴，或因误表，或因妄攻，神倦瘈瘲，脉气虚弱，舌绛苔少，时时欲脱者，大定风珠主之。”舌质光绛，示伤阴脱液。脉虚数，示阴虚热灼。

治法：滋阴清热，潜阳熄风。

处方：大定风珠加减。

大生地15克，麦冬9克，生白芍9克，五味子5克，炙甘草5克，生鳖甲15克（先煎），生龟板15克（先煎），鸡子黄2枚（分2次搅冲），知母9克，阿胶9克（分2次烊入），生牡蛎30克（先煎），钩藤9克（后下）。每日一剂，水煎二次，先纳阿胶烊尽，候稍冷，再入鸡子黄搅和，分服。

温热病伤阴当分两个阶段。第一阶段先伤胃津，应投甘寒之剂，如石斛、花粉、麦冬、芦根等生津养胃为治。邪热久羁，必伤肾液，此时“邪气已去八九，真阴仅存一二”，甘寒自不能及，急宜阿胶、生地、龟板、鳖甲、鸡子黄等咸寒的药物以滋养之。鸡子黄必俟药小冷，然后搅拌冲入，恐受热则蛋黄凝结成块。亦有嫌其腥浊难服，用布包煎，殊失制方原意。

温疫疠气

温疫疠气多由感染疫疠之气所致，且最易传染。《温疫论·原序》云：“夫温疫之为病，非风、非寒、非暑、非湿，乃天地间别有一种异气所感。”又说：“疫者感天地之疠气，……此气之来，无论老少强弱，触之者即病，邪自口鼻而入，则其所客，……舍于夹脊之内，去表不远，附近于胃，乃表里之分界，是为半表半里，即《针经》所谓横连膜原是也。”疠气从口鼻侵入，内传夹脊，表气不能通于内，里气不能达于外，营卫运行之机受阻，故临床表现为先恶寒而后发热，头疼身痛。《温疫论·温疫初起》云：“温疫初起，先憎寒而后发热，日后但热而无憎寒也。初得之二三日，其脉不浮不沉而数，昼夜发热，日晡益甚，头疼身痛。”邪热散漫，越于太阳，故项痛连及腰背；越于少阳，故胁痛、耳聋、呕而口苦；越于阳明，故眉棱目眶疼痛，鼻干，舌苔白如积粉，示疫邪遏伏。脉数，示热盛。

治法：达原透邪，化湿清热。

处方：达原饮加減。

槟榔9克、川朴4.5克、草果3克、白芍9克、青蒿9克、黄芩9克、知母9克、炙甘草3克。每日一剂，水煎二次，分服。

项痛连及腰背加羌活4.5克；胁痛、耳聋、呕而口苦加柴胡4.5克；眉棱及目眶疼痛、鼻干加葛根4.5克。

服药后，如病邪不从汗解，舌根先黄，渐至中部，应用三消饮：即达原饮合三阳经引经药再加大黄。如高热汗多，口渴引饮，脉洪数，应用白虎汤。如热盛烦躁，鼻孔呈煤烟色，舌苔变黑生

刺，应用大承气汤。

温疫疠气为病，来势急骤，寒热俱盛，脉不浮，舌苔多白如积粉。临床体会，实由疫邪湿秽深重，湿遏热伏，表里阻隔所致。吴又可定达原饮，自称“槟榔能消能磨，除伏邪，为疏利之药，又除岭南瘴气，厚朴破戾气所结，草果辛烈气雄，除伏邪盘踞，三味协力，直达其巢穴，使邪气溃败，速离膜原”。辨证用药，独具卓识。盖非苦温辛烈，殊难开达疫邪秽湿。然里热郁遏，过燥则湿从热化，因此必须佐以黄芩、知母清热护阴。

疟邪瘴毒

多由疟邪夹痰留伏或山岚瘴毒所致。前者属疟疟，后者属瘴疟。疟邪夹痰或瘴毒内舍募原之间，入而与阴争，出而与阳争，故临床表现为寒战壮热、休作有时。营卫失调，故骨节酸痛。痰浊中阻，胃肠不和，故时有呕吐。《素问·疟论》云：“疟之始发也，先起于毫毛，伸欠乃作，寒栗鼓颌，腰脊俱痛，寒去则内外皆热。”瘴疠毒邪冲心，故迷闷烦躁，甚至神昏谵语。《杂病源流犀烛·疟疾源流》云：“瘴疟者，感受山岚湿润之毒气，以至败血瘀心，瘀涎聚脾，故乍寒乍热，迷困发狂。”舌苔腻，示痰湿蕴热。脉弦，示疟证。

治法：截疟化痰，泄热解毒。

处方：截疟七宝饮合藿香平胃散加减。

常山5克，草果3克，槟榔9克，厚朴5克，苍术9克，藿香9克，制半夏9克，干菖蒲9克。每日一剂，水煎二次，分服。

寒多热少为牝疟，加柴胡9克、桂枝9克、干姜5克；热多寒少为瘴疟，去川朴、苍术、藿香，加桂枝5克、生石膏30克（先煎）、黄芩9克；呕吐加玉枢丹1.5克，温开水调送；神昏谵语加紫雪丹3克，分2次，温开水调送。

疟邪留阻半表半里，故寒热往来，证如少阳，惟休作有时稍异。轻症用小柴胡汤和解达邪，每能取效，久疟或杂瘴疠，则需驱瘴截疟。常山、草果、槟榔均属驱瘴截疟的要药。但疟疾多夹痰

湿，所谓“无痰不成疟”，而草果气秽，常山又令人呕恶，因此临床上应配合藿香平胃散化痰除湿，且可缓解常山、草果的反应。牝疟寒多热少，宜柴胡桂姜汤；瘧疟热多寒少，宜白虎加桂枝汤加减为治。

（选自《中国百年百名中医临床家丛书·张镜人》，中国中医药出版社2002年版，11~23页）

用泄热化湿法治愈风湿案

袁某，女，33岁。

初诊：1979年12月3日。

主诉：持续高热六天，咽喉疼痛，头痛，四肢酸楚，恶心，上腹部不适。体检：体温39℃，神志清晰，巩膜轻度黄染，咽部充血，扁桃腺I度肿大。化验：血白细胞350~800/立方毫米，谷丙转氨酶95单位，胆红素1.80毫克%，总胆红素2.04毫克%，新鲜尿找到巨细胞病毒包涵体。

诊查：热势起伏，经候不解，面赤头痛，咽痛，口唇干燥，胸闷不畅。脉细数，舌根白腻，前半苔黄少润。

辨证：风湿时邪，挟湿交阻，有化热转气之象。

治法：先拟清温泄热。

处方：清水豆卷12克，炒牛蒡5克，桑叶9克，炒杭菊9克，炒黄芩9克，连翘9克，银花12克，野荞麦根30克，瓜蒌皮9克，广郁金9克，炒枳壳9克，益元散9克（包），钩藤9克（后下）

二诊：12月6日。发热仍壮盛，汗出不畅，头痛口干，巩膜色黄，胸闷不畅，右肋下按之疼痛。脉细滑数，舌苔黄腻满布，边红。邪湿交遏，瘀热在里，少阳气郁，胆液外溢。拟予清温达邪，化湿泄热。

处方：清水豆卷12克，茵陈30克（另煎冲入），炒山栀9克，连翘9克，银花30克，瓜蒌皮9克，平地木15克，大青叶12克，白花蛇舌草30克，甘露消毒丹12克（包），炒黄芩9克。

三诊：12月9日。热势朝衰暮甚，头痛，无汗，巩膜色黄，胸闷不畅。脉虚弦而带滑数，舌苔黄腻，质红。湿热熏蒸，气阴受烁，邪盛正虚，拟仿白虎加人参法。

处方：皮尾参9克（另煎冲入），生石膏30克（先煎），银花藤30克，杏仁9克，炒黄芩9克，炙远志3克，茵陈15克（另煎冲入），猪殃殃30克，炒赤芍15克，左秦艽9克，广郁金9克，蛇舌草30克，连翘9克，甘露消毒丹12克（包）。

四诊：12月12日。得汗热势大减，口干较缓，头痛胸闷亦瘥，惟巩膜仍黄染。脉转濡数，舌苔黄腻渐化，质红已淡。温邪虽获透达，湿热逗留未彻。再守原方，宜慎饮食，以防反复。

五诊：12月14日。身热已退，巩膜黄染渐淡。脉濡数带滑，舌根黄腻尚未化净，质偏红。法当清理余邪湿热而和胃气，竹叶石膏汤加味。

处方：皮尾参9克（另煎冲入），生石膏9克（先煎），茵陈15克（另煎冲入），广郁金9克，连翘9克，银花藤15克，秦艽9克，炒桑枝12克，淮小麦15克，白杏仁9克，淡竹叶15克，白花蛇舌草30克，香谷芽12克，益元散9克（包）。

患者住院两周，身热逐减，以致退尽。体检：巩膜无黄染，咽部（一）。化验：血白细胞上升至4400/立方毫米，肝功能恢复正常，尿未找到巨细胞病毒包涵体。痊愈出院。

按语：温病学家陈平伯称：“风温为病，春月与冬季居多。”吴坤安亦谓：“凡天时晴燥，温风过暖，感其气者，即是风温之邪。”由于风温属阳邪燥热，燥热从金，热归阳明，常先犯肺胃，症见身热、咳嗽、烦渴。然本案初起并无咳嗽，临床表现高热口干，巩膜黄染，右胁下疼痛，显系少阳、阳明湿热交遏，客邪再至，内外相引，煽动木火燔灼，胆液泄溢，致热势鸱张，面赤目黄，乃风温之变证。复以湿邪挟热内郁，耗伤气阴，因此，身热逾旬不解，脉见虚弦。实验室检查，血白细胞仅350~800/立方毫米，提示邪盛正虚，预后堪虑。证变则论治自需权宜，遂仿白虎加人参法，参入化湿泄热之品，三剂而热衰，六剂而热退黄淡，效应犹如桴鼓。于焉体会，医者必须知常达变，深思果断，毋失时机。

若惟务按图索骥，因循贻误，又安能咎药石之无灵耶！

〔选自《中国现代名中医医案精华（二）·张镜人医案》，北京出版社1990年版，1042~1044页〕

治春温医案

初诊：遗泄后感受寒邪，自毛窍而入，引动少阴伏气，发为春温。身热微微，过经不解，神志时清时昏，多笑，目赤，烦躁，渴不多饮，得温而安，腹中乍疼，寤寐不宁。红疹渐现，尚未透足。二便均行。脉象左寸紧，关尺弦细，右寸关滑数，尺细；舌色边白，中央淡黄腻。势属非轻，防其内闭外脱之虞，拟温解清托。

川桂枝四分泡汤，炒淡黄芩一钱，苏梗二钱，姜山栀二钱，淡豆豉四钱，前胡二钱，桑叶二钱，牛蒡子三钱，川贝二钱，全瓜蒌四钱（炒），北细辛三分，广橘络二钱，朱灯心二十寸，姜竹茹二钱，佛手一钱，附子理中丸八分（包）。

复诊：遗泄后受寒，引动伏邪，发为春温，病经九日，热不外扬，四肢乍冷，神志时清时晕，谵语多笑，渴不欲饮，红疹隐约未透。脉象细数，舌色淡黄根腻。防其风动痉厥不测。

川桂枝三分，淡黄芩一钱五分（同炒），粉葛根一钱，橘络二钱，净柴胡六分，净蝉衣一钱五分，淡豆豉三钱，老苏梗二钱，朱连翘一钱五分，牛蒡子三钱，姜山栀二钱，姜竹茹二钱，附子理中丸一钱（包）。

三诊：春温挟湿，病经旬日，身热略扬，四肢渐温，寤寐少安，神志虽清，多言多笑，口渴不喜饮，红疹肌布，四肢未足，骨楚唇燥，溲少便秘。此由邪伏三焦，势属非轻，明当大节，慎防变迁，饮食起居，诸宜谨慎。拟清解疏里之法。

淡豆豉三钱，细生地五钱（同打），朱连翘一钱五分，瓜蒌子三钱（炒），姜山栀二钱，橘络二钱，前胡二钱，炒陈皮一钱，桑叶一钱五分，熟牛蒡三钱，竹茹二钱（姜汁炒），佛手一钱。

四诊：诊脉左寸关弦滑，右寸关滑数少神，两尺皆细，苔色淡黄尖绛。春温逾旬，湿蕴化热，谵语虽减，神烦多笑，寤寐渐安，

红疹未化，现发白痞，口腻。症势非轻，防其痉厥，宜清解治之。

大豆黄卷三钱，仙露半夏一钱五分，象贝三钱（去心），青黛三分（拌润），玄参三钱，新会皮一钱五分（盐水炒），陈蒿子一钱五分，广郁金一钱，纯钩藤三钱（后人），鲜竹茹二钱。

注：青黛拌玄参，有滋肾清肝之效。

五诊：温邪十二天，表热虽有解意，里邪达而未楚，红疹已现而显，肺气稍利，见有晶痞，神志时清，疲倦少力，口黏。脉象弦数带促数，舌淡黄浊腻尖绛。欲图滋腻，深虑邪湿胶固；再谋攻托，恐致营阴耗竭。勿敢偏执，聊以清化。

黑豆卷三钱（炒），姜山栀一钱五分，青蒿梗一钱五分，铁皮石斛三钱，姜半夏一钱五分，带心连翘一钱五分（朱砂拌），炒黄川贝二钱，新会皮一钱五分（盐水炒泡），广郁金一钱，牛蒡子三钱（勿打），二青竹茹二钱（姜水炒），佛手柑一钱。

六诊：温邪十三天，表热虽淡，里气未和，腹鸣，大便未畅，疹痞略化，肌痒。脉象滑数，舌浊腻。邪未清撤，明当两候，防其战汗致变，予清化痰湿。

陈蒿梗一钱五分，姜半夏一钱五分，通草一钱，生枳壳六分，新会皮一钱五分（盐水炒），赤苓三钱，炒黄川贝二钱，朱连翘一钱五分，采云曲二钱，橘络二钱，竹茹二钱（姜汁炒），佛手柑八分，藿香正气丸一钱五分（包）。

七诊：表热虽解，里气未和，腑气仍然未通，口黏，神疲乏力，疹痞略化。脉滑而促数，苔糙。温邪两候，湿热弥漫，防有转变，宜清里膈。

黑豆卷三钱，姜山栀二钱，朱茯神三钱，全瓜蒌四钱（炒），炒枳实一钱五分，朱连翘二钱，鲜石斛四钱，青蒿梗一钱五分，前胡二钱，焦薏仁三钱，竹茹二钱（姜汁炒）。

八诊：温邪半月，热势已退，余湿未楚，大便行而未畅，神疲乏力，胃纳少思，疹化，痞点半收。脉软滑数，舌腻稍化，苔微白。慎防反复，宜清里治之。

陈蒿梗一钱五分，仙露半夏一钱五分，川郁金一钱，片通草一钱，赤茯神三钱，川贝二钱，姜山栀一钱五分，泽泻一钱五分，炒

陈皮一钱五分，香谷芽四钱，佛手柑一钱，扁金斛三钱。

九诊：里邪解而未楚。昨晚便行时，误披冷衣，复受寒邪，以致身热又盛，口腻溲少，疹化，晶痞半收，汗出首而。脉软滑数，舌腻满布色白。病逾半月，余邪未楚，复受新感，症势重笃，防其内传，先予温泄治之。

清炙桂枝三分，炒枳壳一钱五分，青蒿一钱五分，炙柴胡六分，姜山栀一钱五分，橘络二钱，炒香豆豉三钱，全瓜蒌四钱（炒），姜半夏一钱五分，炒陈皮一钱五分，姜竹茹二钱，凉膈散一钱（包）。

十诊：昨投温通之剂，服后肌热略淡未退，大便虽行不畅，神倦乏力，胃不思纳，口淡，渴不饮浆，小溲短少，红疹虽化，晶痞半收。脉软而数，舌白稍退，根腻尖绛。新邪虽有解意，三焦依旧不利。病延半月余，势属非轻，慎防再发痞疹，变迁不测，勉拟表里兼施之法。

黑豆卷三钱，姜山栀二钱，苏梗一钱五分，川桂枝三分，拌炒青蒿梗一钱五分，全瓜蒌四钱（炒），佛手柑八分，川连三分拌佩兰叶一钱，橘络二钱，姜竹茹二钱，炒牛蒡三钱，带心连翘一钱五分（朱砂拌）。先服碧雪丹五分，白开水调送。

注：桂枝炒青蒿，川连拌佩兰，表里兼施，亦属我家创法。春末夏初季节，每取桂枝拌炒青蒿治外感风邪，内蕴湿热的病例，服后得微衄，则可冀迅获邪衰热退之效。碧雪出《局方》，芒硝、青黛、石膏、寒水石、朴硝、硝石、甘草、马牙硝各等分。

十一诊：昨投两顾之法，大便依然未更，汗泄不调，唇干齿燥。脉细虚数，舌糙少液。症势甚险，防其昏脱。

黑豆卷三钱，京赤芍一钱五分，知母二钱，铁皮石斛四钱，朱连翘二钱，牛蒡子三钱（炒），纯钩藤五钱（后人），黑山栀二钱，丹皮一钱五分，南花粉一钱五分，鲜竹茹二钱，川郁金一钱。

十二诊：连战两晚，战后有汗，大便虽行，色如败酱，神疲乏力，胃纳略思，两目仍赤，晶痞大如绿豆。脉数，两尺皆滑软。病经两旬，体虚邪不肯清，尚虑虚脱不测，勉予清化。

鲜石斛四钱，生山栀一钱，知母一钱五分（盐水炒），纯钩藤

四钱（后人），川郁金一钱，牛蒡子一钱五分（炒），朱连翘二钱，南花粉一钱五分，炒黄川贝二钱，朱灯心二十寸，姜竹茹二钱，活水芦根五钱。

十三诊：脉静身凉，虞防再复。

焦白术一钱五分，仙露半夏一钱五分，炒枳壳二钱五分，川石斛四钱，炒陈皮一钱五分，陈蒿子一钱五分，赤茯神三钱，炒黄川贝二钱，佛手柑一钱，广郁金一钱，泽泻一钱五分（盐水炒），焦谷芽三钱。

注：以后八诊略，共二十一诊全愈。

（选自《中国百年百名中医临床家丛书·张镜人》，中国中医药出版社2002年版，43~48页）

陈务斋

三阳风热症案

病者：吴兴，年三十岁左右，广西藤县，住梧州旅司令部。体壮，军政界。

病名：三阳风热证。

原因：劳心太甚，昼夜不能安眠，心神焦躁，火热渐升。诱因出巡适值天气乍寒乍热，感受风邪。素因性直而刚，过于疲劳，往往肝气郁怒，久郁而火暴发。

证候：起则头目疼痛，肢体困倦，肢表麻木挛急，骨节疼痛，寒热往来，目赤唇焦，渴饮呕逆，呻吟不息。继则全身大热，昼夜不休，鼻干口燥，气逆喘急，口苦耳聋，形容憔悴，谵语昏狂，危殆异常。

诊断：左则浮洪弦数，右则浮滑数，六脉有力而实。脉症合参，风热证也。奈阅前医之方，以温散治风之药，愈服则风愈生，火愈盛，而病岂不危乎。今所幸者，脉尚未脱，谅能救治。

疗法：汤剂用疏风羚羊钩藤汤。取莲心、玉竹、羚羊、磨犀清心肝郁热，柔润熄风为君；钩藤、柴胡、蝉退、木瓜解表和里，舒筋活络为臣；石膏、知母、胆草、粉葛平阳明胃热，润燥生津为佐；木通、皂角利水化痰，通关开窍为使。二服则燥热已减，谵语已除，人事醒而不昏，肢表不挛。惟头部仍痛，体中发热，诊脉浮洪已除，只见弦数。又用平阳退热汤，取其清心肝而平君相，疏表和里，清热解肌，生津平胃。连数服，热退体和，头痛已除，渴饮亦止。惟腹满大便燥结十日不行，诊脉数而有力。又用大承气汤，推荡大肠去郁热。连三服，得下十余次，腹中不满，略能进食。惟四肢重倦无力，步履困难，又用荣筋逐湿汤，取其活血荣筋，宣通筋络，清热去湿。连数服，则肢不倦。惟元气太弱，语言艰涩，诊

脉已弱无力，又用参芪宁神汤，取其补气生津，清心宁神，运脾健胃，滋阴去湿。

处方：疏风羚羊钩藤汤方。

羚羊角钱半，磨犀尖二钱，钩藤勾五钱，生石膏五钱，莲子心五钱，川柴胡一钱，明玉竹三钱，生葛根一钱，川木瓜三钱，蝉退钱半，肥知母四钱，牙皂角一钱，龙胆草二钱，汉水通钱半，煎服。

次方：平阳退热汤方。

生石膏五钱，钗石斛三钱，知母四钱，胆草二钱，川草薢三钱，羚羊角一钱，莲子心四钱，丝瓜络三钱，木通钱半，青蒿三钱，煎服。

三方：大承气汤方。

川厚朴三钱，川枳实四钱，生大黄四钱，元明粉三钱，煎服。

四方：荣筋逐湿汤方。

川木瓜三钱，桑寄生五钱，威灵仙二钱，川黄柏三钱，生土薏六钱，归身钱半，云茯苓三钱，丝瓜络三钱，生牛膝三钱，防己二钱，嫩桑枝六钱，煎服。

五方：参芪宁神汤方。

花旗参三钱，生白芍三钱，破麦冬四钱，怀山药三钱，开莲米四钱，薏苡五钱，酸枣仁二钱，云茯神四钱，川杜仲二钱，正龟胶一钱，炙黄芪二钱，煎服。

效果：十日燥平渴止，谵语已除，人事已醒，热退休和。二十日食量大进，三十日元气已复，精神壮健。

廉按：此肝络伏热，因感外风，从阳明而外溃，故一发即热盛风动，病势剧烈，非犀羚白虎汤加减不足以杀其势，大承气汤不足以芟其根，善后二方，亦有力量，故能效如桴鼓。惟方中柴葛，劫肝阴而伤胃汁，究宜慎用。

（选自《全国名医验案类编·初集·四时六淫病案》，福建科学技术出版社，30~32页）

陈存仁

治感冒医案

谭右

初诊：外受风寒之邪，清肃失司，咳嗽气机不利，头重神疲。治予疏化润肺。

嫩前胡钱半，象贝母钱半，旋覆花三钱，嫩桑枝三钱，化橘红三钱，海蛤壳三钱，炙紫菀三钱，炙款冬三钱，白苏子三钱，苦桔梗八分，冬瓜子三钱，瓜蒌皮三钱。

二诊：风寒外袭，清肃失司，鼻塞气机不利。治予疏利清肃。

清水豆卷四钱，嫩前胡八分，瓜蒌皮三钱，荆芥穗八分，青防风八分，海蛤壳三钱，炙紫菀三钱，炙款冬三钱，冬瓜子三钱，苦桔梗八分，清炙枇杷叶（去毛，包）三钱。

三诊：寒热已解，咳嗽未已，气机失畅，余邪逗留，痰多，治以补肺理气。

化橘红三钱，光杏仁三钱，海蛤壳三钱，佩兰梗钱半，净蝉衣八分，炙紫菀三钱，瓜蒌皮三钱，六神曲三钱，象贝母钱半，炙款冬钱半，旋覆花三钱。

陈宝宝

初诊：风邪逗留肺胃，蕴为湿热，痰多气喘，苔黄咳嗽，神昏。治予疏化清理。

清水豆卷四钱，赤茯苓三钱，旋覆花（包）三钱，六神曲三钱，荆芥穗一钱，瓜蒌皮三钱，天花粉三钱，冬桑叶三钱，嫩前胡钱半，光杏仁三钱，莱菔子三钱，佩兰叶一钱，淡黄芩三钱。

二诊：痰喘略痊，风邪逗留肺胃，蕴为湿热，唇焦苔黄，身热咳嗽，神昏呓语。治予疏化清理。

清水豆卷四钱，粉葛根三钱，车前子三钱，旋覆花三钱，淡黄

芩三钱，赤茯苓三钱，青礞石三钱，炙紫菀三钱，冬桑叶三钱，碧玉散四钱（包），代赭石三钱，炙款冬钱半，瓜蒌皮三钱。

三诊：脉象细数，苔黄蕴热，余邪逗留肺胃，咳嗽少减。治予清理。

清水豆卷四钱，瓜蒌皮三钱，京赤芍钱半，炙款冬三钱，赤茯苓三钱，旋覆花（包）三钱，象贝母钱半，海蛤壳三钱，牡丹皮三钱，炙紫菀三钱，佩兰叶一钱。

四诊：湿热余邪，逗留肺胃，痰多闭塞气机，咳嗽不畅，治予清理湿热。

清水豆卷四钱，海蛤壳三钱，瓜蒌皮三钱，车前子三钱，冬桑叶三钱，光杏仁三钱，苦桔梗八分，六神曲三钱，化橘红三钱，象贝母钱半，冬瓜子三钱，生熟苡仁各三钱。

（选自《近代中医珍本集·医案分册·陈存仁先生医案》，浙江科学技术出版社2003年版，915~916页）

陈作仁

春温案

病者：陈其义，三十六岁，南昌人，住城内。

病名：春温。

原因：失偶续弦，时当客冬，房事过劳，真阴亏损，又兼冬令严寒。《经》云：“冬伤于寒，春必温病。”又云：“冬不藏精，春必病温。”其斯之谓欤。

证候：初起症似伤寒，惟热多寒少，常有汗出，汗后而热不稍减，且口渴引饮，此与伤寒病状，大不相同。

诊断：两寸脉浮大而数，右寸脉尤洪。脉症合参，断为春温，乃热邪伤阴之候也。

疗法：但春温证而恶寒，微兼表证，不能骤用纯阴之剂，宜仿仲景麻杏甘石汤主之。但麻黄春夏宜慎用，兹以薄荷代麻黄为君，杏仁宣表为臣，石膏质重泻火，气轻解肌为佐，甘草和中为使。但温必有毒，有浊气，加银翘芳香化浊，泄热解毒，以助石膏之清解。

处方：苏薄荷一钱二分，叭嗒杏仁三钱（去皮尖），生石膏八钱（杵），生甘草一钱，净金银花三钱，青连翘三钱。

效果：此方连进二剂，各症均减过半，惟咳嗽热渴尚未痊愈，易以桑菊饮加减续进。

冬桑叶三钱，白菊花二钱，苦杏仁二钱（去皮尖），桔梗钱半，贝母钱半，鲜芦根三钱，淡竹叶钱半，苏薄荷四分，生甘草一钱。

此方又接进三剂，未七日而各症逐渐就痊矣。

廉按：辨证清切，选药愜当，妙在初起即用荷、杏、石、甘加银翘，而为辛凉之重剂，较吴氏银翘散力量尤大，真得叶氏薪传也。

（选自《全国名医验案类编》，福建科学技术出版社2003年版，288页）

春温误治案

病者：杨春芳，年四十八岁，南昌人，住广润门外。

病名：春温误治。

原因：无子而新娶一妾，甚宠爱，未免房事过劳，时届春令，无以应生发之气，致发春温重症。误服辛温发表等剂，病日加重，延误旬日。

证候：壮热不退，汗多口渴，大便旬余不通，舌苔黑生芒刺，病势危险已极。

诊断：脉左右俱洪数鼓指。合参病势现象，察其前服各方，知系春温误药所致。证已至此，非大剂滋阴兼涤肠，不及挽救。

疗法：议以增液承气法，重用玄参、生地、麦冬为君以滋水养阴，合大承气汤以急下存津，此亦破釜沉舟之意也。

处方：润玄参六钱，鲜生地六钱，杭麦冬五钱（去心），生川大黄三钱，川厚朴二钱，炒枳实二钱，元明粉二钱（冲）。

次诊：一剂大便即通，热渴俱减，险象已除。遂改以复脉汤去姜、桂续进。

细生地六钱，杭麦冬五钱，杭白芍三钱，阿胶珠三钱，生甘草二钱，火麻仁三钱（去壳，捣）。

效果：服二剂，热渴均愈，惟胃阴不足，正气尚亏。又进益胃汤加减，以为善后调理。

北沙参四钱，润玉竹三钱，细生地四钱，杭麦冬三钱，抱木茯神三钱，粉甘草二钱，鲜橄榄四枚（剖破，若无橄榄时不用亦可）。

煎成后去渣，加上冰糖五钱烱化，频频服之，服四剂而痊愈。

廉按：春温误治，至舌黑而生芒刺，症势已险，方用增液承气法救误，确有巨功。惟续进减味复脉汤，稍嫌太骤。当先进益胃汤为合法，俟胃阴复而胃气健，然后用复脉法滋填收功，较为适当。

（选自《全国名医验案类编》，福建科学技术出版社2003年版，292-293页）

风温发痉案

病者：刘小孩，年甫二岁，南昌人，住城内。

病名：风温发痉。

原因：时值春令阳升，适被温风袭肺。外风引动内风，遂发痉而状如惊痫。

证候：初起热咳微喘，涕泪交流，显系风疹现象。前医妄投辛温风药，以致风助火势，陡变哭无涕泪，皮里隐隐见点，手足抽搐，目睛直视，角弓反张。

诊断：面赤兼青，指纹沉紫。此由疹毒内郁，热盛生风，仲景所谓状如惊痫、时时瘈瘲是也。故世俗通称急惊，其实似惊而非真惊耳，然亦险矣。

疗法：急急救济，议以重剂清解法，重用银花、连翘以清热解毒为君，以芥穗、薄荷、浮萍、桔梗透疹宣表为臣，佐以桑、菊、钩藤熄风镇痉，贝母、竺黄利窍豁痰，使以甘草，和诸药解疹毒也。

处方：净银花三钱，青连翘二钱，苦桔梗七分，川贝母一钱，荆芥穗一钱，紫背浮萍钱半，苏薄荷七分，冬桑叶一钱，双钩藤钱半，滁菊花钱半，天竺黄半钱，生甘草五分。

次诊：前方连进二剂，痉瘈已平，遍身已现红点。险象既除，谅无意外之虞。前方减去芥穗、钩藤，加杭白芍钱半、广陈皮八分，接进二剂。外用西河柳芽、鲜芫荽共煎水，洗前后心手足心，日洗二次。

三诊：遍体疹点满布，烧热渐退。惟咳嗽口干，大便未通，此系热邪伤阴所致。再当养阴清肺，以为善后调理。

三方：玄参心二钱，杭麦冬二钱（去心）、鲜石斛二钱、川贝母钱半，白芍钱半，广陈皮五分，北沙参二钱，生甘草三分。

效果：连进三剂，各症痊愈。

廉按：风温发痉，多由于外风引动内风，风动发痉，状如惊痫，病势之常也。奈专科一见此症，每称急惊，辄用挑法，因此僨

事者，目见甚多。此案认为疹毒内郁，热盛生风，诊断颇有见地，用药层次井然，后学深可为法。

（选自《全国名医验案类编》，福建科学技术出版社 2003 年版，22 ~ 23 页）

陈良夫

论温热病

温邪上受，首先犯肺，次传于胃，故温热之为病，要不离乎肺胃二经。盖肺主皮毛，胃主肌肉，邪从外受者由肺及胃，邪从内发者必自胃而传肺。吴又可云：温邪有九传，有表里分传者，有先表后里，先里后表，传化无定。故昔人云，温邪初起，须究表里三焦。温邪为病，须防内陷，治之之法，不离乎汗下清三法。大旨不外宣通表里，疏达三焦，以引邪外出。温邪以外达为轻，下行为顺；津液未伤，热邪不致内结，轻清宣达，尚易为力。如阳明胃经素有伏热，兼之外束风邪，遂致表里同病，当以宣通表里。温邪内逗，熏蒸失达，则宜宣化清泄，以分达其邪，表里三焦一齐尽解。如屡经汗下清而热象不减即属里邪之征。温邪不从外达，势必内结，而多变态。故王氏孟英有阳明之邪当假大肠为出路之说。温热之邪，最易内陷而劫津，迫至津伤邪陷，或为风阳翔动，或成内闭之征，也是自然之理。

（选自《现代著名老中医名著重刊丛书·陈良夫医案集》，人民卫生出版社2006年版，45页）

治风温医案

张男

初诊：温热之为病也，要不离乎肺胃两经。盖肺主皮毛，胃主肌肉，邪从外受者，必由肺以及胃；邪从内发者，必自胃而传肺。据述形寒身热，循环而作，头或疼而胸或闷，咳痰欠豁，甚则带红，咽痛神烦，易见鼻衄，便下未能通畅，脉来弦细滑，右手滑数，苔糙薄黄。此阳明胃经素有伏热，兼之外束风邪，肺气失肃，

遂致表里同病，发为温病。温邪以外达为轻，下行为顺。若郁而失达，必有耗气劫津之变。今舌色红而稍有芒刺，气液已有劫损，苔糙色黄，伏热依然内盛。顾正势必滞邪，祛邪恐其损正，不得不予为留意也。昔吴又可治温病，以汗下清为大法，叶氏专重保津。孟英有阳明之邪，当假大肠为去路之说。拙拟参用诸法，投以宣肺清胃、保津泄热，分达其蕴结之邪，急救其已伤之液，务使正胜邪却，庶无液涸风动神蒙之虑。

淡豆豉，黑山栀，杏仁，杭菊花，象贝母，桑叶皮，连翘，银花，牛蒡子，天花粉，蒹皮，鲜石斛。

二诊：前从风温痰热劫损津液议治，身热依然间作，咳痰欠豁，便下如酱，人夜略能安寐，神疲肢软，脉来弦细滑数，苔糙黄根厚，舌色仍红，刺仍未退，良由肺经留痰与胃经伏热，郁遏熏蒸。痰得热而愈黏，热得痰而愈炽，已损之津液，势必尚须时日也。况津伤热逗，证情易多反复，必得加意静摄，庶几稳妥。目前证象，务期表热渐和，咳痰频吐，津液复而苔渐化，斯可日臻佳境。仍拟宣肺化痰，清胃泄热，参入保津之品，祛其邪以顾其正，能得徐生效力为佳。

豆豉，山栀，杭菊，桑叶皮，大连翘，金银花，象贝母，枳壳，杏仁，天花粉，瓜蒌皮，鲜石斛。

三诊：身热渐和而咳痰亦豁，纳呆神惫，便通又涩，腹常鸣响，脉来弦滑，苔色糙黄，肺经痰热未能遽楚，治宜清宣化降，徐图效力。

桑叶皮，山栀，光杏仁，冬瓜子，全瓜蒌，川象贝，天花粉，炒枳壳，黛蛤散，鲜石斛，香谷芽。

按：叶天士谓：“温邪上受，首先犯肺，逆传心包。”不仅明确了风温初起的病变所在，而且指出了温病的演变规律。本例肺胃同病，表里之症迭见，风热之邪束肺，清肃失职势所必然；胃之伏热内炽，津液劫损在所难免。若泥于先解表后清里，则表邪未尽而里热益炽，若徒投苦寒必冰伏其邪。陈氏集栀豉、桑菊、银翘之长，轻透其邪，而不伤津；泄热解毒而不滞其邪，其中石斛、花粉贯串始终，乃寓津损热逗，当保其津之意。

孙妻

初诊：身热不退，头痛肢酸，神志时清时昧，脘痞太息，鼻塞唇燥，脉弦细数，苔糙黄浮灰，舌尖色绛，此属温邪入营之候，不得宣达，有津伤风动之虑，势欠稳妥，姑拟宣达清泄为治。

犀角，连翘，川贝母，广郁金，鲜菖蒲，豆豉，瓜蒌皮，鲜石斛，山栀，杏仁，清心丸。

二诊：温邪不从外达，势必内结。昨进清泄之剂，神志依然时清时昧，鼻塞气粗，耳听欠聪，便下失达，脉细滑数，左手兼弦，苔黄浮灰，舌绛起刺。温邪内结，津液耗损而神明被蒙；证势仍欠稳妥，拟清心达邪之法，应手则吉。

犀角，淡豆豉，山栀，大连翘，玄参，广郁金，菖蒲，川贝，石决明，石斛，玄明粉，至宝丹。

三诊：阳明之邪，本当假大肠为去路，昔人是以有釜底抽薪之法。进清心达邪方，神志稍慧，腑气通畅，脘闷口渴，苔灰舌刺，脉细滑数。燥矢虽去，伏热尚盛，津液受劫而神明被扰，险途依然未出，再以清心化热，参保津为治。

犀角，郁金，知母，石膏，山栀，玄参，连翘心，生地，川贝，石决明，鲜石斛，天花粉。

四诊：温病以津液为至宝，留得一分津液，方有一分生理。连进清心泄热方，热象徐退，神识渐清，仍或泛恶，脉细滑数，苔黄起刺，舌本色绛，温邪未能尽退，津液受劫，再从清泄，参保津为治。

犀角，竹茹，玄参，鲜石斛，生石决，知母，瓜蒌，桑皮，广郁金，天花粉，地骨皮，灯心。

五诊：温邪须顾津液，百病胃气为本。前进保津泄热之法，苔已退而舌色转红，刺尚未平，精神疲乏，脉来濡细带数，肺胃津液未克递复，后天生生之机尚未勃发。当易甘平养阴之法，徐图效力。

洋参，生石决，广郁金，鲜石斛，制女贞，玄参，泽泻，茯神，花粉，灯心，谷芽。

六诊：肝为风木之脏，高巅之上，惟风可到。昨因哭泣，旋即

头痛，体复灼热，神烦妄语，脉弦细数，舌红苔花。津液未复，余邪未清，复得肝郁化火，风阳旋扰，当从清热保津，参入熄风为治。

羚羊，石决明，知母，鲜石斛，连翘心，白蒺藜，天花粉，钩藤，广郁金，茯神，滁菊，竹叶卷心。

七诊：火郁则生风，理固然也。前进保津泄热熄风之剂，头痛虽未止而幸能间断，口干善饮，精神疲乏，不时烘热，便秘不通，脉细滑数，舌红苔微。证由津液未复，胃热肝阳互相冲扰，当仍以前法为治。

羚羊角，肥知母，鲜石斛，玄参，瓜蒌皮，滁菊，石决明，枳壳，麻仁，广郁金，天花粉，鲜生地。

八诊：伏热久逗，津液与水饮皆能炼而为痰，胸膈为清气流行之部，亦属积痰受盛之区。叠进保津泄热之剂，便下溏而色如酱，伏热之邪，当从下达，无如身热不净，至夜尤灼，神情烦躁，胸膈如窒，口干舌红，脉细滑数。肺胃之阴津未克速复，心肝之阳遂亢而无制，阴虚不复则余热难泄，再拟清热保津，标本两顾治之。

羚羊角，西洋参，鲜石斛，鲜生地，地骨皮，肥知母，天花粉，炒蒌皮，川贝母，石决明，制丹参，炒枳壳。

九诊：津与液皆属阴，是阴中之阳也，所以充身泽毛，润养经脉者也。前方连服数剂，今诸疴徐退，惟肌肤觉燥，口干欲饮，头痛隐隐，大便少解，脉细数，苔干黄。时邪之后，津液大伤，余热已净，法宜培养后天，仿吴氏增液汤加味为治。

京金斛，鲜生地，京玄参，麦冬，炙鳖甲，肥知母，制女贞，桑皮，麻仁，阿胶珠，谷芽，滁菊。

按：本案初诊见舌绛，神志时清时昧，陈氏断为温邪入营，用梔豉汤和清营汤加减，并用牛黄清心丸宣达清泄；菖蒲、郁金、川贝涤浊利窍，无如病重药轻，力有不逮。二诊时改用至宝丹加强清热辟秽开窍的作用，并加入玄明粉咸寒通下，釜底抽薪，始得见效。但由于津液受劫，则热不易彻，故迨后数诊均以清热保津为治。后复因情志刺激，余热复织，肝郁化火生风，故六、七诊急用羚羊、石决、蒺藜、钩藤、滁菊等平肝潜阳熄风。最后二诊重用养

阴生津之洋参、石斛、鳖甲、阿胶、麦冬、玄参、花粉等育阴清热以善其后。纵观全案，温邪深入心营，夹痰动风，病情颇为复杂，但陈氏辨证精细，治法进退有序，用药丝丝入扣，故病得痊愈。

（选自《现代著名老中医名著重刊丛书·陈良夫医案集》，人民卫生出版社2006年版，53~57页）

治春温医案

李男

初诊：《素问·阴阳应象大论》谓：“冬伤于寒，春必病温。”此明言寒邪内伏，至春发为温病也。阳明为诸经之海，亦为蕴热之乡，故伏邪为病，大都由阳明而来。始起恶寒发热，继则壮热不已，汗时稍见红疹，口渴，溲赤，大便少行，脉细数，苔糙，舌本色绛，良由伏气内发，里热未清，可谓有诸内形诸外也。拟清化宣泄，必得伏热外达，不致传为昏厥为妙。

淡豆豉，山栀，连翘，知母，石决明，通草，赤芍，白薇，枳壳，滑石，甘中黄，鲜石斛。

四诊：风寒暑湿燥火是谓六气，其伤人也，惟寒邪最易深大，迫至化热内燔，则蒂固根深，叠从伏邪内发议治，诸恙渐舒。惟日哺仍有体灼，脐下偏右胀痛，大便四日未行，腑气不通则伏热不能下达，脉仍带数，舌红苔糙，宗孟英温热之邪当假大肠为出路之说，拟泄腑通滞为治。

生大黄，玄明粉，炒枳壳，山栀，知母，天花粉，连翘，滑石，赤芍，白薇，玄参，石斛。

按：春温的特点是发病突然，病情严重，病程较长，变化较多，初起即见里热证候。本案从其发病的症状及其发病机理来分析，当属春温症。方以栀豉汤配连翘、知母、甘中黄、紫草、赤芍、白薇等苦寒清热凉营之品，清透气营之邪热。二、三诊证情方药未见记录，四诊时诸恙渐舒，惟日哺身热，便秘腹胀，阳明腑气不通，即转用承气汤通腑泄热，方中石斛、花粉、玄参为舌红津伤所设，有增水行舟之妙。本例虽处方不全，但亦能反映陈氏对伏气

温病的认识和治法。

宋男

叶香岩云：疹子为邪热外露之象，见后宜热退神清，方为外解里和，若斑疹出而热势不解，或其色不晶莹者皆是邪虽出而气液虚也。孟英谓温邪须顾津液，留得一分津液便有一分生理。鞠通云温病之不大便者不外乎津干、热结两端。此皆先贤之明训，而为后人所取法也。初起即壮热口渴，旋见疹点，神烦，舌刺，更衣不行，手指搐搦。本属春温伏邪，充斥气营，津受劫而神被扰，风阳从而暗动，已非浅候。急进气营两清之法，便下稍通，内伏之邪虽得清泄，然身热入夜尤灼，疹点日多，延又旬余，便复秘结，神志时有恍惚，耳欠聪而时鸣，口干纳少，舌本光绛，根苔干糙，顷诊脉来弦数，不甚有力。合参苔脉症因，拙见是春温伏邪尚未尽去，而气液已大受劫损，阳明失于清润，腑气因之秘结，心肝之阳，复化风而上扰清窍。目前证象，有正不能支之虑，勉拟救正为主，化邪为佐，仿吴氏增液汤加味，从标本两顾，以免流弊，未识诸同道以为然否？

细生地，麦冬心（辰拌），辰茯神，大连翘，肥知母，火麻仁，粉丹皮，玄参心，西洋参，生石决明，天花粉，玄明粉。

另用猪胆汁灌入肛门，以润肠通便。西洋参、枫斗石斛煎汤代茶，随时饮之。

按：在温热病中，津液的耗损若何与疾病的逆顺、转归休戚相关，安有津液充足而邪不去焉？此案初起即壮热口渴，伏气温病可知，身热入夜尤灼，舌绛则邪入心营显然，舌刺、更衣不行，阳明失其清润，腑气不通昭昭。陈氏不惑于此，不拘于驱邪为急，而是以大剂生脉、增液加味，力救两亏之气阴。辅以连翘、知母、丹皮清热凉营，石决明平肝熄风，麻仁、玄明粉通腑泄热。即此可见陈氏重视权衡邪正之盛衰，当津液消亡，正不胜邪之际，纵然邪势鸱张，亦不惜倾全力以救已耗之阴。

王男

初诊：肺主皮毛，胃主肌肉，六气着人，首先犯肺，次传于胃。感而即发，则为头疼身热，是表分病也。若肺不即病，传袭于

胃，郁久而发，便成伏气也。据述自觉感风，旋即不寒身热，头痛异常，曾经汗解，顷转壮热，此属新感表邪，引动伏气。神烦寐少，甚则气粗若逆，左手震动，盖表邪既解，里分伏热，乘机勃发，自里蒸表，正如抽蕉剥茧，层出不穷。气液受其劫损，风阳因而翔动，深虑热愈炽，正愈伤，而有内陷动风之变。且热盛生痰，冲扰肺金，而肺气又失肃降，故热时又增咳呛，复有气粗之状。诊得脉来滑数带弦，苔色薄糙而花，舌尖光绛。目前证象，治之之法，计维轻清宣达，佐以保养气液，顾其正，化其邪，庶无热盛生风之虑，然必得热势递缓为顺。

豆豉，连翘，天花粉，光杏仁，陈胆星，石决明，铁石斛，枯芩，山栀，桑叶，川贝，钩藤。

二诊：邪正二字，本相对峙，邪盛则正伤，邪却则正胜。所谓正者，气阴是也。气也者，所以完我之神者也，阴也者，所以造我之形者也。温热之邪，最易耗气伤阴，然更有气中之阴，阴中之气，尧封谓津与液皆属阴，实气中之阴也。初起不寒身热，顷转壮热，曾从汗解，屡发不已，迄今旬日，神倦嗜卧，寤时多而寐时少，气怯而粗，口干唇燥，喉间似有痰声，形瘦神乏，便下失达，苔花糙，舌尖色绛，脉象六部滑数，左手稍大。合参苔脉症因，气阴已形告乏，邪热依然留恋，肺气既失其展布，胃阴复失于涵濡，殊有正不胜邪之势。考《内经》论逐邪之法，一则曰衰其大半而止，再则曰无使过之，过则伤其正焉。孟英谓留得一分津液，便有一分生理。此证正虚邪逗，补正恐其碍邪。祛邪又虑损正。今与少伯翁两先生会商，议得先从救阴补液为急，并以釜底抽薪，冀其气阴来复。热从下达，斯精神日见振刷，余剩之邪，不击而自退，庶无风动神迷之变。未识有当否，录方候正。

吉林参须，生地，通草，生石决，连翘，枫斗石斛，天花粉，甘中黄，麦冬，钩藤，玄参，玄明粉。

另西洋参煎汤代茶。

按：本案春温初诊为里热炽盛，肺有留痰，津液劫损，肝风翔动，故用桑叶、豆豉、山栀、连翘、枯芩清热透表；杏仁、川贝、胆星清肺经痰热；石斛、花粉清热生津；石决、钩藤清热平肝熄

风。二诊虽然邪热未退，然而神疲乏力，舌绛、嗜卧，种种见象，尚存之气液日见消磨，正不胜邪堪虑，故用吉林参须补其已虚之元气，又以增液汤加西洋参增强救阴之力。治法已从清热救阴转为扶正为主，可见陈氏用药，不守成规，能抓住病机变化，自持进退。

（选自《现代著名老中医名著重刊丛书·陈良夫医案集》，人民卫生出版社2006年版，57~60页）

陈莲舫

治风温医案

杨，左，身热不解，头痛口渴，温邪郁蒸，势将发疹。治以分泄。

冬桑叶，杭菊花，粉前胡，淡竹叶，淡豆豉，荆芥穗，光杏仁，柔白薇，薄荷尖，净蝉衣，川通草，新会皮，荷叶，红蔗皮（六钱）。

王，左，身热咳喘，便溏脘闷，湿温互感。再从分泄。

冬桑叶，鲜佛手，粉前胡，淡豆豉，干佩兰，薄荷叶，方通草，焦建曲，嫩白薇，焦米仁，净蝉衣，新会白，荷叶包益元散。

吴，左，廿四，旧伤新感，寒热咳呛，胁旁引痛，脉见浮弦。治以和降。

冬桑叶，粉前胡，冬瓜子，方通草，淡豆豉，全福花，白茯苓，川贝母，光杏仁，新绛屑（四分），新会络，鹿衔草，丝瓜络。

叶，左，身热少许，脘痛便秘，表解而里未通，仍防神志昏迷，脉浮。拟以清泄。

冬桑叶，焦山栀，炒瓜蒌，粉前胡，淡豆豉，淡竹叶，炒枳壳，柔白薇，薄荷尖，荆芥穗，光杏仁，方通草，荷叶。

张，左，风温之邪，首先犯肺，郁热蒸痰，煽烁不解，咳嗽喉鸣，气逆胁痛，关系者在舌苔罩灰质红起腐，势将劫津为变，脉两手弦数。拟以清解。

南北沙参（各一钱五分），瓜蒌仁，全福花，白茯苓，鲜石斛，光杏仁，代赭石，新会络，蜜桑叶，川贝母，粉蛤壳，方通草，莱菔汁（四钱），荸荠汁（三钱），枇杷叶，竹茹。

孔，左，脉两手数大，舌尖绛且有芒刺，肌灼少汗，脘腹痛，

痛而拒按，便闭口渴，谵语手痉。此乃邪入营分，食滞中焦，颇为棘手，难许无虞。

乌犀角（磨冲，四分），鲜石斛（三钱），大豆卷（三钱），元明粉（三钱），羚羊角（八钱），连翘心（一钱），杭菊花（一钱五分），炒蒺藜皮（三钱），鲜生地（三钱），黑山栀（一钱五分），光杏仁（三钱），制锦纹（三钱），芦根（一两），辰灯心（十寸）。

（选自《民国江南医家著作选粹·陈莲舫医案集》，福建科学技术出版社2008年版，32~34页）

治春温医案

俞，左，春温夹湿，身热微寒，有汗不解，脉见浮滑，舌色带灰。治以分泄。

淡豆豉，薄荷尖，荆芥穗，光杏仁，黑山栀，嫩白薇，焦米仁，炒枳壳，冬桑叶，方通草，白茯苓，炒蒺藜皮，荷叶，新会皮。

钱，孩，四，春温身热，热而无汗，咳呛痰多，入夜略有谵语。防内陷神昏，治以分泄。

淡豆豉，炒麦芽，粉前胡，杭菊花，冬桑叶，方通草，双钩藤，白僵蚕（三钱），薄荷尖，荆芥穗，光杏仁，新会皮，荷叶。

费，右，春温夹湿，寒热往来，呕逆脘闷。治以疏和。

冬桑叶，白蔻仁（四分），佛手柑，嫩白薇，焦米仁，焦建曲，新会皮，法半夏，川郁金，制小朴，方通草，荷叶，白茯苓。

刘，左，春温之邪扰于阳明营分，牙衄口臭，脉息滑大。拟以清降，兼顾痘毒未清。

冬桑叶，生甘草，墨旱莲，新会皮，白茅花，板蓝根，绿豆衣，鲜生地，银花炭，炒荆芥，连翘壳，炒丹皮，炒藕节。

戴，左，身热渐除，咳呛胁痛，舌色黄腻。湿邪夹痰，阻于肺络。治以清泄。

全福花，川贝母，方通草，杭菊花，冬桑叶，粉前胡，白茯苓，净蝉衣，光杏仁，新会络，薄荷尖，荆芥穗，枇杷叶，丝

瓜络。

复：身热渐除，仍咳呛脘闷，脉息细弦。再以分泄。

冬桑叶，方通草，净蝉衣，焦米仁，光杏仁，粉前胡，白茯苓，杭菊花，嫩白薇，新会络，薄荷尖，川郁金，荷叶，丝瓜络。

（选自《民国江南医家著作选粹·陈莲舫医案集》，福建科学技术出版社2008年版，30~31页。）

范文甫

论治外感热病

先生擅用仲景诸方，挽救垂危，对后世各家学说，也勤求博采，撷取精华。他诊治外感热病，远绍仲景，近法诸贤，法活效著，使人耳目一新。

明辨伤寒温病，治法相应变通

先生治热病，首先明辨抑或伤寒，抑或温病。对伤寒则遵仲景六经论治。如治伤寒太阳病习用桂枝汤、麻黄汤、桂枝汤加厚朴杏子汤、小青龙汤、瓜蒌桂枝汤和越婢加半夏汤等；太阳阳明合病用葛根汤；热入血室及蓄血证用桃核承气汤；阳明病用白虎汤、三承气汤，谓“阳明实热之证，药不嫌凉”；余热未净用竹叶石膏汤，兼气虚者用人参白虎汤；少阳病寒热干呕用小柴胡汤，实证用大柴胡汤；太阴病脾胃虚寒用小建中汤；少阴病用四逆汤、真武汤，若灼液化燥者用炙甘草汤；厥阴病用乌梅丸等。而对于见症复杂、仲景方未备者，也参用时方，如阳明病用承气汤后阴液亏损者，即用增液汤养阴滋液；太阴病投建中汤后，随用六君子加附子补脾。对温病则根据季节时令、运气和症状的不同，分风温、春温、暑温、湿温、伏暑、秋燥、冬温及温疫等，其用药多采撷金元四大家和明清各家诸方。如风温病除热邪逼肺用麻杏石甘汤外，对痰涌热盛者，以吴氏宣白承气汤治之；肺热衄衄者用千金苇茎汤或清燥救肺汤；春温见有神昏者用紫雪丹；温邪化热入里用王清任解毒活血汤从血分透达，兼扶元养阴；伤阴重者三甲复脉汤或生脉散；有动风之变则用大小定风珠；湿温惯用河间清震汤；对夏秋间寒热，肢酸，舌苔腻之伏湿类症证，用藿朴四逆散（四逆散加藿香、厚朴）；秋燥用喻嘉言清燥救肺汤；对冬不藏精而病温者，拟黄芪、

人参、白术、当归、柴胡、附子以补益为主。综上，可见先生对外感热病中伤寒与温病的诊治，既师古又达变，且与那些寒温不辨，药石乱投者，大相径庭。

表达里下，法药相宜

病邪在表，宜以汗解之，这是常法。先生对伤寒太阳病或温病初起，皆遵“其在皮者，汗而发之”，每得心应手。有用麻黄汤峻汗，有用桂枝汤啖热粥温复取汗，有用桂枝麻黄各半汤小发其汗，风温初起，头痛发热，咳嗽气喘者，治用麻杏石甘汤。同时指出，当今之医，常囿于汗多伤津耗气之说，畏惧汗法，即使用之，亦是胆小谨慎，或用量过轻，犹如杯水车薪，无济于事；或遇表邪发热，用苦寒清热泻火之剂，忽视汗法，以致应汗不汗，坐失良机，甚则引邪入里，贻误病情。运用汗法，不只限于表卫之证，认为太阳阳明合病，或太阳病转入阳明气分，亦可清气与发汗同用，使邪热内清而外达。如治陈姓女孩案：伤寒，内热壅盛，不能外达，谵语耳聋，神识昏迷，脉细，肢冷，投桂枝白虎汤而热退神清。

但先生亦竭力反对滥用汗法，防止不当汗而汗，造成津液耗伤，病情加剧。如治吕孩案中“风温衄衄，误用麻、桂诸药，肺燥已极，命将难全。”并指出“正气充盈方可发汗”强调汗法的适度。因为阴血不足，已无汗资，故不宜浪投，否则祸必旋踵。

下法是先生治疗外感热病的一种常用方法，认为“温病早投攻下，不为大害”。其用药贴切，手法娴熟，每“一下”即能挽救危症。同时，根据病情轻重缓急，或急攻，或缓下，或补下并用等。若热结阳明，用清气通腑；阴亏便秘，用养阴通便；热灼营血，热结旁流，用凉血通泄；邪入心包，燥实便秘，用泻下开窍。如治陈某：温热日久内陷，身热神昏，呓语烦躁，涩脉见于关下，细按之沉数，唇焦，齿缝出血，舌黑而焦，有横裂纹，起芒刺，鼻血量多，热结旁流，下利清水，又有宿粪，治宜急下存津，大承气汤合增液汤。四诊后，热退，谵语除，病趋痊愈。

此外，先生认为孕妇、产后、经期及年老体弱、病后津伤、已吐下者，病虽当下，亦需慎用，谓“得下即止，另用别方，防其

虚损难复也”，强调下法应有分寸，以得畅便、泄邪热为度，务使邪去正安为要。

温病救阴温温重温

《内经》曰：“阴精所奉，其人寿。”阴液是人体赖以生存之重要物质基础。吴鞠通谓“温为阳邪……最善发泄，阳盛必伤阴”。而津液之存亡，直接决定病情的转归和预后。所以，养阴护津法不仅能扶正祛邪，而且是调整机体阴阳平衡的重要方法。先生在治疗外感热病的过程中，对保护津液极为重视，认为“津液者，生命之根本也”。凡外感风寒初起，表实无汗，当用麻黄汤辛温发汗，只求微微汗出，避免大汗；外感风热初起，用辛凉透邪，万不可辛温发泄，以免过汗伤津，热邪化燥生火，致后患无穷。中焦气分热盛，忌苦寒直折，滋阴凉遏，而每用白虎汤清气保津；邪盛伤阴用白虎加入参汤清热救津。对于热邪结于中焦，出现阳明腑实，甚则下焦真阴欲竭，邪入营血，热伤血络，神昏谵语者，更需急下存津，“舍此别无他法”。如治沈妇：风温，咳嗽痰血，热结旁流，身热入夜尤甚，耳聋谵语，舌干绛，其中血迹斑斑。脉细而数，症势危殆。不得已下之，泄其热，存其津，用鲜生地30克，大生地30克，元明粉9克，生大黄9克，元参24克，麦冬24克。三诊神清，血止，再稍稍下之，泻其余热。

对温病后期，由于邪热久羁，劫灼真阴，克伐肾水，乙癸乏源，津液亏耗，而导致的五心烦热，低热不退，耳聋神疲，齿黑唇焦，舌绛而干，脉细而数等症，常用生地黄、元参、麦冬、枸杞子、阿胶、龟甲等咸寒甘润并用，以育阴救逆；若见内风暗动，手足痿痹，阴液有欲竭之势，则用大定风珠；温病症后调理，亦须顾护津液，阴复则余邪自退。

湿温是夏秋间常见的时令病。湿为粘腻之邪、氤氲之气，与热相合，病热缠绵。先生常谓“长夏、初秋之际，乃湿土司令，每多阴雨连绵，秽浊蒸熏，人感之者而为病。”又谓：“多为内不能化水气之湿，外复感时令之湿”，湿郁上焦，清阳被蒙，湿热内蕴，致病湿温。治疗以化湿为主，俾湿去而热孤。若初起头痛恶

寒，身重疼痛，苔白，脉濡，胸闷不饥者，为湿邪外困，肺失清肃，不能通调水道，治当轻开上焦，芳香宣透，或藿香、川朴、省头草宣表卫以开肺；或四苓、蔻仁利太阴之气机，所谓“通阳不在温而在利小便”，湿去则阳自伸。若伏湿类疟，寒热往来，湿邪滞着不化，则用藿朴四逆散疏滞化湿。若中阳不振，湿热内陷，以藿朴五苓散分消湿浊，化上中之秽浊而开郁，俾邪还出下焦而解。如治周如伦案，湿热内陷，湿蕴于上，热盛于内，脉无伦次，神识不清，小腹胀满，势极危殆。用藿朴五苓散，四诊后神清湿化，大有转机。

对于湿重于热，舌苔白腻，头重如裹，胸闷纳呆者，每喜用河间清震汤。谓“茅术健脾燥湿，升麻升阳辟邪，荷叶清香，解郁消暑”。如治孙彦魁案：胸闷头重，舌淡红，苔白腻，面上一团湿邪滞气，脉象濡弱，此湿陷也。用升麻9克，鲜荷叶一大张，生茅术30克。药后症状大瘥。

无论湿热轻重，蒸蕴日久，每致化燥化火，耗伤津液，外窜内陷，变证迭出，或为腑实，或传营分。认为此时不能拘泥于湿温忌清凉滋阴之说，以清营泄热、滋液息风为大法，终以养阴益气而收功。又在湿温病治疗中，中阳素虚或治之不当，可致邪内陷而阳微，正如叶天士所说“湿热一去，阳亦衰微也”，当用附子理中汤、参附回阳汤之类。如治邵某，湿邪久困太阴，陷入少阴，神不守舍，用参附回阳、龙牡潜阳，转危为安。

洞察寒热真假，救脱杜渐防微

先生治热病，还注意明辨寒热真假，告诫后学，辨病察证，要遵循《内经》、《难经》经旨，“谨守病机，各司其属”、透过现象识本质，不要被假象迷惑。若辨证不清，治无法度，则失之毫厘，差之千里。在疾病过程中，特别是在病情危重阶段，往往出现真热假寒、真寒假热之证。前者由于内热过盛，阳气闭郁于内而不能布达于四末，即“阳盛格阴”，证见身寒不欲衣被，手足冰冷，但胸腹灼热，烦渴喜冷饮，口臭，尿赤，舌红绛，脉虽沉但重按弦滑有力。如治陈案：伤寒，内热蕴盛，不能外达，语语耳聋，神识昏

迷，脉细肢冷，舌红唇干，用白虎汤辛寒清里热，加桂枝辛温达外寒，一剂表解里和，二剂大效。后者由于温病后期，阴损及阳，或禀体素虚，出现外热征象，即“阴盛格阳”，见身热面赤，口渴脉大，身热反欲衣被，口渴多喜热饮，脉大无力，舌淡不红。如治一证：大热大渴，奄奄一息，脉沉而闭，惟舌不红，查前方皆是牛黄、安宫、白虎之类，先生则断为真寒假热，用“附子蜀漆散三服而愈”。可见，先生洞察秋毫，明辨寒热真假，方药如矢中的，使人叹服。

温热病虽以热盛伤阴者居多，但亦有因正气素虚，邪气太盛，或汗下太过，阴液骤损，阴病及阳，甚至亡阳、气脱者。吴鞠通提出了“内闭外脱”之病机，并列为死证之一。先生认为本证“二气不相接续，衰脱之证最速”，故治疗应及时采取回阳救逆、益气固脱。若中暑、暑温、伏暑之气营期，阳明病热盛正虚，邪热蒸迫，津气两伤者，每用人参白虎汤治之。如治林翁案：太阳传入阳明，壮热口渴，脉不归部，用人参白虎汤后，热即化出，脉转洪数，症遂好转。若面色晄白，大汗口渴，短气肢厥，脉气将散者，可用生脉散益气固脱。如治陈某案，用生脉散合附子理中汤而获愈。

温热病中期，先有高热、神昏，继则大汗亡阳，肢厥唇青，脉微欲绝者，此真阴涸竭，阳气暴脱，应急用参附龙牡汤。如治邵友方：湿温月余，神识昏糊，耳聋肢冷，脉细欲绝，舌淡不干，完谷不化，其脾肾阳气虚损可见，不宜再三克伐。急以人参9克，淡附子9克，龙骨9克，牡蛎30克，归身9克，柴胡9克，黄芪12克，白芍9克，枳壳3克，药后汗止神清。若暑温日久，阳气耗伤，以致阴盛格阳，阳气暴亡者，急用附子蜀漆散回阳救逆。如治奉化某案：秋后伏暑晚发，脉沉而闭，舌淡不红，有真阳欲绝之变。用附子9克，炒蜀漆9克，茯苓9克，龙骨9克，生姜3克。连服3剂，霍然而愈。

（选自《现代著名老中医名著重刊丛书·范文甫专辑》人民卫生出版社2006年版，22~27页）

治风温医案

王右，温邪有升无降，经府气机交逆，营卫失其常度，为热邪所迫，津液日耗，则渴饮不饥。温邪本先犯肺，今兼头痛，舌红而苔白，宜辛凉宣泄。

麻黄6克，杏仁9克，甘草3克，生石膏30克。

二诊：身热得汗而解，咳嗽阵作，尚需清宣。

麻黄3克，杏仁9克，甘草3克，生石膏12克，象贝9克。

按：陈平伯云：“风温为病，春月与冬季居多，或恶风或不恶风，心身热，咳嗽，烦渴，此风温证之提纲也。”指出本病好发季节与初起时的临床特点。外感风热病邪，多从口鼻而入，首先侵犯于肺，肺主气而属卫，与皮毛相合，所以初起多有肺卫见证。先生用麻杏甘石汤辛凉宣解，祛邪外出药后，身热得汗而解，颇具效应。

王孩，素有痰湿，复感外邪，障塞气机，肺不清肃，胃不宣通，咳嗽阵作。风温胸膈，证殊不轻。

麦冬12克，象贝9克，杏仁9克，冬瓜子24克，黄芩9克，小生地15克，生大黄9克，生石膏12克，枇杷叶露500克，肺露500克（见注）。

二诊：较昨日见瘥。

象贝9克，小生地9克，生甘草3克，炒麻仁9克，生石膏12克，炙鳖甲9克，杏仁9克，麦冬6克，枇杷叶9克，桑叶9克。

三诊：热势减轻不少，余邪尚存。

瓜蒌皮9克，炙鳖甲9克，麦冬12克，小生地9克，陈青蒿9克，象贝9克，麻仁9克，清甘草3克，杏仁9克，桑叶9克，枇杷叶露500克。

按：胸膈一症，即鼻翼扇张，喉间痰鸣，气促而喘，乃邪热壅肺，热极生风，因风生痰，风痰潮涌所致。温病邪热内盛，肺不肃，胃不降，气机闭塞，则有传逆之变。先生处方仿吴氏宣白承气汤法，泄热宣肺、通腑撤热、保津存液。吴氏有云：“其因肺气不

降，而里证又实者，必喘促寸实，则以杏仁、石膏宣肺气之痹，以大黄逐肠胃之结，此脏腑合治法也。”后诊见瘥。用喻氏清燥救肺汤加减，以润肺、清热、养阴而愈咳喘。

注：肺露

药物：猪肺（去血洗净）1具，孩儿参、天门冬、麦门冬、百合、川贝母、阿胶珠、丝瓜络各6克，北沙参、黛蛤散、冬瓜子、生玉竹、茯苓各9克，炙桑白皮、炙款冬花、地骨皮、丹皮、知母各4.5克、炙葶苈子、炙马兜铃各3克，芦根60克，炙枇杷叶12克。

功用：清肺化痰。

主治：吐血、衄血，干咳无痰，肺痿咳喘，虚损久咳等症。

制法：上药共置于蒸馏器中，加水蒸馏取药露约2000克。用法：一般每次30~60克，隔水炖温后饮服，早晚各1次，或冲入煎剂中服用。

吕孩，风湿胸膈，误用麻、桂诸药，肺燥已极，一命将难全。

元参24克，小生地24克，麦冬30克，炒麻仁24克，枸杞子18克，炙甘草3克，杏仁9克，炙鳖甲15克，肺露500克，枇杷叶露500克。

按：此清燥救肺之法，妙在枸杞子、生地黄、麦冬、甘草等同用。枸杞子为救脱纳气固本要品，王孟英氏称之为小复脉汤主药。肺露代水煎药，以肺养肺，同气相应也。

裘小孩，风湿胸膈，肺热化燥，虽有食，亦不顾及，此乃伏邪因新感引动耳。

水芦根30克，麦冬12克，杏仁9克，炙鳖甲9克，小青皮2.4克，炒麻仁18克，元参9克，清甘草3克，枇杷叶9克，肺露代水煎。

按：小儿肺热胸膈，喉中痰鸣，而兼有食滞，则是上焦中焦同病。处方从清燥救肺汤化出，加小青皮以消食，中上二焦并治。

陈师母，风湿内热，干于经络，面部浮肿，通体疼痛，热迫下利。

炙鳖甲9克，麻仁9克，杏仁9克，桃仁9克，生石膏24克，小生地24克，生甘草3克，鲜水芦根24克。

按：此案所用为清燥救肺汤合千金苇茎汤变化之方，具清热豁痰之效。患者遍体疼痛，鳖甲可以熄内风，配合芦根、石膏、杏仁、桃仁等豁痰止痛。这里可以看出先生的卓见，和一般仅知祛风活血药可止痛者有所不同。

沈师母，风温，咳嗽痰红，热结旁流，身热入晚尤甚，耳聋谵语，舌干绛而裂，其中血迹斑斑，脉细而数。证势危殆，不得已下之。泄其热，存其津。

鲜大生地各30克，元参24克，麦冬24克，生大黄9克，玄明粉9克。

二诊：此证譬如屋宇失火，任其焚烧，而救火车不到，可乎？服昨药已得下，瘥来有限，理当再下。但元虚太甚，姑缓一日。仍旧可危之至。

鲜大生地各30克，元参24克，麦冬24克，甘草3克，象贝9克，杏仁9克。

三诊：已瘦多，神清，血亦止。再稍稍下之泻其余热。

鲜、大生地各30克，元参24克，麦冬12克，炒枳壳4.5克，生大黄6克，杏仁9克。

按：风温之邪从口鼻而入，传变最速。邪热内结，犹如烈火燎原，其势凶猛。火邪上炎，木火刑金，肺络受伤，则咳嗽痰中带血；邪热内攻，神明被扰，则神昏谵语；热结于下，阳明腑实，则热结旁流；舌中干裂出血，亦是邪火烧灼，津液大损所致。一派炎炎火势，毋庸迂缓。证急则宜急攻之，用增液承气汤泄热存津，釜底抽薪，直折其势。方药对证，故一剂效，二剂瘥，化险为夷。

（选自《现代著名老中医名著重刊丛书·范文甫专辑》人民卫生出版社2006年版，55~58页）

治春温医案

水老先生，患春温，前医不识，始认为是感冒风寒，遂用荆、

防辛温之剂发之。一剂汗出伤津，再剂化燥生热，复炽如焚。更医治之，继而又用西药大发其汗，渐至神识昏迷，肢厥，病家不得已，出院而归。今晨大便溏，小便赤，舌质红绛，苔白薄而干，咳嗽痰稠，右脉细数，不归其部，大非佳兆，左手尚觉洪数，此温热之邪内攻也。何以知之？大便溏薄，热结旁流也；小便赤涩，热从膀胱出也；神识昏蒙，热扰心神也；舌质红绛，脉细数均是邪损营阴之明据。就脉证而论，右手不归其部，大有败象；左手还有些希望。总之，花甲老翁，得此重症，实在可虑也。素有痰疾不及顾虑，所谓先治新病，余当在后。方请章先生教正再服。

炙鳖甲 15 克，生石膏 24 克，大生地 15 克，麦冬 9 克，元参 9 克，炙甘草 3 克，枇杷叶 9 克，紫雪丹 1.5 克（开水吞服）。

二诊：舌润不少，两手脉归本体，内热已瘥，神识亦清，见效不少，但嫌好得太速，恐见反复。

炙鳖甲 15 克，生牡蛎 30 克，麦冬 12 克，生地黄 18 克，元参 9 克，真阿胶 9 克，炙甘草 3 克，麻仁 9 克，桑叶 9 克，枇杷叶 9 克。

三诊：病邪已去大半，脉仍弦数，见于尺部，是内热壅结也，宜以调胃承气汤下之。但年六十有余，津液太亏，姑缓图之。增液以固其本，加生大黄以助推荡之力，得下即止，防其虚损之难复也。

大生地 24 克，西党参 9 克，炙甘草 3 克，麦冬 9 克，淡竹叶 60 片，桑叶 9 克，枳壳 3 克，生大黄 9 克。

四诊：将愈，阴液未复，尚需调治。

大生地 24 克，元参 12 克，麦冬 12 克，西党参 9 克，甘草 13 克。

按：高年之人，阴精先亏，正气不足。复感温热之邪，医皆以风寒治，误用辛温发汗，不痒，又误经西药发汗，以致症益重。汗者心液也，心液大伤，营阴暗耗，邪热更易内陷。每热神昏，谵语便赤，手足厥冷，脉不归部，则提示邪气盛元气大伤。此屡经误逆之危候，亟宜救阴以泄热。先生拟方用鳖甲、生石膏清气泄热；紫雪丹清心开窍；生地黄、麦冬、元参清营生津；枇杷叶、甘草润肺

止咳。药后脉归本体，神识清楚，疗效卓著。热邪久留，真阴受劫，二诊仿《温病条辨》加减复脉汤法，滋阴养液。三诊时，病邪虽去大半，但津液劫伤，肠燥便秘，故于养阴润燥剂中加生大黄以增水行舟。四诊，将愈未愈，邪少虚多，则用增液汤加党参、甘草气阴两顾，终使危笃之症转危为安。

齐金生，温热犯肺，热极劫津，咳嗽气喘，烦躁脉数，病情极重。

生石膏 30 克，炙鳖甲 9 克，小生地 24 克，炒麻仁 24 克，炙甘草 3 克，杏仁 9 克，麦冬 9 克，鲜水芦根 30 克，肺露 500 克，枇杷叶露 500 克代水煎药。

二诊：生大黄 9 克，元明粉 12 克，川朴 3 克，大生地 30 克，元参 30 克，麦冬 24 克。

三诊：生石膏 30 克，知母 9 克，鲜、小生地各 24 克，麦冬 24 克，姜半夏 9 克，元参 15 克。

四诊：昨日去下药后，热气复甚。

生大黄 9 克，炒枳壳 6 克，川朴 4.5 克，元明粉 9 克，鲜、小生地各 30 克，元参 24 克，麦冬 24 克。

五诊：又瘥矣，谵语亦除。

鲜、小生地各 24 克，麦冬 24 克，元参 24 克，生大黄 9 克，清甘草 3 克，鲜芦根 30 克，炒枳壳 3 克。

六诊：白虎汤合生地黄、元参、麦冬。

按：此案首用清燥救肺法，因温热病证势危重，邪热入里，不仅中焦热炽，而且三焦热炽阴亏，出现舌焦口干，便秘，神昏谵语之证，故二诊改用增液承气法。三诊单清气分大热，肠胃积热未净，除去泻下药后，高热又起。所以四诊时复用清热养阴法，加用生大黄、元明粉通之。通观全案，可见温为阳邪，热变最速，易化燥伤阴，辛凉解表、清气透热、苦寒折热，时时保津存液，是温病治疗之大法也。

陈君，温热日久内陷，身热神昏，谵语烦躁，涩脉见于关下，细按之觉沉数。唇焦，牙齿缝中出血，舌黑而焦，有横裂纹起芒刺，鼻血出多量。热结旁流，下利清水，又有宿粪。奈何？惟有急

下以存津，以希生机。

炒枳壳6克，川朴6克，生大黄9克，元明粉9克，麦冬12克，大生地24克，元参12克。

二诊：服前方此刻得下三次，脉象已出不少，唇亦转红，颇有生机。但邪热内陷，一时不能解，仍当守法。如稍胆小，则大事去矣。

生大黄9克，枳壳9克，川朴9克，麦冬12克，鲜、大生地各12克，水芦根30克，桃仁9克。

三诊：唇舌黑焦已去，似不可再下。惟满口有血，谵语未除，宿屎未见，仍是当下之候。

生大黄9克，元明粉9克，炒枳壳9克，桃仁24克，红花9克，鲜、大生地各30克，元参30克，麦冬18克

四诊：见瘥，身热退，谵语除。

清燥救肺汤。

按：本例系温邪内陷，由气分逼入营分，气营两燔之危证。营分热甚则神昏；血络受灼则口鼻出血；热结于内则旁流下利清水而谵语；脉来沉涩，真阴欲竭也。热势燎原，险象丛生，此时惟有釜底抽薪一法。所谓“撤热以保津”，庶可免痉厥之变。首三方均以大承气汤合增液汤为主加减，斩将夺关，急下存阴。至邪退正虚之时，才用滋阴润肺法以善后。

范老志，脉弱无气，舌苔元津，面黧黑无神，上腭喉间白糜满布。其脘痛而作呕，则是老病。此症盖得之伤食不落胃，服消化之品过度，元本虚弱，又感外邪，以致开门揖盗，热邪内生。至今商治，惟有大剂存津，舍此别无它法。轻清降泻，恐未有济。鄙见如是，请高明裁酌。

小生地24克，炙鳖甲9克，麦冬12克，太子参9克，枸杞子12克，炙甘草3克，生牡蛎30克，仙半夏9克，枇杷叶9克，白蜜2匙，淡竹茹9克。

按：脉弱无气，面色黎黑无神，已是阴阳俱衰、精血虚弱的久病征候；舌苔无津，上腭喉间白糜满布，亦是热邪伤阴，正虚邪盛，正不胜邪之象。脘痛而呕，明是胃弱旧疾，医者又用攻伐消导之品，

再伤脾胃，使其元气更虚而罹疾。故先生谓之“开门揖盗”。

钟某，昨日用下药，得下利，阳明热郁，无从出路，于法亦是。今脉不振指，其元神觉不支，热入血分炽而不减，正不胜邪，将何施治？念其尚能吃药，检其身上有斑点发出，从血分治之，以希万有一生之望。

当归，赤芍，桃仁，红花，炙甘草，大生地，连翘，葛根，柴胡，炙鳖甲，麦冬，天花粉。

按：此方为王清任解毒活血汤去枳壳加鳖甲、麦冬、花粉，是从血分透达为主，兼奏扶元养阴之效。

梅亭，伏邪化热，热甚，神识不清，此乃冬不藏精所致。

方拟解毒活血汤。

生地黄 12 克，赤芍 9 克，连翘 9 克，柴胡 3 克，葛根 4.5 克，桃仁 6 克，红花 4.5 克，当归 6 克，枳壳 4.5 克，生甘草 3 克。

二诊：高热时作舌红绛而干。

生石膏 30 克，知母 6 克，米仁 12 克，甘草 3 克，大生地 30 克，牛膝 9 克。

三诊：见瘥。

竹叶 9 克，生石膏 30 克，党参 9 克，麦冬 9 克，甘草 3 克，枸杞子 12 克。

四诊：热久伤阴。

真阿胶 9 克，西党参 9 克，麦冬 9 克，甘草 3 克，枸杞子 9 克，麻仁 9 克，鳖甲 9 克，石膏 24 克，白薇 9 克，柏子仁 9 克。

五诊：舌绛苔脱，肾阴虚极，阴虚生内热。元虚至此，惟有存津清热一法。

生牡蛎 30 克，龟甲 24 克，鳖甲 24 克，麦冬 18 克，大生地 24 克，炙甘草 4.5 克，杏仁 9 克，真阿胶 9 克，党参 3 克，杞子 12 克，竹茹 9 克。

六诊：大瘥。

昨方加党参 6 克、五味子 6 克。

按：本例为伏邪为患，里热外达，所以初诊时无卫分症状，起

病即见热邪炽盛、神识不清等证。首诊用解毒活血汤清热解毒，凉血和营，透热外达。这是先生治疗伏邪温病的独特方法。温病伏邪久羁，每多深入下焦，劫烁肝肾之阴，虽常见低热稽留、舌绛唇干、虚烦不寐等证，却不能过用苦寒。所以二诊起分别以白虎汤、竹叶石膏汤、三甲复脉汤、生脉散加减，清热滋阴，益气生津，以收全功。

徐志舜，温热入于少阴，邪盛元虚，神倦不寐，手足瘈瘲，津液被灼，舌绛而干，脉数无伦次。证实险重之至，请高明调治则吉。

炒麻仁 12 克，生牡蛎 24 克，炙甘草 6 克，麦冬 12 克，大生地 18 克，西党参 9 克，炙鳖甲 9 克，龟甲 15 克，真阿胶 9 克。

二诊：见瘥。前方加西洋参 3 克泡茶服。

按：本案温热深入下焦，重伤真阴。手足瘈瘲是阴虚风动之征；脉数无伦次，为正不胜邪、阴阳离决之兆。温病至此，险重之至。先生仿吴氏“热邪久羁，吸烁真阴……神疲瘈瘲，肺气虚弱，舌绛苔少，时时欲脱者，大定风珠主之”，急用大定风珠加减，以填补欲竭之真阴，潜摄浮越之虚阳，平熄内动之肝风。二诊见症，则毋用更张，乃加西洋参增强救阴益津之力，以资巩固。

谢永泉，苦寒热，初一起日夜数发，脉沉弱，舌淡白，此乃冬不藏精所致。

生黄芪 9 克，西党参 9 克，炒冬术 9 克，当归 9 克，柴胡 9 克，淡附子 9 克。

按：《素问·金匱真言论》云：“夫精者，身之本也。故藏于精者，春不病温。”精气充沛，则邪不外侵。吴鞠通说：“不藏精三字须活看，不专主房劳说，一切人事之能摇动其精者皆是。即冬日天气应寒，而阳不潜藏，如春日之发泄，甚至桃李反花之类亦是。”今此案仿冬不藏精例处治，谅是冬暖多汗，以致元虚，春时复感外邪，正虚邪陷之候生矣。故治用培补真元之法，以扶正驱邪。加柴胡一味，利少阳半表半里之枢机，从里引邪外达。

（选自《现代著名老中医名著重刊丛书·范文甫专辑》人民卫生出版社 2006 年版，59~64 页）

治暑温医案

样耕，患暑温半月有余，前医错用大剂寒凉，非但邪不透达，反而深陷于里。身热如火，神志不清，脉数而弦洪，三部直行，热极之巨；舌苔黄腻而舌底红鲜亦是热极之征。此候死固多也，但治之得当，亦有活者。救人之心，人皆有之，惟病势过于险重，不得不交代明白。

鲜藿香9克，葛根9克，桃仁9克，红花9克，当归9克，鲜生地12克，大生地12克，赤芍9克，柴胡9克，连翘9克，生甘草3克，芒硝9克，生大黄12克。

或问曰：此证热极，不用寒凉之剂何也？譬之炭火甚炽于一盆，用冷水浇之，火非不熄，热气上乘，肺先受之，肺不堪受此熏灼，则肺先死，不可救矣。此方如铁耙一把，将火拨开，热势不聚于一处，后可缓缓透达而熄之，其意如此。

二诊：已得泻下，余详前。

加紫雪丹1.8克，生姜汁4滴，井水调下。

三诊：脉象将复其部，但数而弦，苔尚厚腻。热势稍减，烦躁亦减，比昨日轻可不少，但尚是危险。

豆豉9克，川朴9克，藿香9克，鲜、大生地各30克，山楂9克，炒枳壳9克，葛根9克，当归9克，赤芍9克，柴胡9克，桃仁24克，甘草3克，生大黄9克，芒硝9克。

四诊：瘥矣。前方去芒硝、生大黄。

按：本例是夏令感暑，内陷心营之危证。暑为火热之邪，传变迅速，本宜清透，医者反用大寒之剂，以致气机得寒益闭，暑邪陷而不透。暑性炎热，燔灼阳明，化火内传，深入心营，故见神志不清，高热烦躁，舌红苔黄，脉洪而数等证。方用解毒活血汤合调胃承气汤加减，取其清暑化湿，凉血透热，釜底抽薪，上中下同治，俾内陷之暑热下泄外达。此案辨证明细，用药切中病机，足可效法。

汤右，暑湿化热，热盛神蒙，治颇不易。

豆豉9克，黑山楂9克，知母9克，川朴6克，生石膏24克，鲜芦根30克，冬瓜子9克，紫雪丹1.2克（阴阳水调下）。

二诊：今得鼻衄，神清热减。

鲜生地30克，小生地30克，甘草3克，生石膏30克。

麻仁12克，枇杷叶9克，鳖甲12克，杏仁9克，青蒿12克。

三诊：病气去尽，元气未复。

清燥救肺汤全方。

按：暑热入营，则灼热烦躁；内陷心包，则神识昏蒙，所以古人有“暑易入心”之说。治法以清暑透邪，清心开窍。论曰：“服药已微除，其人发烦目瞑，剧者必衄，衄乃解。”药后鼻衄，是热邪随之而泄，故热减神清。暑为阳热之邪，最易耗气伤津。故于邪退正虚之时，以养阴益气之法，投剂而愈。

（选自《现代著名老中医名著重刊丛书·范文甫专辑》人民卫生出版社2006年版，64~66页）

林沛湘

论治感冒

外感风邪夹湿证

感冒一病由外感风邪而成，然广西属亚热带气候，湿气偏盛，因而风邪犯表时多夹湿邪。症见头昏重或胀痛，鼻塞流涕，恶风，咽部痛痒不适，身体酸重或疼痛，胸闷，恶心，舌苔白，脉浮或濡。若证候偏于风热，可见身热，恶寒，汗泄不畅，咳嗽，痰黏或黄，咽燥，或咽喉红肿疼痛，口渴不欲饮等，舌苔微黄，边尖红，脉浮数。外感风邪夹湿者，治宜疏风祛湿解表，方剂可用桑菊饮或羌活胜湿汤化裁。常用药物有桑叶、苏叶、菊花、桔梗、前胡、防风、荆芥、薄荷、葱白、蔓荆子、羌活、续断、救必应、鬼箭羽等。如证属风热夹湿，其发热明显者，按外感发热辨治，无明显发热者，则常合银翘散以辛凉解表。治疗感冒忌用大苦大寒之品。

气虚感冒

本证常见于中老年体虚感冒患者。一些年老体虚妇人之感冒更常见此证。本证常由于卫气不固，外感风邪后因气虚而托运无力，使邪不易解。其临床症状除见前述之外感风邪的表现外，还可见身楚倦怠，乏力，病情反复发作，欲解而未愈，舌质淡，舌苔白或薄白，脉浮无力，或仅为虚脉或脉沉细无力等。治宜益气解表。方用参苏饮或人参败毒散化裁，常用药有党参、大枣、桑叶、菊花、羌活、苏叶、前胡、薄荷、葱白、桔梗、甘草等。合并血虚者，则加当归、红枣。治疗正虚感冒，应注意扶正与祛邪的轻重缓急。

例：陈某，女，60岁，1991年4月17日初诊。

头痛，鼻塞，肢体酸痛2月余。1991年2月中旬因劳累过度而发病，病见头痛头晕，鼻塞流涕，肢体及项背酸疼，咽喉疼痛等，曾服用多种中西药物治疗，病情未见好转。现症见头痛头晕，鼻塞流涕，全身酸楚疼痛，无发热，微恶风寒。诊见面色少华，舌质淡，舌苔白，脉虚而缓。中医诊断：感冒，证属气虚及外感风邪夹湿。西医诊为上呼吸道感染。治法：益气解表，疏风祛湿。方药：参苏饮化裁。处方：党参17克，大枣15克，炙甘草6克，桑叶10克，紫苏叶8克，续断10克，救必应10克，鬼箭羽10克，蔓荆子10克，桔梗10克，前胡10克，鲜葱白20克。3剂，水煎服，每日1剂。

1991年4月20日二诊：服药后症状大减，唯咽喉疼痛，舌脉同前。药已对证，仍守前法调理。于前方去大枣、炙甘草、续断、鲜葱白，加诃子10克，改党参为10克，再服3剂后病愈。

按：其证候为气虚外感风邪夹湿。素体虚弱则易感外邪，湿邪阻遏则病情缠绵。头痛、头晕、鼻塞流涕为风邪上犯之征，身体酸痛为湿邪阻遏之象，舌淡脉虚足见其正气不足。气虚则卫表失固不任风邪，加之湿气重着难解，故非寻常感冒药物所能治愈。林老在治疗时，注意了扶助正气的基础上解表祛邪。方用党参、大枣、炙甘草以益气固表，桑叶、紫苏叶、蔓荆子等发散风邪。川断本为壮腰健肾的药物，但《本经》云其“主伤寒”。林老也体会它有很好的祛风散湿功效，最宜于感冒夹湿者使用。鬼箭羽、救必应清热解毒祛湿，是广西民间治疗疹证之常用药物。桔梗、前胡宣肺气，葱白通鼻窍。

（选自《中国百年百名中医临床家丛书·林沛湘》，中国中医药出版社2004年版，202~204页）

岳美中

用白虎汤治温热证案

汪某，男性，年54岁。患感冒发热，于1971年6月12日入某医院。在治疗中身热逐步上升，到14日达38℃以上。曾屡进西药退热剂，旋退旋起，8天后仍持续高烧达38.8℃，6月22日由中医治疗。诊察证候：口渴，汗出，咽微痛；脉象浮大，舌苔薄黄。认为温热已入阳明经，内外虽俱大热，但尚在气分，不宜投芩连苦寒之剂，因疏白虎汤加味以治。处方：生石膏60克，知母12克，粳米12克，炙甘草9克，鲜茅根30克（后下），鲜芦根30克，连翘12克。水煎，粳米汤成，温服。下午及夜间，连进2剂，热势下降到38℃；23日，又按原方续进2剂，热即下降到37.4℃；24日，原方石膏量减至45克，进1剂；25日又进1剂，体温已正常，口不渴，舌苔退，唯汗出不止，以王孟英驾轻汤加减予之。随后进补气健脾剂，兼饮食调理，月余而愈。

白虎汤是方剂中的一个著名古方，由后汉张仲景著录在《伤寒论》里，标明用途，两千年来经过多少医生准确地使用在临床上，不知治愈了多少高热症，挽救了多少危重病人，是值得我们珍视和继承的。

吴塘说：“太阴温病，脉浮洪，舌黄，渴甚，大汗，面赤，恶热者，辛凉重剂白虎汤主之。”（按：吴谓白虎汤治在手太阴肺经之热邪，非是。石膏知母究是阳明胃经药，若治肺经，则须麻黄、石膏，细读《伤寒论》自知）又说：“白虎本为达热出表，若其人脉浮弦而细者，不可与也；脉沉者，不可与也；不渴者，不可与也；汗不出者，不可与也。常须识此，勿令误也。”“此白虎之禁也。按白虎慄悍，邪重非其力不举，用之得当，原有立竿见影之妙；若用之不当，祸不旋踵。儒者多不敢用，未免坐误事机；孟浪

者不问其脉证之若何，一概用之，甚至石膏用至斤余之多，应手而效者固多，应手而毙者，亦复不少，皆未真知确见其所以然之故，故手下无准的也。”这是吴著《温病条辨》中对白虎汤立的四禁之说，是否正确可循，张锡纯《医学衷中参西录》中曾有说云：“近世用白虎汤者，恒恪守吴氏四禁……其四条之中，显有与经旨相反之两条，若必奉之为金科玉律，则此救颠扶危挽回人命之良方，几将置之无用之地。愚非好辩，而为救人之热肠所迫，实有不能已于言者。……按：前两条之不可与，原当禁用白虎汤矣。至其第三条谓不渴者不可与也，夫用白虎汤之定例，渴者加人参，其不渴者即服白虎汤原方，无事加参可知矣，吴氏以为不渴者不可与，显与经旨相背矣。且果遵吴氏之言，其人若渴则可与以白虎汤，而亦无事加参矣。不又显与渴者加人参之经旨相背乎？至其第四条谓汗不出者不可与也，夫白虎汤三见于《伤寒论》，惟阳明篇中所主之三阳合病有汗，其太阳篇所主之病及厥阴篇所主之病，皆未见有汗也。仲圣当日未见有汗即用白虎汤，而吴氏则于未见有汗者禁用白虎汤，此不又显与经旨相背乎？且石膏原具有发表之性，其汗不出者不正可借以发其汗乎？且即吴氏所定之例，必其人有汗且兼渴者始可用白虎汤，然阳明实热之证，渴而兼汗出者，十人之中不过一二人，是不几将白虎汤置之无用之地乎？夫吴氏为清季名医，而对于白虎汤竟误设禁忌若此，彼盖未知石膏之性也。”

石膏合知母，方名白虎。今人用白虎独以石膏入剂，而不合知母者，则所治不专主阳明，而失掉了命名白虎的意义。另外，石膏、知母相配伍，治阳明胃热，石膏、麻黄相配伍，治太阴肺喘，在石膏用量上是有所不同的。白虎汤方中石膏之量，从不少于500克，而麻杏石甘、越婢等汤方中石膏之量，从不超过250克。这是仲景《伤寒论》方剂配伍中至关重要的部分，不容等闲视之。

（选自《现代著名老中医名著重刊丛书·岳美中医案集》，人民卫生出版社2005年版，105～108页）

金子久

治风温案

案一，风温由皮毛而入肺，秽浊从口鼻而入胃，前用辛凉透皮毛以解风温，芳香宣阳气以逐秽浊，汗泄蒸蒸，在表之风温渐从汗衰，大便频频，在里之秽浊渐从下夺。而舌苔仍形黄腻，其中尚有浊邪，脉象依然数大，上焦犹有风热。风为阳邪，鼓荡肝阳，阳升于上，耳窍为鸣，风淫末疾，指节为酸，阳动则心烦，热炽则唇燥，胃气尚窒，纳谷未增，病邪专在气分，气郁渐从火化，大旨似宜前辙，以芳香轻扬法。

羚羊角，连翘，山梔，钩藤，鲜石斛，滁菊，丝瓜络，橘红，佩兰，瓜蒌皮，郁金，桑叶。

按：风温袭受，在外之表邪，已得汗泄而解，在内之秽浊，亦从下夺而退。惟脉仍数大，上焦风热未撤，纳谷不增，胃家气机尚窒，病之重心，专在气分。气郁则化火，火升则阳动，故治法轻清宣气，芳香苏气，气机通畅则内外流行，而诸症可去。羚羊角一味，取其有散风清热之功，当时货源较多，价亦不贵，故恒多用之。

案二，咳呛已有一句，身热亦见七日，表邪有余，终日热不离体，阴分不足，统夜热甚于肢，每日咳呛有一二十声，每夜身热无片刻之凉，胃纳较昔减去一半，隔时热中又见畏寒，左脉浮数而大，右脉滑弦而数；舌苔薄白，唇口干红，表中之风非辛凉不解，里中之热非甘凉不泄，调治法程，姑仿其旨。

连翘，玄参，桑皮，丹皮，杏仁，蛤壳，川石斛，山梔，薄荷，菊花，橘红，竹茹。

二诊：身热已有退舍，咳呛未见减去，有声有痰，肺燥脾湿，口舌唇红，湿蒸热腾，胃纳仍然减退，更衣依然通利。左部脉象搏

指而大，一由肝火有余，一由肾水不足；右部脉象弦滑而数，半由肺金多燥，半由胃土多湿。燥火上炎为咳逆，湿热中焦为嗽痰，夏令湿火用事，治法务在潜火，气火一降，咳逆日缓。

铁皮石斛，菊花，秋石，玄参，杏仁，芦根，冬桑叶，苡仁，丹皮，橘红，地骨皮。

三诊：预拟廓清肺胃标病，藉以潜育肝肾本病。

粉沙参，青蛤壳，知母，玄参，丹皮，茅根，川贝母，铁石斛，橘红，秋石，菊花，甘草。

按：叶天士曰“温邪上受，首先犯肺”，肺失清肃，咳嗽有矣。脉见浮数而大，舌苔薄白，可见表证未解，邪留肺卫。金氏治温病初期，病在卫分者，辄辛凉解表法，主张“表中之风，非辛凉不解”，而内热之盛，亦宜甘凉以泄之，此宗《素问·至真要大论》“风淫于内，治以辛凉，佐以苦，以甘缓之”之旨也。复诊身热见退，惟咳嗽未减，良由肺金多燥，脾胃多湿使然，改方以泄火清金为主。三诊廓清肺胃，兼顾其本，前后用药，粗看似觉驳杂不纯，但实为经验之方。

案三，时感风温，逗留肺胃，外达皮毛，发现斑痧，内郁气分，酝酿痰热，痰阻清肃，时或咳逆，热入肝窍，目眶痒，稚阴不足，病热晡剧，脉象浮数而滑，当用轻清宣泄。

羚羊角，连翘，黑山栀子，钩藤，川通草，橘红，瓜蒌，象贝，忍冬藤，滁菊，白杏仁，竹茹。

按：风温由皮毛而入，邪袭肺卫，肺失清肃，气郁酿痰，致有咳逆之患。邪不外解则渐入阳明，邪欲外泄则发为斑痧，稚体阴分不足，脉见浮数而滑，证脉合参，既非麻疹之热毒，亦非营分之斑块，显系时感之邪，化成斑痧之类，故其邪尚在气分，治以轻清宣泄，显在情理之中。

案四，大衍余年，阴液始衰，风温病将经月，咳逆反复蝉联。痰黏难咯，肺气无肃化之权，唇焦齿干，胃液有枯槁之象，纳谷渐减则生机更耗也，大便窒滞是液燥使然也。五六日前一经大汗，真元已从外耗，脉象虽不空乏，重按均无神韵，舌中虽腻边尖光绛，证颇棘手，延防涸脱，虚多邪实，调治极幻。亟宜润燥生津以涤

痰，存液执中平妥治之，未卜应否。

西洋参，粉沙参，玄参，旋覆花，天冬，川贝母，麦冬，枇杷叶，浮海石，燕窝根，糯稻根，橘红。

按：风温经月，咳逆缠绵，曾经大汗，阴液耗伤，唇焦齿干，胃液已见枯槁，纳谷渐减，生机日形匮乏，证候系虚多实少，病情将内涸外脱。金氏以润燥生津为急，用三参养阴益气；二冬滋润生津；枇杷叶、糯根须清养肺胃；川贝母、浮海石清肺化痰；咳久肺伤，燕窝根颇宜；痰黏气滞，旋覆堪用，方药总以救肺胃之阴，增肺胃之液，证虽棘手，理法可师。

（选自《现代著名老中医名著重刊丛书·金子久专辑》，人民卫生出版社2006年版，77~79页）

周小农

温病案

病者：陈席珍，年六十余，住无锡。

病名：温病。

原因：素体液亏无苔，花甲之年，倒账折阅，郁气不舒，肝失调畅为内因，丙午夏病温为外因。

证候：身热自汗，渴不恶寒，神烦恶热，时时懊恼。

诊断：脉左小数，右洪搏数，舌红而绛。遂断为温邪郁火交蒸，最防热盛动风，骤变痉厥。

疗法：用梔、翘、芦、竹、知、茹、郁、桔急疏清解为君，兼顾胃津，花粉、石斛以佐之。

处方：黑山梔三钱，青连翘三钱，广郁金三钱（生，打），桔梗一钱，淡竹茹三钱，天花粉三钱，肥知母四钱，鲜石斛三钱。

先用活水芦根二两，鲜淡竹叶四钱，煎汤代水。

复诊：病势不衰，陈素信乱方，云：年周花甲，元阳大亏，若再投凉剂，必致生机骤绝。乱示附子理中汤，高丽参、炮姜、附子均重用，陈不敢服。至三候遍发黑紫斑，大显温热明证，热恋阴伤，舌至绛紫而干。始同意复诊，因议大剂化斑，双清气营。

复方：生石膏一两（研细），肥知母五钱，生甘草八分，生粳米三钱（荷叶包），玄参五钱，犀角粉一钱（药汤调下）。

效果：继以甘凉频投，如吴氏五汁饮之类，至四候热退净而愈，然亦险矣。噫，治病最虞有人中伤，若假神妄评，更为阴刻也。

廉按：此治伏气温病之正法。凡温病有汗者，清热兼保胃津，当然之理，然犹病势不衰，必须大剂化斑清营，频投甘凉生津，至四候热退而愈。可见伏气温病与新感风温，其病势之轻重，治法之

难易，迥不相同，但用银翘桑菊两方者，焉能济事，势必耽误而貽人夭殃也。噫！

（选自《全国名医验案类编·初集·四时六淫病案》，福建科学技术出版社，272～273页）

周筱斋

论治风温

风温是感受风热病邪所引起的急性外感热病。初起以发热、微恶风寒、咳嗽、口微渴等肺卫症状为其特征，多发于春冬两季。

风温之名，首见于《伤寒论》，云：“若发汗已，身灼热者，名曰风温。”但其所指是热病误汗后的坏证。至《类证活人书》明确提出了“风热相搏，即发风温，”其治“不可发汗”。本病的病因为感受春季或冬令风热之邪。春季风木当令，气候温暖多风，阳气升发，素禀不足之人，或因起居不慎，即可感受风热病邪，着而成病。叶天士说：“风温者，春月受风，其气已温。”风温四时皆有，以冬春为多。外感风热病邪，从口鼻而入，肺位居高，首当其冲，所以本病初起以邪在上焦手太阴肺经为病变中心。由于肺主气属卫，与皮毛相合，卫气敷布于皮毛，因而病变初起即出现发热、恶风、咳嗽、口微渴等肺卫证候。如肺卫之邪解，则其发展趋向大致有两种情况：一是顺传于胃，一是逆传心包。叶天士谓：“温邪上受，首先犯肺，逆传心包。”凡邪热顺传于胃，由卫转气，雍阻肺气，郁于胸膈或传入阳明，多呈阳明邪热炽盛之证；如邪热逆传心包，内陷心营，则必见神昏、谵语等神志证候。病变过程中易于化燥伤阴，尤多见肺胃阴伤表现。后期邪传下焦，则可产生肝肾阴伤的病理表现。在辨证时，首先应辨别卫、气、营、血的不同阶段，同时要详审虚实的转化。本证的治疗原则为泄热透邪，顾护阴液。初起邪在肺卫，治以辛凉解表、疏风泄热；邪传气分，治以清气泄热为主，合以宣肺、化痰、凉膈、开结等法；热在营血，治以清营凉血；热闭心包，合以清心开窍；热盛动风，兼以凉肝熄风；至本病后期，邪热已退而肺胃津伤未复时，则宜甘寒清养肺胃之阴为主；病程中正气暴脱，又当及时采用益气固脱之法。

医案：吴某，女，1951年2月21日晨诊。

咳嗽，高热 39°C ，声音嘶哑，神疲，迷昧欲睡，面色青紫，舌苔黄糙质白，腹胀便溏，病期业经四日，显示热毒侵肺，深虑心脏受邪，势颇重险，勉拟麻杏石甘汤加味，得效方吉。

处方：麻黄（不去节）2.4克，整杏仁6克，生石膏9克，粉甘草2.4克，浙贝母4.5克，远志根3克，九节菖蒲2.4克，鲜枇杷叶（去毛）1片。1剂。

2月22日午前诊。

服麻杏石甘汤后，热势涣散下降，测见 37.9°C ，音声圆润，咳时起扬，面色不复青紫，神态爽朗，惟大便仍属溏薄，橘滓不化，依然排出，腹胀不消，舌心犹溃，厚苔，是肺之症状轻减，而肠胃犹病，续以清肺运肠为治。

处方：杏仁6克，远志3克，焦神曲7.5克，浙贝母4.5克，桔梗4.5克，炒枳壳4.5克，前胡4.5克，薄荷2.4克，薄橘红4.5克，炒枯芩3克，陈莱菔英6克。1剂。

咳止，大便稍溏，腹胀已消，苔退转薄。继以清肺运肠，3剂而安。

按：温邪上受，邪毒过盛，正气不支，有逆传心包之势，为防邪闭内脱之变，先急予辛凉重剂清热宣肺，仿麻杏石甘汤加入化痰清热之味，以解痰热互阻肺胃之急。药后热势得降，邪热亦有外泄之机，然肺热尚存，脏腑同病，故继以清肺运肠而收功。

（选自《中国百年百名中医临床家丛书·周筱斋》，中国中医药出版社2004年版，37~39页）

郑沛江

风温夹湿案

病者：徐寡妇，年二十余岁，业农，住南通通兴镇西。

病名：风温夹湿。

原因：夫病瘵死，抑郁为怀，是其夙因。冬伤于寒，是其伏因。辛勤田野，加冒风雨，新感风温，是其诱因。

证候：初起体热，咳嗽胸闷，身痛头疼，便泻口渴，不甚引饮。早经前医历投凉解疏化等剂。嗣黄安仁先生介绍予诊，病已月余，神倦瞽瘵，口燥咽干，大便不行，溲赤而涩，月汛二期不至，奄奄待毙。

诊断：脉微欲绝，舌绛苔少。予断为真阴已亏，故脉微神倦。肝脉上巅，肝热，故头疼不减。舌绛者胃阴将亡也，苔少者胃气犹存也，咽干口燥者伏寒化火、阴虚火旺也。眼目昏花、暗中见鬼谓之“瞽”，肝筋被灼、筋不得伸谓之“瘵”，火炽于上则瞽（目乃火之户），风淫于筋则瘵（肝主筋）。《经》云：“诸热瞽瘵，皆属于火。”又曰：“诸风掉眩，皆属于肝。”详审病机，其为水亏木旺也无疑。至于大便不行、天癸逾期，又是血虚液涸之症，小溲赤涩乃肝旺而失疏泄之职，幸而胃动知饥，客邪已去十分之八九，此则尚有生机也。

疗法：治以大队浓浊之阿胶、龟胶、鳖甲、生地填阴补隙，壮水制火为君，臣以平肝之白芍、牡蛎，佐以杏仁、麻仁通幽泄火，五味敛阴，使以甘草调养胃阴，犹恐不足，令药前吞生鸡卵一枚。

处方：生白芍三钱，陈阿胶钱半（烊冲），龟胶钱半（烊冲），大生地三钱，炒麻仁三钱，五味子一钱，生牡蛎三钱，粉甘草二钱，连心麦冬三钱，炙鳖甲四钱，甜杏仁三钱（去皮，杵）。

效果：两剂而脉起，瘵止神清，苔生，便溺畅利，饮食稍进。

惟四肢无力，不能起床，渐次调补，逾两月而汛至，体健而愈。

廉按：辨证详明，处方精切，从吴氏三甲复脉汤加减，潜镇摄纳，为治内虚暗风之正法，是得力于《温病条辨》者。

（选自《全国名医验案类编》，福建科学技术出版社 2003 年版，16～29 页）

赵文魁

疏卫清化法治恶寒灼热案

叶赫那拉氏（慈禧），女。

诊查：五月初七日申刻，臣张仲元、赵文魁请得老佛爷脉息，左寸关弦数，右寸关浮滑而数。

辨证：感寒化热，蓄滞不清，以致头晕恶寒，身肢灼热酸痛，口干恶心，精神懒倦。

治法：谨拟清解化热之法调理。

处方：南薄荷一钱五分（后下），葛根三钱，淡豆豉三钱，荆芥一钱五分，酒黄芩三钱，桑叶三钱，白菊花三钱，知母三钱，鸡内金三钱，甘草一钱。

引用：广皮二钱。

按语：顷诊左寸关弦数，右寸关浮数，说明体内蕴热，可能是感寒化热，也可能本来就是风热上受，不可拘泥于“有一分恶寒，就有一分一表证”的老套。自温病学说创立二百余年以来，人们总是不能正确认识风热从口鼻吸受而来；温乃热邪，从口鼻而入，经咽喉、气管而至肺，肺主皮毛，故曰在卫，这与伤寒皮毛受寒不同。因为没有风邪寒邪，也没伤及皮毛，故脉不缓不紧而动数，两寸独大，因而温病以清为主，最忌解表发汗。

本方先以辛凉辛微温疏卫分以解除郁热，须候卫分郁开再行化热，故用葛根辛温、薄荷辛凉、淡豆豉宣疏、荆芥辛微温散风疏表，共以开郁结，绝不可以发表求汗。与黄芩、桑叶、菊花、知母等甘寒、苦寒泄热之品配合得当，则不会发汗伤津损伤阴分。再以甘草和中，内金助消化，广陈皮和胃宽中，合而为疏卫清化之佳方。一定要嘱病人禁食荤腥，防其胃中积滞而发热再起。

〔选自《中国现代名中医医案精华（三）》，北京出版社2002年版，1535～1536页〕

赵心波

论治感冒

感冒，包括现代医学的上呼吸道感染和流行性感冒等。这里主要介绍重症感冒的证治。

1. 风温袭表

主要原因是风温犯肺，束于肌表，热毒内蕴三焦，灼液生痰，阻于肺络，气机因之窒塞。

症见身热不退，朝轻暮重，嗜睡，醒后烦躁不安，轻者流涕，咳嗽，重则喘憋，不思饮食，且多惊惕。

治宜清宣肺气以解表，化里热而清三焦。方选桑菊饮加减：

桑叶 10 克，淡豆豉 5 克，杭菊 6 克，生石膏 15 克，薄荷 1.5 克，连翘 6 克，黄芩 6 克，麦冬 10 克，法半夏 6 克，生姜 2 片，杏仁 6 克。

此证常能转变肺炎，方中杏仁、石膏、黄芩、麦冬为辛凉肃肺，既退高热，又止喘憋；桑叶、杭菊、连翘、薄荷，轻宣解表；豆豉、法夏、生姜辅助宣散兼祛痰浊。

上方在临床实践中，甚属平稳，任何季节，都可适应，剂量可以加减，灵活采用。

2. 表里俱热

表邪未解，里热炽盛，浊邪蕴肺，灼液生痰，清肃之令不行。

症见高热不退，时有咳嗽，身倦肢怠，不思饮食，二便秘结，舌质红或有垢苔，脉多浮数。

治宜清疏外邪以宣肺，清里热而退高热。方选麻杏石甘汤和银翘散加减：

麻黄 3 克，生石膏 24 克，炒杏仁 6 克，生甘草 3 克，金银花 10 克，连翘 10 克，芥穗 3 克，薄荷 2.4 克，芦根 12 克，淡豆豉 3 克。

方中麻黄、芥穗、豆豉、薄荷解表以宣透。金银花、连翘、生石膏清热解毒；杏仁、芦根、生甘草既可清肺降逆，且能祛邪止咳。全方既解表邪，且清里热。

3. 温热夹滞

因夹湿停滞复感外邪，气机闭塞，清浊混淆，湿热内蕴，脾胃失调。

症见发热不退，大便频泻，精神萎靡，多数舌苔黄腻，亦有舌苔薄白者，脉象以浮滑为主。

治宜逐湿解表，化滞清热。

方选：藿香 10 克，薄荷 2.4 克，滑石 10 克，川连 1.2 克，黄芩 6 克，金银花 10 克，苏叶 3 克，炒麦芽 6 克，枳壳 6 克，车前草 6 克。

方中藿香、金银花、薄荷、苏叶清宣解表而兼疏散。黄芩、川连、滑石、车前草既可清热逐湿且可止泻利尿。麦芽、枳壳用以宽中化滞而兼理气。

此证四季都可发生，但以夏秋为多。夹湿停滞复感表邪，以致身热不解，便下泄泻，服用上方，较为适宜。

4. 暑热炽盛

感染暑热，迅即传经入里，有逆传包络引动肝风之象。

症见高热，汗出，热仍不解，神识昏沉，口干津少，多渴不食，舌绛苔黄，剧者抽搐。

治宜清暑生津解表，芳香开窍。

方选竹叶石膏汤加减，并加安宫牛黄丸冲服。

淡竹叶 6 克，生石膏 24 克，玄参 10 克，连翘 10 克，金银花 12 克，麦冬 10 克，法半夏 5 克，生草 3 克，生姜 3 片。

方中连翘、金银花、竹叶、生草解毒消热。石膏、玄参、麦冬辛凉解肌且能生津滋液；法半夏、生姜化痰疏表宣散。加用安宫牛黄以化邪热内扰，兼能开窍醒神。

此所谓暑易归心，蒙闭心包，引动肝风，发作急惊抽搐。凡有厥阴肝风抽搐者，皆可加用钩藤、全蝎、胆星以熄风止搐。

（选自《现代著名老中医名著重刊丛书·赵心波儿科临床经验选编》，人民卫生出版社 2005 年版，1~3 页）

病案：

1. 刘某，男，3岁，病历号862960。

正值流感流行，昨天突然高烧，今晨体温仍39.2℃，咳嗽声浊，舌质红，脉浮数。血象：白细胞计数6500/立方毫米，嗜中性粒细胞46%，淋巴细胞52%，嗜酸性粒细胞2%。诊为流行性感胃。证属风温袭表，郁于腠理。治以宣散解表，清热之剂。

荆芥穗6克，薄荷2.4克，银花10克，苏叶5克，蔓荆子6克，连翘10克，炒杏仁5克，瓜蒌10克，芦根12克，浮萍2.4克。

紫雪丹1.2克，日服3次。

服药两剂，体温正常，余邪未净，偶有咳嗽，脉缓，咽红。继予清肺利咽，化余热之剂调理之。

菊花10克，荆芥穗5克，瓜蒌10克，炒杏仁5克，黄芩6克，连翘10克，蔓荆子6克，炒栀子5克，鲜生地12克，麦冬10克，生草3克。

两剂即愈。

按语：突发高烧，咳嗽声浊，脉象浮数，舌质红。考虑高热突发，为表邪引起，但有咳嗽声浊，显系肺络郁阻。中医认为，皮毛者，肺之合也。风温上受，首先犯肺，因之咳嗽声浊，治以宣散解表，自属正法；但舌质红，脉现浮数，为热邪内潜，所以治此非加用清热之剂不能速效。赵老选用紫雪丹，他认为紫雪丹泻火解毒，芳香逐秽，既可清解五脏六腑之热邪，又可逐经络之秽浊，防热毒内陷，配合解表宣散法能够迅速退高烧，这是赵老治疗流感和其他发热性疾病的宝贵经验。

2. 高某，男，2岁，病历号4057。

因高热3天，频吐不止入院。住院经输液救治，脱水、酸中毒明显好转，但小儿嗜睡，大便3日未行，口腔糜烂，脉沉细有力。证属阳明腑实，消燥阴津而致脱水。予以白虎增液兼解毒通便之剂。

生石膏23克（先下），知母6克，生草6克，鲜麦冬16克，生地13克，玄参10克，川连2.6克，黄芩6克，生大黄6克，银

花 10 克，连翘 10 克，薄荷 2.6 克（后下）。

服药一剂，精神好转，口腔仍糜溃，体温仍高，舌苔中心薄黄，脉象沉数有力。再以清胃解毒，消导利咽之剂。

连翘 10 克，生石膏 26 克，川连 2.6 克，山豆根 6 克，生草 4.7 钱，蒲公英 10 克，银花 10 克，大黄 6 克，黄芩 6 克，麦冬 10 克，鲜生地 13 克，薄荷 2.6 克（后下）。

上药二剂，并服用千金散 0.5 克，每日 3 次。

继之上方加减服三剂，口腔溃疡痊愈，热退出院。

按语：发热、呕吐、大便 3 日不行、口腔糜烂属阳明腑实之证，大便不行，腑气不通则热毒不去。然本例热已伤阴，增液方可行舟，赵老以增液通腑兼解毒清热之法，共用药六剂即获痊愈。

3. 葛某，女，4 月，病历号 21280

流涕，咳嗽，痰不多，身热无汗，腹泻日 5～6 次，体温 38.8℃，苔光，脉数。疏表和中。

防风 3 克，桔梗 3 克，葱白 1 个，薄荷 0.7 克，六一散（包）1 克，芦根 10 克，象贝 6 克，神曲 6 克，麦芽 6 克，生姜片半片。

服药二剂热降，精神良，鼻塞、咳嗽大减，流涕仍有，大便稀，日行 8 次，苔薄，脉细数，继服前方。继之复发热，咳嗽剧，纳佳，便次减，为再感，治以平解。

炙麻黄 1 克，杏仁 6 克，生石膏（先煎）6 克，甘草 6 克，牛蒡子 10 克，桔梗 6 克，象贝 6 克，莱菔子 6 克，麦芽 6 克，神曲 6 克。

三诊：热退，咳剧，大便 4 次，苔薄，脉数。

炙麻黄 1 克，杏仁 6 克，生石膏 6 克，甘草 3 克，牛蒡子 10 克，桔梗 6 克，象贝 6 克，莱菔子 6 克，麦芽 6 克，神曲 6 克。

服药二剂，无发热，轻咳，精神佳，食纳好，大便 2 次，继服前方二剂后，于前方加茯苓 6 克，白术 4.7 克，痊愈出院。

按语：因感冒引起发热、咳嗽、腹泻者临床并不少见，赵老初用疏表和中之法，少用大苦大寒之药，以防伤正。待表邪被除，即加用茯苓、白术以护脾土，临床疗效确切，后人当认真学习。

4. 李某，女，3 岁，门诊病历。

昨夜突发高烧，今晨体温高达 39.2℃，其他无自觉不适。舌苔根部垢厚，脉象沉数，证属宿滞内蓄，兼染表邪之候。法以表里双解。

大青叶 10 克，麦冬 10 克，黄芩 6 克，神曲 6 克，牛蒡子 3 克，薄荷 2.4 克，淡豆豉 3 克，杭菊 10 克，炒枳壳 6 克，焦军 5 克，生石膏 12 克。

上药服用二剂，热退，食纳好，精神好，病痊愈。

按语：表里双解，是赵老治疗小儿感冒常用的方法之一。小儿脾常不足，易生积滞，常常是在内有宿滞的情况下，容易外染表邪，患儿除有表证外，还常伴有食欲减，大便不通，舌苔黄或垢腻，此时采用表里双解，收效速。如本例在清宣解表的基础上，加用生石膏、焦军、炒枳壳、神曲，清里消导，药只二剂，而病痊愈。

（选自《中国百年百名中医临床家丛书·赵心波》，中国中医药出版社 2004 年版，5～12 页）

赵锡武

用麻杏石甘汤加味治愈小儿风温案

例一，李某，1岁半。

主诉：咳嗽，痰盛，发烧一周，因气喘鼻煽一天入院。

诊查：体温 39°C ，呼吸 60 次/分，精神差，无汗，苔薄白，脉浮数，两肺听诊广泛中细水泡音，心率 160 次/分。胸透：右肺下野炎性病变。西医诊断为肺炎。

辨证：风温犯肺。

治法：宜清热解毒，辛凉透表。方用麻杏石甘汤加味。

处方：麻黄 3 克，杏仁 9 克，甘草 6 克，生石膏 12 克，银花 6 克，连翘 9 克，桔梗 6 克，芥穗 12 克，鲜芦根 30 克。

二诊：服药一剂后，身热退（体温 36.7°C ），精神好转，咳喘减轻，痰减少，食欲不振。舌苔黄白垢腻。表邪已解，余热未尽。前方去芥穗，加枳壳 12 克。

三诊：服药两剂后，体温正常，咳喘继减，食欲渐增。舌净，脉缓。宜辛凉轻剂以善其后，用桑菊饮加减。第六天痊愈出院。

例二，王某，男孩，7 个月。

入院日期：1960 年 1 月 8 日。

主诉：因咳嗽，发烧四天，体温最高达 39.5°C ，伴有喘憋，时作呕而入院。

诊查：体温 39.5°C ，呼吸 52 次/分，面赤，时烦躁，嗜睡，点头呼吸，三凹征明显，口围青，舌根部有少许白苔，脉浮数，心率 132 次/分。胸透：右胸内带片状阴影，左侧心缘旁有片状阴影存在。西医诊断为肺炎。

辨证、治法：表里皆热。治宜清热解毒，辛凉透表。方用麻杏石甘汤加味。

处方：麻黄3克，杏仁9克，生石膏15克，甘草6克，丹皮6克，竹茹12克，鲜芦根30克，花粉9克，黄连3克。

二诊：服药一剂后，仍身热，咳嗽、气喘、嗜睡有好转，呕渐减，惟大便干。舌赤苔黄，脉稍浮数。前方去花粉、黄连，加瓜蒌仁9克，紫雪丹1.2克（分二次冲服）。

三诊：服药二剂后，精神好转，大便已解，仍气促有痰，发热。舌质红无苔，脉仍稍弦数。前方去紫雪丹、瓜蒌仁，加浙贝6克，橘红6克。

四诊：入院5~6天身热退，稍有喘，气粗有痰。苔薄白，脉缓。证属表邪渐解，余热未消，宜清热豁痰。

处方：鲜芦根3克，桃杏仁各9克，冬瓜仁9克，苡仁9克，甘草6克，桔梗9克，杷叶6克，川贝6克，橘红6克。

七天后舌净脉缓，精神食欲转佳，两肺已无啰音，惟稍有微咳，拟桑菊饮加减二剂，出院带回随服。

按语：此两例小儿肺炎，均属中医温病范畴。温热毒邪，传变最速，且易伤阴，故治疗应辛凉泄热、甘寒凉营、芳化解毒综合应用，方可适应小儿特点。两例虽都以清热解毒、辛凉透表为法，用麻杏石甘汤加味治之，但前者属风温犯肺，邪尚在表，故加用银花、连翘、桔梗、芥穗辛凉宜泄、清热透表之品；而后者则属表里俱热，因而加用黄连、丹皮以清泄里热、凉血解毒，不失为辨证而施治。前例余热清而湿浊生，故加枳壳以理中气除湿浊，后例余热清而痰热重，故用清热豁痰之品。最后，两例均以桑菊饮辛凉宣肺以止咳而获痊愈。

〔选自《中国现代名中医医案精华（三）》，北京出版社2002年版，1654~1656页〕

胡希恕

论治感冒

感冒又称伤风，相当于西医的上呼吸道感染（鼻、咽、喉、扁桃腺炎症）。感冒之名何时形成尚无确论，一般教科书说始于北宋，系指杨士瀛《仁斋直指方·诸风》引《和剂局方》之参苏饮：“治感冒风邪，发热头疼，咳嗽声重，涕唾稠黏”，这里的感冒二字尚属动词。元代《丹溪心法·中寒附录》：“凡症与伤寒相类者极多……初有感冒等轻证，不可便认作伤寒妄治。”这里正式提到感冒的名词。值得注意的是，朱丹溪这里所说的伤寒，系指《伤寒论》第3条：“太阳病，或已发热，或未发热，必恶寒、体痛、呕逆、脉阴阳俱紧者，名为伤寒。”其意是说感冒有轻有重，有可能是中风，有可能是伤寒，有可能是温病，不能都作伤寒看待。明代龚廷贤《万病回春》提出把感冒分为风寒、风热两证型为主，后世多有宗此者。明代张景岳《景岳全书·伤风》云：“伤风之病，本由外感，但邪甚而深者，遍传经络，即为伤寒；邪轻而浅者，止犯皮毛，即为伤风。”他这里说的伤风，强调了病情轻，比伤寒轻。这段话给后人以误解，以至提出“感冒不同于伤寒”的论调。历代各家对感冒不同认识的产生，一是用病因、感邪的性质来推理、分证型。一是用八纲来分证型。当然更受临床经验的影响，而临床经验丰富者，多认为感冒是外感病之属，有的症状就属伤寒，一些人提出“感冒不同于伤寒”含糊不清的概念，是不科学的。实际早在宋代就用六经辨证论治伤风。如陈无择将伤风列为专题论述，他在《三因极一病证方论·叙伤风论》中，以六经辨证治疗伤风，如太阳伤风用桂枝汤，阳明伤风用杏子汤，少阳伤风用柴胡加桂枝汤，太阴伤风用桂枝加芍药汤，少阴伤风用桂附汤，厥阴伤风用八珍汤。也说明感冒、伤风临床症状可出现六经症状，

不仅只现表证、太阳病。现代西医认为感冒是上呼吸道感染，所述临床表现也多有伤寒之属及六经各证。因此用六经辨证理论才能正确指导治疗感冒。

感冒在表变匆匆，审证勿疏有合病

例一，陈某，男，24岁，病案号97771。

初诊日期1965年10月9日：昨天打篮球后用凉水洗澡，今早感恶寒身热（ $T38.6^{\circ}\text{C}$ ），无汗，头痛，身酸痛，口不渴，舌苔薄白，脉浮紧。此属太阳表实证，治以发汗解表，予麻黄汤。

麻黄三钱，桂枝二钱，炙甘草二钱，杏仁三钱。

结果：上药急煎即服，并加盖棉被得微汗出，热渐退，未再服药，调养两天自愈。

例二，刘某，女，28岁，病案号12517。

初诊日期：1965年8月30日。昨日受凉后，出现鼻流清涕、喷嚏、头痛、头晕、微恶风寒、咽痒，舌苔薄白浮黄，脉细数。证属太阳阳明合病，予桑菊饮加石膏。

芦根五钱，桑叶三钱，菊花三钱，连翘三钱，薄荷二钱，杏仁二钱，炙甘草二钱，生石膏一两半。

结果：上药服二剂，症已。

按：胡老常用经方，但遇感冒、咳嗽初起，阳明里热轻者（温病学派辨证多为风温表证时）常用桑菊饮加减，疗效亦颇佳。实不失六经辨证和辨方证之旨，又善学时方之意。

例三，张某，男，44岁，病案号96718。

初诊日期：1965年3月25日。自昨日来，恶寒，无汗，项背强，头痛，腿痛，口唇干，舌苔薄白，脉浮紧。证属太阳阳明合病，与葛根汤加石膏。

葛根三钱，桂枝三钱，麻黄三钱，白芍三钱，生姜三钱，大枣四枚，炙甘草二钱，生石膏一两。

结果：上药服一剂，感冒证解。

按：以上三例，例一为单纯表实证，故用麻黄汤发汗得解。后两例，虽发病仅一天却都合病阳明里证，故治疗不能仅用汗法，必

同时兼清阳明里热，因治疗得法，故很快皆愈。这里值得注意的是，同样是太阳阳明合病，例二用了桑菊饮加石膏，例三用了葛根汤加石膏，还有临床常见一发病即呈大青龙汤、麻杏石甘汤方证，这是因为临床所表现的方证不同，必须应用不同的适应方药治疗之故。这也就是胡老所强调的：临床辨证论治，不但要辨六经，更重要的是辨方证。

这里也可看出，感冒与其他外感病一样，证在表时变化多端而快。感冒所呈现的表证是很短暂的，很快出现合病、并病，有的一发病就可能是合病，如例二、例三。因此，一些教科书称感冒无传变是不符合临床实际的。

感冒并非皆表证，治疗当忌都发汗

例四，唐某，男，35岁，病案号37867。

初诊日期：1965年4月24日。感冒三天，咽痛，口干，恶心，不欲食，头痛头晕，咳则右上胸疼，舌苔白，脉弦细稍数。证属少阳阳明合病，为小柴胡加石膏桔梗汤方证。

柴胡四钱，半夏三钱，黄芩三钱，党参三钱，生姜三钱，大枣四枚，炙甘草二钱，苦桔梗三钱，生石膏一两半。

结果：上药服三剂，口干、咽痛已，咳嗽亦不明显，但感恶心、腰痛、下肢凉，上方去苦桔梗，加桂枝、赤芍各三钱，生龙骨、牡蛎各五钱，服三剂诸症已。

按：此患者是以咽炎为主的上感，是临床多见的感冒，因多数初起不来诊，故来诊时表证已不明显，而呈半表半里少阳证或少阳与阳明合病，故胡老常以小柴胡汤加减治疗。小儿患者感冒更多呈现此方证。此时如用汗法解表，徒伤人体津液、正气，使感冒迁延不愈、加重，感冒后自服许多药，或治疗不当而长期不愈者屡见不鲜。这就告诫后人，感冒虽小病，治疗也要辨证论治。一见感冒就解表，是非常错误的。

例五，张某，女，27岁，病案号125。

初诊日期：1965年9月24日。一月来感冒，头晕、咽痛、咽痒、鼻塞、流涕等反复出现，前医曾诊为“秋燥”、风热束肺，用

薄荷喉片、六神丸、桑菊饮、银翘散等，症状不减却越来越重，因而找胡老会诊。近症：头晕，头痛，背痛，恶寒，咽痒而咳，咯痰困难，晚上尤甚，口苦咽干，舌苔薄白，脉弦细数。胡老辨证为三阳合病，为柴胡桂枝汤合半夏厚朴汤加石膏方证。

柴胡四钱，党参三钱，半夏四钱，黄芩三钱，桂枝三钱，白芍三钱，厚朴三钱，苏子二钱，苏叶二钱，生姜三钱，大枣四枚，茯苓三钱，炙甘草二钱，生石膏一两半。

结果：上药服三剂，头晕、头痛、口苦解，背痛、咳嗽减未已，仍微恶寒，脉已不数，与桂苓五味姜辛夏杏甘草汤，服六剂症已。

按：此患者初起为鼻炎、咽炎，西医诊断为上呼吸道感染，中医贯称感冒、伤风。前医称为“秋燥”，而用清凉解表久不效，是因辨证不确，方药不对证。转至胡老会诊时，呈三阳合病挟饮，故以柴胡桂枝汤加石膏和解三阳，并加半夏厚朴汤化饮降逆，使三阳证很快解除。后以桂苓五味姜辛夏杏甘草汤化痰降逆，遂使病愈。可见感冒、伤风并非只现表证，如不仔细辨证，凡见感冒悉用辛凉或辛温发汗解表，徒伤津液，伤人体正气，使病情迁延、加重，惟有以六经辨证，辨清方证，才能做到药到病除。

表证阴证阳证分，论治温补发汗殊

例六，贺某，男，8岁，病案号79322。

初诊日期：1965年10月23日。感冒发热一周，每日上午11点半出现发热（ $T38^{\circ}\text{C}$ 左右），汗出，至夜12点后烧自退，饮食精神均好，大便隔一二日一行，他无不适，舌苔白润，脉虚数。证属太阳表证，为营卫失和之桂枝汤方证，与桂枝汤：

桂枝三钱，白芍三钱，生姜三钱，大枣四枚，炙甘草二钱。

结果：上药服二剂，上午已无发热，下午1点后尚有低热（ $T37.2^{\circ}\text{C} \sim 37.5^{\circ}\text{C}$ ），舌苔薄黄，脉尚稍数，与桂枝汤合小柴胡汤加生石膏三剂，诸症解。

按：本例为小儿，因自我感觉及表述能力差，故症状表现不多，但抓住为太阳表阳证与桂枝汤调和营卫则解。

例七，许某，男，47岁，病案号3752。

初诊日期：1978年5月4日。感冒2天，右头痛，自觉无精神，两手逆冷，无汗恶寒，口中和，不思饮，舌质淡，舌苔薄白，脉沉细，咽红滤泡增生多。此属虚寒表证，治以温阳解表，与麻黄附子甘草加川芎汤：

麻黄三钱，制附子三钱，炙甘草二钱，川芎三钱。

结果：上药服一煎，微汗出，头痛解，未再服药，调养两日，精神如常。

按：何廉臣的《重订全国名医类案》中就载有少阴感冒，认识到因体质的不同感冒出现的症状则不同，也即感冒与其他外感病一样表现为太阳病和少阴病。体质强壮者呈太阳病用发汗解表治疗，因太阳病又分表实（如例1）（无汗）、表虚（自汗恶风），发汗法又有所不同，例6即太阳表虚证，用桂枝汤调和营卫发汗解表。而例7是体质阳虚明显的咽炎感冒，呈现虚寒阴性表证，即少阴病，解表须用汗法，但须加温阳强壮的附子等才能驱除外邪。这就是《伤寒论》表证分阴阳，即分为太阳、少阴，治皆用汗法而有不同的实质。

（选自《中国百年百名中医临床家丛书·胡希恕》，中国中医药出版社2001年版，5~10页）

胡剑华

治风温夹食案

病者：汪瑞庭，年三十八岁，米厂机师，住景德镇。

病名：风温夹食。

原因：夏历八月，酷热异常，初受风热而不觉。于八月十七日傍晚赴筵，嗜酒狂饮，多食油腻，夜深回家，觉渴甚，食生菜菹一枚。迨东方将白之时，自觉右肋疼痛，发热恶风矣。

证候：头痛身热，自汗恶风，怕寒胁痛，先在右肋，继移左肋，背亦隐痛，渴嗜冷饮，咳剧心烦，痰浓而黏。

诊断：脉数而尺肤热，舌中间靠右边一条黄腻而润。合参脉症，断为太阴风温而兼食滞。此《素问·刺热篇》所云“肺热病者，先淅然厥，起毫毛，恶风寒，舌上黄，身热，热争则喘咳，痛走胸膺背，不得大息，头痛不堪，汗出恶寒”也。

疗法：凡太阴风温，先宜轻宣清解，故用连翘、片芩、蝉蜕、豆豉为君；因其肺有热痰，复投栀子、牛蒡、杏仁清肺行痰为臣；兼有积滞，故用蔻仁、厚朴、陈皮、莱菔子宽中行滞为佐；又有胁痛彻背，故以芍、甘、延胡和血止痛为使。

处方：净连翘钱半，淡豆豉二钱，牛蒡子二钱（炒），莱菔子八分（炒），甘草三分，淡黄芩钱半，焦栀子一钱，苦杏仁二钱，川厚朴八分，陈皮一钱，延胡索二线，净蝉蜕一钱，白蔻仁六分（冲），生白芍四钱。

复方：净连翘钱半，苦桔梗一钱，焦栀子一钱，淡黄芩钱半，川贝二钱，苦杏仁三钱，白茅根五钱，生甘草三分，牛蒡子二钱（炒），银花二钱，瓜蒌仁四钱（杵），蝉蜕壳七分，淡竹沥两瓢（冲）。

效果：服初诊方四剂后，诸症皆减。惟咳痰甚难，非三四声不

能咳出，其痰甚浓，色白带黄，每逢咳时，牵动左胁作痛，接复诊方三剂痊愈。

廉按：清解消导，自是正治，方亦从叶法脱化，诊断引经证医，足见学有根柢。

（选自《全国名医验案类编》，福建科学技术出版社 2003 年版，27～28 页）

俞慎初

温热病治验举要

温热病是临床的常见病、多发病，大多起病急骤，传变较快，临床表现以发热为主症，且易化燥伤阴为特点。俞慎初教授指出，大凡温热病临证，须熟谙叶、吴、薛、王诸温病学家之旨，掌握卫气营血和三焦辨证大纲，并参与伤寒六经。察证审机，分辨湿热偏重、病位深浅、正邪盛衰之不同，立法用药，细致权衡，灵活运用透表、清气、祛湿、清营、凉血、滋阴等不同治法。然而温热为病，变化最速，又易化火伤阴耗液，故温病之治，以“迅速祛邪”和“顾护阴液”为临证之关键。

时发暑症，治以清泄少阳

《素问·阴阳应象大论》云：“夏伤于暑，秋必痎疟。”夏月感受暑湿，邪郁伏于少阳，阻遏枢机，过夏而发。症见寒热如疟，午后热甚，入暮尤剧，天明得汗则减，热退又复升，缠绵日久，且伴有脘痞呕恶，舌红苔腻，脉弦数或濡数，治拟清泄少阳胆热，兼以化湿。方用清代俞根初的蒿芩清胆汤。若湿偏重，可酌加藿香、佩兰、通草等；热偏重者，方用雷氏清营捍疟法（连翘、竹叶、扁豆衣、青蒿、木贼草、黄芩、青皮）加减

案例：王某，男，25岁，1975年8月11日来诊。患者暑天在乡，外感发热，微恶寒，每日于上午10时前后体温逐渐上升，下午4时前后可达39℃左右。曾往医院经西医治疗，热度稍退又复升，时轻时重，有汗而热不解，缠绵数月。伴有头重胸闷，咳嗽，痰白而黏，小便如浓茶色，舌苔白，脉弦数。此乃暑湿郁遏少阳，拟清泻少阳，分消湿热，方用蒿芩清胆汤加减。处方：青蒿叶6克，黄芩6克，枳壳6克，陈皮4.5克，连翘6克，瓜蒌24克，

法半夏6克，茯苓10克，碧玉散15克（包），水煎服。

上方嘱其连服5剂。每天上午8至9时左右服头煎，午后3至4时左右服次煎。5天后，热已退，后进补中益气汤加减，以善其后。随访半载，未再复发。

按：本例病发如疟，身热数月不退。俞师究其病起于夏令伤暑，“暑必挟湿”，为暑湿所犯。寒热如疟状，是邪郁少阳气分之证，故以清泄少阳湿热立法，用蒿芩清胆汤清胆利湿，使少阳枢机旋运，遏伏之邪外达，湿去热除，5剂而愈。又因病情延治日久，耗气伤正，故以补中益气汤善后。俞教授又重视服药时间，在邪正交争的发热时服药，不仅汤药易达病所，又有利于助正驱邪，临床易于取效。

（选自《中国百年百名中医临床家丛书·俞慎初》，中国中医药出版社2001年版，15~16页）

施今墨

论外感病证治

春气温和，夏气暑热，秋气清凉，冬气冷冽，此四时之正气。若气不适其候，正不御其邪，皆能为患，四季均有外感病。然分其大类不外风寒与温热二者，其中又可再分传染性及非传染性两种，如流脑、乙脑、伤寒、猩红热、麻疹等皆属传染性者；如感寒、中暑等则为非传染性者。余意不论其为外感风寒或温热，不论其为传染性或非传染性，必须外因内因结合起来看，六淫疫疠之邪皆为外因，若单纯外因亦不均能致病。例如流行性感冒病毒，其传染性颇高，传播感染最为广泛，然而流行区域亦非百分之百均染是病。又如夏日酷暑，温热蕴郁，但中暑究竟不是多数。“邪之所凑，其气必虚”，外因通过内因始生作用，确为至理名言。

古人论外感病，自《内经》以后，历代均有所发展，尤以仲景之《伤寒论》为后世所宗。至刘河间之《素问病机气宜保命集》主张清凉治温，通下治疫，始为温病治法之转折点。尔后明之吴又可，清之叶天士、吴鞠通、王孟英、雷少逸等，在理论与治法上均有发展，逐渐创立温病学说。如叶天士《温热论》曰：“温邪上受，首先犯肺，逆传心包。肺主气属卫，心主血属营。辨营卫气血虽与伤寒同，若论治法则与伤寒大异也。”实是独具创见，发前人之未发。其察舌验齿辨别斑疹法，至今在临床诊断中仍有重大意义。

外感性疾病之伤寒与温病两大学说，前人论证精确详细，六经辨证、卫气营血辨证、三焦辨证各有其长，所创诸方，亦均显效，不多赘述。而余在临床中对于外感，着重辨气血、虚实和表里。辨气血，即分清层次。邪在卫气，治之较易；邪入营血，病情严重。温邪在卫分的时间很短，极易伤及气分，但只要病邪尚在气分，就

应坚守气分这道防线，不使病邪再继续深入。叶天士提出“在卫汗之可也，到气才可清气，入营犹可透热转气，……入血则恐耗血动血，直须凉血散血”的原则，临床中实属重要。邪尚留气分中时，一定注意不要用血分药，以免将邪引入营血。论虚实，即考虑邪正关系。虚实不分，邪正不明，时常会发生误治。如正气素亏，外感风寒者，应扶正祛邪，若只投发散之剂，往往使表不固正愈虚而生他变。审表里，即详查表里比重。外感热性病多属内有蓄热，外感风寒，治疗时应既解表寒又清里热，用药时表里比重必须恰当。余治此类病有七解三清（即解表药味和清里药味之比例为七比三，依此类推）、六解四清、半解半清、四解六清、三解七清之说，虽属个人杜撰，但在临床中亦示明表里比重关系至切，较为实用。

外邪入侵必予出路，万不可闭门逐寇。其出路有三，为汗及二便。在表多以汗解，在里多以二便而清，因此分清表里最为重要。而过汗则伤津，过下则正衰，若引邪由膀胱水道外出，则较为妥帖。苇根、竹叶、滑石、荷梗之类，既不伤津又可清热，若予浮萍，则外邪可从汗尿两途而去。

用药之配伍，颇具技巧，治病如作战，配伍如将兵，熟习战士特点，善于调配兵伍，指挥裕如，始克顽敌，医者熟习药性，精研配伍，亦同是理也。如外感病不宜过早用连、芩、梔子、生石膏等寒凉药物，以免引邪入里，但梔子伍豆豉，生石膏伍薄荷、桑叶，黄芩伍芥穗，既能解表又清里热，相互为用，效果益彰。

温病中以湿温最为缠绵，要层层解脱，治以芳香化浊、淡渗利湿、苦寒清热、宣气化湿诸法。不宜过汗或攻下，否则时见发热初退旋又再发，故治湿温尤要细致慎重。若病人血分，出现神昏谵语，舌绛唇焦，不可汗解，宜选用紫雪丹、安宫牛黄丸、局方至宝丹配合汤剂以治之。

温病之舌苔变化甚多，余在临床中体会，凡舌苔薄而润，病尚轻，若外白中黄或灰且厚腻而垢者病重难治。亦有初见厚腻舌苔，一夜之间突然变为无苔而舌色猩红者，均不易治。古人论舌苔，白主寒，黄主热，黑为热极，但不可一概而论，应结合舌质颜色及苔

面润燥来定。如苔白如粉，舌质绛红干燥不润者，为热伏邪盛，湿滞不化，行将津枯之兆。又如舌润苔黑，并见肢冷腹泻，却为寒极之象。

风寒外袭案

张某，男，50岁，病历号52，4，3810。

一周前，晚间外出沐浴，出浴室返家途中即感寒风透骨，汗闭不出，当夜即发高热，鼻塞声重，周身酸楚。服成药，汗出而感冒未解，寒热日轻暮重，口干，便结，胸闷不欲食，舌苔黄厚，脉洪数有力。

辨证立法：浴后感寒，腠理紧闭，阳气不得发越，遂致高热，虽服成药汗出而寒邪化热不解，必清里以导邪出，拟七清三解法治之。

处方：杭白芍（桂枝5克同炒）10克，淡豆豉10克，酒条芩6克，炒山栀6克，紫油朴4.5克，全瓜蒌24克，炒枳壳4.5克，杏仁泥10克，薤白头10克，苦桔梗4.5克，白茅根15克，炙草梢3克，白茅根15克，大红枣3枚，鲜生姜3片。

按：浴后汗出，毛孔开张，骤遇寒风侵袭汗闭不出而发高热，患者虽服成药发汗，然外感并未能解，病邪入里化热，此时当以表里双治，患者里热重于表寒，故清里为主解表为辅，七清三解为法清解比例恰当，患者只一诊即愈。本案以桂枝汤、栀豉汤合瓜蒌、薤白治之。施师对于胸闷不食，便结气滞者，常以苦桔梗、炒枳壳、杏仁泥、薤白头四药配伍，用之多效。

表寒里热案

刘某，男，39岁，病历号56，10，448。

一周之前，暴感风寒，左臂骤然作痛，咳嗽剧烈，夜不安枕，经服药及针灸治疗，未见显效，昨晚忽又咳血，大便四日未下。体温38.8℃。舌苔黄，脉浮紧。

辨证立法：脉象浮紧，浮则为风，紧则为寒。风寒痹阻经络左臂骤痛。肺主皮毛，风寒客肺，症现咳嗽。大便不通，内热甚炽，遂致咳血。基本以五解五清法治之。

处方：赤芍药6克，白芍药6克，川桂枝（炒）4.5克，炙苏子10克，炙白前6克，片姜黄10克，炙紫菀10克，炙前胡6克，白杏仁10克，炙麻黄3克，嫩桑枝30克，苦桔梗4.5克，大蓟炭6克，白茅根15克，酒黄芩10克，小蓟炭6克，白茅根15克，炙甘草3克，紫雪丹3克（温开水分二次冲服）。

二诊：前方服二剂，发热退，臂痛减，咳嗽见好，未吐血，大便已下。

处方：前方去大小蓟炭、紫雪丹，加旋覆花6克，新绛4.5克（前二味药同布包）。

三诊：药服二剂，左臂痛已好，体温正常，咳嗽减轻，但周身似有气窜走，酸楚不适，夙疾偏头痛又现。

处方：杭白芍10克，片姜黄6克，旋覆花（红新绛4.5克同布包）6克，川桂枝（炒）3克，酒地龙10克，白蒺藜15克，海风藤10克，石楠藤10克，蔓荆子6克，炙甘草3克。

按：素蓄内热，暴感风寒，腠理紧闭，不得透越，遂发高热。热逼血溢，致生咳血。高热苔黄而便干，里热炽盛。脉象浮紧，咳则臂痛是属风寒未解。故以清解并举之法。新绛有活血通络之功，姜黄活血理气有治风湿臂痛之效。

半表半里案

张某，男，57岁，病历号53，5，430。

身发寒热已二十余日，曾服药发汗，汗出又复畏风，全身倦怠无力，不思饮食，小便黄，量甚少。舌苔薄黄质红，脉弦数。

辨证立法：病已二十余日，邪正互争，寒热时作，病在半表半里之间，故服药虽汗出，而邪仍不得解。小便黄少，苔黄舌红而脉弦数，说明兼有里热，拟和表里，清内热，通利膀胱水道之法治之。

处方：赤白芍各6克，川桂枝（柴胡4.5克同炒）1.5克，旋覆花（炒半夏曲10克同布包）6克，炒香豉6克，炒知母6克，川厚朴4.5克，炒山栀10克，煨草果4.5克，白通草4.5克，白苇根12克，酒黄芩10克，赤茯苓10克，白茅根12克，酒黄连4.5克，赤小豆10克，炙甘草3克。

二诊：药服四剂，寒热大为减轻，周身舒畅，二十余日以来无此佳象。尿量增多，食欲稍好。

处方：赤白芍各6克，银柴胡（桂枝1.5克同炒）3克，旋覆花（炒半夏曲10克同布包）6克，车前草6克，赤茯苓12克，冬瓜子12克，车前子6克，赤小豆12克，冬葵子12克，白苇根18克，炒黄连4.5克，炙草梢3克，焙内金10克，炒谷芽10克，炒麦芽10克。

按：里有蓄热，易致外感，外邪入于半表半里，遂使里热更炽，惟以和解兼清里热之法方能奏效。初诊之方以达原饮、柴胡桂枝汤、栀豉汤化裁。方中桂枝与二芍，柴胡与二黄，苇根与茅根，豆豉与山栀，草果与知母，一表一里互助配合，桂、柴、苇、豆、草同施有逐邪外出之功，芍、黄、茅、栀、知共起敛阴、清热、凉血之效。解清共伍，体现了施师善用对药的特点。旋覆花配半夏曲和胃降逆，川朴除湿散满，甘草调和诸药并扶正。赤苓、赤小豆、通草等味利湿使邪有出路。本方药味较多，初看杂乱无章，细审方知组方配伍均有法度。

小柴胡汤之应用，王孟英氏说：“惟风寒正疟，邪在少阳者，可以按法而投……若温热暑湿诸疟……但执此汤，奉为圣法，则参、甘、姜、枣，温补助邪，骤则液涸神昏，缓则邪留结痞，且有耗阴伤血而成疟劳者。”本案虽由外感而致发寒热如疟，但因素有蓄热内伏，临床构成复杂之证，正如王氏所云，“非属风寒正疟”，故施师不用小柴胡汤，以防“参、甘、姜、枣，温补助邪”，耗伤津液。古人有“疟属少阳”之说，施师抓住邪在半表半里，兼有蓄热内伏的病机，采达原之意，以和解为法，佐清热利湿之品，宣、疏、清、利共施，一诊便收到了很好的治疗效果，其辨证、立法、组方、配伍俱见巧思。施师治病的风格于此案中可见一斑。临

床中证候复杂，千变万化，病人的症状往往不能完全符合书本上某证某方，遇此情况，施师绝不墨守成规，而是灵活运用古法古方，体现了古为今用的特点。施师常说：“决不能凑症状以命证，执成方以治病。”

类疟案

石某，女，44岁，病历号52，10，60。

病已一周，隔日发寒热一次，类似疟疾，经医院检查，未发现疟原虫，寒热发作时，头痛口干，周身酸楚，汗出甚多，倦怠无力。舌苔白，脉数大。

辨证立法：时届秋日，感受风寒，素体不健，正气不足以抗邪外出，致使营卫不调，表里失和、邪正互争，症发类似疟疾。拟和表里，调营卫治之。

处方：炒柴胡3克，炒桂枝3克，煨草果5克，酒黄芩10克，赤白芍各6克，肥知母6克，桑寄生15克，炒常山5克，野党参6克，嫩桑枝15克，炒槟榔10克，清半夏10克，川厚朴6克，炙甘草3克。

二诊：前方服四剂，寒热发作已无规律，且症状减轻，胸闷、头痛、口渴仍存。

处方：炒桂枝1.5克，北柴胡3克，青皮5克，赤白芍各6克，酒黄芩10克，广陈皮5克，煨草果5克，野党参6克，炒槟榔6克，肥知母6克，清半夏10克，川厚朴6克，酒川芎5克，鲜生地12克，天花粉10克，炒蔓荆5克，鲜茅根12克，甘草梢3克。

按：本案与上案，均以寒热如疟为其主症，同用和解之法，但前案兼清里热，本案则兼补气。本案处方中，补气药味并未多用，且党参用量轻，既无温补助邪之患，又起鼓助正气之功，用药之技巧，即在于此。

热入血室案

李某，女，32岁，教师，病历号53，5，170。

病历四日，发热，头痛，项强，经水适至，呕吐不食，心烦不能眠，甚则谵语妄言，口干，大便已四日未解。舌苔外白中黄，脉浮紧。

辨证立法：暴感外邪，适遇经至，热入血室，即应调和气血，兼以通便。

处方：赤白芍各6克，川桂枝3克，银柴胡4.5克，川独活4.5克，酒黄芩6克，酒黄连3克，紫丹参6克，酒川芎4.5克，粉丹皮6克，姜竹茹10克，炒陈皮6克，香豆豉（炒）12克，蔓荆子6克，法半夏6克，晚蚕砂（炒皂角子10克同布包）10克，砂仁壳4.5克，白茅根12克，炙甘草3克，豆蔻壳4.5克，白茅根12克。

二诊：服前方二剂，发热渐退，头痛减轻，颈项不强，仍感不适，呕吐止，大便已通，但干燥。

处方：赤芍药6克，炒柴胡4.5克，蔓荆子6克，杭白芍10克，川独活4.5克，酒川芎4.5克，牡丹皮6克，酒归尾6克，鲜茅根10克，细丹参6克，鲜生地10克，苦桔梗4.5克，炒香豉10克，莱菔缨6克，炒山栀6克，莱菔子6克，炙甘草3克。

按：《金匱要略》云：“妇人伤寒发热，经水适来，昼日明了，暮则谵语，如见鬼状者，此为热入血室。治之无犯胃气及上二焦，必自愈。”本案即为暴受风寒，入里化热而又月经适至，以致热入血室。症见头痛，项强，甚则谵语妄言，治宜从气分血分双治。加晚蚕砂、皂角子以润肠通便。就诊二次，服药四剂，应手而愈。

外感表虚案

任某，女，52岁，病历号53，10，120。

一月以前发病，初起恶寒发热，周身酸楚，屡经医治，寒热始

终未退，近日来更加时时自汗，畏风，胸闷，胃胀，气短心慌，睡眠不安。

舌苔薄白，六脉虚软无力。

辨证立法：体弱多劳，中气素亏。前感风寒，迭进发散之剂，遂致表虚不固，自汗多，畏风怕冷，腠理松弛则外邪极易侵入，故寒热久久不退。今当和营卫，固腠理，补中气，调脾胃为治。

处方：炙黄芪18克，北防风3克，杭白芍（桂枝木3克同炒）10克，炒白术6克，米党参6克，当归身6克，云茯神10克，炒远志10克，云茯苓10克，浮小麦30克，五味子3克，炙甘草3克，厚朴花4.5克，大红枣2枚，鲜生姜2片，玫瑰花4.5克。

二诊：服药四剂，汗渐少，精神强，食欲稍增，惟睡眠仍欠佳，心慌气短如旧。有时仍觉有寒热，两胁又现窜痛。

处方：前方去五味子，加柴胡4.5克、北秫米12克、炒半夏曲10克，再服五剂。

三诊：服前方寒热退净，食欲增强，行动时汗易出。

处方：黄芪皮10克，杭白芍（桂枝1.5克同炒）6克，浮小麦30克，野白术4.5克，当归身6克，厚朴花6克，地骨皮10克，炒远志10克，玫瑰花6克，香稻芽15克，炙甘草3克。

按：平素体弱，外感风寒，不宜重施表散，否则表愈虚，腠理愈不固，外邪更易侵袭，一再重感，寒热何由得解。施师治疗此病，以玉屏风散合桂枝汤、四君子汤为主，和营卫，补中气，腠理固密，外邪难侵。

温邪内伏案

马某，男，61岁，出诊。

病已四月，反复发热不退，曾自购成药服用未见效果。体温在39℃左右，头痛如裂而晕，口渴多饮，大便稀溏灼热，小便短赤，烦躁不安，时发谵语。舌质红，苔黄厚，脉数。

辨证立法：温邪内伏，蕴结不解，所以历久发热不退。当以清热为主佐以透邪，基本以七清三解法治之。

处方：白茅根 12 克，金银花 10 克，桑叶 6 克，白茅根 12 克，金银藤 10 克，桑枝 20 克，煨葛根 6 克，酒黄连 4.5 克，赤芍 10 克，酒黄芩 6 克，赤茯苓 10 克，薄荷 4.5 克，炒香豉 12 克，炒山栀 6 克，草梢 3 克，龙胆草（酒炒）6 克，蔓荆子（炒）4.5 克。

二诊：服药二剂，汗出头痛减，大便泻已止，小便量增多，色深黄，口渴多饮，体温 38℃，仍作谵语，咳嗽气促，舌红苔垢。防转肺炎，拟清凉透邪佐以止咳化痰为治。

处方：白茅根 15 克，酒黄芩 10 克，炙前胡 4.5 克，白茅根 15 克，酒黄连 4.5 克，炙白前 4.5 克，生石膏 15 克，炙紫菀 4.5 克，桑叶 6 克，肥知母 6 克，炙化红 4.5 克，桑枝 18 克，淡竹叶 10 克，蔓荆子（炒，布包）6 克，赤芍 10 克，节菖蒲 4.5 克，赤茯苓 10 克，粳米（布包）100 粒。

三诊：服二剂，发热渐退，体温不及 38℃，口渴多饮，小便短赤，汗出如蒸，神识清楚，但仍烦躁，舌红，苔黄已不厚，脉稍数。温邪初退，不宜汗解，应导之由小溲而去。

处方：赤茯苓 12 克，朱寸冬 6 克，冬瓜子 12 克，赤小豆 12 克，朱茯神 6 克，冬葵子 12 克，淡竹叶 10 克，炒远志 10 克，白通草 4.5 克，车前草 10 克，金石斛 6 克，瓜蒌根 10 克，车前子 10 克，鲜石斛 6 克，瓜蒌皮 10 克，节菖蒲 4.5 克，炙草梢 3 克。

四诊：热退至常温，神识清楚，除觉体倦无力及食欲不振外，余无他症。拟养阴开胃作善后处理。

处方：北沙参 10 克，鲜生地 10 克，鲜石斛 10 克，朱茯神 10 克，淡竹叶 10 克，冬瓜子 10 克，朱寸冬各 10 克，佩兰叶 10 克，冬葵子 10 克，旋覆花（布包）6 克，节菖蒲 6 克，炒远志 10 克，半夏曲 10 克，炙草梢 3 克。

按：本案为年事已高，又罹温邪内伏发热不退之证。初诊用葛根黄芩黄连汤及栀子豉汤加减，以清热为主佐以宣透之味，二诊以新加白虎汤为主治之，加强清凉透热作用，三诊清热为主，养阴为辅，四诊则反之，养阴为主清热为辅。温邪蕴久最易伤阴，不可过汗过下，惟以导邪由小溲而出，始较妥帖，三诊中重用利尿之药，达八味之多，充分体现施师退热时，采用引邪由水道而出的特点。

施师组方时，既突出重点又照顾全面，二诊在清凉透热时佐以止咳化痰的前胡、白前、紫菀、橘红消除咳嗽症状，以防微杜渐。四诊主要养阴扶正，又用半夏曲化痰开胃，佩兰叶醒脾化湿，善后处理十分周到。本案虽属年高病久，每诊法随证变，治法很有条理，配伍颇具匠心，遂使四个月不退之热，四诊而愈。

暑湿案

高某，女，56岁，病历号51，8，634。

盛暑酷热，贪食生冷，院中乘凉，深夜始睡。今晨忽腹痛如绞，腹泻四次，恶心呕吐，不思食，头痛微热，腰酸身倦。舌苔薄白，六脉濡数。

辨证立法：外感暑湿，内伤寒滞，互阻中焦，胃失和降，故呕吐不食。脾乏健运，因以腹泻。即予祛暑、利湿、和胃、健脾法治之。

处方：藿香梗4.5克，苍术炭10克，扁豆花6克，苦桔梗4.5克，白术炭10克，扁豆衣6克，姜厚朴6克，广陈皮4.5克，云茯苓10克，白通草4.5克，炒薏仁12克，姜半夏6克，炒香豉10克，干芦根12克，炙草梢3克，大红枣3枚，鲜生姜3片。

二诊：服药二剂，呕吐腹泻均止，但觉胸腹不适，食欲欠佳，全身酸软无力，头已不痛，但觉晕。

处方：云茯神10克，厚朴花4.5克，野於术4.5克，云茯苓10克，玫瑰花4.5克，陈皮炭6克，佩兰叶10克，益元散（用鲜荷叶包煎）10克，炒枳壳4.5克，扁豆花10克，苦桔梗4.5克，扁豆衣10克，炙草梢3克。

按：夏日暑湿熏蒸，脾胃不健，复加贪食生冷，乘凉感寒，致使脾胃升降失调。泄泻之病，盛暑多见，良由是故。本案化裁藿香正气散方，药服两剂，吐泻均止，二诊则以开胃和中为善后。

暑风案

张某，女，62岁，病历号51，8，205。

昨日急急出城探视女病，烈日当空，途中亦未少休，当晚又赶回城内，劳苦乏倦，在院中乘凉时竟然入睡，夜间即感周身酸楚无力，今晨已觉发热，头晕，自汗，口干不思饮，恶心不欲食，大便两日未解。舌苔薄白，六脉濡数。

辨证立法：白昼外出受暑，夜晚乘凉感风，是为伤暑之证。患者年逾六旬，体力本已不足，更易受暑感风，急拟清暑热祛风邪为治。

处方：鲜佩兰10克，鲜苇根15克，厚朴花6克，鲜藿香10克，鲜茅根15克，玫瑰花6克，鲜薄荷6克，嫩桑枝18克，冬桑叶6克，益元散（鲜荷叶15克包煎）15克，川郁金6克，半夏曲6克，酒黄芩6克，建神曲6克，酒黄连3克。

按：王安道云：“暑热者，夏之令也，大行于天地之间，人或劳倦，或饥饿，元气亏乏，不足以御天令亢极，于是受伤而为病。”长夏酷暑常见此类病案，不外受暑感风或受暑感寒。《素问·王运行大论》云：“在天为热，在地为火，……其性为暑。”暑热最易伤津耗气。夏日伤暑，发热有汗者，多为受暑感风，辛凉轻宣，散风清热即可，不可用温热发散之药，以免重虚其表，愈伤津气。施师即以清暑祛风、芳香化浊为主要治法，患者服药二剂即愈。佩兰、藿香、苇根、茅根、薄荷、荷叶均用鲜者，取其清新之气，清暑生津力强。

（选自《现代著名老中医名著重刊丛书·施今墨临床经验集》，人民卫生出版社2008年版，1~14页）

治流行性感冒医案

赵左，年二十余岁。身体素健，昨日感受风寒，发热39.5℃，脊背时冷，头痛，身痛，四肢酸楚，胸闷，食欲不振，大便干，小

便赤，拟用退热祛风法。

鲜芦根一两，鲜茅根五钱，桑叶二钱，桑枝八钱，蔓荆子钱半（炒），白僵蚕钱半（炒），薄荷梗钱半，山栀钱半，淡豆豉四钱，苦桔梗钱半，白杏仁二钱，薤白二钱，青连翘三钱，金银藤四钱，炒芥穗钱半，枳壳钱半。

方义：本方以苇根、茅根、山栀、豆豉退热；芥穗，薄荷、桑叶、蔓荆子、白僵蚕祛风治头痛；桑枝治身痛及四肢酸楚；连翘、金银藤清热解毒通络；苦桔梗、炒枳壳、薤白、杏仁通调腑气。

二诊：服药后，热退痛除，惟食欲仍未思进，头时晕沉，拟清内热、调胃肠法。

厚朴花、代代花各钱半，酒条芩二钱，赤茯苓三钱，赤芍药二钱，佩兰叶三钱，焦内金三钱，炒谷麦芽各三钱，苦桔梗钱半，炒枳壳钱半，白杏仁二钱，薤白头二钱，青连翘三钱，天花粉二钱。

方义：芳香化浊法，可开胃口，故用厚朴花、代代花、佩兰叶；消除积滞用焦内金及谷麦芽；以条芩同赤茯苓、赤芍药、连翘、天花粉清其余热；桔梗、枳壳、杏仁、薤白通调胃肠。

（选自《近代中医珍本集·医案分册·施今墨医案》，浙江科学技术出版社2003年版，969~970页）

费伯雄

论治时病

营分受寒，治宜温里。

全当归，酒白芍，上肉桂，金香附，覆盆子，小茴香，小青皮，大丹参，台乌药，怀牛膝，煨姜，莽饼。

风热上壅，先宜疏解。

老苏梗，薄荷叶，粉葛根，白茅根，荆芥穗，赤茯苓，新会皮，白蒺藜，连翘壳，香豆豉，甘菊花，夏枯草，淡竹叶。

时毒重症，姑拟清解。

酒川连四分，紫马勃六分，粉葛根二钱，大力子二钱（打），赤茯苓二钱（青黛拌），白茅根五钱，连翘壳二钱，夏枯草一钱，天花粉二钱，生姜皮二钱，竹叶十张。

祖怡注：此症偏身发斑，大者如拳，小者如豆，舌本老黄，边尖黄色。

夹滞春温，姑拟和解。

川雅连，车前子，粉葛根，粉丹皮，广藿香，淡吴萸，连翘壳，瓜蒌仁，青防风，陈广皮，荸荠，白茅根，薄荷叶，细青皮。

春温重症，先宜疏解。

广藿梗一钱，车前子二钱，制半夏一钱，细青皮一钱，陈广皮一钱，粉葛根二钱，焦谷芽三钱，淡豆豉三钱，薄荷叶一钱，赤茯苓三钱，净连翘一钱半，佛手片五分，白茅根五钱。

时邪发呃，宜降逆和中。

酒炒黄连，淡吴萸三分，赤茯苓三钱，广藿梗一钱，新会皮一钱，制半夏一钱半，广木香五分，春砂仁一钱，佩兰叶一钱，白蒺藜三钱，粉葛根二钱，佛手片五分，姜竹茹五分。

邪滞结胸，壮热，神昏谵语，舌焦起刺，面目红赤。此热入包

络、滞郁胃中所致。症极沉重，姑拟清神导滞，以望转机。

大丹参二钱，真琥珀一钱，柏子仁二钱，川雅连五分，江枳壳一钱，黑山栀一钱，薄荷叶一钱，川厚朴一钱，连翘壳一钱半，细青皮一钱半，灯心三尺，荸荠三枚。

（选自《近代中医珍本集·医案分册·孟河费氏祖孙医案》，浙江科学技术出版社2003年版，505～506页）

费绳甫

论治伤寒案

伤寒热入胃中，与糟粕相结，则为口渴引饮，谵语无伦。热入血室，则为昼则明了，暮则谵语，如见鬼状。温热湿温，阳明散漫之热，熏蒸心包，则为口渴引饮，谵语无伦，神识乍清乍昏。是凡见以上诸症，罔不由于热者也。温热湿温，固为热邪，即系伤寒，亦必在寒邪已化热之后，历古至今，几若印版文字矣。而自余诊广东郭映堂少君之症，竟有不然者。

郭君住南市杨家渡，其少君鋈益，年十三岁，丁未七月十五日，发热头痛，大便泄泻，八九日不退，驯至口渴引饮，神识乍清乍昏，谵语无伦，入夜尤甚，始就治于余。诊其脉，仅浮弦，并不洪数。苔白滑润，满布至尖，舌并不绛。且病逾一候，尚点汗未得，断为外感风寒，失于温散所致。然风寒着人，人身中温暖之阳气，本有化邪为热之能力，且已发热至八九日，乃外显热象而内实未化热者，必前手误用栀豉、银翘，温热治法，遏抑其邪，邪不得越所致。凡寒邪所至之地，皆阳气不到之处，阳气不得行于营卫之间，而但周旋进退于脏腑之中，则是阴反在外，阳反在内。人身之有阳气，犹天之有日光。阳为阴掩，犹之日为云遮，其光不显，故神识乍清乍昏也。谵语无伦，入夜尤甚者，夜则营卫行于阴，阴盛则阳愈受枯，不与阴和，反与阴争也。渴而引饮者，凉药助其湿痰，湿痰碍其运动，浊饮不去，则津液不生也。病因于寒，邪不在里，但用辛温之剂，使遏抑之风寒外达，内停之痰湿渐消，则一切假热之症，皆能自退。处方以防风二钱，荆芥钱半，苏梗二钱，苍术一钱，厚朴一钱，半夏钱半，广皮一钱，茯苓二钱，甘草五分，另以葱白二钱为引。两剂而泄泻即止，头痛口渴神昏谵语皆减，惟汗出不畅，热退未清耳。即前方加桂枝一钱、羌活一钱、生姜三

片，又两剂而得畅汗，热退尽，神识清，谵语止，白苔化，风寒痰湿，一律肃清。改用生津益气，善后而痊。此病下手，本当即用姜、桂，则凉药遏抑之寒邪，易于外解，以神昏谵语，且兼口渴，举世莫不以为然，虽用药者独具真知灼见，自信不谬，能保病家之不疑而他图乎？惟先用轻淡之品，使稍见功效，而后加重，则病家之心安。而吾辈救人之志遂矣。粗工不察，以及热症，治以寒凉，转遏转深，转深转郁。待郁久化热，则弄假成真，逼人心包，温之则劫阴，凉之则增遏，即用开达，亦多不及矣。余故尝曰，治病必先辨证，辨证须辨兼证。徐洄溪谓有一症不具，即须审慎者，固难为见病治病、知常不知变者道也。

上海吴君仲祥之妻，患伤寒，先恶寒而后发热无汗，苔白头痛。医用寒凉药，即胸脘闭塞，呼吸之气难以出入，势濒于危，急延余诊，右手脉已不应指，左寸关尚浮弦，风寒已伤营卫，加以寒凉遏抑，引邪入里，伤及中阳，气道不通。向来阴虚痰重，不胜麻桂，遂用防风二钱、荆芥钱半、苏梗二钱、葱白二钱、半夏钱半、橘红一钱、杏仁三钱、厚朴一钱、甘草五分，一剂，胸脘即舒，气道流通。再剂，汗出热退而愈。

上海王君佐才，恶寒发热，头项强痛，牵及腰背，无汗苔白，脉来浮紧，太阳经寒伤营证也。与麻黄一钱，桂枝一钱，酒炒羌活一钱，苦杏仁三钱，甘草一钱，生姜三片，一啜而病悉退。

广东郭君道斋，发热无汗，头痛如劈，至于如厕仆地，呼号不已。急延余诊，脉来浮弦而紧，亦太阳经寒伤营证也。先以藁本、川芎、羌活、防风各三钱，浓煎，纳面中浸令透，即起绞干，乘热熨其头，巾仅两易，而痛顿止。更与酒炒羌活钱半，防风三钱，荆芥三钱，甘草八分，煎汤饮之。一剂即汗出热退，其病若失。其尊人仁山曰，病来甚急，而势甚险，先生治之，药甚轻而效甚速，能不令人倾倒。余曰，此本麻黄汤证，麻黄之效诚速，而执事未必敢用，以此等轻药重投代之，执事不疑，而效亦未尝不速也。

常州杨君廷选之夫人，发热头痛，恶寒无汗，呕吐泄泻，胸腹痛不可忍，苔白润，脉浮弦而缓，此内有寒湿，而外感风寒也。风寒非温散不解，其治在经；寒湿非温燥不化，其治在腑。乃参用麻

桂平胃法，与酒炒羌活一钱，防风钱半，荆芥钱半，苏梗钱半，焦茅术钱半，川厚朴一钱，赤茯苓三钱，陈皮一钱，甘草五分，生姜三片，一剂，表里之症悉退而愈。

孟河金奎官，发热，有汗不解，脘痞作痛，神昏谵语，时常痉厥，口干苔黄，中心灰黑厚腻。医皆束手无策，请余诊之，脉来沉实而滑，此阳明内热，非急下存阴，不能挽救。遂用酒炒大黄五钱，芒硝三钱，枳实一钱，厚朴一钱，一剂，大便畅行二次，热退神清，痉厥皆止。以粳米熬粥，缓缓与服，约两日，即知饥而痊。

旧仆闻金兆，童时病发热神昏，肢厥不语，自丙子年除月初，迄明年元宵，幼科百方治之而无效，请治于余。余奇其神昏发厥之症，而能延至四十日之久也。视之，倦卧向里，略无躁扰之象，按脉豁大而空，乃太阳少阴两感之症，日久传入厥阴，外热里寒，热为假象，寒是真情，幸其头面无汗，有汗则早已亡阳而不可救矣。急与制熟附三钱，炮姜炭三钱，上肉桂一钱，党参三钱，白术一钱，甘草五分，覆杯即厥回神醒。其父狂喜，走告以状。余曰，未也，趋再饮之，不尔将复厥。其父半信半疑，奔而视之，果又厥矣，急煎第二剂饮之，乃复醒，不再厥。正气既回，托邪有权，汗出而热亦随退，以食养为调理，月余而康。

广东林君子钦，患感甫解，忽又受寒，壮热恶寒，脉盛而神气大惫不能支。盖前此邪退正虚，未及善后进补，复感新邪，邪气虽实，而正气已虚。凡泄邪必须散发，而欲宣布发散之药力，则全赖正气。今正气如此之虚，复何所恃以为宣布发散药力之具。然则徒散既虑其正脱，纯补亦惧其邪锢，仲圣桂枝加人参法，一面散邪，即于散药之中，一面补正，此其治矣。与桂枝一钱，别直参一钱，杭白芍一钱，甘草一钱，生姜二片，大枣二枚，一剂得汗热退，精神复振，不烦调理而愈。

相任注：自以上诸案观之，可见孟河费氏也是很能用经方，很能用温燥药的。

（选自《近代中医珍本集·医案分册·孟河费氏祖孙医案》，浙江科学技术出版社2003年版，525~530页）

治感冒案

缉卿生母孔夫人，病感冒，医用发散太过，阴液伤残，心悸不能自恃，内热口干，头眩耳鸣，神倦自汗，夜不成寐，每日只饮米汤数匙，其势更危，延余诊之。脉来弦细，阴血亏损已极。倘汗多气促，即是脱象。遂用西洋参三钱，麦冬三钱，白芍钱半，甘草五分，石斛三钱，小麦五钱，红枣五枚，连进三剂，诸恙皆减。照方加大生地三钱，服十剂而安。

吴仲祥之子德如，发热头痛，口干腹痛，诊脉浮弦急滑，外感风热，内停湿滞。方用牛蒡子钱半，薄荷叶一钱，香豆豉三钱，冬桑叶一钱，粉甘草五分，神曲四钱，香谷芽四钱，淡竹叶三钱，一剂汗出热退，便通而痊。

徽州曹君物恒，略受外邪，而不自觉。医用补药数剂，遂发热喉痛，口干胁痛。予诊脉浮弦，邪热自气灼营，法当清透。方用牛蒡子一钱，薄荷一钱，马勃八分，瓜蒌皮三钱，桑叶钱半，连翘钱半，丹皮二钱，象贝母三钱，甘草五分，竹叶三钱，连进两剂，汗出热退，喉痛胁疼皆止，邪从汗解。惟津液暗亏，口干便结，不思饮食，夜不成寐，用甘凉益胃而安。沙参四钱，麦冬三钱，白芍钱半，甘草五分，石斛三钱，天花粉三钱，茯神二钱，生谷芽四钱，此养胃阴法也。

佚名，初诊：感受风寒，挟素蕴之湿痰，阻塞气机，肺不清肃，胃不宣通，脘闷腹痛，二便不甚通利，呕吐痰水，肢节阴酸，神倦力乏，脉来浮弦。治宜泄邪化痰，肃肺和胃。

老苏梗三钱，冬桑叶一钱半，酒川连二分，淡吴萸二分，冬瓜子四钱，薄橘红八分，淡竹茹一钱半，光杏仁三钱，白茯苓三钱，生谷芽四钱，熟谷芽四钱，荷梗一尺。

二诊：风邪外解，营卫流行，恶寒发热已退，惟知饥少纳，头昏神倦，胃气未和，宣布无权。调和胃气，不外甘平，脉来细弱，治宜甘平养胃。

人参须五分，北沙参四钱，大白芍一钱半，粉甘草五分，白茯苓三钱，女贞子三钱，甜川贝三钱，瓜蒌皮三钱，薄橘红八分，冬

瓜子四钱，生谷芽四钱，熟谷芽四钱，红枣五枚。

佚名，初诊：外感风邪，内挟食滞，淆乱清浊，升降失常，大便泄泻，少腹作痛，头眩且胀，口干苔白，脉来弦细。虚体受邪，必以祛邪为先，外解风寒，内消食滞，清浊自分，邪退正安，河间治法，不外乎此。宜泄邪消食，升清降浊。

老苏梗一钱半，嫩桔梗一钱，粉葛根二钱，生甘草五分，六神曲四钱，江枳壳一钱，赤茯苓二钱，冬瓜子四钱，川通草五分，车前子二钱，川石斛三钱，香连丸一钱，生熟谷芽各四钱，荷叶一角。

二诊：进泄邪消食、升清降浊之法，发热已退，邪从外。惟内陷肠胃之邪，因体虚气弱，难以外透，挟食滞耗气灼营，泄泻转为痢疾，红白俱下，少腹作痛，舌苔白腻，口不作干，脉来弦细。脉症细参，正虚邪陷，非养正透邪，下痢安有止期！症势非可轻视，治宜补散兼行，佐以消导。

嫩桔梗一钱，粉葛根二钱，荆芥穗一钱，吉林参须一钱，赤茯苓二钱，茅苍术一钱，焦山楂三钱，六神曲三钱，大腹皮二钱，陈广皮一钱，青防风一钱，生白术一钱，江枳壳一钱，生甘草五分，荷叶一角。

三诊：湿热已化，清升浊降，下痢已止，大便虽溏颇畅。前日用宣散之剂，风邪乘虚而入，遏抑营卫，内热口干，余邪未清，胃失降令，脉来弦滑，治宜清余邪，甘润和胃。

淡豆豉二钱，黑山栀二钱，川石斛二钱，赤茯苓三钱，冬瓜子四钱，生甘草五分，象贝母三钱，广皮白八分，生熟谷芽各四钱，鲜荷梗五寸。

游桂馨之如夫人，感冒解后，内热心悸，口干头晕，夜不成寐，大便燥结，每日只进米汤数匙，卧床不起，已经月余。延余诊之，此胃阴虚而气不下降，两手脉来皆沉细无力，治必清养胃阴，方能挽救。遂用北沙参四钱，麦冬三钱，白芍钱半，甘草三分，石斛三钱，川贝母二钱，大玉竹三钱，甘蔗四两，芦根二两，陈广皮一钱，连进三剂而病减，再进三剂而愈。

（选自《近代中医珍本集·医案分册·孟河费氏祖孙医案·感冒》，浙江科学技术出版社2003年版，531～533页）

治春温案

上海丁顺兴之室病发热鼻衄，作恶呕吐，咳嗽口甜，饮食不进，脉来细弦，势濒于危。痰热内蕴，风邪外袭，肺胃肃降无权，法当表里并解。方用荆芥一钱，白茅根三钱，酒炒黄连二分，吴萸一分，象贝母三钱，佩兰叶一钱，川石斛三钱，鲜竹茹一钱，冬瓜子四钱，生熟谷芽各四钱，服二剂，汗出热退，鼻衄止，口甜呕吐皆减。照前方去荆芥、茅根，加南沙参四钱、甜杏仁三钱、薄橘红五分，连服六剂而安。

上海王荣生发热汗出不解，口渴引饮，苔黄溺赤，目赤流泪。余诊其脉弦滑洪数，邪热灼津，津伤热炽。方用生石膏八钱、薄荷叶一钱、银花三钱、连翘钱半、酒炒黄芩钱半、酒炒黄连三分、牛蒡子钱半、丹皮二钱、天花粉三钱、象贝母三钱、冬桑叶钱半、生甘草五分、竹叶三钱、芦根四两，连进三剂，汗出热退而痊。

广东陈君荫堂病春温，发热头痛，口渴引饮，咳嗽苔黄，胸腹作痛，食难下咽，小便赤色，夜不成寐。予往诊之，脉极弦细，津液已伤，邪热阻气灼阴，肺金清肃无权，胃气流行失职。治宜生津清热，苦降辛通。方用石斛三钱，天花粉三钱，黄连三分，吴萸一分，桑叶钱半，蝉衣一钱，甘草五分，竹茹钱半，冬瓜子四钱，生熟谷芽各四钱，光杏仁三钱，进一剂，汗出热退，头痛腹疼皆止。照前方去蝉衣，加南沙参四钱、甘蔗二两，连服三剂，苔黄已退，口渴引饮亦止，饮食渐进而痊。

江宁马月樵之夫人发热，有汗不解。医误认为伤寒，用桂枝、麻黄、葛根、柴胡等类，病转剧，口渴引饮，大便溏泄。更医误认为暑湿，用香薷、藿香、青蒿、厚朴等类，势转危，咳嗽咯血，间或神昏谵语，乃邀余诊。脉弦数洪大，此温邪犯肺，津液受灼，邪热不从外泄，内蒸包络，幸未传入，尚可设法。方用银花三钱，连翘三钱，酒炒黄芩钱半，酒炒黄连三分，薄荷一钱，桑叶一钱，丹皮二钱，甘草三分，天花粉三钱，石斛三钱，冬瓜子四钱，芦根四两，连进两剂，汗出热退，神识清楚。再进二剂，咳血皆止，大便

亦调。惟口干不思饮食，夜寐不甚酣畅，此邪热清而胃阴虚也。改用沙参四钱，麦冬三钱，石斛三钱，白芍钱半，甘草三分，连进三剂，眠食俱佳而康。

处州镇台班馥垒之子缉卿发热，有汗不解。医用发散清导，遂壮热便泄，口渴引饮，苔黄耳聋，头眩肢掣，势甚可危，乃延余诊。脉来洪大滑数，此邪热灼津，津伤液耗，倘肝风内动，即有痉厥之虞。方用石膏八钱，银花三钱，连翘三钱，桑叶一钱，天花粉三钱，石斛三钱，甘草五分，冬瓜子四钱，竹叶三钱，芦根四两，连进二剂，热退泻止，头眩肢掣皆减。邪热已解，而津液内损，宣布无权，口干耳聋。照前方去石膏、银花、连翘，加南沙参四钱、川贝母三钱、麦门冬三钱，服五剂痊愈。

贵州刘子贞发热咳嗽，痰黄口干，舌苔黄腻，溲赤便结，心烦懊恼，难以名状，已经一候不解，势甚可危。请余诊之，脉来浮弦滑大，此邪热销烁津液，必须生津泄邪，令津液宣布，托邪尽泄于外。遂用冬桑叶一钱，薄荷叶一钱，银花三钱，连翘钱半，山梔钱半，香豆豉二钱，象贝母三钱，天花粉三钱，生甘草一剂，汗出一昼夜不止。病家骇甚，恐汗脱难救，请用止汗之法。余慰之曰，邪热非汗不解，现汗出热退，邪从汗泄，此汗多正是病之出路，断不可止。且脉息业已安静，绝无汗脱之虞。宜进粥以和胃气，候邪尽，汗自止。明日果如所言，汗止而热退尽，心烦懊恼、咳嗽口干皆止。改用石斛三钱，南沙参四钱，川贝母三钱，天花粉三钱，生甘草三分，冬瓜子四钱，二剂而康。

镇江严紫澄发热烦躁，口渴苔黄，彻夜不寐。余诊脉弦数，此邪热灼津。方用石斛三钱，花粉三钱，豆豉三钱，山梔钱半，银花三钱，连翘钱半，甘草五分，薄荷一钱，牛蒡子钱半，象贝母三钱，冬瓜子四钱，竹叶三钱，芦根二两。一剂热退，再剂痊愈。

安徽蒯光辅之室患春温，咳嗽发热，热盛时神昏谵语，口渴引饮，苔黄溺赤，脉来弦数。邪热灼津，从肺熏蒸包络，与邪入包络迥殊，芳香宣窍万不可投。遂用黄连三分，黄芩一钱，山梔钱半，豆豉三钱，薄荷一钱，蝉衣一钱，川石斛三钱，生甘草八分，鲜竹茹钱半，银花三钱，连翘钱半，杏仁三钱，连进两剂，汗出热退，

咳止神清。惟心悸头眩，眼花神倦，邪退阴虚已著。改用西洋参钱半，川石斛三钱，生甘草八分，天花粉三钱，川贝母三钱，鲜竹茹一钱，桑叶一钱，生谷芽四钱，连服三剂而愈。

南京沙聚东之弟发热肢掣，神昏谵语，诊脉弦滑而数，此邪热不从外泄，内陷包络。用牛黄丸一钱，开水化服，神识即清，谵语亦止。惟发热口干，络邪已退，邪热仍灼肺津。用牛蒡子钱半，薄荷叶一钱，冬桑叶一钱，净连翘钱半，净银花三钱，川贝母三钱，天花粉三钱，鲜竹茹钱半，鲜芦根二两，连服二剂，汗出热退而安。

苏州王子咸之室发热神昏，口噤不语，红疹满布，脉来弦大。此邪热不从外泄，内陷包络，非用芳香宣窍，安能通其内闭。至宝丹一钱，开水化服。汗出热退，神清能言，红疹仍发，口渴引饮。络邪外透，余邪留恋，销烁津液。用冬桑叶一钱，薄荷一钱，蝉衣一钱，牡丹皮二钱，牛蒡子钱半，净银花三钱，天花粉三钱，生甘草五分，冬瓜子四钱，光杏仁三钱，川通草五分，鲜竹茹钱半，两剂而安。

常州王禹臣之长女发热神昏，口噤发厥，来势颇险，诊脉浮弦洪大，邪热从肺逆传心包。用紫雪丹五分，开水化服。热退神清，厥止能言。惟脘满作恶，大便不通，络邪已泄，而阳明邪滞交阻。用黄连三分、竹茹一钱、法半夏钱半、瓜蒌仁三钱、苦杏仁三钱，大便畅行，胸脘宽舒，阳明邪滞皆清，而余邪留恋少阳，寒热往来。用柴胡一钱，酒炒黄芩一钱，法半夏钱半，甘草三分，天花粉三钱，寒邪即止而愈。

（选自《近代中医珍本集·医案分册·孟河费氏祖孙医案》，浙江科学技术出版社2003年版，533~536页）

治冬温案

徽州方君晋三，年已六十六，病冬温。医因年老体虚而用清补药，致禁锢邪热，壮热无汗，咳嗽口渴，苔黄谵语。予诊脉浮洪数大，邪无出路，热蒸包络，症情已著。治当生津泄邪，否则内陷，

恐难挽回。方用牛蒡子钱半，薄荷一钱，豆豉三钱，银花三钱，连翘三钱，杏仁三钱，天花粉三钱，甘草五分，石斛三钱，竹茹一钱，蝉衣一钱，芦根二两，进一剂，汗出热退，邪从汗泄。惟余热留恋营分，喉痛谵语，夜寐不安。改用玄参一钱，鲜生地四钱，丹皮二钱，瓜蒌皮三钱，茅根二钱（去心），马勃八分，石斛三钱，象贝母三钱，杏仁三钱，竹茹一钱，芦根二两，进一剂，营热已清，喉痛谵语皆止，夜寐亦酣。惟咳嗽仍作，痰多不易咯出，口渴引饮，此津液虚而痰热蕴结也。法当甘凉生津豁痰。方用沙参四钱，石斛三钱，天花粉三钱，贝母三钱，杏仁三钱，甘草五分，雪梨五片，甘蔗二两，竹茹一钱，竹沥二两，进二剂，咳止痰少，口和食增，痰热已化，津液宣化。惟阴虚气弱，四肢软弱无力，入夜小溲频数，乃用人参须五分，西洋参钱半，麦冬三钱，甘草五分，白芍钱半，杜仲三钱，女贞子三钱，石斛三钱，黑料豆三钱，薄橘红八分，进二剂，遂告康复。

谭少柳之幕友周善夫，戊寅仲冬，病冬温，热势已退，惟大便不通，神迷谵语，如癫狂状，延余往诊。脉来弦滑，胃中痰热上蒸包络，非用小陷胸汤导痰热下行，恐难挽救。遂用酒炒黄连三分，瓜蒌仁四钱，枳实一钱，川石斛三钱，象贝母三钱，竹茹钱半，荸荠十枚，进一剂，大便通畅，神识顿清。改用甘凉益胃而愈。

（选自《近代中医珍本医集·医案分册·孟河祖孙医案》，浙江科学技术出版社2003年版，540~541页）

贺季衡

论治风温案

先祖对于风温病总的认识，是以陈平伯所云“风属阳邪，不挟寒者为风温”为依据。因此对本病的治疗，常以“风淫于内，治以辛凉，佐以苦，以甘缓之”为原则。对风温的传变，以“风者善行而数变”为论据，结合叶天士关于“温邪上受，首先犯肺，逆传心包”的论述，认为风温病的“数变”，最常见者是为“逆传”，对“逆传”的治疗，需及时运用清营解毒一法（如神犀丹之类），方能收效。

例一，吴男，风温五日，壮热少汗，咳嗽痰鸣，痰色或红或黑，左胁痛，谵妄神迷，少腹拒按，脉滑数，右部不楚，舌苔腻黄。表里同病，有化燥生风之虑。

麻黄八分（后人），大杏仁三钱，净连翘三钱，川通草八分，炒枳实二钱，生石膏八钱（先煎），象贝三钱，青皮二钱，橘红一钱五分，淡子芩二钱，生竹茹一钱五分，鲜芦根一两。

例二，吴童，风痰壅塞肺部，呛咳痰鸣，表热，汗不畅，神迷嗜卧，脉滑数，舌苔腐白。症属非轻，闭逆可虑。

麻黄五分，白桔梗一钱，射干二钱，大杏仁三钱，薄橘红一钱，川通草八分，瓜蒌皮四钱，马兜铃四钱，象贝三钱，法半夏一钱五分，枇杷叶三钱。

二诊：进麻黄射干汤，呛咳痰鸣及表热俱退，昨又饮食欠慎，于是复热，痰鸣呛咳，舌苔满腻。大有闭逆之虑。

莱菔子三钱炒，前胡一钱，炒枳实一钱五分，橘红一钱，象贝三钱，苏梗一钱五分，瓜蒌皮四钱，射干二钱，大杏仁三钱，炒竹茹一钱五分，鲜姜皮四分。

三诊：呛咳痰鸣虽退，而表热仍有往来，右脉尚数。肺胃余邪

未罢，防再反复也。

前胡一钱，苏梗一钱五分，青蒿二钱，橘红一钱，象贝二钱，川通草八分，瓜蒌皮四钱，

大杏仁三钱，炒竹茹一钱五分，法半夏一钱五分，枇杷叶三钱。

按：例一吴男，例二吴童，俱属风温之邪与痰热壅肺，病程较短。共见身热、少汗、呛咳、痰鸣等症。其不同点在于：吴男兼有腑实之症，同时邪将由气入营，故以麻杏石甘汤清宣肺气，配以化痰热、通腑气之品，共组成方，以之祛其化燥之源（痰与热），截其传营之路，此为治理本证的第一步（惜后案未录！）。吴童则兼有痰浊壅塞肺气（舌苔白腐），势将闭逆，故以射干麻黄汤去其温化之姜、辛，加入清化痰热之蒌、贝，温化痰浊之橘、半，意在宣肺化痰为先，防其痰闭而成厥逆。至于吴童二诊时，因“食物欠慎”而致复热，是为节外生枝，所以去麻黄而加入消导之品，是以标本兼顾立法。

例三，孙男，风温热退之后，未能得汗，心烦谵语，气逆呛咳，舌起黄苔，便闭，脉小数。其邪将从内陷，仍防化燥。

麻黄八分，生石膏八钱（先煎），前胡二钱，橘红一钱五分，黑山栀三钱，炙甘草五分，净连翘三钱，炒枳实二钱，川通草八分，梨皮四钱。

二诊：进麻黄石膏汤，热从汗解，谵妄亦清，呛咳未已，便结未通，舌苔黄。邪去滞存之证。

瓜蒌皮四钱，川通草八分，大杏仁三钱，薄橘红一钱五分，炒六曲四钱，炒枳实二钱，苡仁五钱，谷芽四钱，竹茹一钱五分，荸荠三个（打）。

按：本例风温为患，与例一吴男的类似之处，在于肺气不宣，痰热内蕴，将有传陷之变，故亦先以麻杏石甘汤加味。不同点在于本例二诊虽有“便结未通”、“邪去滞存”之说，但立法却未投攻下，而是仿“轻可去实”之意，免致药过病所，“诛伐无过”。二诊病案的保留，使该例更有价值，上载有“热从汗解，谵妄亦清”等，可见前方服后收效较快。

例四，赵男，风温两候有余，表热无汗，呛咳烦扰，鼻衄如注，协热自利，舌心灰黑少津，目瞽神迷或谵语，脉细数无力。热邪伤阴，势已化燥，正在险途。

鲜生地八钱（切），鲜石斛四钱（杵），净连翘二钱，黑山栀二钱，淡子芩二钱，薄荷一钱，正滑石五钱，大杏仁三钱，方通草八分，云神四钱，鲜竹叶卅片。

另：鲜梨可吃。鲜芦根泡汤代茶。万应锭磨搽鼻孔。

二诊：风温鼻衄如注已止，协热下利亦减，表热虽折，而又发白痞，神迷谵妄，舌心灰黑，脉小数无力。邪热伤阴，仍防继续化燥。

南花粉四钱，净连翘三钱，蜜银花四钱，云神四钱，象贝三钱，酒子芩二钱，大杏三钱，益元散四钱（包）。青蒿二钱，黑山栀三钱，白茅根四钱，炒竹茹一钱五分。

三诊：风温鼻衄如注，协热下利先退，白痞亦畅发，惟热清复热，汗无多，合目则谵语，舌黑转黄，脉细数无力。阴伤邪热未透，仍在险途。

香白薇四钱，净连翘三钱，青蒿二钱，瓜蒌皮四钱，益元散五钱（包），川石斛四钱，大杏仁三钱，象贝三钱，云神四钱，炒竹茹一钱五分，梨皮四钱，枇杷叶三钱。

按：本例风温，期延两候余，症见呛咳、烦扰、神迷、舌心灰黑少津等，皆为邪已由卫传气入营之征，且渐有“逆传心包”之象，此时虽兼现表热无汗、协热下利，但立法未泥于“先表后里”或“表里双解”，因所急者已为气、营均热，津、阴俱伤，故亟投甘寒（生地、石斛）苦寒（栀、芩）合法，以使热泄、阴存，先救其急。待二诊时虽热减、衄止，但神迷谵语、舌心灰黑仍在，且又复外发白痞，邪有外透之势，故减少甘寒之品，以防恋邪，增入银花以助清透。三诊时白痞遂畅发，虽又复热，但舌黑已转黄，险象已去大半了。可见此例治法，急投泄热存阴，次进清宣透化，既可截其传营、伤阴之径，又能开其“入营犹可透热转气”之门。此中先后缓急，可谓处理得当。

例五，谢男，风温延绵两旬，内外灼热，得汗不解，呛咳气

粗，痰鸣自利，脉滑数右大，舌前干绛，舌根糙黄。已从燥化见象，症属非轻。

南花粉四钱，生石膏一两（先煎），寒水石五钱（先煎），象贝三钱，肥知母二钱，乌玄参四钱，正滑石五钱，大杏仁三钱，淡子芩二钱，生竹茹一钱五分，活水芦根八钱，煎代水。

二诊：进三石汤加味，内外灼热大减，舌前干绛亦起津，舌根尚黄糙，呛咳痰鸣。可见表邪初退，里热未清，犹虑再增枝节。

南花粉四钱，肥知母二钱，马兜铃一钱五分，象贝三钱，方通草一钱，酒子芩一钱五分，正滑石五钱，薄橘红一钱，大杏仁三钱，大麦冬二钱，生竹茹一钱五分，梨皮四钱。

三诊：风温热退神清，咳未已，痰尚多，两腿烧热，日来又增呃逆，脉虚数，舌苔灰黑已化为红剥。胃阴已伤，不宜再生枝节。

川石斛四钱，大杏仁三钱，陈橘白一钱，生谷芽四钱，柿蒂四枚，瓜蒌皮四钱，旋覆花一钱五分（包），刀豆子四钱，法半夏一钱五分，炒竹茹一钱五分，枇杷叶三钱。

按：本例风温两句，出现肺胃热盛，化燥伤阴之象，故首进三石汤加味，用微苦辛寒以泄热存阴、宣肺化痰。投药后，热减津生，呛咳痰鸣如故，所以转从润肺化痰为主，兼以养阴清热。三诊时，灰黑苔已转为红剥，又增呃逆，其为痰热初化，胃阴已伤，和降失职可知，这和虚寒呃逆不同，故投养阴清热、和胃降逆，以善其后。

三石汤出自《温病条辨》，方由飞滑石、生石膏、寒水石、杏仁、竹茹、银花、金汁、白通草组成。主治“暑温蔓延三焦”，但又指出其适应范围，“虽云三焦，以手太阴一经为要领”。

以上两例同为热盛而致化燥伤阴，其区别在于：赵男是气、营均热，津、阴俱伤，故亟投甘寒、苦寒合法，使其泄热存阴，先救其急；谢男是肺胃热盛为主，故投三石汤之微苦辛寒，以清肺胃之热，使其热减津存。该两例后期发展也有不同，赵男虽津、阴已伤，所幸介于营卫之间，邪热尚能“透热转气”，故在方内增入清宣透化药味，意在“因势利导”；而谢男是在热轻痰化之后，出现胃阴虚而降化失常的呃逆，故只需养阴清热、和胃降逆，即可妥善

其后。

例六，黄男，风温五日，内外灼热，得汗不解，热从内陷，神迷谵妄，循衣摸床，协热自利，咳不爽，痰鸣，脉小数，左手不了了，舌尖红干，苔黄且厚。据此见象，势有化燥生风之害，症属险要。

鲜石斛四钱（杵），淡子芩一钱五分，大杏仁三钱，净连翘二钱，粉葛根二钱，益元散五钱（包），香白薇四钱，云神四钱，半夏曲二钱，炒竹茹一钱五分，灯心十茎（朱染）。

另：神犀丹一小锭，温开水磨服。

改方：去葛根，加黑山栀二钱。

按：本例风温五日，邪热内陷，化燥伤津，逆传心包，故以甘寒、苦寒合法，一以保存阴液，一以直清里热，并急投神犀丹清营解毒，以祛心包邪热。先祖对风温逆传之证，用此法每多显效。

神犀丹出自《温热经纬》，方由犀角、石菖蒲、黄芩、生地、银花、连翘、金汁、板蓝根、香豉、玄参、花粉、紫草组成。治疗温热暑疫初起，或邪不即解，耗液伤营，逆传内陷，见痉厥昏狂、谵语发斑等症。

（选自《贺季衡医案》，江苏科学技术出版社1983年版，1~7页）

袁桂生

温病案

例一

病者：史汉泉君，年约三十余岁，住本镇。

病名：温病。

原因：庚戌四月，吸受温热，病已多日，病家出前医之方示予，盖皆不出银翘散、三仁汤、增液汤之范围，病势日渐增剧。

证候：昏沉不语，面垢目赤，鼻孔如烟煤，壮热烁手，汗濺濺然，手臂搐搦，溲赤。

诊断：两手脉数疾，舌苔黑燥。问不能言几日矣？曰：昨犹谵语，今始不能言，然大声唤之，犹瞠目视人。问近日大便通否？曰：始病曾泄泻，今不大便已三日矣。予谓此热病未用清药，阳明热极，胃家实之病也，非下不可。

疗法：与调胃承气汤合三黄石膏汤加味。

处方：生锦纹三钱，元明粉三钱，炙甘草八分，瓜蒌仁四钱，焦山栀三钱，黑犀角一钱，淡黄芩二钱，小川连一钱，生川柏一钱，生石膏一两。

次诊：接服两剂，竟未得下，惟矢气极臭，溲色若血，神识较清，而身热舌黑如故。

次方：瓜蒌仁六钱（杵），焦山栀三钱，淡黄芩二钱，小川连一钱，生川柏一钱，黑犀角一钱，生石膏一两（研细），炙甘草八分，鲜生地一两，雅梨汁一两，莱菔汁五钱（同冲）。

三诊：热减神清，黑苔渐退，脉息亦较平，时吐黏痰，目睛转黄。遂改用小陷胸汤加芦根、菖蒲等芳香清冽之品，以分消膈中痰热。

三方：瓜蒌仁四钱，小川连六分，仙露夏二钱，淡竹茹二钱，

冬瓜仁四钱，全青蒿钱半，川贝母二钱（去心），石菖蒲钱半，汉木通一钱，鲜茅根一两（去衣），活水芦根二两，以上二味，煎汤代水。

四诊：接服四剂，胸部颈项间遍出白，如水晶珠，腹部腿畔亦发白痞，于是身热全清，知饥进粥，但精神疲弱耳。

四方：西洋参钱半，原麦冬二钱，鲜石斛三钱，生苡仁三钱，川贝母钱半（去心），淡竹茹二钱，鲜枇杷叶三片（去毛，抽筋）。

效果：调养数日，始解黑燥屎数次。当时两进大黄而不下者，盖其戚友中有知医者，潜将大黄减去一钱，每剂只用二钱，故但有解毒之功，而无攻下之力，而奏效亦较缓也。然究胜于粗工之滥用硝黄而僨事者矣。

廉按：此为温病实证，治法初用寒泻，继用清润，终用清养，选药处方，层次一丝不乱，药皆极有力量，似此佳案，堪为后学之师范。

例二

病者：袁尧宽君，忘其年，住本镇。

病名：温病。

原因：庚戌四月患温病，初由章绶卿君诊治，服药数剂，病未大减。嗣章君往江北放赈，转荐予治。

证候：壮热谵语，见人则笑，口渴溲赤，体胖多湿，每日只能进薄粥汤少许。

诊断：脉息滑数，右部尤甚，舌苔黄薄，而干燥无津，盖温病也。热邪蕴伏日久，蓄之久而发之暴，故病情危重若是。

疗法：当以解热为主，而佐以豁痰润燥，方用三黄石膏汤合小陷胸汤加减。

处方：青子芩二钱，小川连一钱，生川柏一钱，生石膏一两（研细），焦栀子三钱，瓜蒌仁四钱（杵），细芽茶一撮，川贝母三钱，青连翘三钱，全青蒿二钱，梨头汁一两（冲）。

次诊：接服二日，热未大退，至第三剂后，乃作战汗而解。但余热未清，复以前方去石膏、芩、连、瓜蒌等品。

次方：焦栀子三钱，青连翘三钱，全青蒿二钱，川贝母三钱，

细芽茶一撮，生川柏一钱，生苡仁三钱，天花粉三钱，北沙参三钱，飞滑石六钱（包煎），活水芦根二两。雅梨汁一两（冲）。

效果：连服数剂，清化余邪，热清胃健而瘥。

说明：凡温病之解，多从战汗，刘河间、吴又可发之于前，叶天士、王九峰畅之于后。证以予所经历，洵精确不易之学说也。盖前人于此，皆从经验中得来，惟必俟服药多剂始能奏功，而作汗之时，必先战栗，其状可骇，医家当此，何可无定识定力耶。

廉按：伏气温病，其邪始终在气分流连者，多从战汗而解。若在血分盘踞者，或从疹痍而解，或从疮疡而解。惟将欲战汗之时，其人或四肢厥冷，或爪甲青紫，脉象忽然双伏，或单伏，此时非但病家彷徨，即医家每为病所欺，无所措手矣。且汗解之后，胃气空虚，当肤冷一昼夜，待气还自温暖如常矣。盖战汗而解，邪退正虚，阳从汗泄，故肤渐冷，未必即成脱证。此时宜令病者安舒静卧，以养阳气来复，旁人切勿惊惶，频频呼唤，扰其元神，使其烦躁。但诊其脉，若虚软和缓，虽倦卧不语，汗出肤冷，却非脱症；若脉急疾，躁扰不卧，肤冷汗出，便为气脱之证矣。故医必从几经阅历，乃有定见于平时，始有定识于俄顷。此案大剂清解，竟得热达腠开，邪从战汗而解，尚属温病之实证。若病久胃虚，不能送邪外达，必须补托，而伏邪始从战汗而出者，亦不可不知。昔王九峰治一人，年及中衰，体素羸弱，始得病，不恶寒，惟发热而渴，溲赤不寐，发表消导，汗不出，热不退，延至四十余日，形容枯削，肢体振掉，苔色灰黑，前后大解共三十次，酱黑色，逐次渐淡至于黄，溲亦浑黄不赤，昼夜进数十粒薄粥四五次，夜来倏寐倏醒，力不能转侧，言不足以听，脉微数，按之不鼓，用扶阴敛气、辅正驱邪法，以生地、人参、麦冬、五味、当归、茯神、枣仁、远志、芦根为剂，服后竟得战汗。寒战逾时，厥回身热，汗出如浴，从朝至暮，寝汗不收，鼻息几无，真元几脱。王仍以前方连进二服，汗收症退，调理而安。

（选自《全国名医验案类编·初集·四时六淫病案》，福建科学技术出版社，269～272页）

春温兼寒案

病者：姚某子，年十五岁。

病名：春温兼寒。

原因：三月间由学校归家，自觉外寒夹内热而发。

症候：恶寒欲睡，旋即发热，头痛身痛，谵语不能识人，口渴溲赤。

诊断：脉滑数，苔白腻。此内热为外寒所束也。

疗法：辛凉轻透，以银翘散合梔豉汤加减。

处方：金银花三钱，青连翘三钱，焦山梔三钱，淡豆豉三钱，苏薄荷钱半，苏叶梗钱半，牛蒡子钱半，苦桔梗一钱，生甘草五分。

先用活水芦根一两，煎汤代水。

次诊：下午四时复诊，神昏谵语如故，身热自汗泱泱然不止，面赤口渴欲饮水，脉息滑而不数，舌苔薄腻，不黄不燥。因思《伤寒论》云：阳明病发热汗多者，急下之。而面赤神昏，又皆当下之症，遂改用小承气汤加味。

次方：生锦纹三钱，川厚朴五分，生枳壳二钱，淡黄芩二钱，青连翘二钱，白知母二钱。

三诊：服后，解大便两次，神清安睡，汗止热解，自能起坐，知饥欲食。其家以为病愈，不复延诊。越三日复发热，有汗口渴，脉滑数。与白虎合小陷胸汤。

三方：生石膏三钱（研细），白知母三钱，生梗米三钱，生甘草五分，瓜蒌仁四钱（杵），小川连四分，仙露夏二钱。

效果：服后热退神清，惟咳嗽痰中带血而已。复与泻白散加黄芩、知母、茅根等，二剂痊愈。

廉按：冬时伏气，随春令温热之气而发，但所发之因不同，有感非时暴寒而发者，有饥饱劳役而发者，有房室不慎而发者。此案春温兼寒，俗名冷温，或称客寒包火。张路玉谓怫郁之热，乘春温之气而发，虽有非时暴寒，止宜辛平之剂发散。初方用银翘散合梔

豉汤加減，微發以解其新邪。迨新邪解後，而伏邪外達，見有下症，放胆用小承氣加味，非熟讀《傷寒論》者不辦。第三方白虎合小陷胸湯亦有力量。惟咳痰帶血，肺經尚有伏熱，故用二皮、芩、知以清肺經之伏火，佐以茅根涼血寧絡，甘草、粳米調養胃氣，剛剛恰好。

（选自《全国名医验案类编》福建科学技术出版社2003年版，302~303页）

钱存济

春温夹食案

病者：张修臣子，年十二岁，住广德北乡。

病名：春温夹食。

原因：初因伤风发热，头痛自汗，不寒而渴，余投以麻杏甘石汤加薄荷、银花，一剂即愈。后因误食鲫鱼半碗，其症复作，他医进以辛燥，病转剧。

证候：目肿如桃，头痛如劈，烦躁谵语，大渴引饮，潮热自汗，小便短数，大便不通，胃胀拒按。

诊断：脉象滑实，舌绛苔燥，合病因脉症参之，此胃实证也。夫外邪初解，胃气必虚，正宜清淡滋养，以生津液，乃不戒于口，恣食荤腥，停滞于胃，复进辛燥，助阳耗液，食积得阳明燥化，致胃经所统属之地，皆结实不通。故目肿头痛者，阳明燥火上冲也。烦躁谵语者，胃热上蒸神经也。大渴引饮者，胃津竭而求救于水也。潮热者，阳明旺于申酉，实则得旺而剧也。自汗者，津液外泄也。小便短数者，津液下逼也。大便不通者，肠有燥屎也。病既内外皆实，自宜急下，以泻悍热之气，而救将绝之阴也。

疗法：以大承气汤原方，先煎枳、朴，继纳大黄，次入芒硝，盖取生者气锐而先行，熟者气钝而和缓之义，欲使芒硝先化燥屎，大黄继通地道，而枳、朴除其积滞，皆所以通泄大肠而逐热也。

处方：厚朴五钱，枳实四钱，大黄四钱，芒硝三钱。

以水三碗，先煮枳、朴取二碗，去滓，纳大黄，煮取一碗，去滓，纳芒硝熔化，顿服。

效果：服一剂，下燥屎数十枚。诸恙霍然，即占勿药。令以米饮调之，一周而愈。

廉按：案语多所发明，选方极为确切，非精研《伤寒论》，胆

识兼全者不办。

(选自《全国名医验案类编》，福建科学技术出版社 2003 年版，293 ~ 294 页)

钱苏斋

风温暴泄案

病者：华镜文室，年三十岁，住苏城皮市街。

病名：风温暴泄。

原因：产后弥月，新感风温，发热咳嗽。第三日经邻医徐某投桂枝汤，乃作暴泄，症势大剧。

证候：泄泻一昼夜十余次，津涸神昏，气促痰鸣，舌苔焦黄干燥，齿板面黧，目闭多眵，身灼热，渴饮无度。

诊断：脉弦而驶，症本风温犯肺，不与清解，反投辛温，肺热下移于大肠，乃作暴泄，《内经》所谓“暴注下迫，皆属于热”也。况产后营液先伤，利多又足亡阴，当此一身津液倾泻无余，非甘寒急救其津液，不足以挽兹危局，若误认为脾病，予以温燥升补之药，必阴下竭而阳上厥矣。

疗法：欲存阴必先止下利，欲止泄必先清肺热。因以白虎汤为君专救肺热，佐以甘凉诸品以救津液，不得谓泄泻之症，忌进寒凉也。

处方：鲜石斛二两，鲜沙参三钱，川贝母三钱，生甘草一钱，生石膏二两，鲜生地二两，鲜竹叶三钱，鲜芦根二两，肥知母三钱，麦冬肉三钱，竺黄片三钱。

又方：塘西青皮甘蔗榨汁一大碗，频频服之。

效果：用大剂甘寒，服竟日，面泄止津回，热解身凉，竟以大愈。后加西洋参、扁豆衣等，两日即痊。

廉按：风温误投桂枝汤，在上者轻则失音，重则咳血，在下者轻则泄泻，重则痉厥。此由鞠通之作俑也，为其所欺以误人者，数见不鲜。今用大剂甘寒以救误，竟得大愈，全在医者之处方对症，用量适当耳，然而幸矣。

风温火逆案

病者：荣锡九，年四十八岁，时住川东永邑五间铺观音桥。

病名：风温火逆。

原因：是年三月，春行夏令，温度太高，继以因公赴县，往来受热，故致此病。

证候：四月一日回家，沉睡昏迷，不省人事。延族兄诊视，以锡九素病吐血，身体极弱，误认为阴寒，进以补中汤，身灼如火。是由火逆，病势一变，幸次日发衄，衄后稍苏。

诊断：自诊脉浮数擎指。浮为风，数为热，身灼热焦痛干燥，此风温证也。

疗法：拟用银翘散加减。风温身灼，焦燥如火熏，非汗不解，焦燥阴伤，汗之反逆，只得养阴，听其自解。

处方：蜜银花三钱，青连翘三钱，大力子三钱，苦桔梗二钱，薄荷三钱，淡竹叶三钱，生白芍三钱，生甘草八分。

效果：此方稳服一星期，胸腋头面稍得汗解，得汗处肌肉便活，以外焦灼如前。将前方去大力，加真川柴胡三钱以为输转。又一星期，腰以上得汗，以下无汗。再一星期，汗至足胫，两足无汗，痛不敢履地。直服到四星期，全身皆得汗解，安好无恙矣。此症原误服补中汤，故缠绵不愈有如此久，然犹幸衄后人苏颇能自主，不然病久不解，未有不东扯西挪寒热杂投者，其为病不知胡底矣。

廉按：病本热厥，妄投补中，岂作中热气脱治耶？不然，何所见而率用提补耶！幸而鼻衄人苏，经治而愈，然亦险而幸矣。

（选自《全国名医验案类编》，福建科学技术出版社2003年版，18~19页）

风温夹食案

病者：吴吉人，年四十九岁，住苏城赛儿巷。

病名：风温夹食。

原因：素体瘦弱，食积易停，温邪由口鼻吸入肺胃，与痰滞胶结而发。

证候：初起表热，一日即解，能食不大便，痰嗽气逆。病届五日，曾陡作胀闷、喘急欲绝，旋即平复。迄十一日晨，始行大便一次，登厕方毕，腹中痛不止，冷汗如雨，气促脉微，昏谵痰嘶，面色晦黯，呼号欲绝。自晨迄晚，连易五医，俱言不治，或仅书生脉散方以固其正。余审其龈腭间有糜腐，与之语神识尚清，中气未夺，按其腹并不拒，但言绕脐剧痛，矢气臭秽而极多，量其热度，只九十八度。

诊断：脉甚细弱，而舌苔焦黄垢腻厚浊。此温邪与痰滞交结，阻塞肠胃间欲下而不得下，故有此剧烈之腹痛也。冷汗频流，此痛汗，非脱汗也。脉虽微细，身虽无热，其人阳气素弱，邪亦不甚，但积滞太多，非一下所能愈者。兹当舍脉从证，先与急下之剂，不可误认为正虚欲脱之证，致犯实实之戒，反致不救也。

疗法：下法宜用汤，汤之言荡也。惟痰热宿滞，皆胶黏之物，淤积既久而又多，非一下即能荡涤无余者。观其满口糜腐、矢气叠转，胃将败而生机未绝。攻下之中又宜相度缓急，分数次以行之。

处方：礞石滚痰丸七钱（包煎），焦六曲三钱，莱菔子三钱，广橘红一钱，海蛤粉四钱，陈胆星一钱，制半夏三钱，炒枳壳一钱，瓜蒌实六钱，光杏仁三钱，山楂炭三钱，芒硝一钱（冲）。

又方：川连七分，楂炭三钱，枳实钱半，制半夏三钱，白杏仁三钱，乌药钱半，苏梗钱半，六曲三钱，槟榔钱半，全瓜蒌七钱，川郁金钱半，大腹绒钱半。

三方：枳实导滞丸七钱（包煎），广橘红一钱，制半夏三钱，莱菔子三钱，白杏仁三钱，苏子三钱，瓜蒌实五钱。

效果：服第一方，下宿垢甚多，腹痛缓，自觉未畅，矢气尚多。与第二方，又解一次，痛止痰平，但自言腹中宿垢尚多。再服第三方，又畅下宿垢甚多，糜腐去而舌苔脱去大半，下露淡红新肉。乃用石斛等养胃法，调理旬余而痊。

廉按：风温夹食，食积化火酿痰，数见不鲜。此案诊断既明，

方亦稳健可法。

(选自《全国名医验案类编》，福建科学技术出版社 2003 年版，25~26 页)

徐小圃

治温病案

潘宝宝

初诊：咳呛经日，重感新风，肌热五日，有汗不解，气急鼻煽，神倦不渴，舌白腻，脉濡滑。气阳不足，肺气闭塞，治以温开，以冀转机。

黄附片三钱，淡干姜一钱，生龙齿一两，川桂枝钱半，黑锡丹四钱，白杏仁四钱，炙细辛七分，活磁石一两，姜半夏三钱，薄橘红钱半，炙紫菀一钱，炙远志七分。

二诊：肺气虽宣，气阳未复，再以两顾。

黄附片三钱，活磁石一两，炙紫菀一钱，黑锡丹五钱，生龙齿一两，炙远志七分，川桂枝钱半，白杏仁四钱，姜半夏三钱，橘红钱半，天将壳五只。

三诊：肺气已宣，气阳尚虚，动辄自汗，气浅，舌白，脉软滑，再以温开。

黄附片五钱，炙细辛一钱，仙灵脾三钱，黑锡丹五钱，五味子八分，煨益智四钱，川桂枝钱半，淡干姜钱半，巴戟天四钱，川朴一钱，橘红钱半，姜半夏三钱，远志七分。

四诊：肌热多汗，起伏不一，咳呛阵作，气急鼻煽，动则更甚，舌白腻，渴不多饮，脉濡滑。阳虚邪恋，治与温下。

黄附片五钱，川桂枝钱半，炒生龙齿一两，黑锡丹五钱，白芍三钱，炒五味子（打）八分，炙细辛一钱，活磁石一两，淡干姜（打）钱半，煨益智四钱，巴戟天四钱，川厚朴一钱，姜半夏三钱。

五诊：热得解，气急鼻煽亦减，咳呛阵作，寐则谵语。舌白脉濡滑，再以温下潜阳。

黄附片五钱，川桂枝钱半，活磁石一两，炙细辛一钱，白芍三钱，生龙齿一两，黑锡丹五钱，朱茯神四钱，煨益智四钱，五味子（打）八分，川厚朴一钱，淡干姜（打）钱半，姜半夏三钱。

杨宝宝

初诊：湿温逾候，肌热有汗，朝衰暮盛，神倦不渴，舌腻脉濡数。邪在阳明，不易霍然。

粉葛根二钱，炒茅术三钱，白蔻花钱半，广藿梗三钱，黄郁金三钱，炒苡仁四钱，川厚朴钱半，白杏仁四钱，赤茯苓四钱，省头草三钱，陈皮二钱，仙半夏三钱。

二诊：湿温旬日，肌热晚甚，舌苔虽化，仍不多饮，脉濡数。阳虚邪恋，再以温下：

黄附片三钱，粉葛根二钱，朱茯神四钱，活磁石一两，川厚朴二钱，黄郁金二钱，生龙齿一两，炒茅术三钱，姜夏三钱，陈皮二钱。

三诊：湿温十有二日，热较轻，舌苔已化，脉息濡数，再以温潜，不变则佳。

黄附片三钱，川桂枝一钱（炒），油当归四钱，活磁石一两，白芍三钱，炒白蔻花钱半，生龙齿一两，朱茯神四钱，砂仁壳钱半，半硫丸四钱，陈皮二钱。

刘宝宝

初诊：湿温逾候，肌热有汗，朝衰暮甚，脘痛欲恶，神倦不渴，舌白腻，脉濡数。邪在阳明，不易霍然。

黄附片三钱，活磁石一两，光杏仁四钱，川桂枝钱半，朱茯神四钱，仙半夏三钱，粉葛根二钱，白蔻花钱半，广陈皮二钱，广藿梗三钱。

二诊：白痞已布，脘痛已止，肌热多汗，舌腻渐化，脉濡数，再以疏化温下。

黄附片三钱，炒茅术四钱，白蔻花钱半，川桂枝钱半，黄郁金三钱，姜半夏三钱，川厚朴一钱，白杏仁四钱，陈广皮二钱，广藿梗三钱。

三诊：湿温旬日，白痞已布，脘痛已止，肌热有汗，舌腻燥

化，渴不多饮，脉息濡数。气阳不足，湿浊留恋，恐其成慢。

黄附片三钱，川厚朴一钱，黄郁金三钱，活磁石一两，姜半夏三钱，朱茯神四钱，生龙齿一两，橘红钱半，白杏仁四钱，仙灵脾三钱。

四诊：湿温逾旬，肌热较轻，舌苔渐化，渴不多饮，脉息濡数，再以前方出入治之。

黄附片三钱，活磁石一两，橘红络各钱半，小川连八分，生龙齿一两，朱茯神四钱，川厚朴一钱，黄郁金三钱，白杏仁四钱，姜半夏三钱，丝瓜络（酒炒）三钱，仙灵脾三钱。

五诊：湿温十有三日，白痞已布，胁痛腑秘，舌黄腻，渴不多饮，脉濡数，右大左弦。邪在阳明少阳之间，再以两顾。

黄附片三钱，川厚朴一钱，黄郁金三钱，炒柴胡一钱，活磁石一两，朱茯神四钱，小川连八分，生龙齿一两，白杏仁四钱，仙灵脾三钱，紫菀一钱，橘络叶各钱半，半硫丸四钱。

六诊：宗前方损益治之。

黄附片三钱，川厚朴一钱，仙半夏三钱，炒柴胡一钱，活磁石一两，橘红络各钱半，小川连六分，生龙齿一两，黄郁金三钱，朱茯神四钱，半硫丸四钱，炒当归二钱。

七诊：湿温十有六日，热得解，腑气未行，舌薄腻，脉濡缓，伤虚湿盛，再以温下。

黄附片四钱，龙齿一两，姜半夏三钱，白杏仁四钱，川朴一钱，橘红钱半，活磁石一两，茅术（炒）三钱，制南星钱半，半硫丸四钱，油当归三钱。

八诊：湿温十有八日，肌热得解，咳呛腑秘，舌中腻，脉濡缓，阳虚湿盛，再以温下。

黄附片（先煎）三钱，白杏仁四钱，油当归三钱，活磁石（先煎）一两，川厚朴一钱，仙灵脾三钱，生龙齿（先煎）一两，橘红钱半，炙远志七分，半硫丸（包）四钱，炙百部钱半。

曾宝宝

初诊：风邪客肺，肺气不宜，咳经旬日，甚则气急鼻煽，肌热不壮，动辄有汗，舌白腻，渴不多饮，脉弦滑，恐其闭塞。

川桂枝八分，薤白头钱半，橘络红各钱半，白杏仁四钱，活磁石一两，紫菀一钱，黄郁金三钱，姜半夏三钱，远志七分，生姜汁十滴，天将壳五只。

二诊：肺气已宣，风邪留恋，咳呛已畅，舌白脉弦滑，再以温开。

炙细辛六分，白芥子八分，橘红钱半淡，干姜七分，白杏仁四钱，紫菀七分，川桂枝八分，姜半夏三钱，远志七分，炙百部钱半，天将壳五只。

吴小姐

初诊：风邪客肺，肌热五日，有汗不解，咳呛便泄，舌白脉濡缓，治以疏化。

川桂枝一钱，薤白头钱半，炙鸡金四钱，白杏仁四钱，姜半夏三钱，紫菀一钱，黄郁金三钱，橘红钱半，远志七分，神曲三钱，生姜二钱。

二诊：热较轻，咳略畅，舌白脉濡滑，再以疏化。

川桂枝一钱，黄郁金三钱，紫菀一钱，白芥子八分，姜半夏三钱，远志七分，白杏仁四钱，橘红钱半，川朴八分，生姜二钱，炙百部钱半。

三诊：宗前方损益治之。

川桂枝一钱，白芥子八分，姜半夏三钱，淡豆豉三钱，黄郁金三钱，紫菀一钱，白杏仁四钱，薤白头钱半，远志七分，炙百部钱半，天将壳五只。

陶宝宝

初诊：风邪客肺，肺气闭塞，肌热一候，有汗不解，咳呛痰鸣，气急鼻煽，神蒙色眇，涕泪俱无，舌白腻，脉濡滑，治以温开，以冀转机。

川桂枝八分，黄郁金三钱，姜半夏三钱，白芥子八分，薤白头钱半，橘红钱半，白杏仁四钱，制南星钱半，川朴一钱，天将壳五只，姜汁十滴，玉枢丹一分。

二诊：热较轻，咳略畅，痰鸣气急，涕泪俱无，舌白腻，脉濡滑，尚在险途，再以温开。

蜜炙麻黄八分，白杏仁四钱，制南星钱半，川桂枝八分，黄郁金三钱，姜半夏三钱，白芥子八分，薤白头钱半，橘红钱半，生姜汁十滴，干菖蒲钱半，天将壳五只，川厚朴一钱。

三诊：热较轻，咳不畅，气急鼻煽，涕泪不多，舌白腻，脉濡滑，再以宣熄，以冀转机。

水炙麻黄一钱，白芥子八分，薤白头钱半，活磁石一两，白杏仁四钱，制南星钱半，生龙齿一两，黄郁金二钱，炒天虫三钱，姜半夏三钱，橘红钱半，天将壳五只，干菖蒲钱半。

四诊：肺气略宣，气阳不足，聪陷环青，舌起糜苔，脉濡滑，再以宣熄温下。

黄厚附片三钱，活磁石一两，白杏仁四钱，蜜炙麻黄一钱，生龙齿一两，黄郁金三钱，黑锡丹四钱，白芥子八分，制南星钱半，干菖蒲钱半，姜半夏三钱，橘皮钱半。

五诊：宗前方损益治之。

黄附片三钱，活磁石一两，白杏仁四钱，川桂枝钱半，黑锡丹五钱，白芥子八分，炙细辛八分，生龙齿一两，黄郁金三钱，制南星钱半，半夏三钱，橘皮钱半。

六诊：病去阳虚，痰多呕恶，舌白脉软，再以温下。

黄附片三钱，生龙齿一两，朱茯神四钱，川桂枝钱半，姜半夏三钱，白芥子八分，活磁石一两，橘红钱半，制南星钱半，炙百部钱半，川厚朴八分，淡干姜钱半。

七诊：阳虚未复，痰渴留恋，舌白脉软，再以温化。

黄附片三钱，生龙齿一两，白芥子八分，川桂枝钱半，姜半夏三钱，制南星钱半，活磁石一两，橘红钱半，朱茯神四钱，木蝴蝶七分，淡干姜钱半，远志七分。

（选自《近代中医珍本集·医案分册·徐小圃先生医案》，浙江科学技术出版社2003年版，888~893页）

徐恕甫

论治温病案

温病伤阴，邪气深入血分，不得任用苦燥

裴左，31岁。病已久羁，邪入下焦，尺脉沉数，日晡身热肢逆，无汗，口渴溺尿，大便干结，数日一行，矢气频转。此下焦积邪黏滞，非养阴清热，荡涤肠道不可。青蒿鳖甲汤能入至阴领邪外出，最为合拍。青蒿鳖甲汤加味：

嫩青蒿二钱，生鳖甲四钱，粉丹皮一钱五分，杭白芍二钱，炒枳壳一钱五分，细生地二钱，细木通一钱五分，川厚朴一钱五分，焦楂肉一钱五分，生麦芽五钱，备急丸三粒，每服药汤下梨汁一杯。

连服二剂，下去黑粪许多，病已向愈。

按：温病余邪留伏阴分，有形积滞内结阳明为此案病机。吴鞠通说：“邪气深伏血分，混处气血之中，不能纯用养阴，又非壮火，不得任用苦燥。”故方中青蒿鳖甲汤入阴搜邪，可使阴分之邪透出阳分而解，用川朴、山楂、麦芽、备急丸以导滞通腑，虽嫌温燥，但有甘寒之梨汁送服，相背相成，亦不失为治。

阳明温病，温邪入下焦，施增水行舟法

袁左，十五岁。病延邪入营分，口干舌燥，神呆懒言，身无大热，诊之脉沉而数，大便矢气。津液受损，兼夹腑实，宜仿温病邪入下焦，增水行舟法治之。一剂舌润神稍清，二剂佐以备急丸七粒下利而愈。药方：

润元参四钱，杭白芍二钱，蜜银花二钱，生鳖甲三钱，细生地四钱，粉丹皮二钱，川黄连一钱五分，生麦芽二钱，梨汁一杯

(冲)。

按：本病为温病入营，阴亏液涸之半虚半实证，故用增液汤增水行舟。吴塘云：“服增液汤已，周十二时观之，若大便不下者，合调胃承气汤微和之。”本案乃取其意不用其方，加备急丸七粒急下而收此同功。方中尚佐以银花、黄连、梨汁等以透邪热，使入营之邪促其透出气分而解，也合叶天士“入营犹可透热转气”之意。

温病神昏，病见危象，勉以大剂三才冀挽回于前

方左，十八岁。热入少阴，神昏谵语，耳聋，脉沉细且数，舌绛而干，不思饮食，病见危象，勉以大剂三才汤冀挽回于前：

天门冬五钱，大生地五钱，杭白芍三钱，莲子心一钱，北沙参一两，杭寸冬五钱，至宝丹二粒。

二诊：服上方二剂，热退身凉，神识清楚，不谵语，能安眠，原方去至宝丹加广橘白二钱。

又服二剂，而全愈矣。

按：本例以热入少阴，逆陷心包为病，耳聋亦可由热陷心营，内闭心包，机窍堵闭之机理予以解释。三才汤以天冬、沙参（原方为人参）、生地三味，因药有天地人三名，而补也在上中下之分，使天地位育，参赞居中，故曰“三才”，功在补肾泻心，健脾开胃，复加用莲心、寸冬清心定志，至宝丹清热开窍，立展神明，三方相配，开窍尤著。二诊时神已转清，遂去至宝丹而增橘白一味，化痰宽中，和胃启脾。本案不用人参而重用北沙参为一两，盖取其滋阴益肺之力，配以开窍至宝丹，对扶正却邪，苏醒神志，功效较著，同时亦为防至宝芳香辛燥，耗阴劫液之弊而设定，斯为用古而不泥。

昏谵，芳香护应中以防内闭，一剂病瘥

庙岗左，二十六岁。病卧兼旬，邪入心包，身微热，口渴，潮赤，入暮昏谵，脉细数。宜芳香护膻中以防内闭，佐以清热。服一剂热减而神清思食。药方：

至宝丹二粒（冲），川郁金二钱，辰砂拌连心麦冬三钱，川黄

连一钱，蜜银花二钱，川贝母一钱五分，小木通一钱五分，细生地二钱，甘草梢一钱，荷叶汁一杯（冲），扁豆花二钱。

按：为热灼营阴，邪陷心包之证。热甚，遂用至宝丹以清心开窍为要着，且用大剂清膈中法以防内闭，一剂病瘳。

（选自《中国百年百名中医临床家丛书·徐恕甫》，中国中医药出版社2001年版，48~51页）

郭士魁

论治发热案

1. 汲某，女，37岁，工人。门诊病人。

1979年2月7日初诊：患者发热恶寒2天，无汗，头痛，全身骨节酸痛，咳嗽，痰少，喉间发堵。检查：体温38.9℃。舌质正常，苔白厚腻，脉浮数。

辨证：外感风寒化热。

立法：辛温解表，稍佐清热解毒。

方用：苏叶6克（后下），杏仁10克，前胡10克，牛蒡子12克，板蓝根15克，荆芥穗6克，薄荷6克（后下），陈皮10克，大青叶15克，甘草6克，芦根12克。

1979年2月10日二诊：进前方一剂，诸症大减，体温降至37.4℃。二剂后体温正常，全身痛除，患者只感胸闷，腹不适，下气多，便干纳差，脉滑数，苔黄厚腻。治以和中健胃化滞。方用：藿香10克，厚朴10克，苏叶6克（后下），大腹皮10克，焦山楂10克，白芷6克，陈皮12克，神曲15克，莱菔子10克，马尾连10克，甘草6克。

进前方二剂，胸闷腹胀除，大便已解，食欲进步，治愈上班。

按：本例为外感风寒化热，以苏叶、芥穗辛温解表；杏仁、前胡宣肺止咳；板蓝根、大青叶、牛蒡子、薄荷清热解毒；芦根养阴清肺；陈皮、甘草调理脾胃，服一剂后体温基本消退，二剂后体温正常，又以和中健胃化滞之剂调理之。

2. 姜某，女，30岁，干部。

1965年8月3日初诊：患者因低烧1年，3个月来间断出现高热而住院。1964年9月始出现低热，头晕，乏力，身酸痛，体温37.2℃~37.7℃，曾在某医院就诊，未找出病因，中西药治疗，体

温仍然不退。1965年6月7日突然高烧，体温 39.8°C ，伴寒战，在某医院看急诊，疑为上感用西药治疗后体温下降。7月11日又有类似高烧发生。两日来又寒战高热，伴头晕头痛，全身肌肉酸痛，有时恶心，纳差，口干，手足心热，或有便溏，尿频，无尿痛、尿急。检查：脉沉细，苔薄黄，体温 39°C 。白细胞 $17000/\text{立方毫米}$ ，中性 59% ，淋巴 36% 。肝功正常。胸透正常。尿常规：红细胞 $10\sim15$ ，白细胞 $5\sim6$ 。尿培养：大肠杆菌阳性。西医诊断：发热待查，慢性肾盂肾炎。

辨证：湿热内蕴。

立法：养阴清热利湿。

方用：生地15克，元参15克，瞿麦12克，冬葵子12克，黄芩10克，篇蓄10克，木通3克，滑石18克，甘草10克，银花12克，车前子15克（包）。

1965年8月12日二诊：进前方二剂体温渐退，现仍有低热 $37^{\circ}\text{C}\sim37.6^{\circ}\text{C}$ ，病人感到疲乏无力，轻度腰酸，无尿频尿急等症。脉细无力，舌苔薄白。仍宗前方加减：生地18克，当归12克，元参20克，山栀子10克，丹皮12克，黄芩10克，柴胡12克，木通5克，冬葵子15克，银花15克，滑石15克（包）。

上方加减服用20剂，体温 37°C 左右，病情明显好转，食欲进步，尿培养已无细菌生长。再以前方加党参15克继服，自10月2日起体温正常，又观察治疗1个月，病人已无自觉不适，尿常规正常，尿培养阴性，于11月6日治愈出院。

按：本例长期低烧达1年之久，证见精神倦怠，口干，手足心热，尿数便溏。尿检有红白细胞，尿培养有大肠杆菌。用生地、元参养阴；黄芩、银花清内热；瞿麦、篇蓄、冬葵子、木通、滑石、车前子清热利湿，此方加减服用50剂，体温正常，尿培养阴性而治愈。

临诊笔录

发热的治疗原则是，有是证而用是药，不拘泥一方一证。病机转了即应易法更方，尤其急性热病，变化快，应随时观察病情，视证用药。郭老临床治疗发热病有以下的方法与原则：

1. 虚劳病人低热，日晡潮热，午后颧红，口干。常用柴胡清骨饮或青蒿鳖甲汤加减治疗。银柴胡 10~12 克，秦艽 10~12 克，地骨皮 10~15 克，知母 10~20 克，青蒿 10~15 克，当归 10~12 克，麦冬 10~12 克，鳖甲 15~30 克，甘草 6 克。

伴咳嗽者加杏仁、枇杷叶、百部，食欲不好者加炒麦谷芽。

2. 气虚发热，日久不愈，少气懒言，畏寒无力，面色苍白，脉弱或数。常用补中益气汤加减。党参 10~12 克，柴胡 10 克，升麻 6~10 克，陈皮 10~12 克，白术 10~15 克，生黄芪 15~30 克，当归 10~12 克，地骨皮 10~15 克，青蒿 10~12 克，白芍 10~15 克，女贞子 10~12 克，生姜 6~10 克，大枣 20 个。

（选自《中国百年百名中医临床家丛书·郭士魁》，中国中医药出版社 2004 年版，5~8 页。）

曹沧州

治温热病案

吴，壮热六日，胸闷气结，咳逆，脉不扬，温邪郁肺胃，正转重，勿泛视之。

淡豆豉，干浮萍，牛蒡，紫菀，前胡，白杏仁，枳壳，青皮，神曲，赤芍，通草，泽泻，白蒺藜。

韦，形寒头痛，肢节尽痛，脉数，风温深重，非达泄不可。

淡豆豉，羌活，防风，苏叶，荆芥，枳壳，前胡，紫菀，陈皮，莱菔子，六曲，泽泻，桑枝。

李，壮热形寒，胸闷头胀，脉数，咳不畅。温邪内郁，急宜透泄。

淡豆豉，紫菀，枳壳，赤苓，泽泻，干浮萍，荆芥，青皮，白蒺藜，桑枝，牛蒡，防风，赤芍。

赵，昨畅汗，热仍壮，头胀口渴，胸闷，咳不多，脉数。温邪痰滞深重，经八日，防渐渐转重。

大豆卷，桑叶，赤芍，前胡，牛蒡，紫菀，杏仁，象贝，枳壳，竹茹，通草，泽泻，枇杷叶。

韦（复诊），昨汗未畅，形寒发热，头痛胸骨痛均减，脉数，舌白。风温犹恋，仍以达泄法。

淡豆豉，大服皮，枳壳，苏叶，白蒺藜，羌活，陈皮，荆芥，桑枝，防风，楂炭，制半夏，泽泻。

李（复诊），得汗，寒热，头胀，骨痛较松，咳声不畅，腕痛，气不舒，脉数。宜解表疏中并用。

淡豆豉，前胡，白杏仁，枳壳，广郁金，紫菀，牛蒡，象贝，青皮，六曲，莱菔子，泽泻，白蒺藜，桑枝。

吴（复诊），春温一候，热不解，胸闷，咳嗽气结。宜开泄肺

胃，舒畅中宫。

淡豆豉，前胡，莱菔子，神曲，泽泻，紫菀，白杏仁，枳壳，干佩兰，楂炭，牛蒡子，象贝，青皮，赤芍。

赵（复诊），温邪病九日，咳窒胸闷，口渴脉数。温邪痰滞阻气分，宜开泄疏化。

淡豆豉，蝉衣，白杏仁，楂炭，泽泻，枳壳，牛蒡，象贝，青皮，枇杷叶，赤芍，紫菀，六曲，车前子。

李（三诊），表热未净，头胀咳窒，脘痛脉数，防余邪鸱张。

淡豆豉，紫菀，枳壳，秦艽，白杏仁，苏叶，前胡，青皮，莱菔子，白蒺藜，防风，牛蒡，六曲，泽泻。

李，温邪寒热，经二日，头晕恶心，咽痛，腹痛下利，脉数舌黄。温邪鸱张，病方转重，勿忽。

淡豆豉，前胡，青皮，白蒺藜，泽泻，苏叶，牛蒡，六曲，赤芍，干佩兰，干浮萍，枳壳，楂炭。

杨，形寒发热，头痛腹痛，胸闷，脉不扬。一派风温见象，当散之。

淡豆豉，前胡，枳壳，荆芥，泽泻，苏叶，牛蒡，青皮，赤芍，白蒺藜，防风，象贝，莱菔子，赤苓。

吴（三诊），春温一候幸解，咳嗽，胃未舒，面黄，脉数，防余邪双复。

前胡，枳壳，象贝，六曲，苡仁，牛蒡，青皮，赤苓，楂炭，枇杷叶，白杏仁，赤芍，泽泻。

李（复诊），春温病三日，得汗不足，仍身热头晕，恶心下利，胸次督闷，舌黄。拟表里两解，以泄鸱张之势。

淡豆豉，牛蒡，青皮，车前子，干佩兰，苏叶，枳壳，六曲，白蒺藜，桑枝，荆芥，紫菀，楂炭，象贝。

韦（三诊），发热一候已解，头痛骨痛，舌白咳窒。风温留恋，正在方张，勿忽。

淡豆豉，前胡，青皮，赤苓，通草，紫菀，枳壳，赤芍，泽泻，白蒺藜，牛蒡，桔梗，苏叶。

曹，热八日，舌黄，头痛，咳嗽，脉数，邪郁深重，不可忽。

淡豆豉，枳壳，青皮，白蒺藜，泽泻，紫菀，白杏仁，六曲，赤苓，枇杷叶，牛蒡，象贝。

姚，胸闷气急而短，形寒发热，头胀。风温内郁，法宜疏达。

淡豆豉，白蒺藜，前胡，白杏仁，泽泻，苏叶，枳壳，牛蒡，象贝，桑枝，荆芥，青皮，紫菀。

韩（四诊），病经十一日，热退未净，诸急稍松，尚防反复。

桑叶，枳壳，六曲，赤苓，陈皮，赤芍，青皮，莱菔子，泽泻，生米仁，川石斛，象贝母。

吴（四诊），春寒后天气遽温，劳倦感邪，寒热旬余，脉数，夜则糊语。邪滞蒸热，防化燥昏陷。

淡豆豉，枳壳，紫贝齿，紫菀，泽泻，川石斛，竹茹，牛蒡，楂炭，枇杷叶，连翘，赤芍，象贝。

严，热三日，头晕，食下作吐，脉数。宜疏散风温，消导痰滞。

淡豆豉，牛蒡，白蒺藜，陈皮，青皮，前胡，莱菔子，煨天麻，法半夏，紫金锭，紫菀，苏子，赤芍。

曹（复诊），表热九日，舌黄，头痛，咳呛，脉数。邪滞深，化达不易。

淡豆豉，青皮，白杏仁，白蒺藜，防风，干浮萍，牛蒡，车前子，枇杷叶，苏叶，莱菔子，枳壳，泽泻。

吴（五诊），春温病约十二日，夜来热甚，糊语，舌中干黄厚，咳嗽，脉数。痰热邪滞交结，势防昏陷。

淡豆豉，连翘，生石决明，陈胆星，前胡，黑山栀，赤芍，牛蒡子，川通草，枇杷叶，楮实，竹茹，象贝。

沈，春温病一候，畏热无寐，夜则谵语神躁，便泄，口干，舌黄，脉弦数。邪滞内郁，防昏厥。

淡豆豉，枳壳，前胡，泽泻，莱菔子，粉葛根，青皮，牛蒡，楂炭，干佩兰，炒赤芍，焦六曲，赤茯苓，川通草。

吴（六诊），春温病十三日，昨汗，得腑通，尚是脉数热壮，舌黄垢，仍防化燥，七日陷。

淡豆豉，赤芍，连翘，白杏仁，泽泻，蝉衣，枳壳，陈胆星，

象贝，枇杷叶，牛蒡，竹茹，紫贝齿。

沈（复诊），春温病八日，水泻渐止，无寐谵语神躁，稍有咳，舌黄质红，脉弦数。势防化燥昏陷。

淡豆豉，赤芍，紫菀，陈胆星，枇杷叶，枳壳，朱茯苓，牛蒡，泽泻，天竺黄，紫贝齿，前胡。

徐，春温病经十二日，便溏，脉数，舌根灰黄前半干，腹痛。邪无出路，势防昏陷。

淡豆豉，前胡，紫菀，青皮，泽泻，干藿梗，枳壳，赤芍，车前子，牛蒡，楂炭。

蒋，热一候汗畅，刺肋痛减，仍咳痰不止，兼有血丝，舌黄垢厚，便秘，脉数。邪滞痰热深重，极防变幻。

淡豆豉，莱菔子，竹茹，象贝，枇杷叶，黑山栀，生石决明，牛蒡，前胡，丝瓜络，枳实，茯神，白杏仁，车前子。

又（转方），据述腑气得通，热八日初得退凉，咳嗽尚盛，防余邪反复。

桑叶，象贝，瓜蒌皮，赤芍，前胡，牛蒡，冬瓜子，竹茹，通草，枇杷叶，白杏仁，瓦楞子。

吴（七诊），春温病十六日，咳夜渐畅，白斑细，午后作寒，地界不清，舌中黄，嗜卧，多糊语，脉数。正气已乏，邪热痰滞深重，极易变迁，勿以小效为恃。

淡豆豉，陈胆星，石决明，枳壳，枇杷叶，青蒿，天竺黄，大腹皮，前胡，枇杷叶，干藿斛，楂炭，赤苓，台乌药，干佩兰，赤芍，青皮，牛蒡子，泽泻。

戴，春温一候，脉左细数，右较大，舌干白，胸闷，咳痰腻，烦躁谵语，便溏。正不胜邪，势防昏厥。

淡豆豉，枳壳，茯神，通草，连翘，干藿斛，蝉衣，天竺黄，泽泻，枇杷叶，牛蒡，赤芍，紫贝齿。

顾，病两日，表热发狂，舌白黄，目赤，不省人事，两脉不畅。温邪痰滞深重，势防厥闭，险重之至。

淡豆豉，天竺黄，朱茯神，青皮炭，楂炭，干菖蒲，鲜竹茹，赤芍，莱菔子，紫金锭（研末，开水化，先服），石决明（生，

杵)，枳实，白蒺藜。

又（复诊），春温伤寒，三日起即昏狂，今麻疹齐发，偏体痛，舌干黄，神识时清时蒙，脉数不扬。防昏陷，万分险重。

淡豆豉，桑叶，紫贝齿，枳壳，白蒺藜，牛蒡，丹皮，陈胆星，黑山栀，桑枝，赤芍，连翘，天竺黄。

冯，春温病八日，脉数不大，舌白而无泽，胸闷，痰腻，烦躁糊语，便溏。邪无出路，最防内传。

淡豆豉，蝉衣，朱茯神，石决明，楂炭，鲜薑斛，牛蒡，陈胆星，枳壳，泽泻，紫菀，赤芍。

吴（八诊），病交十八日，正虚邪恋，脉数，舌黄，多糊语。仍易变迁，勿忽。

青蒿子，牛蒡，川石斛，陈胆星，泽泻，赤芍，白杏仁，天竺黄，连翘，枇杷叶，生石决明，象贝，竹茹。

祝，表邪身热，缠绵经旬，溲赤，法当泄化分利。

青蒿子，白蒺藜，川草薢，陈皮，川石斛，赤芍，赤苓，六曲，米仁，秦艽，泽泻。

赵，风温寒热，经三日，鼻衄，泄化透达。

桑叶，荆芥，白蒺藜，枳壳，泽泻，牛蒡子，苏叶，白杏仁，赤苓，紫菀，前胡，赤芍，象贝。

（选自《近代中医珍本集·医案分册·曹沧州医案》，浙江科学技术出版社2003年版，439~445页）

章次公

用泻肺消痰为主治愈风湿一例

周某，男。

诊查：体温 39.5℃，谵语见于病起之第三日，在肠伤寒殊为少见。呼吸紧张，时有痰凝于喉间，咯吐不爽。

辨证：此温邪首先犯肺之候。

处方：桑白皮 9 克，地骨皮 9 克，连翘 12 克，知母 9 克，杏仁各 9 克，葶苈子 9 克，地龙 9 克，远志肉 4.5 克，瓜蒌仁 9 克（玄明粉 9 克同捣），生甘草 2.4 克。

二诊：气略平，入夜两颧发赤。如见神蒙，便是逆传心包之候。

处方：生麻黄 2.4 克，生石膏 30 克，光杏仁 9 克，粉甘草 3 克，淡黄芩 9 克，地龙 9 克，桑白皮 9 克，远志肉 4.5 克，陈胆星 2.4 克，石菖蒲 9 克。

按语：热邪迫肺，灼液为痰，肺气阻痹而咳喘，乃为风湿必有之症。首诊用桑皮、地骨皮、连翘、知母、地龙以泻肺经之热，葶苈、杏仁、苡仁、瓜蒌以消痰利肺，远志祛痰宁神，玄明粉与瓜蒌同捣，既可清化热痰，又兼通里荡邪。二诊用麻杏石甘加黄芩、桑皮、地龙开闭泄热，陈胆星、菖蒲、远志以祛痰宁心。痰热廓清，则可免逆传心包之险。

〔选自《中国现代名中医医案精华（三）》，北京出版社 2002 年版，1663～1664 页〕

梁右斋

风热案

病者：刘源生之母陈氏，年五十一岁，住驸门前益大酒坊内。

病名：风热。

原因：风热客于会厌，咽痛音哑。医以养阴清肺，咽痛愈而胸闭，畏寒而恶食。易医以温表主之，遂变发热肢痛。又易医以桂麻姜辛投之，又变淋漓气馁头晕。医又谓病变冬温，投以达原饮，遂变气促郑声（喊叫乱言为谵语，声细语重为郑声）耳鸣舌燥，诸医束手，告以不治。

证候：汗流如雨，面若涂朱，举动气促，神昏耳鸣，交睫郑声，舌燥无津。

诊断：脉微而数，按之有神，根气尚在。犹可挽回于末路。

疗法：清淡平补，以生津养神为主。

处方：西洋参八分，辰茯神三钱，夜交藤三钱，鲜石斛四钱，白芍三钱，柏子仁二钱，女贞子钱半，生甘草八分，乌芝麻五钱（炒）。腹五剂。

复诊：汗收气平，神宁卧静，面红退，舌津生。以前方加鳖甲、龟板各四钱，野台参五分，熟地四钱，服三十余剂。

效果：调养月余，身体方能复原。

廉按：杂药乱投，病随药变，幸其入根气尚坚，犹可挽回于末路，然亦侥幸之至矣。故病家择医，不可不慎之于始也。

风热夹痰案

病者：朱永兴之幼子，二岁，住社稷坛。

病名：风热夹痰。

原因：客腊发现痰病，三月有余。前医屡以搜风化痰，燥热温中，愈服愈重，奄奄一息。

证候：满面青筋扛起，遍身瘦如鸡骨，喉间痰声辘辘，气喘汗出，十指黑筋扛起，时有寒热口渴，大便泄青色水粪，溺涩赤短，惟瞳神灵活。

诊断：纹紫脉数，青筋扛起，大便泻青，此厥阴经风热为病。

疗法：以辛凉清风，润燥豁痰。

处方：冬桑叶八分，双钩藤钱半，丝瓜络钱半，瓜蒌仁钱半，嫩桑枝一钱，白池菊一钱，淡竹茹钱半，川贝母八分，枇杷露、旋覆露合成一两，分冲。

效果：一剂知，二剂痰热均减，至四剂病若失。

廉按：风热夹痰，最易激动肝风，上冲神经，陡变状如惊痫。似此辛凉熄风，清润涤痰，处方轻灵可喜，方中如再加羚羊，尤为着力。

风热夹积案

病者：李月仔之子，半岁，住小西门内陈氏祠堂。

病名：风热夹积。

原因：七月初旬，患积热泻数次，粪如泡成蛋花。医治以藿香、苍术、桔梗、葛根等药，泻未止而增口渴。易医又以川朴、法半夏等温燥药治，至十四夜，脑陷肢冷而转重。

证候：面青白，目上窜，口渴，舌苔微黄，神迷倦卧，气逆肢厥，溲长频频。

诊断：气逆口渴溲长，肺有热也，面青肢厥，肝经风热甚炽也。幸指纹未射甲，虽危尚可挽救。

疗法：顺气清肺，涤热平肝为主。

处方：北沙参二钱，原麦冬一钱，海蛤粉一钱，片芩一钱，知母钱半，杭白芍钱半，生甘草六分，石决明三钱，全瓜蒌一钱（杵）。

外针少商穴三呼。

复诊：据述夜半十点钟，手足温而神苏。惟气促便溏，形瘦神弱。急以提补平剂消息之。

复方：东洋参六分，炒麦冬五分，生玉竹八分，抱木茯神一钱，杭白芍八分（炒），炒扁豆八分，炒糯米一撮。服五剂。

效果：经两星期调补而痊。

按：凡春末及夏秋之间，小儿患烧热泄泻，粪如泡成蛋花，或如菜绿色，泄出直射甚远，粪门焮红，指纹细淡红沉滞，腹痛呕哕，四肢逆冷，甚至目窜倦卧，气逆痰壅，均属太阴阳明，燥病居多，或兼暑风。初起治法，宜清凉兼微辛微苦之药。若热稍减，而舌苔淡薄，速宜清淡滋养之品，调补肺脾津液。若舌黄腻燥黑，急宜调胃承气汤下之以救津液为要。

廉按：婴儿风热夹积，患者最多，病亦善变，全在医者随机策应，对症发药，未可以一定之成法执而不化也。此案方法及案后按语，特其临证一得之见识耳。

（选自《全国名医验案类编·初集·四时六淫病案》福建科学技术出版社2003年版，29~35页）

董廷瑶

论小儿高热证治

小儿高热是临床常见症状。引起高热的病因不同，症状各别，治疗各异。治小儿高热必须分清伤寒、温病，从六经或卫气营血论治。辨证明确，治无可误，既合病机，辄能药到热退。兹将几种小儿高热的辨治分述如下。

风寒表证

感受风寒，邪在太阳，治宜辛温，以麻桂为主。太阳伤寒，寒邪束表，腠理闭塞，发热无汗，恶寒较重，鼻鸣喘逆，苔薄白，脉浮紧，宜麻黄汤发汗解表宣肺。

太阳中风，发热恶风，腠疏汗出，脉浮苔白，主用桂枝汤。而桂枝汤在素体较薄，面白易汗，发热不高，饮食拒纳，舌苔薄润的幼儿，为了和营卫、养脾胃，其应用机会尤多。是质薄易感小儿之有效良方：

案例一，俞某，女，2岁，门诊号5485。

1984年2月14日就诊：发热二天，现体温38.5℃，咳嗽有痰，纳减便稠，小溲短浊，手凉欠温，舌淡苔薄白。营卫失调，外邪夹滞。治拟和表化痰消滞。药用桂枝3克，白芍6克，甘草3克，生姜3片，红枣5枚，陈皮6克，半夏9克，紫菀6克，莱菔子9克，连翘9克。服药2剂热净，诸症亦瘥（方中莱菔子合连翘乃取保和之意，里滞既化，表邪自解）。

风邪袭表，稍见恶寒，发热汗闭，鼻流清涕，咽喉肿痛，脉见浮数，舌苔薄白。一般选用荆防败毒散加减，疏解风寒，疏表发汗。药用荆芥、防风、苏叶梗、豆豉、陈皮、桔梗、杏仁、鸡苏散等主之。鼻塞不利加葱白、苍耳子；恶心呕吐加生姜、半夏；咳嗽

痰多，配象贝、前胡、紫菀、百部；苔腻有痰，参入陈皮、半夏、川朴、六曲。体禀虚弱小儿，须酌加党参（或太子参）。

案例二，郑某，6岁，门诊号35718。

1978年10月12日初诊：气候突变，新感寒邪。腠闭无汗，发热2天（38.5℃~39℃），咳嗽气促，夜有痰鸣，胃纳欠佳，舌淡苔腻，脉浮紧。证属太阳伤寒，麻黄汤主之。药用：麻黄、桂枝、清甘草、陈皮各3克，姜半夏9克，杏仁、象贝、紫菀各6克，生姜3片，红枣5枚。3剂后热退气平。

案例三，周某，10月，门诊号30567。

1984年3月12日就诊：发热二天，今日体温39.5℃，便泄水泻，日4~5次，苔薄，脉浮细数，小便自利。风寒外袭，湿胜濡泄。治拟逆流挽舟法，荆防败毒散解表和泻。处方：

荆芥4.5克，防风4.5克，苏叶6克，豆豉9克，葛根9克，羌活6克，薄荷4.5克（后下），陈皮3克，甘草3克。服药二天热净。

风热上受

风热之邪，入于口鼻，侵袭上焦，其恶寒见症短暂，而迅即出现高热、咳嗽、口渴、咽痛蛾肿、溲赤、舌红苔薄、脉浮数等症，此属温病（春温、风温），为邪在卫气之间。治宜辛凉轻解，用桑菊饮、银翘散为主。选用桑叶、连翘、薄荷、牛蒡子、桔梗、豆豉、黑山栀、银花、荆芥、竹叶、芦根、黄芩等以清透泄热。咽喉肿痛加蝉衣、射干；咳逆痰阻加杏仁、象贝、前胡、竹茹。此等病症，多见于急性上呼吸道感染，西药治疗效果不理想，应用上法，疗效甚佳，一般服药2剂，即可津津汗出而透，邪解热退。津津汗出乃微汗肤润之意，与用西药安乃近之类发汗不同，安乃近发汗虽大汗而邪留，须臾旋热；而津津汗出是邪随汗出，热度渐降。

案例四，宋某，男，2岁，门诊号7586。

1982年3月24日初诊：感冒发热，数天不退，近日连续高热，夜间体温高达40℃，鼻塞涕黏，咽喉肿痛，小溲黄赤，口干欲饮，舌边尖红苔薄，脉浮数。此乃风热外袭，兹拟凉解。药用：

桑叶6克，连翘9克，桔梗6克，生甘草3克，芦根30克，黄芩9克，银花9克，薄荷3克，蝉衣4.5克，淡豆豉9克。3剂。

药后津津汗出，高热于2天退净，咳嗽增多，再予清肃而安。

风热侵袭上焦，有以邪结咽喉为主者。症见咽喉红肿疼痛较剧，甚则扁桃体或咽峡分布疱疹，或有脓性分泌物之类。涕黄痰稠，溲赤便干，脉见弦数，舌质偏红。此时可用银翘马勃散方，功效甚佳。常用药物为银花、连翘、桔梗、生甘草、牛蒡子、荆芥、马勃、射干、山豆根、黄芩、青黛（或碧玉散），清热解毒为主。咽干口渴加元参、花粉诸品；热高不降加板蓝根、紫花地丁之属。以本法再加重解毒软坚药（加夏枯草、大青叶、土贝母等），亦可用治“疔腮”（腮腺炎）。

案例五，潘某，男，2岁，门诊号4406。

1982年6月23日初诊：经常扁桃体发炎，近日又作。现咽痛红肿，扁桃体满布白色斑点，高热不退，体温40℃上下，口渴喜饮，大便秘结，脉数，舌边尖红，苔薄而干。邪热壅结咽喉，治拟解毒泄热利咽。处方：

山豆根9克，马勃6克，青黛3克（包），黄芩6克，桔梗6克，生甘草3克，元参6克，花粉9克，瓜蒌仁10克，川石斛9克。4剂

服后大便通下，咽痛亦和（扁桃体亦已如常），热尚未净，鼻塞咳嗽，续予清肺化痰。

若症见咳嗽热高，无汗烦躁，口渴喜饮，小溲黄赤，脉滑带数，舌红苔薄，此时选用梔豉汤、凉膈散加味。此时邪在气卫，胸膈发热，运用本法清泄透热，退热颇捷。

案例六，张某，男，9月，门诊号5405。

1984年5月16日就诊：发热二天，现体温39℃，舌红苔黄，腠闭无汗，躁扰不宁，大便坚硬，治拟清热解毒。处方：

黑山梔9克，豆豉9克，银花9克，连翘9克，生黄芩9克，桑叶9克，竹叶6克，芦根30克，鸡苏散12克（包）。2剂药下热降，三天退清。尚见纳呆苔黄，再拟清疏开胃。

温病四时皆有，但有新感伏气之分。新感即以辛凉轻解治之。

而伏气多匿于膜原，或内舍于营，证属肺胃。若症见发热较高，咳呛不畅，痰鸣气促，舌红苔黄，脉弦滑数，为风温犯肺，热郁肺闭。如外感引发哮喘性支气管炎、支气管肺炎等，由于温邪上犯，肺胃郁热，亟当用麻杏石甘汤加桑叶、薄荷、牛蒡子、连翘、象贝等品。痰涎壅盛者加桔梗、莱菔子、竺黄或竹沥；肺热较重加黄芩、桑皮、黑山栀、芦根。

案例七，陆某，男，17个月，门诊号16791。

1983年3月9日初诊：发热陡起，现体温40.2℃，咳逆喘促，面颊红赤，痰鸣喉间，小溲深黄，脉滑急数，舌红苔黄。风温犯肺，邪热郁闭，亟以麻杏石甘宣肺泄热。处方：

麻黄3克，生石膏30克（先煎），杏仁6克，清甘草3克，黄芩9克，芦根30克，牛蒡子9克，前胡9克，连翘9克。2剂。

服药后次日高热渐降，续用原法三剂，其症告平。

邪结少阳

小儿高热，亦有从少阳辨治。其症寒热往来，时高时低，烦扰不宁，纳少作恶，舌边尖红，脉弦而滑。治宜小柴胡汤和解退热。若上症伴微恶寒，骨节疼痛，乃少阳兼太阳表证，治宜柴胡桂枝汤，和解少阳，兼散外邪。

案例八，朱某，男，18岁，住院号135585。

1977年3月1日：发热五六天，因高热40℃入院。血常规、胸透均无异常，西医“发热待查”。现发热，微恶寒，寒热往来，汗出不彻，咽干口苦，胸胁满闷，小溲短赤，便结两天，舌红苔薄白，脉弦数。证属少阳而太阳表证未罢，拟柴胡桂枝汤主之。处方：

桂枝3克，柴胡4.5克，白芍6克，条芩9克，清甘草3克，生姜2片，红枣3枚，3剂。

3月5日二诊：汗出较多，热度已退，寒热不作，稍有咳嗽，舌红苔薄黄，脉缓。表邪初解，上焦余热未清。治以轻宣理肺。处方：

桑叶9克，蜜枇杷叶9克，杏仁9克，连翘9克，薄荷2.4

克，象贝9克，条芩4.5克，陈皮3克，生草2.4克。3剂，药后病愈出院。

按：《伤寒论》146条云：“伤寒六七日，发热微恶寒，支节烦痛，微呕，心下支结，外证未去者，柴胡桂枝汤主之。”此为邪入少阳而太阳证尚未罢的证治。本例的病情属这一类型。其寒热往来、口苦咽干、胸胁苦闷、脉象弦数为一系列少阳见症；又有微恶寒、汗出不彻的太阳表证，故宜于柴桂汤。其加减之处，以不呕而去半夏，不渴而去人参，悉遵仲师之法度。由于辨证精确，见效甚速，服后二天热退；余邪不清，恋肺作咳，遂以轻清宣肺，三日而安矣。

应用小柴胡汤，增其退热疏宣之力，中气不虚者去党参，纳呆苔腻，加陈皮、枳壳；热势较高，加连翘、芦根；夜间热重，参以青蒿、白薇诸品。

案例九，徐某，女，18岁，住院号132958。

1976年9月25日一诊：发热月余不退，其症寒热往来，胃纳不佳，便下间隔，形色萎倦，舌苔白薄，脉象细数。邪恋少阳，治以小柴胡加味。处方：

党参4.5克，制半夏9克，柴胡4.5克，条芩9克，生姜2片，红枣3枚，炙甘草3克，枳实4.5克，青蒿9克，佩兰9克。
3剂

9月28日二诊：发热升降不退，纳少便涩，脉舌略同。仍宗原法。

上方去枳实，加白芍9克，党参用9克，4剂。

10月5日三诊：发热已和（37℃），胃纳亦动，大便畅下，舌淡苔白，脉象细弱。原方既合，续予和解。处方：

党参9克，半贝丸9克（包），条芩6克，白芍9克，炙草3克，生姜3片，红枣3枚，柴胡4.5克，陈皮3克，青蒿9克。
4剂。

药后热平而愈。

按：仲景论少阳病，云：“伤寒中风，有柴胡证，但见一证便是，不必悉具。”该患者初诊见寒热往来，不欲饮食之少阳病证，

故可与小柴胡汤。加枳实以下气利便；加蒿、佩以清其兼夹暑湿之邪，乃因时制宜者也。一周后其热果退，大便随之而通畅。仲师所谓“上焦得通，津液得下，胃气因和”，遂使清升浊降也。

案例十，高某，女，44岁，住院号138075。

1977年6月11日一诊：原有风湿病，近因新感而高热二周不退。先寒后热，每日发作，胸院不适，咽痛汗多，关节酸楚，大便3天未通，脉滑数，舌红苔黄。先从少阳阳明考虑，拟予大柴胡汤。处方：

柴胡4.5克，大黄9克，枳实4.5克，条芩6克，炙草3克，生姜2片，制半夏9克，红枣2枚，青蒿9克。3剂。

6月14日二诊：药后便下二次，热度初退，纳和溲长，但骨节酸痛，舌苔薄黄，脉象转缓，新感已解，须治风湿。处方：

桑枝、寄生各9克，黑山栀9克，青蒿9克，条芩6克，木防己9克，赤苓9克，陈皮3克，炙草3克，枳壳4.5克。4剂。

6月18日三诊：肢酸见瘥，胸院亦舒，舌润脉和，兹以调养。处方：

桑枝、寄生各9克，赤苓9克，炙草3克，陈皮3克，川石斛9克，白芍9克，条芩4.5克，炒麦芽9克。7剂。

服后诸症均安而出院。

按：大柴胡汤原主少阳郁热，阳明里结。本例见症新感而兼夹旧疾，急则治标，故初诊投以大柴胡汤加减和解通腑。二诊时因便通热降，故兼治旧疾。方以条芩、山栀、青蒿清解里热，桑枝、寄生、防己祛风胜湿，蠲痹镇痛，而以枳、苓、陈、草调气和胃佐之。最后则以调养收功。

案例十一，俞某，男，2岁，门诊号59630。

1984年1月24日初诊：发热已近一周，数日来入暮热升，体温达39.5℃，清晨则退。咳嗽有痰，纳食不佳，溲黄便通，睡眠尚安，舌边尖红苔浮腻，脉细弦数。邪在少阳，治以和解。药用：

柴胡4.5克，黄芩4.5克，半贝丸9克（包），青蒿9克，连翘9克，杏仁6克，陈皮3克，淡豆豉9克，芦根30克，2剂。药后其热即退。

案例十二，梁某，男，2岁，门诊号18897。

1983年12月15日就诊：发热三天，现肛温 39°C ，热势起伏，大便秘结，肢末清凉，咳嗽痰多，苔根薄腻，脉滑纳呆，邪郁少阳，腑有实积，治拟表里双解。药用：

柴胡4.5克，黄芩6克，半贝丸9克（包），前胡6克，杏仁6克，川朴4.5克，枳实6克，生军3克（后下），生姜3片，红枣5枚，3剂。三日后复诊，其热即清。

以柴胡剂退热，其另一常用方为四逆散。指征在于寒热时作，而肢末清冷，每见迁延日久，纳少烦躁。证属少阳气结，热郁于内。以四逆散为主疏达运枢，解郁泄热，正合契机。其加味法同前。

案例十三，程某，男，6岁，门诊号15142。

1983年1月26日初诊：低热五月，体温 $37.5^{\circ}\text{C} \sim 38.5^{\circ}\text{C}$ ，夜间为高。四末不温，纳少便干，眠中寝汗，脉弦细，苔浮腻。西医理化检查无阳性发现。证属气机不舒，邪热内郁，治以四逆散。处方：

柴胡3克，枳壳6克，清甘草3克，赤芍6克，青蒿9克，地骨皮9克，陈皮3克，茯苓9克，生姜2片，红枣3枚。5剂。

药后夜热渐降，复诊时体温 37.2°C 。再予银柴胡、地骨皮、青蒿、白薇、石斛、甘草等5剂，半年发热，迅即获安。

（选自《中国百年百名中医临床家丛书·董廷瑶》，中国中医药出版社2001年版，48~57页）

董建华

论治春温病

春温是春季发生的一种温热病。其病机是冬季感受寒邪，潜伏于体内，郁而化热，至春令温暖，阳气发泄，伏邪外出而发。本病有伏热自发和新感引发两种类型。由于受邪深浅的不同，故伏邪外出的表现亦随之有区别：有出自气分的，有出自血分的。其特点为初起里证为多，病在营分的、血分的，则发病初起即可出现烦躁、谵语，甚或神昏、发斑等危重症状。故本病最易化燥伤阴。在治疗上，需时时保护津液。本病初起和中期以祛邪为主，兼顾津液；后期则着重养阴，兼清余热。

具体治法

1. 滋阴解表法

阴虚之体，感受温热之邪，症见头痛身热，微恶风寒，咳嗽，痰稠难出，无汗或少汗，口渴，咽干，心烦，舌赤，脉细数。舌赤，脉数，头痛，身热微恶风寒，为风热犯肺，卫气被郁，肺气失宣之症。治宜滋阴解表。

生玉竹 10 克，元参 10 克，连翘 10 克，白薇 6 克，豆豉 10 克，薄荷叶 3 克，炙甘草 3 克。

加减：表证较重加防风、葛根；咳嗽咽干，咳痰不爽加牛蒡子、瓜蒌皮，心烦口渴较甚加竹叶、天花粉。

2. 滋阴攻下法

适宜用于热结阳明，化火灼津，腑气壅闭。症见身热，腹满，大便秘结不通，口燥咽干，舌红苔焦燥，脉沉细。治宜滋阴攻下。

元参 12 克，麦冬 10 克，细生地 12 克，大黄 3 克，元明粉（冲）3 克。

3. 凉血解毒法

适于热毒深入血分。症见身热不退，夜甚晨轻，神烦躁扰，吐血、衄血或便血，发斑，舌质深红而绛，脉数。治宜凉血解毒。

广犀角 6 克，鲜生地 30 克，白芍 10 克，丹皮 10 克，茜草炭 10 克，大青叶 15 克，川连 6 克，山梔 10 克。

若发斑、吐衄同时伴壮热、口渴，则用生石膏 30 克，知母 10 克，元参 10 克，细生地 12 克，麦冬 10 克，石斛 12 克。

4. 滋阴养液法

适用于温病日久，温热邪气损耗肝血肾精，虚热内生，邪少虚多之候。症见身热夜甚，神倦欲眠，甚则神昏，耳聋舌强，口干舌燥，舌红绛少苔，脉虚数无力。治宜滋阴养液。

生地黄 18 克，生白芍 12 克，麦冬 10 克，北沙参 10 克，石斛 10 克，阿胶（烔服）10 克，知母 10 克，麻仁 6 克，炙甘草 3 克。

若见四肢蠕动者，则宜滋阴清热，养血熄风。

生牡蛎 15 克（先下），炙鳖甲 15 克（先下），炙龟板 15 克（先下），白芍 10 克，麦冬 10 克，生地黄 10 克，炙甘草 5 克，北沙参 10 克，麻仁 6 克。

治疗用药特点

春温为伏气温病，起病大多阴津已伤，所以春温的治疗“存津液”贯穿始终。但养阴生津之品有清腻之分，临床应当辨清阴津损伤的程度，适时适量用之。一般轻度津伤，热在卫气时，多用芦根、葛根或少量沙参。中度津伤则用沙参、麦冬、元参、天花粉等。重度阴津损伤可用生地、麦冬、石斛、玉竹等。若非下元阴精虚甚，黄精、熟地、龟板胶等滋腻之品尽量不用或少用，以防碍胃恋邪之弊。

病案举例

病案一，张某，女，54 岁。1960 年 3 月 10 日初诊。近来发烧且伴头痛，咳嗽气促，口干喜饮，汗出，溲黄。舌质红无苔，脉象洪大。

辨证：冬寒内伏，郁久化热，复感时邪，伏气外出气营。

立法：宣透伏热，清气生津。

方药：桑叶10克，连翘10克，薄荷5克（后下），甘草3克，黄芩5克，山梔6克，花粉10克，玄参10克，生地10克，麦冬10克，生石膏15克（先煎），知母10克，粳米3克。2剂。

二诊：进清透增液药后，外邪得泄，内伏郁热渐次减轻，伤阴之象明显好转，热势渐退，舌干转润，余症均有好转，因咳逆有痰，宗原意加化痰利肺之品。

牛蒡子6克，连翘10克，杏仁10克，桔梗5克，川贝母6克，生石膏10克（先煎），知母6克，山梔6克，甘草3克，生地12克，玄参6克，麦冬10克。3剂。

三诊：药后热势渐退，咳逆亦平，略思饮食，舌红转淡，脉象见缓，病情近愈，继以清养肺胃善其后。

生石膏10克（先煎），竹叶5克，粳米6克，沙参15克，半夏5克，麦冬10克，山药10克，扁豆12克，桑叶6克。服1剂痊愈。

春温又称“伏气温病”，据《内经》记载，春温之证，由于伏寒化热，从内出外，所以最易化热伤阴。本例即是时邪引动伏温，伏气外发气营之证。故症见发热头痛，咳嗽气促，口干，脉洪大，溲黄，舌红无苔等热灼伤阴之象，治以清热养阴为主，佐以宣透。在初诊时，一面用白虎清气，又配用生地、玄参凉营分之伏热，方中桑叶、连翘、薄荷、山梔等轻宣透表以达外邪，药后表解伏温外出，所以见效明显。再诊时，鉴于痰阻肺络，故仍宗原法，适当加入开提肺气之牛蒡子、桔梗，化痰止咳之杏仁、贝母。最后用竹叶石膏合沙参麦冬二方加减以善其后。可见伏气温病，非同一般外感一汗即解，内热之证，得清即愈。必须在清透之中，配以养阴之品，始能取得满意效果。

病案二，李某，女，71岁。1982年5月4日初诊。寒热往来，已半月余，头晕，身痛，口苦胁痛，干呕心烦，口干不欲多饮，尿少而黄。舌质红绛，中裂无苔，脉象细弦数。

辨证：春温晚发，邪热未清，表里失和，营分已伤。

立法：清胆泄热，养阴生津。

方药：黄芩 10 克，青蒿 10 克，银柴胡 6 克，竹茹 6 克，芦根 20 克，滑石 10 克，石斛 10 克，天花粉 10 克，桑叶 6 克，桑枝 15 克，杏仁 10 克，丝瓜络 5 克。

二诊：上药进 3 剂，寒热往来已退，胃津得复，舌面复生薄黄苔，脉象弦细，表里通达，再加养阴清热善后。

沙参 10 克，麦冬 10 克，丝瓜络 5 克，生竹茹 5 克，生谷芽 5 克，生地 10 克，芦根 15 克，黄芩 6 克，杏仁 20 克，全瓜蒌 15 克，桑枝 15 克。

服上方 3 剂而病愈。

柳宝诒指出：“邪已化热，则邪热燎原，最易灼伤阴液，阴液一伤，变证蜂起，故治伏气温病，当步步顾其阴液。”柳氏之论，颇中要领，临床不可忽视。本例用黄芩、青蒿、银柴胡疏通少阳，宣展气机，清其郁热；芦根、天花粉、石斛养阴清热。由于清热之时，顾其阴液，所以疗效神速。

病案三，陈某，男，17 岁。1960 年 3 月 14 日初诊。寒热往来 1 周余，头晕目眩，胸胁痞满，恶心，不思饮食，小便赤短。舌苔黄腻，脉象弦数。

辨证：伏温挟湿，阻遏膜原。

立法：和解少阳，清利湿热。

方药：蒿芩清胆汤加减：青蒿 10 克，黄芩 10 克，姜半夏 6 克，藿梗 6 克，炒枳实 10 克，陈皮 6 克，茯苓 10 克，竹茹 10 克，桑叶 10 克，菊花 10 克，碧玉散 12 克（包）。

复诊：上药连服 4 剂，寒热即除，诸症痊愈。

伏温挟湿，阻于少阳膜原气分，春令阳气开泄，伏邪欲出，与正气相争，故起病即见往来寒热，胸胁痞满，恶心，不思饮食，溲黄，苔黄腻，脉数等，均为湿热内阻之表现。本证治疗不同于伤寒柴胡汤证，以青蒿、黄芩二药为主清泄少阳膜原伏热，陈皮、半夏、竹茹、枳实、藿梗理气和胃化湿，赤茯苓、碧玉散导湿热以下行，桑叶、菊花以清热泄邪，是以药后有效。春温挟湿，因湿热留连，气化郁阻，故治疗上既不能过于寒凉清热，亦不能过于苦燥化

湿，为此我常在方中配用碧玉散，既有化湿热之效，又有泄胆凉肝之意。本案患者所以收效迅速，与用药适当密切相关。

（选自《中国百年百名中医临床家丛书·董建华》，中国中医药出版社2001年版，62~66页）

论治风温

风温是春季感受风热之邪引起的疾病，属新感温病。春季气候温暖多风，阳气发泄，卫气虚弱，不能抵御外邪，一旦感受风热之邪即可发生本病。肺主皮毛，卫气通于肺络，风温侵入人体，肺卫首当其冲，故本病初起为邪伤肺卫，由表及里，发展趋向有“顺传”及“逆传”两种途径：邪从上焦肺卫渐入中焦阳明气分传营入血为顺传；若肺卫之邪不传气分，而径自内陷心包营分则为“逆传”。顺传病势轻，逆传病势比较严重。根据邪在卫气营血不同阶段，选择寒凉药物也各异。卫分证候，选用辛凉清解药物，以解除表邪，使邪气去营卫通而汗出。气分证候，选用寒凉清热药物，以清除里热。营分证候，选用清营凉血药物，并配以轻清宣透气机的药物，以清透营分邪热。血分证候，选用凉血散血的药物，以凉血散瘀。

（一）具体治法

1. 辛凉清解法

适于风热之邪初袭肺卫，肺气失宣，卫气被郁。症见发热轻，头痛，咳嗽，咯痰不爽，口微渴，苔薄白，舌边尖红，脉浮数。肺失宣降，上逆而咳。温病初起，伤津不重，故口仅微渴。舌苔薄白，脉浮是邪浅，病在卫之候。宜辛凉清解。

桑叶10克，菊花10克，炒杏仁10克，象贝母10克，桔梗5克，连翘10克，前胡10克，鲜芦根30克，薄荷5克。

身痛加桑枝15克；痰多加冬瓜仁10克；渴甚加花粉10克；咽肿痛加牛蒡子10克，元参10克，马勃10克；胸胁隐痛不舒加柴胡10克，郁金10克。

2. 清热宣肺法

适于温热邪气恋于肺，化热转剧。症见身热恶热，汗出口渴欲

饮，咳喘气急，痰白黏稠或黄，舌红苔黄，脉滑数。宜清热宣肺。

麻黄 3 克，生石膏（先下）20 克，炒杏仁 10 克，银花 10 克，连翘 10 克，炒山栀 5 克，生甘草 3 克。

痰盛加苏子 10 克，清半夏 10 克，橘红 10 克；痰黄稠者加瓜蒌 20 克，大贝母 10 克，冬瓜子 15 克，黄芩 10 克；痰中带血加桑白皮 10 克，地骨皮 10 克，仙鹤草 10 克。

3. 清热生津法

适于风温邪热传入阳明。症见壮热，面赤神烦，汗出恶风，口渴欲饮，苔黄燥，舌质红，脉洪大。宜清热生津。

生石膏 30 克（先下），竹叶 10 克，麦冬 10 克，知母 10 克，芦根 15 克，生甘草 5 克，炙杷叶 10 克。

大便干加生大黄 6 克，元明粉 10 克（冲）；心烦加连翘 10 克，莲子心 10 克，栀子 10 克，渴甚加鲜石斛 10 克。

4. 清心豁痰开窍法

适于温热内传，痰热闭塞包络。症见身热灼手，痰壅气粗，四肢厥逆，神昏谵语或昏愦不语，烦躁不安，舌红绛，苔黄燥，脉细数。其身热灼手，乃邪热内陷所致。宜清心豁痰开窍。

先用安宫牛黄散 3 克，温开水调服，或清开灵静脉滴入。然后再进汤剂。

元参 12 克，莲子心 6 克，竹叶卷心 6 克，鲜生地 10 克，连翘 10 克，菖蒲 5 克，郁金 10 克，赤茯苓 10 克，远志 10 克。

热盛加犀角 5 克；痰盛加天竺黄 10 克，川贝母 6 克；咳痰不清加瓜蒌皮 10 克，桔梗 10 克。

5. 宣肺泄热，凉营透疹法

适于营卫合邪。症见身热，咳嗽，胸闷，心烦不寐，皮肤出红疹，舌质红绛，苔薄黄，脉数。风热外袭，肺卫失宣则咳嗽胸闷。体表气机不畅，气血郁于体表不得宣畅，则使血瘀滞于肤表血络之中而成红疹。由此可见，疹外发，乃卫营合邪所致。身热，心烦不寐，舌质红绛，脉数乃风热邪气内窜深入营分之兆。宜宣肺泄热，凉营透疹。

银花 10 克，连翘 10 克，鲜生地 10 克，大青叶 10 克，赤芍 10

克，元参10克，牛蒡子10克，丹皮5克，竹叶6克，桔梗5克，生甘草3克。

斑疹已布，身热重加生石膏（先下）24克，知母10克，紫草10克。

6. 凉肝熄风，化痰开窍法

温热邪气深入血分，导致肝经热盛，热极生风。症见壮热，神昏，两目上吊，颈项强直，口噤不语，喉间痰声辘辘，手足抽搐，舌质绛，苔腻，脉弦数。宜凉肝熄风，化痰开窍。

生石决明（先下）30克，天竺黄10克，川贝母3克，钩藤15克，菊花10克，僵蚕10克，连翘10克，全蝎3克，生龙齿（先下）15克。

（二）治疗用药特点

风温为新感温热邪气所致，风温初起多以肺卫病证居多。故治疗风温宜用轻清流动之品，切勿轻易以大苦大寒之品遏伤阳气，使寒遏冰伏成“寒包火”之势而病难速愈，或转逆证。一般多用银翘散或银翘白虎汤、银翘清营汤、银翘清宫汤。即以银花、连翘、牛蒡子、竹叶等为主药，用于卫、气、营各期病证，取其轻清流通，不易伤阴，不甚苦寒，遏伏病邪，入营分令邪热透营转气之良效。

（三）病案举例

病案一，刘某，男，7岁。1960年3月15日初诊。初起微有恶寒，旋即发烧，体温高达40.6℃，头痛无汗，微咳，口渴喜饮，食欲不振。舌苔边白中微黄，脉象浮数。

辨证：温邪外感，卫气不宣

立法：辛凉透表，清热解毒。

方药：银花10克，连翘10克，竹叶10克，荆芥5克，牛蒡子6克，薄荷3克（后下），豆豉10克，甘草1.5克，桔梗5克，芦根10克，山栀5克。2剂。

复诊：服药后微微汗出，热势降至37.4℃，口渴，不思食，微咳，舌苔薄少津，脉缓。余热未尽，肺胃津伤，再以清热生津为治。

银花6克，薄荷1.5克（后下），杏仁6克，甘草1.5克，石斛10克，连翘6克，炒谷芽10克，炒麦芽10克。

服1剂，病告愈。

本例发病正值春令，证属温邪外感，卫气不宣，故见头痛无汗；邪热灼津，将入气分，故高热不恶寒，口渴喜饮而苔黄。宗吴鞠通辛凉平剂解表透邪，取银翘散加味而获效。在辛凉方剂中，吴鞠通有辛凉轻剂、辛凉平剂、辛凉重剂之分，必须掌握病情、权衡而施，若误用麻桂辛温，则温邪愈炽，或汗多耗阴，或火化而动风，变证莫测。

病案二，于某，女，57岁。1983年2月1日初诊。发热5天，微恶寒，无汗，头晕，身痛，咳嗽有痰，痰黏色白，咽红咽痛。

辨证：风热之邪，初袭肺卫。

立法：辛性清解，以护阴津。

方药：银翘散加减：银花10克，连翘10克，牛蒡子10克，荆芥10克，豆豉10克，冬瓜子15克，桑叶6克，桑枝10克，桔梗6克，甘草3克，薄荷5克（后下），芦根20克。

二诊：服上药4剂后，微微汗出，热退脉静，但咳嗽未已，痰白，左胁隐痛，舌暗苔薄白，脉象细滑。此为外受风温郁遏，内因肝胆阳升莫制，此皆肺失清肃，治宜宣肺止咳，疏肝理气止痛。

银花10克，桔梗5克，桑叶6克，菊花10克，杏仁10克，川贝母3克，前胡10克，苏子6克，广郁金10克，赤芍6克，柴胡6克。

又服上药6剂，诸症悉平。

吴鞠通指出：“温病忌汗，汗之不惟不解，反生他患。”吴氏主张，温邪在表初用辛凉轻剂，取凉性清解表热，取辛凉以宣郁散邪，辛凉清散，用意非在发汗，而在宣泄表邪，开其表郁。一旦肺气得宣，气机调畅，腠理通达，营卫调和，自然汗出而病解。若用麻桂辛温之品以发汗，犹如火上浇油，劫胃津，泄阳气，或化火动风，或热陷心包，后患无穷。

病案三，英某，男，成年。1985年3月18日初诊。下午发热汗多，已10余天，头痛鼻塞，形寒恶风，周身关节酸楚，口苦，

舌红，苔黄，脉细数。

辨证：体素虚弱，复感温邪。

立法：先疏风清热，再扶持正气。

方药：桑叶6克，菊花10克，杏仁10克，银柴胡6克，青蒿10克，黄芩10克，银花10克，连翘10克，白蒺藜10克，蔓荆子10克，路路通10克。3剂。

1985年3月21日复诊：服上药3剂，发热恶风怕寒已除，关节酸楚亦减，尚有轻微咳嗽，仍见头痛隐隐，汗出较多，体倦无力，舌淡红，苔薄黄，脉细。风热病邪已退而肺气不宣，卫气失固，当以扶正为主。

黄芪10克，炒白术6克，防风3克，象贝母6克，陈皮6克，炙甘草3克，清半夏10克，全瓜蒌10克，杏仁10克，枳壳10克，焦三仙各10克。4剂。

本例患者最易误诊为柴胡桂枝汤证，但与午后发热，汗多，舌红不符。从时令来看，病发于春季，多为风温。故以疏风清热为先，而继以扶正收功。可见中医治病最宜分清主次、标本、先后。

病案四，王某，男，3岁。1960年3月3日初诊。患儿昨晚起发热，体温38.6℃，且伴咳嗽，喷嚏，流涕，大便干，小便黄，全身皮肤遍起红疹。舌边尖红，苔薄白而干，脉象浮数。

辨证：温邪犯肺，肺气不宣，郁热波及营分，外发成疹。

立法：辛凉解表，宣肺透疹。

方药：银翘散加减：银花10克，连翘10克，薄荷5克（后下），豆豉6克，牛蒡子10克，桔梗5克，竹叶6克，芦根15克，浮萍6克。2剂。

随访：服上方2剂后，热退疹消而愈。

风温发疹，多因热邪内郁，侵入营血所致。疹小色红高出皮肤，与斑鲜红成片隐于肌内有所不同。本例系风温之邪侵袭肺卫，热蕴肌肤，肺卫失宣，故发热咳嗽喷嚏；表邪不解，热入血络，外发皮肤而见遍体红疹。根据《内经》“风淫于内，治以辛凉”及疹宜清透的原则，治以辛凉解表，宣肺透疹。方用牛蒡、薄荷、浮萍、桔梗辛凉宣肺透疹，银花、连翘清热解毒，豆豉、竹叶以除胸

中烦热，配芦根以清热生津，从而使温邪得清，肺气得平，波及营分之热亦除而病告痊愈。

病案五，常某，男，3岁。1960年4月15日初诊。发热、咳嗽已历2周，曾服银翘散、桑菊饮等方，热退一二日复起。现每天午后发热，热时腋下体温 39°C 左右，继则汗出，至晨4时才热退，已有4天。精神不振，嗜卧，咳嗽，口渴思饮，大便溏，小便黄。舌苔薄腻，脉象弦数。

辨证：外感风温，邪入膜原。

立法：和解清热。

方药：柴胡5克，葛根6克，黄芩5克，连翘10克，草果2克，知母6克，通草2.5克，甘草2.5克，茶叶3克，生姜2片。2剂。

复诊：药后午后热势减至 38°C 左右，精神食欲均有好转，脉舌如前，原方再服2剂。

三诊：药后午后发热已除，精神饮食转常，尚有咳嗽痰鸣。痰热迫肺，肺气仍不宜通，从原方增删。

柴胡3克，黄芩5克，知母5克，贝母5克，杏仁3克，银花6克，连翘6克，前胡6克，红枣3枚。服2剂，诸症痊愈。

患儿体质较弱，风温新感，曾服辛凉解表，病势退而复发，邪气由肺卫传入膜原，邪在半表半里，因而成疟。古人所谓疟不离少阳，所以用和解清热，佐以化湿宣肺之品法，方中柴胡、黄芩清少阳半表半里之热，葛根、知母以清里热，草果、生姜辛散和中，连翘、通草清热化湿，调之以甘草、茶叶。药后即见效果，三诊时见有痰热迫肺，肺气失宣，宗原方出入，以宣肺卫，是以药后病愈。

（选自《中国百年百名中医临床家丛书·董建华》，中国中医药出版社2001年版，55~62页）

韩 绪 臣

风热咳血案

病者：李镜湖，年三十六岁，学界，扬州人。

病名：风热咳血。

原因：初因感风，舍肺咳嗽，自以为操劳过度，妄食滋补，风从热化，肺络乃伤。

证候：咳声不扬，颧红气促，右肋隐痛，痰中夹血。

诊断：脉浮而芤，左胜于右。盖肺居高部，乃一身行气之司令脏也，处气交之中，最有直接关系，六淫之侵，易于感触，故伤于风者，上先受之。风舍肺膈则咳，若能节饮食、慎起居，风散则咳自己。妄食滋补，助痰遏风，风居肺络，久而酿热，气道为痰所壅，则咳声不扬，风热因郁难伸，则痰中夹血，气壮之人，肺痛因此，气虚之辈，肺痿由来，右肋隐痛者，乃气痹不宣也。所服之方，罔不从虚论治，徒然塞气生痰，吾所不取也。

疗法：轻清透达，理气活痰，君以旋覆、杷叶、桑菊清肺络以开肺痹，佐以橘皮络、川贝、郁金、莱菔子开其痰结，丝瓜络、金橘皮、新绛之属，清营理郁，兼能化瘀。

处方：旋覆花一钱（布包），枇杷叶三钱（去毛），冬桑叶三钱，杭菊花钱半，橘皮、络各一钱，半川贝母三钱，广郁金钱半，莱菔子钱半，丝瓜络三钱，金橘皮一钱，新绛屑一钱。

效果：日服一剂，别无加减，约半月，咳畅痰豁，血止气舒而愈。

廉按：清肺通络，顺气豁痰，不专止血而血自止，为治咳血之巧法，学者宜注意之。

（选自《全国名医验案类编·初集·四时六淫病案》，福建科学技术出版社，32~33页）

蒲辅周

论治春季、夏季时病

春季时病

(1) 风温：风为百病之长。风邪从口鼻或从皮毛侵入人体发生诸病。若春阳过盛，感受温风而病者，名曰风温。其症发热，微恶风寒，头痛目胀，有汗或无汗，口干或心烦口渴，或不渴，鼻干或塞，或胸闷，咽干或咽痛，或咳或不咳（咳者较轻，不咳者较重），身困或酸，而不甚痛，脉象浮数，右大于左，或细数微浮，舌红，苔白或黄，小便黄。以上皆风温病之表现。病在上焦，属手太阴，法宜辛凉解表，宜银翘散、桑菊饮二方出入化裁为主。兼有微寒者略佐葱白、苏叶；夹湿者加滑石、芦根、通草。初起总以达邪外出为要，切勿过早使用寒凉，冰伏其邪，热不得外越而内陷，延长病程，甚则恶化。

银翘散加减：胸闷加藿香、郁金；渴甚加花粉；项肿咽痛加马勃、玄参；衄者去荆芥穗、豆豉，加白茅根、侧柏叶、栀子炭；咳者加杏仁；热渐入里加细生地、麦冬。

桑菊饮加减：小便短少加知母、黄芩、栀子；燥热在气分加生石膏、知母；入营加玄参、犀角（现用水牛角代）；在血分去薄荷、苇根，加麦冬、细生地、玉竹、丹皮；肺热加黄芩、天花粉。

余在临床亦按此法加减，惟初起加入葱白，透邪外出，见效更捷。咽痛加僵蚕、射干；伤食加山楂、莱菔子；若心烦不用葱白，加栀子三枚，即合用栀豉宣解郁热，其效更速。

(2) 寒疫：偶为暴寒所折，发为寒疫，其发病多与伤寒相似。症见憎寒，发热，头痛，身疼，胸闷不饥，或欲呕或泻，或口干不渴饮，脉浮弦而滑或紧，舌质色黯，苔白而秽，治法宜芳香温散和

解，不宜辛凉、苦寒，一般可用香苏饮加味或十神汤化裁。头痛甚加川芎、僵蚕、白芷、蔓荆子；身痛加羌活、防风；背痛加葛根；呕吐、无汗、身痛兼胃肠不和，症状夹杂，可用五积散为末，每用五钱，加生姜三片，水煎温服。

似寒非寒，似温非温，壮热烦躁，无汗头痛身疼，胸腹痞满，大便不利，小便短涩，目胀心烦，口苦不思食，渴不多饮，脉沉紧或浮弦，舌质黯，苔白腻或黄腻者，属内蕴湿热，外感风寒，营卫失和，三焦郁滞，治宜两解，用增损双解散为末，每用五钱，加生姜三片，葱白三枚，水煎热服，汗出热退，二便自和，当避风，以稀粥调养数日即愈。

夏季时病

(1) 先夏至为病温，一般称为温热：发病较速，历代医家治此病以存津液为主，因热甚则伤津。其症状初起即高热烦躁，口渴舌干，头痛微恶风，面赤目红，或有汗，或无汗，小便短赤，脉浮数或洪，初起有表证者，可酌用银翘散合梔豉以解之。若不效，心烦便秘者，可用凉膈散两解之；若表解里热盛，大烦渴，汗大出，脉洪大有力者，可用白虎汤清解之。脉大而芤，热甚津伤，可加沙参、玉竹益气生津。

再者春夏之交，一般热病在三四天之后表证已罢，高热不退，烦渴引饮，或有时谵语，目赤气粗，或汗不出，因肺胃津伤不能达热外出，此时不能再表剂重伤津液，然而又无里实证，不可用下药再伤正气，惟宜生津退热轻宣之法引热外出，可用二鲜饮生津退热。二鲜饮为余经验方，方用鲜芦根（切）三两，鲜竹叶一握（约一两许）。浓煎取汁，不拘冷热频频服之。余在农村行医时用之屡效，若兼衄血加鲜茅根一握（约二两），煎成再加童便半杯兑服，屡获满意效果。此方看来平平无奇，在热病三四日之后，表证已罢，此方类似白虎汤的功用。有衄血者加茅根、童便，则类似犀角地黄汤之功用。丹溪谓降火最速莫过于童便。余临床数十年，凡热盛络伤之证，在对证方中加入童便，颇获速效。此方最宜于乡村缺药之地，就地取材，不花钱能治病，但须注意：童便必须取之于

健康无病之儿童。

附：温毒

温毒者秽浊之气所致之病，四时皆有，春夏较多。其症微恶风寒，咽痛或不痛，耳前后肿，颊肿面赤，甚则头面全肿，耳聋，眼不能开，俗名大头瘟，亦名虾蟆瘟。其尤重者，喉中结塞，咯痰不出，声如曳锯，汤水难入，语言困难，亦名捏颈瘟。脉象多见浮沉俱盛，苔多秽腻，或白或黄，舌质赤黯。治法总以清热逐秽解毒为主，一般以普济消毒饮治之，而杨栗山增损普济消毒饮有发展。若舌苔白腻乃湿盛，宜酌加燥湿解秽之药，如佩兰、藿香、薏仁、豆卷；若苔黄腻乃湿热并盛，宜本方加栀子宣发郁热；若便秘腹胀满，酌加酒炒大黄，频频含咽。并常用热毛巾热敷患处，引热外达，或用赤小豆细末醋汤调，厚敷肿处，以拔其毒，稍凉即换。

(2) 后夏至为病暑：夏至后热盛于上而下迫，湿蒸于下而上腾，湿热交蒸，风行其中，人在气交之中感之而病者即为暑病。静而得之为中暑，即所谓“阴暑”；动而得之为中暍，即所谓“阳暑”。暑本热也，阴暑乃暑天贪凉受寒，非暑有阴也。

暑温、湿温：都是季节性流行病。暑和湿各居六气之一，在每年六气用事各主60日。但春分以后至秋分以前180日是君火、相火、湿土三气错综相互为用，所谓热、湿、火混合为一，故夏秋之间发病急，而见症不一。在夏至后至立秋前，所现症状多属热盛湿轻，宜暑温法治之；若夏至后三伏中多雨，则见热湿并重；立秋后多阴雨，也有属湿重热轻，湿胜必以湿温法治之。但秋季往往少雨，秋阳亢盛，而又多见燥症，须从燥治。在临床必先岁气，重视天候地气。

暑温致病，风、暑、湿三气夹杂，发病最骤，变化亦速，其症状不一，或高热、面赤、心烦、口渴，甚则昏厥、抽搐；或上吐下泻，四肢厥冷。因暑病急，伤元气最速，此乃举其大概。张风逵先生著有专论，可重点参阅。脉象不一，或洪或芤，或细数，或濡缓，或隐而不显。舌色多赤，或绛或紫，苔或白或黄，或无苔。治法可根据张风逵先生所主张的先用辛凉，次用甘寒，终用甘酸。初起头痛身热，微渴，心烦有汗，脉右大于左，可用六一散。

六一散方：滑石六两、甘草一两，为末，每服三钱，温开水调下。胃阳弱者，绢包煎汤服。或用二鲜饮。热重者，脉洪大，身大热，大烦渴，大汗出，宜以辛凉重剂白虎汤主之。脉芤者加人参（以沙参代之，玉竹亦可用），此乃纯热不兼湿之证，名为中喝。若夹湿身重者，宜白虎加苍术。若兼暑湿闭滞，表实无汗，舌苔白秽，可用新加香薷饮。有呕吐加鲜藿香；若心烦，舌赤，苔黄加黄连；小便短涩加六一散。若汗多，脉散大，喘渴，欲脱者，急用生脉散；若暑邪入营，神昏谵语，可用清营、清宫加减酌用，至宝丹、牛黄丸、紫雪丹亦可随症选用。

若邪入厥阴，症见消渴烦躁，神昏谵语，时热时厥，或吐蛔者，可予连梅汤，或用椒梅汤。

连梅汤方：黄连、乌梅肉、麦冬、生地、阿胶。

椒梅汤方：黄连、黄芩、干姜、白芍、川椒、乌梅、人参、枳实、半夏。

善后调理以益胃生津为主，可予益胃汤或三才汤。

伏暑：长夏受暑，过时而发者名伏暑。此病多发于秋后。其中偏于热者，多发于手太阴，宜清暑透邪；偏于湿重者为湿温，多发于足太阴，宜通阳利湿；湿热平等者两解之。初起症状，头痛微恶寒，面赤，口渴，舌白，脉濡而数。无汗者宜银翘散去牛蒡子加杏仁、滑石，香薷可酌用，胸闷加藿香、郁金；若舌赤口渴无汗者，银翘散酌加细生地、丹皮、赤芍。以上皆表实之证，一兼气分，一兼血分。若舌红，口渴，有汗，宜银翘散去牛蒡子、芥穗，加石膏、杏仁、黄芩；若脉大，口渴甚，汗大出，仍用白虎汤。脉虚大则加人参，此邪在气分正虚之证；若舌赤，口渴、汗多宜生脉散加丹皮、生地黄，此邪在血分正虚之证。暑温、伏暑，病本同源，可前后互参，不可偏执。再者若初起恶寒，无汗，身疼，或有微汗而热不解，亦可采用香薷饮；若热甚无汗，心烦，舌赤，小便短涩者，亦可用黄连香薷饮加六一散或六一散加薄荷、葱白、豆豉，轻清宣透，以达到汗出，热从表解。

(3) 夏秋之际为湿温：湿温病发于夏秋之际。湿邪之害，不同于暑。盖盛暑之时必兼湿，湿盛之时不一定兼暑；暑邪只从外

入，而湿邪兼于内外。暑邪为病骤而易见，湿邪为病缓而难知。湿热病四时皆有，湿温病则发于夏秋之间。外受之湿或从雨露而得，或从地气潮湿中而得。皆着于肌表，当用解肌法微汗之，兼风者微微疏散，兼寒者佐以温散，兼热者佐以清解，此乃外受湿邪之治法；若内生之湿，乃从饮食得之，凡过食膏粱厚味，甜膩水果，皆能内生湿热，或兼感外邪。当分三焦论治。

湿温在上焦，其症状头痛，恶寒，身重疼痛，苔白不渴，胸闷不饥，而色淡黄，午后热盛，状若阴虚，脉弦细濡，湿邪黏滞，病难速已，其来也渐，其去也迟，忌汗与下，误汗则神昏耳聋，下之则洞泄，治宜芳香化浊，通阳利湿，以三仁汤灵活运用。喘促者宜用千金苇茎汤加杏仁、滑石。若邪入心包，神昏肢厥，清宫汤去麦冬之滞，加银花、赤豆皮宣清降浊，并可予以至宝丹、紫雪丹。以上属上焦治法，若出现中焦症状，当从中焦论治。

湿温之邪，由膜原直走中道，不饥不食，机窍不灵，宜三香汤。

三香汤方：瓜蒌皮、桔梗、黑山栀、枳壳、郁金、香豉、降香末。若湿郁三焦，升降失司，五个加减正气散，对症选择。

若身痛脉缓，舌苔淡黄，渴不多饮，汗出热解，继而复热，徒清热则热不退，徒去湿则热愈炽，宜湿热两清，用黄芩滑石汤。

黄芩滑石汤：黄芩、滑石、茯苓皮、大腹皮、白蔻仁、通草、猪苓。

若湿聚热蒸，蕴于经络，骨节烦疼，热炽寒战，舌苔灰滞，此属湿痹，宜用宣痹汤，加减木防己汤亦可选用。

宣痹汤：防己、薏苡仁、晚蚕砂、半夏、杏仁、赤小豆皮、滑石、连翘、栀子。

加减木防己汤：防己、桂枝、石膏、杏仁、滑石、白通草、薏苡仁。

若胸腹项背发现白痞，可用薏苡竹叶散。

薏苡竹叶散：薏苡仁、竹叶、飞滑石、白蔻仁、连翘、茯苓、通草。

寒湿：多中于阳虚脾弱之人，寒湿之病，脉沉迟而濡，身无大

热，口不渴，小便清，大便多溏，或身痛重着，手足肿痛，但头汗出，背强喜暖，治宜温中利湿，胃苓汤加木瓜、炮姜，寒盛者酌加川附子，脉浮虚而涩者宜桂枝附子汤。

（选自《中国百年百名中医临床家丛书·蒲辅周》，中国中医药出版社2004年版，315~321页）

温病是随季节而命名。病之来路有二：呼吸与皮毛。病之去路有三：汗、吐、利。温病最怕表气郁闭，热不得越；更怕里气郁结，秽浊阻塞；尤怕热闭小肠，水道不通，热遏胸中，大气不行，以致升降不灵，诸窍闭滞。治法总以透表宣膈，疏通里气，而清小肠，不使热邪内陷或郁闭为要点。并且人体有强弱，感受有轻重，伏邪有深浅，治法有缓急，用方有大小，辨证施治灵活运用，勿犯虚虚实实之戒。瘟疫实与四时温病不同，是杂气为病，杨栗山《伤寒瘟疫条辨》论述颇详，临床灵活运用杨栗山十五方，治疗杂气瘟疫疗效很好，但四时温病之中亦偶有兼秽浊杂感者，须细心掌握，才能提高疗效。

（选自《中国百年百名中医临床家丛书·蒲辅周》，中国中医药出版社2004年版，324页）

论治流行性感冒辨证的一般原则

流行性感冒是传染性极大的疾病，也可以说是一个世界性的急性传染病。到目前为止，资本主义国家对流感的防治仍然没有可靠的方法。而我们采取了积极防治的态度，所以近年来我国人民在与流感作斗争的过程中，取得了很大成绩，也获得了很多的经验。这些经验和成绩是在党的正确领导下，依靠群众，贯彻预防为主和团结中西医的方针，采取中西医合作的综合性措施而取得的。为了更好地发挥中医的作用，进一步探讨中医对流感辨证论治的一般原则，防治流感的流行，保障人民的健康，是有现实意义的。

流行性感冒的辨证规律

祖国医学古典著作之一的《伤寒论》，近来很多学者都认为是包括流行性感冒在内的一类有关急性传染病的临床经验和理论总结。后世各家有关类似流感的论述颇多，不但辨别了流感证候，而且对流感的传染性及其防治方法也有丰富的知识。

在流行期间，诊断流感虽较简单，但在非流行期间，诊断颇属困难。因有多种疾病，其临床症状极似流行性感冒。所以，关于流感的发病因素、流行季节、发病过程及其分类等问题，亦即掌握流感的辨证规律问题，是防治流感的关键。

1. 流行因素

流行性感冒的病原体是滤过性病毒。但是，因病毒有不同类型以及病毒的变异等问题，从而增加了流感流行规律的复杂性。祖国医学虽对病原体尚没有直接观察到，但已注意其自然环境、气候的外在因素，和这些因素对流感流行规律的影响。例如：

(1) “此证因春夏秋三时，感冒非时暴寒所致，多见恶寒发热，头痛，骨节疼，无汗，或呕逆恶心等证，其脉人迎多浮紧，亦有弦数者。”（《中国医学大辞典》感冒条）

(2) “此证多由天时凉暖不一，风邪由口鼻吸入，郁于肺经，而见鼻塞声重，时流清涕，咳嗽自汗等症；甚者头痛身热，痰壅气喘，声哑咽干，脉浮而数，易于传染。”（《中国医学大辞典》伤风条）

(3) “凡人偶感风寒，头痛发热，咳嗽涕出，俗语谓之伤风，非《伤寒论》中所云之伤风乃时行之杂感也。”（徐灵胎）“夫时行气病者，此因岁时不和，温凉失节，人感乖戾之气而生，病者多相染易，故予服药及为方法以防之。”（巢元方）

由上述三点可见，古人所谓“暴寒”、“风邪”、“时行乖戾之气”，虽非明指病毒，但可以说明这些因素是引起流感流行的诱因。同时，还认识到流感是由呼吸道传染及其容易引起流行的发生和预防的方法。

2. 流行季节

祖国医学谓“春应温而反寒，夏应热而反冷，秋应凉而反热，冬应寒而反温，此非其时而有其气，是一岁之中，长幼病皆相似者也，是时行不正之气。”说明四时非时之气均能引起疾病的流行。但亦有不因非时之气而发病的，即所谓六气外感为病。所以对流感的辨证，在因时制宜的情况下，既要分析非时之气，又要分析当令之邪。例如：冬日为寒水正令，单衣薄被，感冒寒邪，多恶寒、发热、头痛、无汗、脉浮紧，此即当令之寒邪为病；若气候反温，感其气而发病者，则为非时之气为病，当于冬温法中求治。春日为风木主令，春日感冒风邪，若初起微恶寒，后则但热不寒，头胀、身痛、口渴、咳嗽，或自汗，脉浮数者为风温，亦当令之邪为病；若寒水之气未尽，或气候骤寒，感之而发病者，则又为非时之气为病，当于感冒寒邪法中求治。至于夏日则多属热属暑，长夏则多兼暑兼湿，秋日则燥气偏胜，而燥又有两种性质，一属于凉，一属于热，因之有凉燥和温燥两种不同的类型。以上根据时令不同，寒温各异，则四时流感亦因时变化，而表现不同的证候类型，在临床上，“审察病机，无失气宜”，自能收到“必伏其所主，而先其所因”的治疗效果。

3. 发病过程及其分类

流感的发病过程很短，病势发展很快，一般1~2天症状达最高峰，各种证候可渐次消失，遗留极度虚弱和劳动力的降低。单纯型的流感很少迁延5~7天以上。有时在第3~4天，体温下降，病即好转。有时，1~2天后体温又复升高，病情加重，呈现双峰型的体温曲线。极轻的病例，整个病程持续1~2天，病人并不卧床。极重的病例，有时病情呈现各种全身中毒征象，甚至呈虚脱，亦有的很快死亡。

流感的临床表现是多样性的，因而就有许多分类的方法。基本上可分为单纯型、混合型及继发性感染的三种病型。

按照中医特点，需要结合流行因素及发病季节，加以归纳分析，若其时仅为当令之邪，或因感寒，或因受风，而不兼其他因素者，则发病多为单纯型的感冒，若其时气候不常而杂感不正之气

者，则发病的变化复杂，多为混合型的感冒。同时，体质有强弱，感受有轻重，年龄有大小，地区有燥湿，以及病毒侵犯的部位各有不同，如有太阳证的，头痛发热，脉浮恶寒；有阳明证的，鼻干目痛，发热，项背强，口渴汗出；有少阳证的，口苦咽干，往来寒热，胸胁满，喜呕；亦有三阳并见，但以某经证多，则加某经之药。间有直中三阴。又以所犯何经，循经治之者。此外，尚有感冒夹食、感冒夹痰，等等，均须仔细辨别（夹食加消食之品，夹痰加化痰之品），则疾病自无遁情。至于流感的继发证，则以肺炎为常见，又须视其继发感染情况，或属治疗不能及时，或属调理失于谨摄，随证治之，适宜为度。

流行性感冒的治疗原则

我们知道，流感总属外感的疾患，治疗流感的原则也就总不外乎解表为主，而解表法又应分辛温解表和辛凉解表两大法则。根据流感的发病因素和季节，区别宜温宜凉，再辨其有无兼夹，自能执简御繁，得其要领。

1. 冬日流感的治疗

冬日流感可分感冒寒邪（同伤寒治法）和应寒反温感受非时之气（同冬温治法）二类。

（1）感冒寒邪：恶寒、发热、头痛、身疼、脉浮紧、无汗、舌白、口不渴、舌质不红，可予麻黄汤；发热、头痛、身疼、项背强、脉浮长、无汗，可予葛根汤；往来寒热、口苦咽干、胸胁满、目眩喜呕、脉浮弦，可予小柴胡汤；恶风寒、头痛身酸、胸闷不渴、舌苔白、脉浮，可予荆防败毒散；恶风寒而咳嗽、身微痛、舌苔白、脉浮而体虚者，参苏饮可予之。以上虽同是辛温解表的方法，但见症不同，体质有异，故处方用药，应区别对待。

（2）感受非时之气：发热甚、微恶寒或不恶寒、头痛鼻塞、舌苔白或微黄、口微渴、脉浮数，宜葱豉桔梗汤凉解之；若发热微恶寒、无汗或有汗不彻、微烦、而微赤、目微红（而赤色者，阳气拂郁在表之象）、口渴、舌苔白或微黄不燥、舌质色红而不绛、脉浮数兼紧，兼见咳嗽气急者，乃内热为外寒所遏，脉气受制，属

寒包火，宜凉散之剂，麻杏石甘汤可予之；若体虚感冒冬温，咳嗽咽干，发热头痛，加味葳蕤汤可以选用。以上是微辛凉解表的方剂，一因冬日虽应寒反温，但仍主寒水司令之时，选方不宜纯用辛凉苦寒，宜辛凉宣透（表1）。

表1 冬日流感方剂表

立法	方名	药品组成
辛温	麻黄汤	麻黄、桂枝、杏仁、甘草
	葛根汤	葛根、生姜、甘草、芍药、桂枝、麻黄、大枣
	小柴胡汤	柴胡、黄芩、人参、甘草、生姜、半夏、大枣
	荆防败毒散	荆芥、防风、羌活、独活、柴胡、前胡、桔梗、枳壳、赤茯苓、川芎、人参、甘草、生姜
	参苏饮	苏叶、陈皮、半夏、茯苓、甘草、前胡、桔梗、枳壳、生姜、西党、葛根、大枣
辛凉	葱豉桔梗汤	葱白、豆豉、山栀、苦桔梗、薄荷、青连翘、甘草、竹叶
	麻杏石甘汤	麻黄、杏仁、生石膏、甘草
	加味葳蕤汤	葳蕤、葱白、桔梗、白薇、豆豉、薄荷、炙草、大枣

注：药量应根据患者年龄、病情和体质强弱而确定（以下同）。

2. 春日流感的治疗

可分感温风之气（同风温治法）和非时之寒（同寒疫治法）二种。

（1）感冒风邪：发热不恶寒或微恶寒，口不渴或微渴，头痛，有汗或汗不彻，或微咳，舌苔薄白，脉浮数，或用辛凉平剂银翘散主之，或用辛凉轻剂桑菊饮主之。按风为阳邪，春则温暖，本《内经》“风淫于内，治以辛凉”之义，故用“辛凉解表”之正法。

（2）感冒寒疫：恶寒发热，头痛身疼，胸闷不饥，无汗，舌白脉浮，用香苏饮，或复以葱豉汤。恶寒发热或寒战，头痛，全身酸疼，咳嗽，无汗，口不渴，舌白而秽，不思食，脉浮紧或浮弦，可予十神汤或苏羌饮（表2）。

表 2

春日流感方剂表

立法	方名	药品组成
辛温	银翘散	银花、连翘、桔梗、薄荷、竹叶、甘草、芥穗、豆豉、牛蒡子、苇根
	桑菊饮	桑叶、菊花、杏仁、桔梗、薄荷、甘草、连翘、苇根
辛凉	香苏饮	苏叶、香附、陈皮、甘草
	葱豉汤	葱白、豆豉
	十神汤	麻黄、葛根、紫苏、香附、橘皮、芍药、川芎、白芷、升麻、甘草、生姜、葱白
	苏羌饮	苏叶、羌活、防风、陈皮、淡豉、生姜、葱白

3. 夏日流感的治疗

夏令多热，感冒则头痛身酸、发热、口渴、无汗、舌白、脉浮数，可用银翘散加杏仁、滑石；发热、口渴、心烦、头痛、有汗，可用银翘散去芥穗、牛蒡子加杏仁、黄芩、生石膏；渴甚者加花粉；胸膈闷者加藿香、郁金；小便短者加梔子或加六一散。若发热、头痛头胀、恶心呕吐、胸闷身倦、腹痛下利、舌白滑或微腻、或渴或不渴，乃暑秽及夹食，可与藿香正气散。

4. 长夏流感的治疗

这一季节，兼暑、湿、风三气。尤多暑湿并胜。如伤暑感冒，表实无汗、发热头痛、舌苔白、而赤口渴、右脉洪大，宜新加香薷饮；若舌尖红，可加黄连少许；小便短，亦可加六一散。如感冒暑湿，恶心呕吐、头晕身痛、倦怠乏力、腹泻不思食、发热口不渴，宜六和汤。如感冒湿胜，头痛如裹、身重、骨节酸疼、舌白苔滑、不渴不饥、脉濡、午后热甚，宜三仁汤。若脉暖身痛、舌苔黄而滑、渴不多饮或竟不渴、汗出热减、继而复热，乃内蕴水谷之湿，外复感受时令之湿，黄芩滑石汤可与之。如风湿上冲、头痛脊疼、项如折，羌活胜湿汤可以选用。

按四时感冒，在夏季，特别是长夏，风、暑、湿、火兼而有之，因此流感所感受的各有不同，所以治疗方法也就有辛凉透邪、芳香清化、通阳利湿等等，我们在应用于临床时，必须掌握病机，

灵活运用（表3）。

表3 夏日、长夏流感方剂表

方名	组成药品
六一散	滑石、甘草
藿香正气散	藿香、腹皮、白芷、茯苓、紫苏、陈皮、白术、厚朴、桔梗、半夏、甘草、生姜、大枣
新加香薷散	香薷、厚朴、扁豆花、银花、连翘
六和汤	藿香、砂仁、厚朴、扁豆、木瓜、人参、白术、茯苓、半夏、甘草
三仁汤	杏仁、滑石、通草、白蔻仁、竹叶、厚朴、生薏苡、半夏
黄芩滑石汤	黄芩、滑石、茯苓皮、大腹皮、白蔻仁、通草、猪苓
羌活胜湿汤	羌活、独活、藁本、防风、蔓荆子、川芎、甘草

5. 秋日流感的治疗

头痛、恶寒、发热、鼻塞咽干、咳嗽稀痰、脉弦无汗，此属凉燥，杏苏散主之。头痛、身微热、口微渴、微咳有汗，桑菊饮主之。头微胀、目不清、口微渴、干咳，余邪不解者，清络饮主之。咳嗽无痰或痰少而黄、咽干、口渴、舌红无苔、脉数，清燥救肺汤可与之（表4）。

表4 秋日流感方剂表

方名	组成药品
杏苏散	苏叶、半夏、茯苓、前胡、桔梗、枳壳、甘草、生姜、大枣、橘皮、杏仁
清络饮	鲜荷叶、鲜银花、西瓜翠衣、鲜扁豆花、丝瓜皮、鲜竹叶心
清燥救肺汤	石膏、甘草、霜桑叶、人参、杏仁、胡麻仁、阿胶、麦冬、枇杷叶

以上是四时流行性感的一般治疗原则。可以前后互参，分别运用，不必拘泥。所列的方法与方剂，仅作临证参考，必须因人、因地、因时，增减化裁。另外，如元素九味羌活汤、海藏神术散、苏沈九宝汤等等，均是流行性感冒可以选用的方剂。因为祖国医学

是非常丰富的，非一方一法或几方几法所能尽其治疗流感的应有作用。

（选自《现代著名老中医名著重刊丛书·中医对几种急性传染病的辨证论治》，人民卫生出版社2007年版，20~27页）

治感冒医案

感冒一

宋某，男，55岁，1960年4月20日初诊。

患者本体素弱，平时易罹感冒。此次感冒持续月余，服药不愈，头痛，畏风，自汗出，身倦乏力，关节不利，二便正常，舌淡无苔，脉象沉迟无力。此属阳虚感冒，营卫不固，治宜温阳益气，宗玉屏风散加味。处方：

黄芪五钱，防风一钱，白术三钱，川熟附子三钱。

先煎附子三十分钟，再纳余药同煎，去滓取汁，分二次温服。

复诊：畏风消失，恶寒亦减，头痛见轻，仍时汗出，脉弦缓，右沉迟，左沉弱，舌苔白腻。属卫阳既虚，内湿渐露，改用温阳利湿为治。处方：

生黄芪四钱，白术三钱，川熟附子二钱，苡仁五钱，山茵陈三钱，桑枝（炒）一两。

再诊：诸症大减，气机舒畅，尚微感恶凉，脉缓有力，前方去桑枝加良姜二钱，以温胃阳。

末诊：服药后已不畏冷，脉右沉迟，左弦缓，继宜温阳补中，改用丸剂缓调以善其后。早服附子理中丸二钱，晚服补中益气丸二钱。逐渐恢复而获痊愈。

按：本体素弱，阳虚卫外力弱，故平时易患感冒。此次感冒月余，汗出不解，腠理空虚，玄府洞开，卫阳不固。故先以玉屏风散加附子，温阳益气固表，使营卫得偕，继以温阳利湿，终以温阳补中而获痊愈。若不辨体质，泛用一般治疗感冒通剂，则表气愈疏，卫愈不固，病必不解。病随体异，用药亦有所不同。

感冒二

王某，男，54岁，干部，1960年5月3日初诊。

患者素有大便不爽、腹痛肠鸣、睡眠不佳等症，近日又觉头晕，身倦微热，脊背酸痛，咳痰，左胸肋发紧，大便稀溏，腹胀尤甚，舌质正常，后根苔黄腻少津，脉寸浮数，尺沉迟，左关弦细数，右关沉细数。蒲老认为：其人脾胃素弱，复受新感，中气不支，脾气下陷。法宜和胃祛风，标本兼治。处方：

苏叶一钱五分，香附一钱五分，陈皮一钱五分，前胡一钱五分，僵蚕一钱五分，防风一钱，天花粉一钱五分，甘草五分，炒麦芽一钱五分，建曲二钱。

二诊：服药后，痛胀、背酸俱消失，大便如前，仍有头晕，微咳痰多，脉象寸浮数，关尺和缓，舌苔减退。病势虽减，但风邪未尽，脾胃未和，继以祛风宣肺，并调脾胃为治。处方：

苏叶一钱，菊花一钱五分，荆芥穗一钱，蔓荆子二钱，前胡一钱五分，僵蚕一钱五分，桔梗一钱，广陈皮一钱五分，生甘草三分，香豆豉三钱，葱白一（连须）二寸。

三诊：头晕已减，咳痰如前，消化尚欠佳，舌苔再减，脉沉滑。外邪已解，肺胃未和，治宜养阴润肺和胃化痰。处方：

茯苓二钱，法半夏二钱，化橘红一钱五分，炙甘草五分，炒麦芽二钱，焦山楂一钱五分，建曲二钱，桑叶二钱，石斛三钱，枇杷叶二钱。

服后咳平，食纳增加，大便正常而愈。

按：脾胃关乎中气，是升降运行的枢纽。若中气不足，则脾胃运输必弱，而肠鸣便滞诸症以作。且卫出中焦，中气弱卫亦不固。今患者中虚不足而见外感，所以治法以和胃为主，祛风为佐，乃安内攘外之法。外邪解后，专调肺胃而获速愈。可见治中虚胃弱之体，不专重在发表。若专重发表，恐中气愈伤，津液被劫，而病程亦将会有延长的可能。

（选自《现代著名老中医名著重刊丛书·蒲辅周医案》，人民卫生出版社2005年版，44~46页）

感冒三

庞某。男，60岁，1958年2月26日初诊。

近来感冒，身微热，微恶寒，鼻塞，咳嗽，痰黏，剧烈头痛。脉浮，舌正苔薄白。属伤风，治宜辛散。处方：

桂枝二钱，麻黄一钱半，杏仁二钱，甘草一钱，桔梗一钱半，前胡二钱，法半夏三钱，陈皮二钱，生姜三片。一剂。

2月27日二诊：药后咳嗽减，仍发微热，头昏，有喷嚏，鼻塞。脉浮数，舌红苔白而略燥。属风化燥，治宜祛风清燥。处方：

桑叶二钱，菊花二钱，薄荷一钱半，桔梗一钱半，杏仁一钱半，川贝一钱半。二剂。

3月1日三诊：头晕，咳嗽，便溏。脉左浮弦，右浮缓，舌正苔白滑。属外感将尽，内饮复动，治宜温化痰饮处方：

桂枝二钱，茯苓三钱，法半夏三钱，淡干姜一钱，细辛五分，五味子（打）五分，白术二钱，大枣二枚，甘草一钱。二剂。

3月6日四诊：咳嗽减，腹微满，便溏。脉两寸微，左关弦大，右关弦，两尺沉，舌正苔减。属脾胃不足，仍宜调和脾胃，以附子理中汤加味，并以丸剂缓治之。处方：

党参三钱，白术三钱，淡干姜二钱，制附子三钱，茯苓三钱，桂枝二钱，法夏三钱，化橘红一钱半。三剂。

人参（或党参）五钱，干姜三钱，炙甘草五钱，制附子一两，白术五钱，肉豆蔻五钱，诃子五钱，五味子五钱，破故纸一两，化橘红五钱，山药一两，芡实一两，茯苓一两，砂仁五钱。共研细末，炼蜜为丸，如梧子大，每服三钱，白开水送服。

近因外出，要求携带感冒方。由于四时季节不同，感冒用药也异。处方如下：

春时感冒咳嗽方：

苏叶二钱，杏仁二钱，法半夏二钱，茯苓三钱，陈皮一钱半，前胡二钱，炙甘草一钱，桔梗一钱半，化橘红二钱，生姜三片。

夏日感冒咳嗽方：

茯苓三钱，法半夏二钱，化橘红一钱半，苏子一钱半，炙紫菀二钱，寸冬二钱，前胡二钱，桔梗一钱半，知母一钱，甘草一钱，

生姜三片。

秋日感冒咳嗽方：

沙参三钱，天冬三钱，茯苓二钱，化橘红二钱，前胡三钱，川贝二钱，苏叶二钱，紫菀二钱，冬花二钱，桔梗一钱半，半夏曲二钱，炙杷叶三钱，生姜三片。

冬日感冒咳嗽方：

炙麻黄一钱，细辛一钱，桂枝一钱半，干姜八分，五味子（打）二十粒，法半夏二钱，苏子二钱，紫菀二钱，大枣四枚，炙甘草一钱。

久年远咳方：

用老生姜二两，蜂蜜三两，新汲水四两，慢火煎30分钟去姜留蜜，再加饴糖四两，微火煎一沸，化橘红三钱、半夏曲三钱、白茯苓五钱，三味研末入蜜饴中，搅匀，装瓷瓶中，每日早晚服三钱，白开水冲服，四季都可服。

按：四季感冒咳嗽方，是根据患者阳虚体质，春日用杏苏散出人，夏日用二陈汤加味，秋日用参苏饮加减，冬日用小青龙汤化裁。

久年远咳方也是针对患者阳虚脾湿而痰盛者用之。

上方虽为备用而立，故录之以资阳虚易感病人的借鉴。同时，本例在一次感冒治疗全过程中，体现了随证施治的特点。初因伤风，即用辛散之剂；二诊有化燥现象，则改用辛凉轻剂；三诊见内饮复动，又立即温化痰饮；终则从本体阳虚，用附子理中温脾胃以善其后。充分体现蒲老临床治疗的原则性与灵活性。

（选自《现代著名老中医名著重刊丛书·蒲辅周医疗经验》，人民卫生出版社2005年版，136~138页）

风热感冒

韩某，男，74岁，1960年3月28日初诊。

昨晚发热，体温38.5℃，微咳，咽红，今晨体温37.9℃，小便黄。脉浮数，舌赤无苔。属风热感冒，治宜辛凉。处方：

桑叶二钱，菊花二钱，牛蒡子二钱，连翘二钱，桔梗一钱半，芦根五钱，僵蚕二钱，竹叶二钱，生甘草一钱，香豆豉三钱，薄荷（后下）八分，葱白（后下）三寸。

水煎二次，共取 200 毫升，分早晚二次温服，连服二剂。

3 月 30 日复诊：服药后热退，体温 36.4℃，咳嗽减轻，但痰黏滞不利。舌正无苔，脉缓和。感冒基本已愈，治宜调和肺胃，兼化痰湿。处方：

瓜蒌壳二钱，橘红二钱，川贝母一钱半，前胡一钱半，云茯苓三钱，天冬三钱，竹茹二钱，枇杷叶三钱，芦根四钱。

水煎二次，共取 160 毫升，兑蜂蜜一两，分早晚二次温服，连服二剂。

按：肺为娇脏，清虚而处高位，选方多宜清轻，不宜重浊，这就是治“上焦如羽，非轻不举”的道理。患者脉证属风热感冒，故用桑菊饮合葱鼓汤辛凉透表，宣肺化痰，治疗而愈。

（选自《现代著名老中医名著重刊丛书·蒲辅周医疗经验》，人民卫生出版社 2005 年版，138～139 页）

阳虚感冒

邹某，男，60 岁，1958 年 8 月 23 日初诊。

形瘦体弱，素易感冒，近因疲劳受凉，头项强痛，畏风，动则汗出，轻微咳嗽，消化不好已久，肠鸣，纳差，精神不振。脉左寸微浮，右寸微，两关弦虚，两尺沉弱，舌正苔薄白黏腻。由体虚卫阳不固，复感新凉之气，治宜调营卫，建中气。处方：

党参二钱，桂枝一钱半，白芍二钱，炙甘草一钱半，生黄芪三钱，法半夏二钱，陈皮一钱，茯苓二钱，生姜二片，大枣二枚。二剂。

慢火煎两次，取 300 毫升，加饴糖一两，和匀，分 2～3 次温服。

8 月 25 日复诊：药后两小时微烦，继而汗出，畏风消失，头痛亦解，饮食略增，睡眠不好。脉两寸沉微，两关弦缓，两尺沉

迟。营卫初和，治宜和脾柔肝，兼滋心肾。处方：

党参二钱，白术二钱，茯苓三钱，炙甘草一钱，半夏一钱半，橘红一钱半，五味子（打）二十粒，酸枣仁三钱，肥知母五分，川芎五分，大枣四枚。

水煎温服，二剂。

按：患者素来体弱，肺胃两虚，卫外不固，故容易感冒。营卫生于水谷，源于脾胃，脾为营之源，胃为卫之本。近因劳逸失当，中气再受损伤，复受风邪而感冒。病者中气虚，为致病因素的主要方面，治宜扶正祛邪。先用黄芪建中汤合新加汤，甘温建中，调和营卫；继用六君合酸枣仁汤，和脾柔肝，兼滋心肾而康复。虚人感冒，尺脉沉弱者，慎不可发汗；中气虚寒而外感者，辛凉之剂亦要慎用。

（选自《现代著名老中医名著重刊丛书·蒲辅周医疗经验》，人民卫生出版社2005年版，143～144页）

治温邪郁闭（腺病毒肺炎）案

闻某，男，3个月，因高烧无汗而喘已五天，于1960年4月27日住某医院。住院检查摘要：肺部叩诊有浊音，听诊有水泡音。血化验：白细胞总数14100/立方毫米，中性46%，淋巴54%，体温40℃以上，肝脏肿大，呈堵塞性呼吸，二度缺氧，神识昏迷，时而抽风。

病程与治疗：曾予冬眠合剂、冰袋、氧气吸入等治疗。29日请蒲老会诊，患儿仍高烧不退，灼热无汗，喘急气促，胸高膈扇，昏迷抽风，唇绀面赤，舌红苔白，脉浮数，此由风温犯肺，卫气郁闭，未出三日急宜解表，宜凉解之剂以解表开闭，并结合毛地黄化，补充血浆、输液及氧气吸入等措施。处方：

麻黄五分，杏仁一钱，生石膏二钱，甘草五分，前胡五分，桔梗五分，僵蚕一钱，牛蒡子一钱，竹叶一钱，葱白二寸，速服二剂。

复诊：患儿虽然仍高烧昏迷，喘急，气促，但周身皮肤微润，

抽风减少，舌仍红，苔转微黄，脉尚浮数，用原方减去桔梗、葱白，加钩藤一钱以熄风，莱菔子一钱，炒苏子八分以降气，进一剂。

三诊：热渐降，喘渐平，神识昏迷亦渐清醒，已不抽风，唯咳嗽痰多，舌红减，苔亦稍退，脉不浮而数，由表邪已解，肺闭已开，但痰尚甚，继以泄热降气化痰之剂。处方：

桑皮一钱五分，杏仁一钱，炒苏子八分，前胡八分，莱菔子一钱，厚朴五分，化橘红五分，茯苓一钱，甘草三分，苇根三钱，二剂。

四诊：患儿热已退清，喘亦不作，神清面荣，诸症基本解除，唯余轻度咳嗽，乃以调和肺胃之品二剂，调理而愈。

按：高烧抽风，昏迷喘促，是小儿肺炎的严重证候。初起虽用冬眠合剂和冰袋镇静退热，而诸症未见好转。究其病机，全由表邪郁闭，卫气不通，肺气不开，以致神昏，并非病邪已犯心营，故用麻杏石甘汤加味直解其表，宣肺开闭，连进三剂始获表解闭开。凡六淫外邪，表闭证多见此候，若不详审，误作邪入心营，进清营、清宫者有之，进牛黄、至宝者有之，则诛伐无过，徒伤正气，表闭终不解除，而成内闭之危，临床者宜慎思之。此案于会诊时，因患儿高烧喘急，昏迷抽风，曾结合西医紧急处理（输液，输氧，药物洋地黄等），为中医治疗创造有利条件。由此可见，中西医结合在处理危重病症方面的特殊重要性。

[选自《蒲辅周医案·温邪郁闭（腺病毒肺炎）》，人民卫生出版社1972年版，181～183页]

治温邪入营（腺病毒肺炎）案

唐某，男，2岁，因发热而喘已十天，于1959年3月25日住某医院。

住院检查摘要：咽培养：大肠杆菌。血化验：白细胞7000/立方毫米，中性75%，淋巴25%。体温39.4℃。肺部叩诊浊音及听诊有水泡音。临床诊断：腺病毒肺炎。

病程与治疗：发病已十天，曾用青、链霉素，会诊时，发热无汗，时而烦躁，嗜睡，微咳，呼吸微，腹不满，下利清绿色，四肢厥冷，齿干舌绛，苔老黄，中心黑，脉沉，此温邪内陷入营，正气已虚，已现厥逆，急防发痉，治宜甘凉养阴、辛凉泄热，虚实兼顾，以冀透营转气。处方：

玉竹三钱，麦冬一钱五分，银花二钱，竹叶二钱，郁金一钱五分，石菖蒲一钱，生玳瑁（先煎）三钱，天竺黄二钱，香豉三钱。

服二剂，微汗热退，已不烦躁，仍嗜睡，四肢厥回，舌由绛转红，黑苔已退，舌根苔黄，脉略缓，继宜养阴清热利痰。处方：

玉竹三钱，麦冬一钱五分，石斛三钱，蛤壳二钱，天竺黄二钱，石菖蒲一钱，川郁金一钱五分，化橘红一钱，谷麦芽各二钱。再服二剂，肺部实化阴影吸收，叩诊听诊无异常，诸症皆平，原方去天竺黄，续进一剂而愈。

按：舌绛，苔老黄，齿干，思睡，是温邪入营之候，四肢厥冷烦躁，是欲有风动作痉之征，故用玉竹、麦冬甘凉以扶正养阴，银翘、竹叶辛凉以透邪清热，菖蒲、郁金开窍辟恶，玳瑁、竺黄解毒涤痰，妙在豆豉具挥发郁热之能，作透营转气之枢。不用清营者，以其邪初入营，犹可透之转气。或问：前例昏迷抽风，何以认为温邪郁闭，邪伤气分？此例嗜睡肢厥，何以认为温邪入营？盖气与营界限虽明，然亦不易分清。前例虽有昏迷抽风之症，但未出三日，舌质红而不绛，其苔尚白，其脉浮数，故为风温犯肺，卫气郁闭，治以解表开闭，而神清风熄；后者虽未见抽风之候，但已有嗜睡肢厥，其舌已绛，其齿干，其脉沉细，病已十日，故知温邪入营，因尚未作痉，治以透营转气，而热退厥回。故辨证必须全面分析，不可拘泥于神昏抽风一个证候。表闭可以导致神昏抽风，入营亦可不发神昏抽风，全在脉证互参，细心体会。

（选自《蒲辅周医案·温邪入营（腺病毒肺炎）》，人民卫生出版社1972年版，183～185页）

治风温犯肺（腺病毒肺炎）案

张某，男，2岁，1959年3月10日因发热三天住某医院。住院检查摘要：血化验白细胞总数27400/立方毫米，中性76%，淋巴24%，体温39.9℃，听诊两肺水泡音。诊断：腺病毒肺炎。

病程与治疗：住院后，曾用青、链、合霉素等抗生素药物治疗。会诊时，仍高烧无汗，神昏嗜睡，咳嗽微喘，口渴，舌质红，苔微黄，脉浮数，乃风温上受，肺气郁闭，宜辛凉轻剂，宣肺透卫，方用桑菊饮加味。处方：

桑叶一钱，菊花二钱，连翘一钱五分，杏仁一钱五分，桔梗五分，甘草五分，牛蒡子一钱五分，薄荷八分，苇根五钱，竹叶二钱，葱白三寸。共进两剂。

药后得微汗，身热略降，咳嗽有痰，舌质正红，苔薄黄，脉滑数，表闭已开，余热未彻，宜予清疏利痰之剂。

处方：

苏叶一钱，前胡一钱，桔梗八分，桑皮一钱，黄芩八分，天花粉二钱，竹叶一钱五分，橘红一钱，枇杷叶二钱。再服一剂。

微汗续出而身热已退，亦不神昏嗜睡，咳嗽不显，唯大便两日未行，舌红减退，苔黄微腻，脉沉数，乃表解里未和之候，宜原方去苏叶加枳实一钱，莱菔子一钱，麦芽二钱。

服后体温正常，咳嗽已止，仍未大便，舌中心有腻苔未退，脉滑数，乃肺胃未和，拟调和肺胃，利湿消滞。处方：

冬瓜仁四钱，杏仁二钱，苡仁四钱，苇根五钱，炒枳实一钱五分，莱菔子一钱五分，麦芽二钱，焦山楂二钱，建曲二钱。

服二剂而诸症悉平，食、眠、二便俱正常，停药食养痊愈出院。

按：叶天士谓“风温上受，首先犯肺”，故以桑菊清轻辛凉之剂，宣肺以散上受之风，透卫以清在表之热。二剂即得微汗，再剂即身热已退，慎勿见其为腺病毒肺炎，初起即投以苦寒重剂，药过病所，失去清轻透达之机，则反伤正阳，易使轻者重，重者危，因

思吴鞠通所谓“治上焦如羽”，实为临床经验之谈。

[选自《蒲辅周医案·风湿犯肺（腺病毒肺炎）》，人民卫生出版社1972年版，178~179页]

廖浚泉

用宣肺清热法治愈风温一例

杨某，男，2岁半。

初诊：1963年2月12日。

主诉（其母代诉）：患儿昨夜突然高烧，身如燔炭，气喘无汗，远道而来请余急诊。

诊查：量其体温 40.4°C ，昏迷惊惕，不思饮食，面赤烦躁，舌质红苔薄腻，脉浮数而滑。

辨证：此乃外感风温，兼肺胃伏热，恐热炽生风。

治法：急拟疏解表邪兼清里热之剂。

处方：麻黄3克，杏仁6克，生石膏12克，甘草3克，瓜蒌仁6克，桑皮6克，黄芩6克，淡豆豉6克，葱白2寸，猴枣散1瓶（分2次兑服）。

二诊：服药后汗出，发热减退（体温 37.7°C ），鼻衄口臭，食少欲呕，腹鸣，大便两日未行，舌苔薄腻而黄，脉缓滑。系表邪已解，里热未尽，食积痰滞，中焦不化。拟方以温胆汤化痰导滞，加黄连、栀子清解里热，藿香梗、麦芽、焦楂芳香和胃，消食导滞，更加秦艽、郁李仁润肠通便。药后大便通畅，诸症痊愈。

按语：风温一病，系“春月受风，其气已温”的一种新感症。本例患儿由于风温挟痰热互阻肺胃，肃降之令不行，阳明之热内炽，已现昏迷惊惕，热甚生风之象。本《内经》“体若燔炭，汗出而散”之旨，以麻杏石甘汤加葱豉、黄芩、瓜蒌、桑皮等加强辛凉解表、清肺平喘之力，并用猴枣散化痰而镇惊，故服之而热退。第二方药服之则里热解，腑气通，病霍然而愈。说明小儿体温虽高，只要审证用药精当，收效亦速。

〔选自《中国现代名中医医案精华（三）》，北京出版社2002年版，2138~2139页〕

颜德馨

论四时感冒务明时气疫气

感冒之名，见于南宋《仁斋直指方·诸风》中，然类似感冒之描述，在《素问》中即有。如：“风者百病之始也……风从外人，令人振寒，汗出头痛、身重恶寒。”迨至清代温病学说兴起，不少医家认识到本病与感受时行之气有关，《类证治裁》更明确指出“时行感冒”之名，然治疗总不外乎祛风解表之法。

余以为，风邪虽为六淫之首，但在不同季节，往往夹四时不正之气而入侵。春季之温、夏季之暑、秋季之燥、冬季之寒和梅雨之湿，固是自然界之变化，但在四时之中，又有气候失常之时。如春应温而反寒，夏应热而反凉，秋应凉而反热，冬应寒而反暖，非其时而有其气，人感乖戾之气，都能入侵人体而致病。另又有感受“疫气”者，则高热、口渴、阵阵剧咳，甚则呼吸困难、紫绀、咯血、舌红、脉数，更不可以作“伤风”治，故曰：四时感冒务明时气疫气。

余治四时感冒，首辨寒热虚实，总不忘乎时气疫气，故喜用清热解毒，但常灵活变通。若风寒遏表，症见高热无汗、形寒、头痛、鼻塞流涕等，则用宣肺开泄腠理，倡以寒温并用，如羌活汤（羌活、大青叶、蒲公英）发汗退热，亦可用于风热不著者，投之辄效。若风热袭肺，症见高热面赤、汗出气粗、咽痛等象，投银翘散、抗毒饮常效。银翘散可日服二三剂，抗毒饮为经验方。由羌活、大青叶、黄芩、白芷、苦参、蛇床子等组成，具有抗病毒作用，尤其适用于流行性感冒。发汗用药首推羌活、清水豆卷，加柴胡可促使发汗退热。若高热长盛不衰，上病下取，釜底抽薪亦为良策，外邪闭肺，热不得泄，出现高热、气粗、张口抬肩，用泻腑之法，常能使邪从下走，以达到退热祛邪之目的。

然老人感冒，又当别论。盖老人肺虚，外感时邪，易伤肺阴，且常反复不愈。

古方人参败毒散、参苏饮虽治虚人感冒，但药性偏于温燥，仍非所宜。而陈士铎《辨证录》中加味补中汤一方，临证用之多验。该方由黄芪、白术、麦冬、当归、党参、柴胡、花粉、陈皮、茯苓、升麻组成，主治虚人感冒，持续不愈，或易于感冒，时作时辍，头痛鼻塞，畏寒倦怠，午后低热，咳嗽胸满。若表邪重者可酌加荆芥、防风、苏叶。此皆经验之谈，可资参考。

（选自《中国百年百名中医临床家丛书·颜德馨》，中国中医药出版社 2001 年版，177~178 页）

潘澄濂

论养阴生津法在温病临床上的应用

养阴生津法大致可分为甘寒和咸寒两大类。前者如沙参、麦冬、石斛，后者如龟板、阿胶、牡蛎之属。但是，临床上后者多与前者联合应用。它具有生津养液、补精益血之功，能起到清热、凉血、镇静、扶羸的作用，文献报道，养阴生津法还能提高机体免疫力及调整电解质的紊乱。临床上常用于治疗多种疾病过程中所引起的伤津耗液、精亏血损之证。今就其在温病领域中的应用，探讨如下。

理论依据

关于阴虚的机理和临床表现，早在《内经》就有论述。如《素问·阴阳应象大论》说：“阳胜则阴病”，“阳胜则身热，腠理闭，喘粗……”又《素问·逆调论》说：“阴气少而阳气胜，故热而烦满也。”又《素问·调经论》说：“阴虚则内热……”《素问·厥论》说：“阴气衰于下，则为热厥。”《灵枢·决气》说：“精脱者，耳聋；……津脱者，腠理开，汗大泄；液脱者，骨属屈伸不利，色夭，脑髓消，胫痠耳数鸣；血脱者，色白，天然不泽，其脉空虚，此其候也。”所有这些，为我们诊断精、液、津、血亏损的阴虚证，提供了指征。

养阴生津法的方剂和药物，在《伤寒论》中，如炙甘草汤治心动悸、脉结代的心荣不足证；黄连阿胶汤治烦躁不得卧的阴虚阳亢证；竹叶石膏汤治热病余邪未净的气阴两损证等等，为后世应用养阴生津法之楷模。特别是《伤寒论》，根据阴阳互根，气血同源的理论，如炙甘草汤之地黄、麦冬配合人参、桂枝，具有益气养阴之作用。如黄连阿胶汤以黄连配合阿胶，具有泻南补北之意义。凡

此配合，辨证精妙，值得研究。

自金元以降，如刘河间之治热病喜用降心火益肾水的方法，朱丹溪倡阳常有余，阴常不足的学说，尤其是明、清时期，温热病学的发展，如叶天士、吴鞠通、王孟英等根据温病最易热化、劫津灼液的规律，提出温病以救阴为主的治则，并认为治温，能保得一分津液，便是退祛一分温邪。因而，养阴生津法的方剂和药物及其应用范围，益加广泛，积累了丰富的经验。

养阴生津法方剂的组成和作用

养阴生津法的方剂较多，笔者将内科（包括温病）临床上所常用的，如三才汤、大补阴丸、增液汤、一贯煎等30余个方剂，给以统计，发现其中药物以地黄（包括鲜、干、熟地黄）、麦冬占首位，其次为阿胶、龟板、元参、白芍。此外，《本经》早就认为石斛有强阴益精之功，《临证指南医案》、《王孟英医案》等治疗温热伤阴劫液，中风阴虚阳亢之证常用之，实为较好的养阴生津药之一。当然，尚有如知母、玉竹、杞子、黄精等等，亦均具有养阴生津的作用。

由于温病有多种多样，病程有长短之悬殊，发病季节有不同，而且患者体质有差异。一般来说，如风温、秋燥较易伤耗肺津；湿温、冬温较易伤胃液；暑痉易伤心营；温疟易劫肝阴。正由于这种关系，所以养阴生津法的方剂及其作用，也有一定的针对性。如清燥救肺汤、沙参麦冬汤以治肺津损伤之证；一贯煎、青蒿鳖甲汤以治肝阴耗劫之证；白虎加地黄汤、竹叶石膏汤等，宜于热邪灼津耗液之证；犀角地黄汤、化斑汤、清营汤等，宜于热毒伤营而见衄血、斑疹之症；加减复脉汤、黄连阿胶汤等，宜于肾液亏损、内风煽动之证。此外，如三才汤、增液汤、大补阴丸等，可以说是养阴生津的基础方。但是，也有甘寒与咸寒之别，要随证选择。

综上所述，养阴生津法方剂的配合，不是单纯的、而是视病情的不同，配合清热、解毒、凉血、通下，甚或开窍宣闭或益气扶正之药，复合应用，才能达到其治疗之目的。总之，如生地、麦冬、石斛等甘寒之药，适用于肺胃津液耗灼之证；如龟板、鳖甲、阿胶

等咸寒之药，适用于肝肾的阴液亏损，或病程较长的羸弱之证。这是一般的应用规律。

（选自《中国百年百名中医临床家丛书·潘澄濂》中国中医药出版社2001年版，21~23页）

论治流行性感冒

流行性感冒一般是依照风温的方法而治疗，多适用于上呼吸道感染类型。但是也有恶寒发热，头痛身疼，甚至肌肉挛急，运动不利的风湿型流感。此外，还有一种类型，是突发寒热、胸痞、恶心呕吐，或大便清泄的胃肠型流感。这两种类型均可在湿温证的范畴来探索它的辨证和治疗。如薛生白《湿热病篇》说：“湿热证，恶寒无汗，身重头痛，湿在表分，宜藿香、香薷、羌活、苍术皮、薄荷、牛蒡子等味，头不痛者去羌活。”第三条说：“湿热证，恶寒发热，身重关节疼痛，湿在肌肉，不为汗解，宜滑石、大豆黄卷、茯苓皮、苍术皮、藿香叶、鲜荷叶、白通草、桔梗等味，不恶寒者，去苍术皮。”这里薛氏所说的“湿在表分”、“湿在肌肉”，是导源于《金匱要略》的湿病，确近似“风湿型”流感一类的病变。证之临床实践，用这种理法治疗，是能获得疗效。例如本所木工家属张某，37岁，女性，于1978年4月突发寒热，无汗头痛身疼，第二天起发现右下肢挛急，牵引作痛，不能行动，舌苔白腻，脉象浮数。经检：白细胞6300，分类中性74%，淋巴25%，嗜酸性1%。认为是湿热伤于经隧，系一种“风湿型”流感。经投麻杏苡甘汤加茯苓、忍冬藤等，仅服3剂，病即痊愈。

至于“胃肠型”流感，一般采用芳香化浊法。药用：藿香叶、苡仁、半夏、茯苓、佩兰、豆卷、黑山栀等治疗，常可获效。对发于五六月间梅雨季节的“胃肠型”流感，中等度发热，肢体倦怠，胸腹痞闷，舌苔白腻或微黄而腻，脉濡细，即雷少逸《时病论》所谓“霉湿”之证，仿达原饮意加减。药用：厚朴、槟榔、藿香、黄芩、知母等随证加减，不三四日即可使热解病却。

除上述二种疾病外，其他如疟疾、钩端螺旋体病、急性血吸虫

病，甚至如风湿热等，在其病程中表现为湿温证的，根据病情，亦有部分病例，可以采用治疗湿温的方法，屡有所效。

总之，个人体会，首先要认识温病学说是在《伤寒论》的基础上而发展起来，这样认识，不至于把两者分割开了，是有好处。同时，对那些什么伤寒传足不传手，温病传手不传足，伤寒是外感，温病是伏邪，尤其是什么是温病，什么是瘟疫，等等，这些多年纠缠不清的问题，可以澄清。

再一问题，就是急性传染病的病原体各有其特性，各种传染病又各有其特征。人们的认识从特殊到普遍是自然的规律，因此对传染病的预防和治疗，对各种传染病的病原体的特性，疾病的特征，以及传染源等，都要清楚。特别是为了提高疗效，我们须大力寻找对病原疗效高、副作用少的药物，与对症治疗的方药相互配合应用，既可抑制或杀灭病原体，又可促进机体的机能恢复。这方面的工作，尚有待于我们的努力。

（选自《现代著名老中医名著重刊丛书·潘澄濂医论集》，人民卫生出版社2006年版，112~114页）

魏树森

春温夹痰热案

病者：高尔昌，年四十余，业商，住泰县。

病名：春温夹痰热。

原因：素因嗜食厚味，内积痰热，又外感时邪而起。

证候：头痛身热，胸脘痞闷，烦躁不安，舌苔黄，且渴，已延一候。

诊断：诊脉浮滑且数。浮脉主表，滑脉主痰，数脉主热，以脉合症，此春温夹痰热病也。方书论温病，有伏气外感之分。此症因素嗜厚味，痰热内蕴，又值时令温暖，腠理开泄，外感时邪，肺先受病，故见头痛身热、胸脘痞闷、烦躁不安等症。前医进辛凉解表之剂，如荆芥、豆豉、薄荷、牛蒡、银翘、甘、桔等味，服后胸烦如故，而表热亦未尽解。考《临证指南》温热门结论云：此病夹有痰热者，用温胆汤。盖夹有痰热之人，痰热熏蒸于外，亦足以致身热而有余，必须清其痰热，则身热胸烦始解，其理甚明。

疗法：用萎贝温胆汤加味，以清其痰热，兼宣通气分，则诸病自除。

处方：瓜蒌霜钱半，瓜蒌皮三钱，法半夏钱半，粉丹皮钱半，小枳实钱半，川通草一钱，川贝母三钱，茯神三钱，茯苓三钱，焦山栀三钱，淡竹茹钱半，六一散四钱，广橘红一钱，冬桑叶三钱，广郁金钱半，射干钱半。

效果：服两帖，身热胸烦尽解。更用清养胃阴之药，调理数日而瘥。

廉按：辨证既明，方亦清稳，是得力于叶法者。

（选自《全国名医验案类编》，福建科学技术出版社 2003 年版，299-300 页）

治疫验方

疫证

除疫救苦丹专治一切瘟疫时证，伤寒感冒，不论已传未传，百发百中。

生大黄二两，瓜儿天麻、麻黄、干姜、松萝茶、绿豆粉各一两二钱，雄黄、朱砂、甘草各八钱。

上九味共为细末，炼蜜为丸如弹子大重一钱五分，瓷瓶贮勿泄气。大人每服一丸，小儿半丸，新汲水调服，出汗即愈，重者连进二服。未汗之时切不可饮热汤、食热物，汗出之后不忌。

诸葛行军散治时气流行瘟疫热病。

绿豆粉一两，麻黄末八钱。

共研和匀，每服一钱，无根水或温水调下，汗自出即愈。

宝丹

朱砂、雄黄各二钱，血竭、粉甘草各五钱，桔梗、硼砂、广皮、牙皂、薄荷霜各一钱，梅片五分，白糖一两。上十一味共为细末。

辟疫香

苍术半斤，贯众、艾叶各四两，排草、菖蒲、吴茱萸、白芷、山柰各二两。

共捣烂，每用一撮，置房中燃之。宜加雄黄一两。

普济消毒饮治大头瘟。泰和二年四月，民多疫疔，初觉憎寒壮热，体重；次传头面肿盛，目不能开，上喘，咽喉不利，口燥舌干。俗云大头伤寒。李东垣曰：身半以上，天之气也，邪热客于心肺之间，上攻头目而为肿耳，须用芩、连等药。活者甚众。

黄芩（酒炒）、黄连（酒炒）各五分，人参三钱，陈皮、玄参各二钱，甘草、连翘、板蓝根、马勃、僵蚕、升麻、牛蒡子各一钱，柴胡五分，桔梗三钱。

上十四味共为细末，半用汤调，时时稍热服之，半用蜜丸噙化。服尽良愈。如大便硬加酒蒸大黄一二钱，以利之。肿势甚者，

以砭针刺之，或加防风、川芎、薄荷、当归各五钱，水煎时时服。

又方

黑豆二合（炒焦）炙甘草一钱。水煎汤热服。

又方

蚯蚓十余条，以白糖拌入，碗碟盖好，半日即化为水，至迟一日必化。用鸭毛蘸水，敷之即消。

（选自《现代著名老中医名著重刊丛书·潘澄廉医论集》，人民卫生出版社2008年版，42~43页）